

## 伤寒论

### 倪海厦讲义

#### 1——1

这次开始介绍伤寒论。伤寒来自难经第五十八难，难经第五十八难说伤寒，有五个病叫伤寒。第一个是中风，这个中风你不要把它想成现在医院里的中风，不一样哦，就是伤于风得到的。还有就是伤寒，再来是温病，再来热，再来是湿热。不管是哪一种都来自伤寒。

在黄帝内经里讲到，冬天是主收藏。外面是很冷的，很寒的。冬天的性本身是主收藏，气候是冷，这叫做正气。为什么要有正气，因为这个节气是这样，这是标准的正气。在伤寒论里面会分到时疫，比如说你现在看到的SAS、瘟疫，就是时疫，这里我会把它分开了，伤寒论里统统有，张仲景都有留方子下来。像SAS我为什么会开大青龙，都会慢慢介绍给诸位。你如果是正气，冬天本来就是冷的，那你在冷的状态之下得到寒症，那你得到的是正气的病，这是一般的病，你如果是得到非正气的病，冬天本来应该是很冷的，结果你是很温热的，气候跟节气不和，冬行春令，这个时候你发现男女老少，不管他是谁，得到的症都一样，这就是所谓疫病，是会传染性的。

张仲景就是看黄帝内经的热论，张仲景把黄帝内经的热论，归纳起来以后，把它分成六经辨证。所谓六经就是：太阳、阳明、少阳、太阴、厥阴、少阴。归经了以后，每一个经发生了病变，你可以依据一个病变一个症状一个处方，你有所依循。有这个六经辨证，这个条理，学中医很好学。经方并不是张仲景研究出来的，张仲景是经方的传承人，他把经方收纳起来，上古圣贤用的绝对处方，所谓经方就是绝对处方，你不要去改它了，依样画葫芦就解决了，叫经典之方。张仲景不仅把它收纳起来，按六经的方式一条一条，每一个经发生的不同病变，用什么处方，张仲景把它配制的非常好。所以我们介绍伤寒论的时候就是讲如何去配制它，当你们熟练了以后，你只要听，一听到那个症状处方就已经开完了，要熟练到这种程度才行，所以每一个方子，我都会给诸位介绍的很详细，包括什么时候使用，所以说当你在进入伤寒论的时候，我会分两种，一种是正气，就是按照节气，春夏秋冬得到的病，我们有开处方。一种是时疫，我们开处方，这两个不太一样。

今天开始，我们伤寒论第一篇。

太阳篇我们就分了，大概占了百分之六十以上。在整个伤寒论就占了百分之六十以上。在介绍之前，我要给诸位一个观念。有了这个观念，在去看伤寒论就简单了。

#### 五运六气 插图

这是十二个时辰，我们所谓五运六气。十二个时辰里面，我们分六个气。第一个气叫厥阴气，厥阴气讲的是巳时跟亥时，这两个是相对的。我们一天分阴阳，阴阳太极图是圆的，不是一条线瞬间天黑，瞬间白天，没有这种事。是慢慢天黑，慢慢白天。这就是阴和阳慢慢在转换的。厥阴的意思就是阴的刚开始的时候，要准备结束了，开始往下坡走的时候。到子时、午时的时候是少阴的时间，到丑、未的时候是太阴。如果走到寅、申的时候，叫少阳，少阳就是阳开始起来一点。

卯、酉称之为阳明，到了辰、戌的时候，叫太阳。这是一天的六气循环。

为什么定义叫做气。所谓六气，气就是不断的动。因为讲到气就是会流动，如果是顺时针走的时候是正，正气。正气就是说你是无病的状态，你是常人。当医生最基本的要知道什么叫健康，你如果不知道，你如何确定这个人被你治好了。伤寒、金匮你看它病症很多，实际上它的重心在健康的标准。所以你的六气如果是顺时针走，是常态，正常。如果是反着走，就是病态，生病了。比如说病在太阳，你没有治好，进入阳明、少阳……，至于中间的变化怎样，我们介绍伤寒论的时候再详细讲。

基本上在开宗明义的时候你心里有这个概念，当你存有这个概念，你脑筋里很清楚了，厥阴证什么的你不会迷惑掉，并且病在痊愈的时候他的症状怎么走，也会很清楚。其实就是一个图，这个就是六气。

伤寒论是条辨，所以要把条辨列出来给大家看，伤寒论条辨是言简刚中。在中国相书上讲，言简刚中的都是君子、人才，讲话简单扼要。张仲景就是言简刚中的人，也因为他的言简刚中也误了很多，大家都看不懂了。所以真的要了解伤寒金匮要把整套看完以后，把它稍微整理一下，次序就出来了。我帮诸位整理过，你看就比较清楚了。

原文：太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。

第一个我们为什么讲太阳病。张仲景为什么从太阳病开始。太阳在表。诸位在学针灸的时候，知道我们的膀胱经是太阳经，手太阳小肠经，足太阳膀胱经，都在肩背后方。

过去的经方家说太阳就是太阳，不要把它跟针灸的经络混在一起，其实混在一起不混在一起倒无所谓。我们看到经络就按照经络来治病，如果真的说太阳指全身我也同意。但是张仲景有些条辨又完全是在太阳经上面。初期是在太阳也就是在表。中医又所谓的八纲辨证，阴阳表里虚实寒热。病如果是外来的，初犯的时候一定是在表，病在外面，表就是在外边。张仲景把这个表就叫做太阳。

太阳之为病它的症状是什么？脉是浮的，头项强痛，恶寒。历代医家，对太阳下了定义，太阳为寒水，这是常态，什么叫做寒水，我们人身上有很多水，所以你摸到人身上皮肤是冰的，正常人。正常人你摸到身上是冰的，手脚是温热的。你摸到他身上很燥热，待会我会告诉你是什么病，张仲景会讲到。所以正常人皮肤表面是冰的，叫太阳寒水。为什么叫寒水，就是保持我们身体跟外界的一个隔阂。有这个寒水保护到我们不会丧失体温。不会受到外界温度的影响。这个水不是停在那里不动的，是不断的在更换，一直在换，一直在换。这个血在循环一直在换。水在换的时候，我们才会有，比如我们吃下去的食物，喝进去的水，一直在不断的更新，不断在代谢。所以我们人是不断的更新不断的代谢的状态之下，多以人是一个动物，他是全身在动，而不是说不动。

当病在表的时候这个脉浮。整个经方里面，伤寒金匮，他有四种脉为主要的脉。第一个就是浮，有浮就有沉，脉有迟有数。以后大家会看到很多的条辨，它会告诉你脉沉，脉迟，脉什么东西，还有很多其他的脉，脉弦啊，先不要去管它。张仲景主要代表的四个脉：浮沉迟数。浮跟数这两个脉是阳，沉迟是阴脉。这是一开始的一个基本的概念。浮脉的定义是什么，你手轻轻的摸到皮肤上，就摸到

脉，那就是浮脉。不要压它，指头根本就是刚碰到，就是浮脉。我们的脉诊，用脉来看病是下工。我们有望闻问切，切是下工。但张仲景提到脉，我们一定要有脉。因为你会四种诊断的时候，往往状况很多，有时候你没有办法望，必须要摸脉，所以四种都要会比较好一点。如果是你重按到骨边就是沉了，所以这两个脉是按部位，位置来形容它。迟和数是以它的速度来决定，它是迟还是速。有的脉跳的很慢。你先不要管一吸几下，脉按下去，跳的怎么那么慢，我的脉比他跳的快，或者他的脉跳的很快。一个迟一个是数。以速度和位置来做阴阳脉的一个基本概念。

当你有这个概念的时候。初病的时候，太阳症得到病，如果你的脉出现浮，后面跟到是大，跟到是动，跟到是滑脉，跟到是速脉，这些都是属于阳脉。但是你以一个浮作为基准。如果说刚开始生到的脉是这个脉，结果后来脉改变了，逐渐改变成涩脉，脉比较涩，比较微，比价弱，脉没有力量，同时脉比较弦。遇到这种情形，本来是阳脉，比较大，慢慢变成阴脉。阳很好，是有病，刚开始的病。脉慢慢变成阴脉的时候，代表病在进。所谓病在进就是病在变坏，是越来越坏，越来越严重。

如果你反过来，病人刚开始病的时候，脉是沉，跟着是很涩，很微，微小的脉，很弱的脉，很弦的脉。这些大家以后在念伤寒、金匱都会读到，你以沉为主，刚开始你看看病人，一得到病的时候就是这个脉，然后脉改变了，逐渐变成浮大滑速，脉动的很强。由阴脉变成阳脉，这是病退，病在退去，这是我们从脉上可以知道。

正常的人，脉不浮、不沉、不迟、不速，这是常脉，这样子想。这是我把脉简单整理给大家。正常人，不管春夏秋冬，你轻轻摸他的皮肤，摸不到脉，就不是浮脉。稍微摸下去，可以摸到脉了，它不是浮。也不沉，沉就是按到骨边才摸到脉，那就是在中间，也不迟，也不数，这是正常人。诸位先不要去看难经里面说寸关尺小肠之类的，先不要去管它。张仲景没有分那么细，张仲景不需要了，张仲景摸摸浮沉就够了，处方就开完了，因为我们还有望闻问，张仲景很会望闻，所以他不会去强调那么多。

基本上对脉的诊断，张仲景说，简单的讲就是，阳有病不可以看到阴脉，任何的病，有病一定要看到阳脉，当见阳脉。我临床的时候就看的很明显，病人来的时候，比如说心脏病，心脏病跟感冒是最明显，因为一处方下去，比如说原来那个脉很浮很大很速，或者是跳一下停一下，处方一个礼拜吃下去再来，还没有问他，一摸脉，已经改变掉了，经方才有办法。经方才可以看到立竿见影这个结果。当然你配合一些针灸效果更快。

当你看到脉浮的时候，浮是在表，太阳病一定是初病，刚开始得到的病，所以脉是浮到的。头项强痛，恶寒，得到太阳病的时候，一定是后项后脑得到。诸位在学针灸的时候，知道我们脑袋后面风府，风池、风门。这些穴道都是用风字来命名，代表说脖子这个地方是最冷的地方了，风最容易进来的地方。所以天气比较冷的时候，诸位缩一下脖子会比较不冷。如果冷气对着脖子后面吹，一定重感冒，因为伤于寒就是从后面来。

天气很热，在外面全身大汗，回来，脸对着冷气吹，寒热之间变化那么快，结果第二天早上起来脸是歪的，脸部中风，昨天晚上流大汗吹风，寒则缩，牵拉

到一边。张仲景虽然没想到，他有方子在那边，理论是一样，处方了解了以后，即使变到现在这个环境，处方还是照样适用。我常常还是开经方治脸部中风还是很快。张仲景不会这样写，他怎么知道后面会发生冷气。但是他的理论是一样，环境再怎么改变，理论还是一样的。

第二个计量的问题，介绍到处方的时候，会讲计量的问题。

会恶寒的原因，我们人身上的常态，正常人，肺主皮毛，所以皮肤毛孔都是肺脏在管，我们的太阳经实际上心肺之表为太阳。心脏和肺脏，这是黄帝内经的，心脏不断的搏动，产生很多的热，这个热是要靠肺，肺是寒，肺法象天是寒，这个寒和热两个对在一起，才能保持一个温度。就想汽车引擎，一定有一个很好的水箱大小，引擎太大不行，太小也不行，水箱和引擎配好，所以保持一个恒温。

如果说受到风寒以后，一受到风寒，寒水停到那边不动，会造成头项强痛。新的水不断的供应上去，旧的水又不能跑掉，停在那边，之间产生的压力当然会痛。

## 1——2

伤寒论的条辨就是说，我们在太阳篇出现这个症状就是太阳症。我不管里面的病是什么，可能是肺癌，可能是肝癌，我不管你，如果病人出现的是这个现象，你就给他太阳症的药就对了。不用去管里面的病是什么。

反过来病人如果是厥阴证，你治疗之后病人变少阴、变太阴、变少阳、变阳明、变太阳，代表病人在痊愈中间，本来是太阳病，被你治成厥阴病，那你自己就要检讨了。所以说中医，真正最有系统就是伤寒论。

这是第一个条辨，所以诸位现在看到了，脉浮，头项强痛恶寒。所以如果来一个人哑巴，你一摸他脉浮，你说是不是头项强痛，他点头，你看他的动作，进来衣服包的好好的，一看就知道恶寒，所以有时候不需要去问他。

原文：太阳病，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。

看第二条，发热，汗出，恶风，脉缓者，名为中风。太阳病我们有中风，有伤寒。什么叫中风，中风的主要症状呢，病人只要有汗出，有发热，有恶风，恶风就是风吹到他很怕很难过，不喜欢风吹。这个中风跟西医讲的半身瘫痪不一样。病人最主要是汗出，病人有流汗，这个流汗是因为病态，不是你去运动，或天气太热流汗，我们都不会流汗，他一个人在那流汗。脉缓者名为中风，中风我们不要把他当成一个病名，当成一个症状。所以诸位只要看到有汗出恶风脉缓，摸他的脉是缓的，当然也是浮了，就变成浮而缓嘛，刚开始得到表症的时候，一定是浮脉，浮脉里带一点缓脉，同时病人有发热的现象，这个发热，有的时候没有发热有的时候会有发热，都可以判断他是中风，这个发热你可以解释称为发烧，但是中风的发烧不是很高的烧，差不多高于正常人一两度，有烧但不是很高，所以只要听到病人跟你陈述，我风吹的很难过，流汗，就已经可以判断他是中风了，为什么这样说，因为中风有中风的处方，伤寒有伤寒的处方，温病有温病的处方，都不一样。这个张仲景把它定义为中风，为什么是来自于风。

这种病一般来说，都是在运动了以后，流汗，外面很热他在流汗，里面冷气很冷，他进去后当时很爽，事后就怪怪，再出去吹到风很难过，就已经中风了，

我们不用管里面是什么，什么 B 型感冒，那些名词讲一大堆，只要听到，这些就可以处方了，这是第一个太阳病。

有的时候病人不知道，他说医生我感冒了，不舒服。你要问他你有没有流汗，流汗就不是伤寒了，就已经把伤寒踢掉了。有汗，怕风吹，就结束了，脉就不用摸了，已经可以开处方了，经方就是这样子。

原文：太阳病，或已发热，或未发热，必恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名为伤寒。

太阳有病，已发热或未发热，并不是重点，必，一定有的症状，一定会恶寒，体痛，呕逆，脉阴阳俱紧者，名曰伤寒。伤寒和中风，我们麻黄和桂枝唯一的区分点，就是一个有汗一个无汗。有汗的时候我们会用桂枝，中风的。无汗的时候我们会用伤寒。有没有发烧都没有关系。阴阳脉俱紧，所谓阴阳脉，寸为阳，尺为阴，这个我们在临床上看的是最标准的，谁治好病谁就是对的，当你摸病人的寸脉，你不用管左右手，寸的部位就是阳脉，尺的部位就是阴脉。就是因为上面是阳，下面是阴，阴和阳之间有个门当到就是关脉在中间，我在摸脉的时候常常是两个指头，阴阳脉，中间我就舍掉，两个指头在摸而不是三个指头放上去摸。阴阳脉在以关为标准的时候，关上关下两只手同时摸的时候又浮又紧，就叫阴阳脉俱紧者，名为伤寒，一般你摸到脉问他，有时不用问他，他怕冷穿着衣服在发抖，这个伤寒出现的时候，就是冬天伤于寒，出现的时候，病人就算是在车子里面，大热天的时候，你不要开冷气，他穿着厚大衣还是冷，温度很高，还是冷。大热天还是有伤寒，所以伤寒不是说冬天才有。夏天都会有，因为冷气，还有跳到水里面游泳，所以伤于寒，我们不能说他是冬天的寒，而是他伤于寒。晚上睡觉很热冷气对着吹，在冷气房里面工作，都会造成伤寒。所以伤寒应该讲伤于寒比较好，而不能说冬天的寒才会有伤寒，夏天就没有，这样的话就变成北方才有了。简单讲就是这样子。

病人如果有呕逆的现象，一般来说，在张仲景伤寒论里面，病进入少阳以后，才会出现呕逆的现象，或阳明才会有呕逆的现象。这里会有呕逆的现象，代表这个人肠胃不是很好。不是说每一个人都会有呕逆的现象。我们进入阳明篇、少阳篇，都会看到呕逆的现象。我们待会介绍到处方的时候，就了解到，会看到张仲景为什么把这个列到这边来。

现在大家了解了，不管你是中风的症状，不管你是伤寒的症状，这个统统属于表，统统是在太阳里面，都在表上面。表症就分了中风，又分了伤寒。

身体会很痛，这个会痛到什么程度能，痛到好像被鞭子打，全身痛，为什么会痛。所有的痛都是来自压力，并不是来自发炎。所以有一个人说，我脚痛，是压力。为什么叫压力，这个体痛，我们身上有水，当你伤于寒的时候，你毛孔是打开的时候，寒进来了，一伤于寒，毛孔缩起来。缩起来以后，很多汗水离开了汗腺，但是又没有到皮肤表面出来。不如说，运动流汗，瞬间跑到冷气间去，或跳到水里，冷水扑到身上，毛孔遇到冷的时候，瞬间缩起来，那里面你刚刚运动还是热的，外面你瞬间碰到很冷的东西。里面的热，造成里面的汗不断从里面的汗腺出来，汗水停在肌肉和皮肤中间，外面是冷的，里面是热的。如果身体比较差一点的人，隔天就开始体痛，为什么，因为这个水停在那边你代谢不掉，你体温不够，肠胃功能不是很好，代谢不够，所以说新的水没有办法去取代旧的水。

这个时候我们会用一些发表药，把寒去掉，一发表，水一流通，新的水去取代旧的水，痛就去掉了，一般多发生于平常身体比较弱的人。那如果身体比较强的人呢，有可能没有感觉，或者有可能觉得皮肤痒一下，因为你那个水在皮肤没有透发，因为冷气嘛。但是他没有感觉，他只是痒一下，抓抓痒就过去了，回家洗个澡一流汗又好了。同样的身体比较弱的人第二天身体就不行了，身体就会有伤寒的现象，所以我们平常就有把身体保养的很好。保养身体好的方式呢，除了我们食物以外，把肠胃一定要弄好。张仲景非常注重肠胃的功能，肠胃一定要弄好。

从自然界来说，你看天上，天是空虚，虚灵。人体是清灵，所谓清灵就是很干净，你今天吃下去的食物到了嘴巴里面去，在身上呆二十四小时，一定要排出去。所以我们经络学里面在讲地支歌诀，肺开寅时，大肠开卯时，周天循环，就代表说你一块肉或一碗饭，吃下去以后二十四小时一定要排出去，你超过二十四小时排不出去就不够清，那就不够灵动。所以健康的人是以虚，身体虚为健康，而不是以实为健康。所谓虚的定义不是人很累，很瘦弱，而是说所有新的东西进去都能把旧的东西代谢出去。不会累积很多实在里面，这是常人。

有的人看到公共厕所不要上，便秘是练出来的，便意就没了。遇到这种人，还没有生病的时候，赶快去把他大便治好，让他大便正常，正常以后他就不会生病。所以肠胃好的人都不容易有病。所以我们从小问题的时候就要开始动手。

现在大家知道，体痛，恶寒，无汗，最主要 是没有汗，这是伤寒。

伤寒论第四条，

原文：伤寒一日，太阳受之，脉静者，为不传也；若脉数急者，为传也。

这定义就是，刚开始你病进来的时候，在人身上的表，在人体的表面，在表的时候你怎么知道病会不会深入，有没有深入进去。

当你表病入里的时候，有两种可能，第一种少阳，第二种阳明。当你的表病如果入里的话，他是入到阳明，就是跑入肠胃里面去。阳明症，比如说白虎、承气，很多阳明症，病就不会进了，到此为止。所以伤寒论，我们介绍到阳明篇的时候，阳明是无死症。也就是说今天有一个人是阳明症，他只是个便秘，结果你把他治死掉了，就是你医之过。你如果厥阴的时候病人就会死在病上面。所以伤寒论不但我们治病有个法则，同时用这个法则去看，这个病人到底是死于病还是死于医，一看就出来了。如果你到了阳明病就不会再进了，到此为止，结束了。所以阳明无死症。所以很多医生便秘，也没什么，就是皮肤丑一点，脸比较黑一点。如果说没有进入阳明，进入少阳，病跑入少阳以后才会进入太阴，才会进入少阴，再来厥阴，才会有这种歌可能，才会进入阴，所以如果没有进入阳明，跑到少阳的话，就会有阴症的出现，这是基本的一个概念。

你怎么知道表病有没有入里？他说一日，这里一日是六天到七天，不是一天。如果说刚开始病在太阳，所谓脉静者，是说脉没有变，阴阳脉浮紧还是浮紧，脉浮缓还是浮缓，六天还是没有变代表病不会传，不会往里面传了，就在表上面，如果你脉急数了，代表你病往里走了。

病传的原因很多。绝大多数病会传经的原因就是心脏。心脏有两种，一种是心藏神，心意。所以你感冒了，现在是桂枝汤症，结果还没有吃桂枝汤，就是太阳症了，太阳中风了。生气，情志受到损坏，病就会传。那你心情很好，病就不

会传。还有一种心脏功能受到影响。我很不赞成抗生素，因为抗生素下去第一个就是伤到心脏。怎么知道伤到心脏，舌为心表，舌头是代表心，就好像心脏的大使。我们要看心脏如何，看看舌头，抗生素吃下去第二天舌头就变了，舌头变成地图舌，有凹洞在上面，心脏就受伤。心脏受伤了病会传，六天了以后，本来是太阳中风，或者是太阳伤寒，结果你吃了抗生素并没有好，一吃下去以后心脏受伤，反而会让病再传。如果按照这个条辨的话，按照张仲景的意思，其实你不吃药也没关系，心情要好。

大家看第五条。

原文：伤寒二三日，阳明、少阳证不见者，为不传也。颇欲吐，若烦躁者，为传也。

如果你是伤寒二三日，阳明和少阳证不见。阳明有阳明的症，阳明是但热不寒，阳明症看不到寒症，全都是热症，不管是口渴，一判断就知道是阳明。少阳是往来寒热，就是忽冷忽热的现象，如果都没有见到这种症状，代表是不传。如果颇欲吐，若烦躁者，为传也。有欲吐就是讲进入少阳，少阳主症就是往来寒热跟呕吐，恶心想吐，少阳症。烦躁一看知道是阳明症，阳明症出现烦躁，烦躁怎么讲，心情不好，睡觉睡不安稳，烦躁的定义非常的广，手脚躁动也叫做烦躁，小孩子跑来跑去多动也叫做烦躁。烦躁不能只是把它解释做心情，按照字面来解释是不够的，凡事动作上没有办法定下来，情志上没有办法安静下来，晚上睡觉睡的不好，统统是叫做烦躁，晚上失眠也叫做烦躁。西药 **NBA** 吃下去，人睡了，眼睛闭起来睡了，可是型没有睡，起来跑出去梦游，你看这种药可以吃吗。所以当出现这种恶心、呕吐就是病在传了，在往里面走。

为什么伤寒论的条辨他把它分那么细，就是希望你遇到，一发现病要传的时候，处方一下去，经方处方在治疗太阳症表症的时候，真的就是一剂，处方对了真是一剂就好。有的一剂还没吃完，一副药煮成三碗，第一碗喝完就好了，那两碗很可惜，但再喝就过了。

第六条。

原文：太阳病，发热而渴，不恶寒者，为温病。

太阳症就有三个病，中风，伤寒跟温病。在太阳症里面，冬伤于寒，春必病温，你到春天的时候，出现的温病，主要的症状呢，他没有恶寒，但发热而渴，这个定义叫做温病，温病是来自冬天的寒。在冬天的时候你受到寒，当时寒隐伏在肌肉里面，没有发出来。到了春天的时候是阳气生发的时候，结果阳气一生发，身体就察觉到有寒在里面，这是一发出来就看到温病的症状。

如果我们用二十四个节气来计算的话，从霜降，霜降是农历九月份中旬以后还是进入寒，进入伤寒。到隔年夏至之前，从霜降以后进入冬天开始冷，得到了伤寒，隔年到春天到夏至以前，发出来的热病，热症，就是叫做温病，在夏至以后就看不到温病了。夏至以后就是暑热，热症还有湿热，这两种。就不是温病了，我们是以节气来看它。

按照节气的正气走，春天是温暖的，夏天是热的，秋天是凉的，冬天是寒的，节气的气候改变，你不适应生到的病就是一般的病，如果说节气不对得到的病，就是所谓的疫病。

当你太阳症出现的时候，三个：一个是中风，一个是伤寒，还有一个就是温病。三个各有三个的处方，都不一样。

第七条。

原文：若自汗出，身灼热者，名曰风温。

当你看到这个病人汗流不止，摸他身体是烫的，这个叫做风温。有的时候这个风温是来自医师，医师开发表的药，我们所谓发表的药就是发汗的药，开的太重，结果病人汗流不止。当个医生要能收能放，汗流不止有汗流不止的处理方式，赶快换别的方子。慌乱了，或病人不晓得汗流不止是不对的，

1——3

回到家里面去也没有再回来问医生。一直汗出，也会造成这种风温的现象，所以有的时候是医师开发汗的药太过，有的时候是病情的转变。一般我们看到的风温，在国外的话没有什么发表的药，因为他们不懂中医。他也有风温的现象，为什么？他原来是伤寒，这个病人伤到寒，有的会自己回复的，在自己回复的过程期间，发温病。所以是在一种混合的想象，会看到风温的现象。我碰过那我就问题，问他之前的现象，他原来的确就是体痛节痛，后来流汗好了，他流汗的原因就是做工，运动出汗，运动出汗跟我们药汗是不太一样的。他运动出汗的时候，又得到感冒，就变成这种汗流不止的现象，就是风温，所以你病还在那边。

看第八条。这个风温呢，简单的讲就是病人在脱水的状态之下，水不断的流失，津液不断的流失，会有这种现象。

这个风温为病，如果是阴阳脉俱浮，汗自出。

原文：风温为病，脉阴阳俱浮，自汗出，身重，多眠睡，息必鼾，言语难出。若发汗者，小便不利，若被下者，直视，失溲；若被火者，微发黄色，剧则如惊痫，时瘈瘲；若火蒸之，一逆尚引日，再逆促命期。

这个风温本省已经在流失津液了，津液就不够了，身上的水分不断的流失，遇到这种状况之下我们有处方。结果病人出现身重，多睡眠的现象，我们就知道病人脱水脱的很多。我们人身上的血里面有非常多的水，如果血没有水在里面的话，血不会循环。如果水跑掉，病人失水的时候，当然讲话没有力量，因为舌头讲话靠我们血的力量，血液循环不好。讲话讲不出来。睡觉打鼾呼吸非常的重，因为肺里面的津液不够了，这些都是津液不足的现象，身重也是。因为脾主四肢主肌肉，身重的现象都是脾脏，还有脾统血，血里面的水分不够了，都会有产生这种身重的现象。

若发汗者，小便不利，你如果说医生看到病人说他有汗，误解，你不晓得他是风温。他有汗，那是太阳中风，开桂枝汤下去，一开，他本来已经汗流失很多了，再一开，你再发发汗，小便不利，因为是汗尿是同源。诸位在夏天的时候，如果运动流汗很多，小便量就会比较少，而且比较黄比较深，就因为你了解他是风温，又开了发汗的药给他，造成小便不利。

如果这个病人遇到医生“被下者”，用攻下的药。我们津液不够，我们人身上的津液，血里面的水分都来自吃的食物，我们吃的食物里面有很多的水，不管青菜、米，都有水分在里面，我们平常喝进去的水，到了胃，胃很热就气化掉了，



但是你如果吃的是食物，这里面的水到小肠里面气化出来，这个水才会进入我们的血液循环系统里面。我们中医为什么不赞成验血，因为你验血光是验血，你没有去验水，西医认为水没有问题了，他不去验，他就验血。那你水的量多和少会影响到血的指数，所以不是很准，所以不要以它做标准。所以我们处方的时候，我们不能看验血报告。现在外面很多的中医，看了验血报告，什么胆固醇很高开什么药，这是不对的，中医并不是这样看病的。

如果说病人已经在脱水了，这个时候医生不知道，医生一看他大便不好，又去攻它，一攻的时候，小肠大肠里面的食物被你攻出来，水的源头又没了。病人很惨了，“直视”，“失溲”这个失溲不是说没有小便了，而是小便失禁，控制不住了，就是在那边滴漏而已，“直视”眼睛都直视了，眼睛都不会转动了，为什么，因为源头没了，津液丧失很严重。津液丧失很严重的时候，我们到最后一层就是厥阴，就是肝脏，肝藏血，很多血藏在里面，血里面的水没了，因为表汗流掉了，大便也没有了，小肠里面的食物里面的水源头也没了，这时候树好像变成干枯的树木一样，眼睛直视的。这个是医师误诊。

还有如果“被火者”，就是过去大陆北方，因为天气冷，都睡在炕上面，炕上面很热，那病人不知道，靠在炕上去睡，靠在火那边去睡，身体会发黄色，那你看到黄色的时候千万不要误诊。我们看到病人发黄的时候，有的时候是肝胆的黄，有的时候他是贫血的黄，是血不够的黄，所以如果说血里面的水被排掉了以后，我们隔着皮层可以看到血的正色，隔皮层看到血的颜色就是黄色。都是失水。如果是严重的容易受到惊吓。“时瘈瘲”，瘈瘲是抽筋，常常会抽筋，如果这个时候，再靠近火熏之，已经丧失津液了，我们这时要把病移开来，如果不知道，还是继续靠近他，你本身已经在流失水分了，再靠近火，再去烘培他的话，等于是想尽办法把水排掉，这个时候病人就会很危险。

#### 第九条。

原文：病有发热恶寒者，发于阳也。无热恶寒者，发于阴也。发于阳者七日愈。发于阴者六日愈。以阳数七，阴数六故也。

为什么是这样子，实际上一样的数目，为什么？因为发于阳，病是发于白天，发于阴，发于晚上，实际上都是十足的六天。只是一个发生在白天，跳过去变成七天，实际上都是六天，这是病的演发的过程，没有治疗。那如果说我们经方治疗，应该吃下去当天就好，就是第二天就好。为什么第二天，因为中午，如果你是在中午以前喝的经方，早上就吃的经方，中午以前就会好。那你如果说下午呢，才开始喝的药，同样是对症，当天不会好，要第二天中午才会好。中午从巳时开始到午时到未时，这是阴气开始盛的时候，中午会好是因为我们有药在里头，药吃下去，阴阳平衡就回复正常了。后面有条辨会专门讲，到时候我们再解释。所以实际上看起来是阴数六，阳数七，实际上这个七跟六是因为白天跟晚上。算起来还是足六天。

#### 第十条。

原文：太阳病，头痛，至七日以上自愈者，以行其经尽故也。若欲作再经者，针足阳明，使经不传则愈。

为什么太阳病到七天以前自己会好，因为“其经尽故也”。“欲作再经者，

针足阳明，使经不传则愈。”这个条辨就解答了我刚刚说的，太阳如果是与中风、伤寒、温病都没有关系，当他传经的时候，会先进入阳明。我们知道他会进入阳明，我们问病人你感冒几天了，我六天了，赶快先针灸阳明，为什么怕他病会进入阳明经，针足阳明的话，足阳明那么多穴道你针哪一个？足阳明的本穴，足三里穴，这个是我们让他经不再传，那一定要等到六天，你不要说今天得到足太阳病，当天你就把他扎到足三里，不需要。六天看他还没有好再去扎。

第十一条。

原文：太阳病，欲解时，从巳至未上。

太阳病要好的时候，从巳时到未时。巳时开始是厥阴，少阴，还有太阴。当六气在运行的时候，一日的六气在运行的时候，厥阴，少阴，太阴这是顺。所以当你在中午了以后，阴之尽，阳开始要回头的时候，你胃口回复，胃口回复就是阳气要回头，这是一个绝对的证据代表说感冒好了。

所以我们处方开给病人吃的时候，如果说早上八点病人来，一看伤寒，处方开给他，中午胃口就好了，你中午好了，下午的汤药就不要喝了。那如果说没有好呢，可能是汤药力量不够，或者是这个人一边喝汤药一边和他先生在吵架诸如此类的，结果没好，再喝第二碗。到隔天中午，一定要跟病人交代，一定要中午的时候胃口恢复，这个是代表病好了。

我们分阳病跟温病。所有的阳病恢复的时候都是在中午。阴病恢复的时候都是在半夜。所以我们在治疗肝病的时候，我们希望病人跟我们说昨天晚上半夜起来饿死了，这是救回来了。所以我们会常常问病人你晚上会不会起来吃东西，没有，还不行，还不到再加重，这都是我们依循的标准。所以只要脏有病的时候都是半夜胃气恢复。腑有病，就是消化系统有病的时候，都是中午的时候胃气会恢复。

张仲景对这个太阳症，表症很在乎，所以在太阳篇的时候就介绍了很多，为什么介绍了很多，很详细，就是因为希望我们当医生的，在病人病在表的时候就解决掉了，根本还不到里就去掉了，如果全世界医生都能这样子的话，那西药厂就完蛋了。

原文：中风表解而不了了者，十二日愈。

中风，如果表解了，不会在恶风了，也不会再流汗了，可是还有一点点不了，一点点不舒服的症状，“十二天愈”，这个十二天就不是六乘十二天，就是十二天就会好。

第十三第十四我们并在一起，因为是相关的。

原文：病人身大热，反欲近衣者，热在皮肤，寒在骨髓也；身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。

为什么要知道这个，病人你摸他身上是滚烫的，结果他包着衣服很冷，我们就知道里寒。表面是热的，但里面是寒的，这个我们在处方的时候，就出现了，比如这个寒在骨髓，这是真寒。真寒假热，热是假的。这个“身大寒，反不欲近衣者，寒在皮肤，热在骨髓也。”这是真热，外面呈现的是假的现象。为什么要知道这个，分真假，如果你知道真寒假热，可以把假的删除掉，不要去管他，你

直接开去寒的药就可以了，他意思就在这里。

以后会遇到上热下寒，我们这样写就是告诉你去热和去寒药同时用。如果告诉你这个人是阴虚内热，为什么这样分辨，因为有阴有虚有热的药，目的是在这里面。只是张仲景在伤寒金匱里面从来不谈阴虚。阴虚都是温病派的医生。

张仲景伤寒论里只有这样区分：阴盛和阳亡。阳盛和阳亡。阴盛就是实，阳盛就是虚。张仲景只区分这个，他不分阴虚，所以伤寒金匱里看不到阴虚。

既然没有阴虚那就不要补药了，对，张仲景说不要用补药。治病的时候不用补药。所以整本伤寒论你去看他的时候，后面你会看到，张仲景小补的时候给你甘草，大补的时候给你加大枣、白芍。大补的时候给你加人参他就结束了，他的补阴的药就是这样子。他用的阳药很多，那我们需不需要补药，需要补药。什么时候可以吃补，正常的时候吃补药。健康的时候吃补药。中医得观念是没有病的时候把身体弄的很好，不要生病。有病的时候用治病的药。病好了以后才可以吃补药，在治病的中间不加补药下去。

#### 第十五条。

原文：太阳中风，阳浮而阴弱。阳浮者热自发；阴弱者汗自出。啬啬恶寒，淅淅恶风，翕翕发热，鼻鸣，干呕者，桂枝汤主之。

太阳有中风，太阳有伤寒，太阳有温病。现在讲太阳中风，太阳中风是阳浮而阴弱。寸脉是浮到的，阴脉你摸到很沉，很小，阳浮者热自发，阴弱者汗自出。啬啬恶寒，病人会有点断断续续的恶寒。淅淅恶风，风吹的很难过。翕翕发热，就是断断续续的有点微热。鼻子呼吸不是很正常，桂枝汤主之。

现在进入伤寒论第一个方，桂枝汤。

这个桂枝汤，还没有介绍汤剂之前。张仲景从伤寒到金匱，大概百分之六十的处方都是桂枝汤在做加减。经方家认为，桂枝汤是一个平衡调和，它能平衡调和阴阳的第一方。

伤寒金匱，会遇到三种，一种是汤剂，一种是散剂，还有一种是丸剂。

汤你过加个草字头，就是扫荡。所以汤取他的迅捷，速度很快。你如果把桂枝汤做成桂枝丸吃下去就不一样。桂枝丸吃下去等了半天不发汗，汤一下去发汗。煮汤的时候还有技巧。你和汤药的时候到底是喝他的气还是喝他的质。当你发表的时候，是不是要发散，所以你煮汤的时候大火去煮，从头到尾都是大火，你如果说大火的时候就是喝他的气。你如果是小火，开了以后小火慢慢煮，桂枝汤煮的很浓稠下来，你是喝他的质，不一样。当你治病的时候，迅捷，汤大火的煮。所以所有发表的药，你的目的要发表，所以用大火去煮。所以同样的方剂，煮的方法不对，效果就没那么好。当我们用攻里的药，我们要取它的质。他们目的不一样。所以我们要去扫荡五脏六腑的东西的时候，我们要用汤剂。通关活络，经络不通的时候，都可以用汤剂。阴阳不平衡的时候，我们也用汤剂。比如有人白天混混沉沉，晚上精神很好，就是阴阳不平衡。当重症，病邪很重，还有病人萎缩了，肌肉一直在收，一直在度，全身没有力量，我们都用汤剂去润泽他，皮肤不好了，我们都用汤剂都会好的很快。增益气血，我们都可以用汤剂。

如果是用散剂，都用在，你如果是四肢久病，这种我们都是用散剂，像风、

湿，这种痹症，风湿关节、表里游走，这个病有时候在表有时候在里，病居无常处，跑来跑去，我们都可以用散。

如果说丸剂，有时候必须要用丸剂。丸剂有时候最能破积聚，所谓硬块肿块。还有吃东西，有的人不进饮食，吃东西吃不下去，我们可以用丸剂慢慢去攻他。

什么时候用汤剂？什么时候用散剂？什么时候用丸剂？如果说迅捷，丸剂的话就变成药缓力专。丸剂的力量比较缓慢。药性比较缓但是力量非常专一。所以我们要集中去打一个点的时候，可能就会需要用丸剂。如果说全身扩散的时候，我们用丸剂就不行，我们要用汤剂才有办法，这是基本的大概一个概念。

比如说我们去打虫，打虫我们会用到乌梅丸，乌梅汤你喝都喝不下去。我们去攻虫的时候，我们用最苦的药，最辣的药，乌梅很酸，乌梅还要泡过醋，泡过两天再做成乌梅丸，这个汤又酸、又苦、又辣，你怎么喝，喝下去全身难过。我们只要它在肠胃里面，所以把它做成丸剂，能够直接攻一个定点的。

桂枝汤方：

桂枝三两去皮、芍药三两、甘草二两炙、生姜三两切、大枣十二枚劈。

右五味，咬咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身絜絜微似有汗者益佳。不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出，病差，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法。又不汗，服后小促其间，半日许，令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服。若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

炙，就是用蜂蜜炒过。你如果是真的这样子开这个两，这是汉朝的度量衡，你开到药房去，药房把你丢出来，我不怪药房，怪你自己，这是汉制的两。

1——4

伤寒论的计量，有一个人叫陆久之，他的外曾祖父姓王，叫王朴莊，这个人是嘉庆的时候，在当地很有名的名医。这个人度量衡他能研究出来。陆久之是很有名的经方家，陆久之和傅青主是同一朝的经方家，傅青主很有名，他是侠医。传说他武功很高，他弟子就是陈士铎，黄帝外经就是他弟子写的，所以在那个时候皇帝外经绝对有，这都是经方家，很厉害。他们当时就把度量衡考证出来了，根据他们的考证，汉制的八两就是今制的六钱。所以如果是桂枝三两的时候，差不多是二点三钱，就是你现在到中药行去抓二点三钱就是他的计量，你不要去写个二点三钱，那么斤斤计较。我心里知道是二点三钱，但我不会去开二点三钱，开三钱算了，为什么？因为后面还有煮的方法喝的方法。那如果是开二点三钱合于现代的。生姜三两，你如果真拿生姜三两下去，煮完都是生姜，病人喝下去好辣，他是生姜喝下去流汗的，不是桂枝芍药吃下去流汗的。生姜两片、三片够了，你不要开个三两吓死人。大枣十二枚劈，大枣为什么劈开，因为大枣外面有红皮把它包着，所以要劈开来。这个煮的时候，微火取三升，去滓。你看他用的微火，实际上都是大火。适寒温，服一升。就是煮完以后要稍微温的时候，一升就是一碗。一升以我们现在来说大概是五钱的量。那你如果喝桂枝汤，要喝稀饭来助药力。在神农本草经的时候，桂枝是阳药，白芍是阴药。桂枝辛辣，味道是甘，所以辛甘发散，辣椒也是辛辣的，但辣椒没有甘味，桂枝有甘味。辛甘发散为阳。

白芍按照本草，白芍你拿起来一闻就是酸的味道，白芍是酸苦，苦味，白芍是苦，涌泄。按照神农本草，酸苦涌泄为阴。所以桂枝是阳药，白芍是阴药，这是肯定的，那桂枝白芍是等量的，我们如果把它放到人体上去的时候。心脏管的是动脉跟静脉，动脉是阳，静脉是阴。静脉跟动脉是一样等长，所以说我们阴阳要平衡，桂枝和白芍的计量是一样的。当阳虚的时候，我们会把桂枝加重，如果阴虚的时候，不足的时候，我们会把白芍加重。张仲景就是这样子，就来调和阴阳，所以有的时候要加桂枝，有的时候要多用白芍，比如建中汤就是用白芍，有时候要加桂枝。光是这个桂枝汤，我们从这个调和阴阳的方子里面，我们稍微加减一下，就可以对付不一样的时机，不一样的症状来使用，目的只是让他阴阳调和，阴阳一调和就回到常态，常态就是健康正常的人。当个医生你只要知道阴阳，就可以做很好的医生。你知道阴阳除了诊断以外，同时药剂上面能够把阴阳调和回来，药物上使用。如果说我们不开其他的药，光是开桂枝白芍两味药，六碗水煮两碗吃，病人马上一下大汗，因为一个阳药一个阴药很强，马上就流汗流掉，三天以后病人打电话给你，感冒好了，也不发热，也不流汗，也没有了，可是我三天都没有大便，为什么，因为你这个桂枝白芍一下去以后，发表的力量很强，动脉血管循环速度很快，一循环速度很快的时候把表邪都去掉了，中风的症状去掉了，去掉同时津液伤到，肠胃的津液没有了，那我们人身上的汗水都是来自肠胃，吃饭吃的很快，喝汤喝的很快就开始流汗。所以为什么要放甘草生姜红枣，这个红枣你去煮它，拿起来就是胃液，粘哒哒的跟胃液没什么两样，它是红黄，里面是黄的肉，黄是土，外面是红的，是火生土。所以我们后面有朱雀汤，就是十枣汤，我们攻坚的时候把肺里面的水排掉的时候，我们开十枣汤下去的时候会用红枣，为什么会用红枣，因为你那个甘遂、芫花、大戟，一下去胃液就没了，那我们用红枣去补它。所以我们在攻的同时也要把它补回来。这样攻邪不伤正气。不然病好了病人也死掉了。生姜，我们以后会有干姜和生姜。生姜也是辛味的，辛辣发散，这里是生姜不是干姜，能够刺激胃，甘草除了和解，实际上甘草能够解毒，因为我们在治病的时候，我们同时要考虑到这个病人肠胃里面可能有宿食在里面，有的食物可能坏死掉了，现在人又生病，里面的食物又坏死掉，坏死掉产生毒素，对病人是负担，本草里面说甘草解百毒，解什么百毒，就是食物的毒，所以我们化解食物的毒都是用甘草。所以甘草炙过以后，除了本身的甘草能够预防肠胃里面发炎以外，同时甘草炙过以后会加强心脏的力量，所以张仲景用炙甘草和用生甘草方向不一样，当用生甘草的时候那只是对肠胃，用炙甘草的时候一定是对心脏，一定是要对心脏，所以张仲景在处方里，后面会有炙甘草汤等，张仲景在治疗感冒的时候，这个桂枝汤，桂枝汤当然不是张仲景的方子，是经方历代传下来的，为什么炙甘草炙过，就是强心脏，所以我们在治病的同时又在固肠胃，又在预防他当时肚子里面食物坏死影响到他，又怕他肠胃津液没有，津液伤到同时又要感冒去掉，顾虑那么多的状况之下，还要顾虑心脏不要受伤，因为我们只要维持到心脏很好的时候，这个人不会有其他的病变，所以心脏很好的人长寿。

所以这个方子拿到以后，不管他是什么病，比如说一个病人肠胃炎，说胃很少痛，但是我常常没事就流汗，风吹到很难过，什么肠胃，就是太阳中风，桂枝汤下去就好了，肠胃也好了，来的人感冒，还是桂枝汤给他。不同的病同样的药这就是中医，所以中医是辩证论治，所以当你讲的时候，说中风的时候，是把它当成症状，中风这两个字就可以涵盖项强、发热、恶风、有汗。伤寒比如说体痛、恶寒，体痛节痛、无汗、发热，所以伤寒就代表了这几个字。就好像我讲的桂枝汤，你不要拿个桂枝泡汤啊，桂枝汤五味药。一个桂枝汤就代表五种中药的组合。

当你有这个概念以后，吃完桂枝汤以后为什么要喝点稀饭，稀饭是土，因为来自五谷，谷类，我们所有长寿的人，最喜欢吃稀饭，然后还喜欢吃红番薯，番薯稀饭。因为番薯本身就是土，土入脾胃，再加上这个米饭，煮稀饭，帮助它药力来发散。为什么要吃稀饭就是肠胃的津液药有，有热下去帮助它发汗，如果说流汗，最好的流汗是一点点微汗，觉得身上有流汗，你摸湿湿的又感觉好像没有汗，这是最好的汗。这个汗意思是说，感冒病毒排出来了，津液没有伤到，这是最厉害最标准。如果说喝完桂枝汤大汗淋漓，太过了，太过的时候病不会除掉。如果喝掉以后病好了，药停掉。不要太过了。太过了，汗流太多，你身体津液伤到了。如果不及，不及的话喝了半天没好，“半日许，令三服尽”如果没有好，两三个小时之后再喝第二碗，再让他发汗，再喝稀饭还是没有发汗，再喝，一天把它喝完，半天就是十二个小时，可以吃三次，“令三服”，那你可以省点，我把这个药九碗水煮成三碗，大火去煮，你开计量多一点，这是一个标准的方。你看这个人是一百公斤的体格，那个人才四十几公斤的体格，同样的计量，你不会这样子开，体格大的开重点，比如一百公斤的人，我开两点五钱，来个瘦子，我开桂枝两钱，一钱就可以。小孩子桂枝开半钱。如果爸爸小孩都得到，你就开爸爸就可以了，然后剩一小口给小孩子喝。方子应用要存乎于行，不要死板板的，所以中医不能那么龟毛。“若病重者，一日一夜服，周时观之，服一剂尽，病证犹在者，更作服。”意思就是还没有好的话要继续吃。你要告诉病人，交代清楚，流汗出来觉得很舒服的时候就可以睡了，但是流汗不可以当风，不可以靠火。一定要等到胃口恢复，所谓胃口恢复就是隔天以后胃口开了，吃东西不会再流汗了，也不恶风了，这才是标准，才是正常。

有的时候张仲景把白芍拿掉，我们在遇到重症的时候，基本处方都是来自桂枝汤。这是我现在给你的一个基本概念。

#### 第十六条。

原文：太阳病，头痛，发热，汗出，恶风，桂枝汤主之。

只要是太阳中风的一定有汗出，这是主要的症状，就是汗出和恶风。伤寒的化就没有汗了。头痛，有的时候头痛，有的时候没有头痛，你都可以用桂枝汤。

#### 第十七条。

原文：太阳病，项背强几几，及汗出，恶风者，桂枝加葛根汤主之。

我们知道汗出恶风是桂枝汤，但是这个人又项背强几几，很强的项强，很硬，这时桂枝加葛根，汤主之。葛根汤有葛根汤的处方。而是桂枝汤里面多加了一味药葛根。

葛根按照神农本草经，葛根长得样子，葛根没有主杆，它是软的，所以它必须攀附在别的主杆上面才能生长上去别的主杆就一根那么长，它绕了好几圈，长好几倍，地下面有水，它还可以把水吸上去，最顶上的嫩芽上面，吸水力量很强，这就是我们为什么要取用葛根的原因，所以葛根的性，药性它能够升提，在神农本草经，它还能化脓，去臃肿，化脓。所以它除了生成津液，把水升上来以外，还有化脓，都可以。那你太阳项强的时候，你桂枝汤下去的时候还没有办法把那个水代谢掉，桂枝汤里面加一味药葛根，葛根能够把新的水提上去，把旧的水排出来。旧的水打掉的时候是靠的桂枝汤。这是为什么加葛根。剂量上很重要，你

如果是用到葛根的话，桂枝，白芍，比如说桂枝三钱，白芍三钱，葛根用到五钱六钱，葛根的剂量一定要高于桂枝白芍的剂量。这是一个大原则。

第十七条。太阳病，项背强几几，及汗出，恶风者，我们介绍了桂枝加葛根汤主之。这个处方在治疗面部中风的时候真的是一剂知，二剂已。很快，脸中风。脸对着冷气吹，或者是没注意到，开车打来来一直吹，脸歪掉。脸部中风的时候这个处方非常好，因为葛根这个药非常好用，葛根还能治疗痺，就是说麻木，肌肉麻木，因为葛根的药性是往上升，所以你脚麻，你开葛根你吃不到，因为它是往上走，药性是往上走。脸麻，没有办法控制了，很好。还有发痲，比如说你化脓了，都可以用葛根来发。

### 桂枝加葛根汤方

桂枝三两去皮，芍药三两，生姜三两切，甘草二两炙，大枣十二枚劈，葛根四两。

右六味，以水七升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，不须啜粥，余如「桂枝汤」将息，及禁忌法。

实际上真正处方的时候，我们都是凭经验。我们知道是二钱，我常常开桂枝开到五钱，为什么？我看他体格大小。因为一次开五钱都没有关系，因为病人喝下去他不是一次喝完，他分三次，一次才一钱多，喝下去没有改善才去喝第二碗。这里葛根就比桂枝剂量来的高，这是重点。你如果是要加重，开到五钱六钱都没有关系。这里的剂量只是一个标准的剂量，你煮的时候用七碗水煮成三碗，然后喝一碗，这个处方它不需要啜粥，因为病人已经有汗出了，恶风，你最主要是治疗他项背强，所以你是希望是脑后面出汗就够了，你不需要喝稀饭来助全身出汗，只要脑后面一个部位流汗就可以了。这个啜粥和喝粥不太一样。你慢慢一点点饮下去的时候肠胃的力量更大。会帮助发汗，这个桂枝汤里面加了葛根，最重要就是头部的肌肉麻痹，统统可以用。我用的最多的就是面部中风。你如果说开的剂量不够，比如说你开的葛根量比桂枝少的时候，到不了面部上面，一定要葛根的量要高于桂枝，为了把皮肤的麻痹的现象去掉，煮的时候快煮，你不要小火慢慢去煮，快煮，发散的力量最强。快煮的时候你吃到的是药的气，不是药的质。

### 1——5

基础方有了，你再去增加一些东西上去。比如说我们脸上青春痘很多。桂枝汤可以到脸上去，痘子跟葛根没有关系，葛根是去风痺，葛根可以去脓。中医来说，化脓的话一定有湿跟有热，那你说只去热不能去湿，所以中医在治疗炎症的时候除了去热，还会去湿，所以中药很多去湿的药，合并在一起就可以把炎症去掉。

去热，比如说黄连，去湿比如白术，药性你也可以看到。比如说中药行里，药粉过一下就硬块，本来是粉，结果盖子没有拴紧，隔两天一看硬邦邦的一块儿，那个药把空气里湿吸收起来，整个硬起来，去湿的药都有这个性。

### 第十八条。

原文：太阳病，下之后，其气上冲者，可与桂枝汤，用前法；若不上冲者，不可与之。

这是什么意思？这里面有一个经方的大原则在里面：有表症及里症时，应先解表再攻里。经方的力量比较强，比较峻，张仲景的意思要速效，当场就要让他好，所以一定要有些大原则。当病人有辩证的时候，表症就是伤风感冒，脉是浮的，不管是太阳中风伤寒，同时他有里症，什么叫里症，比如说便秘。他有便秘同时又太阳中风伤寒，大原则是应该先解表，再攻里。这是原则，也就是说你先去把汗发掉，再去攻里下。但是原则归原则，有例外。你如果是这个人一个礼拜没有大便秘了，你还在发表，再攻里。一个礼拜没大便秘了，攻表跟攻里的药要同时开在一起。

有的医生不知道，病人有太阳症表症在，结果他攻下，一攻下了以后，有逆症如果攻下了以后，不该攻下你攻下，因为病人有表症，这个时候怎么处理，后面有处理的方式。

第十八条就是，攻下了以后，结果气往上冲，感觉气还是往回流，代表说表症还在那边，你还是可以继续用桂枝汤。代表说攻下了，虽然你的动作是错了，但是并没有把病情变坏，还是可以使用桂枝汤，有气上冲的，原因是什么？人体是个圆形，比如说肠胃里面有食物在里面，本来我们应该要发表，结果你攻下，一攻下食物往下走，力量是向下的，皮表上的邪会内陷下来。内陷下来，可是它攻下力量并不是很强，内陷下来我们又把它推出去，它还是在表症上，一推出去病人会感觉气往上冲，气往上冲代表你攻下并没有让病坏事，所以还是可以继续用。如果并没有上冲，就不可以再用桂枝汤发表，就要看当时发展到什么状况，来决定怎么使用，用什么处方。后面会有很多条辨，我们如果误诊了如何去弥补。

第十九条。

原文：太阳病三日，已发汗，若吐，若下，若温针，仍不解者，此为坏病，桂枝不中与也。视其脉证，知犯何逆，随证治之。

经方在治病的时候有三个大原则，叫汗、吐、下。汗法当病在表的时候我们使用汗法。比如说恶风，恶寒，脉浮，发烧，这种都是病在表，就是病在皮肤表面上面，我们用汗法。吐法，病在上膈，比如说食物吃坏，或者是肺里面痰很多，或者是胸腔里面，鼻粘膜很多，我们要把它清掉，要用吐法。下发，就是堵在下焦，比如说我们用承气汤攻它。这是治症一般的原则。

那你都用了以后，病人还是有问题，“此为坏病”，是说这是很严重的问题，里面有别的问题在里面。“桂枝不中与也”这个时候我们要看他的症状来治。

伤寒讲的是六经辨证，介绍完以后要介绍金匱。金匱是杂病，什么病都有。所以我们一定要先了解伤寒论的原则，介绍金匱的时候就很简单了。

中医是不管里面是什么病，当我们看到病人有太阳症的时候，处方下去，明明处方是对的，但是病人病没有恢复的时候，我们知道他有其他的问题存在。这个条辨就是这个意思。

第二十条。

原文：桂枝汤本为解肌，若其人脉浮紧，发热，汗不出者，不可与之也。当须识此，勿令误也。

桂枝汤本来的目的是解肌，因为桂枝汤吃下去以后是在肌肉上面。“若其然



脉浮紧，发热，汗不出者，不可与也。”这个并不是桂枝汤症，第二十条就是说不是桂枝汤症者你不要用桂枝汤。有桂枝汤使用的一定病人有汗，发热，脉浮缓，而不是紧。像这种“脉浮紧，发热，汗不出者”这种都是麻黄汤症，跟桂枝汤完全是两回事。

张仲景认为如果是表寒，表面是伤寒症，你本来应该用麻黄汤，结果病人有便秘，结果你攻下了以后，造成下痢不止。有的时候并不是医生攻下造成的下痢不止，比如今天他是麻黄汤症，结果他正在吃饭吃到坏的食物，坏的食物又吐又下，刚好病人有表症，表邪就下陷掉了。

## 第二十一条

原文：若酒客病，不可与桂枝汤，得汤则呕，以酒客不喜甘故也。

酒客就是很喜欢喝酒，酒鬼的人长期喝酒伤到胃。这个时候吃桂枝汤，桂枝会伤到胃。在黄帝内经里有个处方，苍术和泽泻，苍术和泽泻合并在一起就是解酒的很好的一个处方。因为苍术去湿，泽泻利尿，利水。如果说有酒客病，解酒的药加进去，可不可以和桂枝汤一起用，还是不行。因为他酒客病，他本来就已经被酒伤到，有喜欢喝酒的人最好不要使用桂枝，吃了胃会比较难过。张仲景说因为酒客不喜甘，这个甘指的是桂枝还不是甘草。

## 第二十二条。

原文：若喘家作，桂枝汤加厚朴、杏子仁。

这个处方用的时机非常多。本来他是桂枝汤症，你听他说流汗，恶风，还有咳嗽，只要是桂枝汤症，太阳中风的症状，加上有咳嗽，你就可以使用它，或者是气喘。

有一种气喘平常都不发，不严重。感冒的时候，别人都在咳嗽，他就在喘，这种都是桂枝汤。加厚朴杏仁。

厚朴能降气，能宽肠。杏仁能滋润肺的津液。因为厚朴能够将气，再加上杏仁能够滋润肺的津液，所以哮喘对他很有帮助。这种一定是有桂枝汤症，再加上厚朴杏仁。如果没有桂枝汤症，喘家那处方就不一样了。所以以桂枝汤为主。简单说就是本身有桂枝汤症再加上咳嗽、气喘，就可以使用。

## 第二十三条。

原文：凡吐家，服桂枝汤，其后必吐脓血也。

什么是吐家，就本身他就呕吐恶心的，常常胃不好，吃东西就会吐。所以我们给病人开桂枝汤的时候我们有几种禁忌，这就是禁忌，酒客、喘家、吐家，就不可以使用桂枝汤。

你如果使用桂枝汤，他本身就是吐家，常常呕吐了，吃了桂枝汤以后，因为桂枝是辛香发散的力量很强，这时候胃里面的血管会破裂掉，胃出血，病人会吐脓血出来。

病在太阳，不管是太阳伤寒，太阳中风，太阳温病，没有吐的，太阳症没有吐的。只有到少阳症才会吐。所以有吐症出现就不是太阳症，太阳证是在表，表

症。

条辨第二十四条。

原文：太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。

这是经方里面，一个弥补的措施。就是当你看到病人是太阳症，那你一开处方，病人喝下去太过，流汗流出来不停，当流汗不止的时候，恶风现象还是有你，小便难，为什么？因为汗尿是同源，汗流出来很多，小便自然会变少。四肢微急，为什么？因为你肌肉里面的津液丧失掉，发汗发太多丧失掉了。这个时候我们怎么样去弥补他，就是桂枝汤加一味炮附子下去，就可以弥补他。

桂枝加附子汤方

桂枝三两；芍药三两；甘草二两炙；生姜三两；大枣十二枚；附子一枚，炮，去皮破八片。

右六味，以水六升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。若一服汗止，停后服。

在经方里面，很多地方，张仲景有时候指定用炮附子，有时候指定用生附子。这里是炮附子，炮制过之后，一个是毒性很小，所有草药类的东西，你只要加热，一加热毒就小很多了。生用毒最强。炮制过以后，附子就没什么毒了。

一枚的附子大概三钱左右。生附子，里面津液很多的，同样是一枚，那个至少是五钱。炮制过水没了，比较轻。

这个炮附子是用在固表。因为你汗流太多了，表虚，表不固的时候我们固表用的。以此类推，如果遇到一个病人，脱水，流汗，津液一直在丧失，这就是我们需要用炮附子的时候。但是你开处方单味一个炮附子下去没有用，桂枝汤是解肌的，让皮阳振奋起来，这个时候你加上炮附子在里面的时候，它会到皮肤、四肢上去把它固起来。炮附子和别的药混在一起，处方不一样，它的药性就不一样。这里完全是收表用的。

这个处方，六碗水煮成三碗。先吃一碗，汗停掉以后就不要再吃了。如果汗停了，剩下的药舍不得吃了，表太固汗流不出来也不行了。有汗我们也是有必要有汗，运动你就会有汗，静止下来就没有汗，这是正常。你不能很剧烈的运动一点汗都没出，那也不对。那个毛孔闭锁。我们在开处方的时候常常会开一些麻黄汤，一些发表的药，开下去病人不出汗的，小便排出来。每个人体质不太一样，遇到那种特殊的体质，你要问他。

第二十五条。

原文：太阳病，下之后，脉促，胸满者，桂枝去芍药汤主之。若微恶寒者，桂枝去芍药方中加附子汤主之。

他有时候把芍药拿掉，有时候把附子加进去，同样桂枝汤在应变，这个处方我们可以看出几件事情，第一个胸满，所有经方，从伤寒到金匱，只要有胸满出现的时候，张仲景就不用白芍。所以我们知道心脏病是不用白芍的。祛痰也不用白芍。因为白芍是酸苦，白芍味酸，酸苦涌泄为阴。如果我们把阴当成静脉，

桂枝是动脉的时候，你把白芍拿掉，血流回心脏的速度就会减缓下来，就会让心脏得到喘息。

所以胸满者，胸满的人一律不用白芍。胸满的定义很广，包括你气呼不过来，你胸口心脏满，胸口痛，刺痛统统叫胸满，不用白芍。后面会介绍到只要有腹痛，小腹痛，白芍都要重用。胸满的时候一律不用白芍。

“微恶寒者，桂枝去芍药方中加附子。”因为你太阳病已经攻下了，脉促，胸满者，微恶寒者。里面恶寒就是里虚掉，因为你攻下，攻下了以后如果病人里虚掉，这个时候我没加附子下去，把里面的阳温回来。

#### 桂枝去芍药汤方

桂枝三两，甘草二两炙，大枣十二枚，生姜三两。

右四味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。

#### 桂枝去芍药加附子汤方

桂枝三两，生姜三两，甘草二两炙，大枣十二枚，附子一枚炮，去皮破八片。

右五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。若一服恶寒止，停后服。

一服恶寒止，就不要再服了。我常会问病人怕不怕冷，因为发表药开多了，表虚了也会冷，病人会有微恶寒。

处方说微恶寒和极恶寒不一样，病人会稍微感到怕冷点代表表虚掉了。一般来说，如果是遇到温病的，表虚了，我们开黄芪，黄芪固表，经方，黄芪太慢了，炮附子一下去收表。

#### 第二十六条。

原文：太阳病，得之八九日，如疟状，发热，恶寒，热多，寒少，其人不呕，清便欲自可，一日二三度发。脉微缓者，为欲愈也；脉微而恶寒者，此阴阳俱虚，不可更发汗，更下，更吐也；面色反有热色者，未欲解也，以其不能得小汗出，身必痒，宜桂枝麻黄各半汤。

如果遇到这种情形，“脉微缓者”代表阳气恢复了，胃气恢复了。这个时候病人要痊愈了，你不要去治疗他。

我们当有寒热出现的时候，桂枝麻黄各半汤。桂枝最主要是发热，麻黄是遏寒，这个很好区分，你问病人，你忽冷忽热的现象，往来寒热，这个往来寒热一天两三次，你问他是热多还是寒的时间比较长，病人说相等，差不多，这就是桂枝麻黄各半汤。如果说往来寒热加恶心，根本病就不在太阳，太阳的方子不适用，这个时候就已经进入少阳了，就不是太阳症了，太阳证也有忽冷忽热的现象，但是跟少阳症区分的地方就是恶心。如果病人忽冷忽热，但是没有恶心，一律在太阳症里面处理。桂枝麻黄各半汤就是，桂枝一半，麻黄用一半，两个处方混在一起。

这里还有一个重点，“身必痒”，因为它不得小汗出。比如吸管放水里面去，手按到吸管的头拿起来，水在吸管里面，如果手松开水就出来了。中药为什么要用发表，一发表，毛孔一开开，小便就出来了，所以我们很多的利尿剂，排不出来的时候我们用发汗的方法。你要去发汗一定药性热才发汗，药如果不热，汗怎么出的来，那药有层次上的热，比如我们用的最热的药，比如硫磺很热很热的药，其实硫磺没有毒，其实硫磺是很热，吃下去很热。所以过去我们用硫磺消水肿速度很快，病人水肿很厉害，一剂下去整个水肿消掉了。中热的药，温性的药，像麻黄辛甘温性的药。吃下去以后，麻黄桂枝各半汤，我们发一点表汗，得小汗。小汗一出来以后，小便就排出来了。这是我们用这个处方，主要依据就是身必痒。汗发下去的时候，汗没有办法透发出来的时候，汗已经到了皮肤表面，但是没有办法离开皮肤表面，停在皮肤下面的时候，这个时候皮肤就会痒。没有皮肤病，皮肤就会痒，这就是汗没有透发，这时桂枝麻黄各半汤，发一点汗就好了。

### 桂枝麻黄各半汤方

桂枝一两十六铢，芍药一两，生姜一两，甘草一两，麻黄一两去节，大枣四枚，杏仁二十四个汤浸，去皮尖。

右七味，以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取一升八合，去滓，温服六合。

麻黄为什么去节，麻黄长得像竹子，一节一节的。我们采麻黄把节都去掉，因为这个节是止汗。麻黄的身，才是发汗。最主要的桂枝麻黄量是相等的。

如果把麻黄、桂枝、甘草、杏仁放到一起的时候是后面我们要介绍到的麻黄汤。桂枝、白芍、生姜、甘草、红枣这是我们的桂枝汤。所以桂枝麻黄各半汤就是桂枝汤里面加上麻黄跟杏仁，就已经是桂枝麻黄各半汤。所谓各半就是麻黄跟桂枝的剂量相等。这个水为什么要先去煮麻黄，煮一下。可能张仲景当年就发现了安非他命了，麻黄先煮一下把上面沫去掉，泡沫要去掉，这个很毒，人吃了会很亢奋。去掉以后再把其他药放进去煮。所以麻黄一般来说，张仲景在用的时候一定先煮麻黄，煮过以后，去掉上面药沫，再把其他的药放进去煮。一升八合就是十八合，温服六合，就是分成三碗来喝。我最常用的就是九碗煮成三碗。三碗的时候有个好处在哪里？你九碗下去煮的时候，一次把它煮完，花多点时间煮药力比较强在里面。我们习惯留三碗下来，先喝一碗。治内科病的时候，我们早上一碗，晚上一碗，另外一碗隔天再喝。如果说治表症，我们发汗的时候，三小时一碗，吃一碗没发汗，三小时再吃第二碗，吃第二碗还有发汗再吃第三碗。一般来说严重的话第二碗就发汗了。剂量你开的时候太轻了，他喝了一点汗没有，你再加重上去。一般来说我是不客气的，因为我知道流汗流太多，加点炮附子就把你救回来了。桂枝白芍五钱，五钱煮成三碗的话，一碗不过是一钱多。喝一碗流汗了，第二碗就不用喝了，从来没有说喝出事。

至于刚刚的酒客病，我们可以加一些药在里面，保护胃，即使你桂枝下去都不会造成胃吐血的现象，还有吐家的，也不会。

这个条辨，桂枝麻黄各半汤，我们的到一个心得，就是这个汗，非常重要。我们在治病上面，比如说我们治肾脏病，肾脏病，中医肾是水，肝是木，心是火，当我们治疗肾水的时候，我们一定会治疗心火，再治疗肺金，然后肾的功能就会慢慢恢复，这是我们治症，张仲景说肝有病我们先去治脾，肝的功能就会恢复，

以此类推，治肾脏先去治心脏，再去治肺脏，肾的功能就会回来。我们身上的汗是心之液，当心脏功能很好的时候，我们可以从病人排汗的正常与否，来决定心脏功能好不好。所以肾脏有问题的时候，你问病人流不流汗，，不流汗，运动，天气再热就是不出汗，代笔他心脏功能没有恢复。正常人运动之后一定会流汗。我们治症的时候，心脏功能一恢复，病人都是在流汗。一运动就流汗，流完汗很舒服，汗流越多，水肿消的越多，小便越来越多，就会恢复正常。这个地方就是取汗的方法，桂枝麻黄并用在一起，流汗。

## 第二十七个条辨：

原文：「太阳病」，初服「桂枝汤」，反烦不解者，先刺「风池」、「风府」，却与「桂枝汤」则愈。

你给他桂枝汤下去，结果他病没有完全好。病人烦躁，桂枝汤症还在那边，这个时候用针刺他的风池，风府，回头再给桂枝汤，他就好了。

为什么会这样子，针灸可以通关活络。每个人都不一样，只是太阳证特殊的情形，一般来说我能吃桂枝汤就解掉了。病人吃桂枝汤烦躁不解，也不是说药力不够，而是病人还有其他的问题在里面，那你脖子是受风寒最严重的地方，汗水很多，身上有汗，但是还是没有完全好，这个时候我们知道寒水是停在风池风府，这个就是风进来的地方，我们下真了以后，脖子这个部位就会完全恢复，这个条辨讲的就是说其他身体的症状都好了，但是还是有一点点没有完全去除掉，这个时候我们去真他的风池风府，这个条辨告诉你，风池和风府就是当初受风的地方。太阳中风的地方，所以诸位，风很大的时候，脖子要遮好。

## 二十八条。

原文：服桂枝汤，不汗出，脉洪大者，与桂枝汤如前法，若形如疟，日再发者，汗出必解，宜「桂枝二麻黄一汤」。

如果吃桂枝汤，没有出汗，脉反而变洪大了，再给桂枝汤，如果出现忽冷忽热，隔日再发，汗出必解，宜桂枝二麻黄一汤。

## 桂枝二麻黄一汤方

桂枝一两十七铢，芍药一两六铢，麻黄十六铢去节，生姜一两六铢，杏仁二十六个去皮尖及双仁，甘草一两二铢，大枣五枚劈右七味。

以水五升，先煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升，日再服。

如果说，你看到桂枝汤，桂枝用到二，麻黄用到一的时候，桂枝的计量比麻黄多的时候，一定是热多寒少。病人感觉冷的时间比较短。

所以二十八条，当你出现病人感觉热多寒少的时候，用桂枝二麻黄一汤。那同样的你如果出现热很多很多，寒只有一点，麻黄就减量，桂枝就增加，可以自己调整，这个意思。

桂枝的量会比麻黄加重，桂枝如果我们以三钱来说的话，白芍是两钱，白芍量比桂枝少一点，麻黄把它当作一钱。是三二一的比例，杏仁是三钱。平常我们开这个处方的时候，桂枝三，白芍二，麻黄是一钱，你如果说白芍跟桂枝是等量，

一样可以，这个倒是不是说斤斤计较。

桂枝麻黄各半汤，桂枝二麻黄一，都是中风、伤寒同时有这个现象出现的时候才会使用它。剂量的大小，可以调整。张仲景是桂枝麻黄各一半，或者桂枝二麻黄一，并没有桂枝三麻黄一这种现象。只要用到麻黄的时候，麻黄先煮一下。

伤寒论第二十九条。

原文：服「桂枝汤」，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，「白虎加人参汤」主之。

诸位记得，六气逆行是病态，顺着走是常态。如果在太阳症没有治好，会进入阳明，一种可能进入少阳。进入少阳才有可能进入太阴、少阴、厥阴。如果进入阳明的时候，会分两种情形，一种称为白虎，一种称为承气。承气跟白虎我们怎么样子去看它。阳明证有两种情形，一种是热在经上面，一种是热在腑上面，不管是哪一种，阳明证的大原则就是但热不寒，在阳明证的时候，只出现热症，完全没有寒症。所以你看到病人一派热症，你问他口渴不渴，喝热水冷水，喝最冰的，热症，经热。那如果腑热，腑热就是承气，承气就是大便堵到。如果纯热证出现的时候病人大渴，燥渴壮热，发高烧，津液不够，喝水一直喝小便一直排，没有办法止渴，这是阳明的经热。

腑热讲的就是肠胃里面的大便堵到了。不管是经热还是腑热，阳明无死症。现在有死的，因为他不知道用白虎，承气。如果遇到经热就是白虎，白虎讲的就是石膏。腑热讲的就是承气。

如果吃了桂枝汤，大汗出后，大烦渴不解，脉洪大者，白虎加人参汤，为什么会变成这样子？刚好六天走完，你正在吃的时候，病人已经转入白虎了，转入白虎还没有发现，桂枝汤喝下去，还是出现白虎汤症，只是桂枝汤吃的太慢了而已，并不是说你医生开方开坏了，而是病人来的时候，正在转变白虎的时候碰到你，你处方桂枝汤下去，第二天变白虎汤症。所以桂枝汤你喝多了，即使你流汗流多了，也不会变白虎汤症。流汗流多了，里虚的时候，我们加炮附子就很好了。这个是转变成白虎汤症。

如果主要症状是大烦渴不解，脉洪大者，如果说你看到有人渴的很厉害，喝水喝了半天还不能止渴，看着很像糖尿病，就是糖尿病。渴症的时候，我在开石膏的时候，起价就是一两。我讲我们用到白虎的时候，为什么要用大剂的，因为他是去热，在去热会用到白虎汤的时候，病人有壮热，高烧的很厉害。有的时候病人发烧，你看他全身烫的，喝冷水，被子盖到不放，恶寒啊，这不是白虎汤症。所谓壮热，就是热的把被子都踢掉，不能盖东西，全部是一派热症，才是白虎汤症。

望有时不是看他的颜色怎么样，就看他一些动作怎么样。都踢被子了，你还说你怕冷么？

白虎加人参汤方

知母六两，石膏一斤碎绵囊，甘草二两炙，粳米六合，人参二两。

右五味，以水一斗，煮米熟汤成。去滓，温服一升，日三服。

石膏为什么用棉布包起来，因为石膏是石类的白粉一样，煮过之后粘哒哒跑出来像石灰，汤药都倒不出来，很粘稠。所以你要面部包起来，煮出来以后汤才会稀。

为什么用梗米，在中医得观念里面，饮水入胃，胃的火就会把水汽化掉，因为你喝的是水，如果是食物入胃，胃咀嚼后到小肠，小肠是火，本来是相火，所以小肠会把食物消化掉，这个食物的残渣再进入大肠，大肠里面有水还有残渣，小肠的火在下面烧，水在上面走，这个水气化掉以后回到肺里面，这个水才能止渴。

这个白虎汤跟白虎人参汤，什么时候会用到人参，当饮食入胃以后，到了小肠小肠把它消化掉以后，只有食物的残渣跟水进入大肠，小肠的火在下面烧，大肠的水在上面汽化掉，进入肺，再从肺到我们的皮肤表面，到我们的喉咙，津液就回头。所以说，张仲景在用白虎汤的时候有加梗米，就是糯米，甜的这个米，这个好像是煮稀饭一样，有食物在里面，有食物在里面以后，这个水就有办法进入水的循环系统，所以这个状况，口渴只是喝水，绝对没有办法把这个口渴止掉，喝下去就气化掉，结果嘴巴还是渴的。加人参的时机，张仲景在 经方用的最强的补阴的药，就是用到人参到顶了。会使用到人参，就是因为他认为病人津液伤的很重，才会用到人参。所以一定是大汗不止，大烦渴不解，口渴不能解，这时候我们用人参下去，把他的津液补回去，平常他不会使用的。

如果说我们不用人参，遇到个病人，发高烧，全身是但热不寒，大便很正常，我们知道他是白虎汤，你问他怕不怕冷，不怕，风吹的难过不难过，不难过，因为他很热，没有恶寒，发高烧，大便很正常，这个时候，我们不需要人参，光是白虎汤下去就可以把这个烧退掉。

我最常用的处方，我石膏用一两，知母大概四钱五钱的剂量就够了，炙甘草，两钱三钱，炙过，梗米你不要放太多，放太多煮成干饭了，因为汤都吸收掉了，六合你不要放六碗下去，差不多两钱三钱就可以了。

煮米熟汤成，去渣，喝的是汤汁看到没有，所以是很稀的稀饭。

白虎汤用的非常多，所以我们用的石膏是白色的，所以我们又名白虎。

第三十条。

原文：「太阳病」，发热恶寒，热多寒少，烦躁，脉微弱者，此无阳也，不可发汗，宜「桂枝二越婢一汤」主之。

开始的时候，我跟诸位讲，伤寒论里面讲了阳盛跟阴盛，亡阳跟亡阴。这个阳没有了，我们怎么知道他阳没有了，发热恶寒，热多寒少，阳在的时候，这种热多寒少是阳往外走，里面阳不够了，所以你看到是热多寒少，病人会有烦躁的现象。诸位记得，生病最怕的就是烦躁，

1——7

因为你发汗的话，阳会失的更多，已经没有阳了。这个时候桂枝二越婢一汤，这个越婢汤在伤寒论里面没有，是在金匱里面，在风水，就是在治疗水肿，全身肿起来以后我们用越婢汤。

### 桂枝二越婢一汤方

桂枝十八铢去皮，芍药十八铢，甘草十八铢，生姜一两二铢，大枣四枚劈，麻黄十八铢，石膏二十四铢碎，绵囊。

右七味，㕮咀，以水五升，煮麻黄一二沸，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。本方当裁为越婢汤，桂枝汤，合饮一升；今合为一方，桂枝二越婢一。

这个越婢汤，麻黄、石膏，配上炙甘草、生姜，红枣这个五味药就叫做越婢。

越婢汤的时候，你麻黄跟石膏配在一起使用，麻黄我们有一个名称叫青龙，麻黄是青色的，石膏是白虎。这个人已经无阳了，不可以发汗，用桂枝二越婢一汤，很多人，一般的中医认为麻黄就会发汗，实际上，你真的会用麻黄，我们在少阴症也有用麻黄，这个桂枝麻黄从太阴症一路用到厥阴症哦，所以麻黄不见的是只有发汗，要看你怎么样子使用，你如果是麻黄跟石膏配在一起的时候，阳气会回收，反而会回收，不见的会往外发散。

这个桂枝汤配上麻黄，如果我们不放石膏，光是桂枝汤加一味麻黄下去的时候，他的感觉，病情变化会怎样？桂枝汤的桂枝、白芍、生姜、甘草、大枣这五味药，配进去以后全身的肌肉，里面的水循环会加速，血液循环也会加速，这个时候我们会流汗，流汗以后，如果在桂枝汤的根基上面，加了麻黄以后，会发汗发的更多，你如果说统统不用桂枝汤，光是一味麻黄，吃下去人会比较亢奋，会不会流汗，不会流汗，所以麻黄必须要有别的东西配合在一起，它才有办法去发汗。单一味麻黄并没有办法去发汗，但是精神会非常的好，一个礼拜都不睡觉。

这个地方如果我们不加石膏，光是桂枝汤加上麻黄的时候，病人会骤发汗，这里不可以发汗，我们要加石膏下去。这个麻黄跟石膏碰在一起，青龙碰到白虎，很好，这是很特殊的一个方法。如果说，这个风水，这个风水是指身上发水肿。我们越婢汤很有名，一吃下去冒一点点汗，大水就排掉，小便统统排出来，这是越婢汤，这是因为阳回头。如果说你的麻黄配合石膏再跟桂枝汤放在一起的时候，你会发一点点的微汗，但是这个石膏，会把这个热去掉，去热去掉以后，烦躁的现象没有，这个烦躁在这里面就是津液不足。

肺在中医里面是白色的，肺主皮毛，石膏就是色白。石膏在中药里面药性是寒凉，肺在胸腔里面，胸腔是阳之所，胸腔是阳的所在，那石膏是白色的入肺，所以石膏表面上看起来是寒凉的药，实际上他是主管阳的所在，所以看起来好像石膏，我们在发汗，实际上为什么这个越婢汤能够把那个水肿排掉，因为阳能够回头，我们应该这样子看。所以说，桂枝汤配上了麻黄以后，配上石膏，病人会有收敛汗，阳会回头的现象。

所以在本草里面，石膏除了去热以外，还去烦，为什么去烦？因为黄帝内经里面说，肺主魄，白天见鬼叫做魄，肺主魄，主静，正常的肺的功能管魄，管的是我们的静态，那你开始烦躁的时候，动来动去的时候，我们要靠肺让人静下来，这个时候就是色白的，石膏，白虎汤有办法。所以说，这里烦躁，就是靠石膏，让他的胸阳回头。

这七味药放到一起煮，煮下去以后，这个也是先煮麻黄，只要麻黄出现的时候，统统先煮麻黄。



石膏二十四铢，铢也是一个单位。一般我在临床上用石膏，起手就是一两来记，用棉来包裹。所以许多人不了解，以为石膏只是去热，实际上石膏可以敛阳，可以把阳收敛起来，尤其是肺的。

### 第三十一条。

原文：服「桂枝汤」，或下之，仍头项强痛。翕翕发热、无汗，心下满，微痛，小便不利者，「桂枝去桂加茯苓白术汤」主之。

如果说你吃了桂枝汤，或者是病人有便秘，你攻下了，吃完以后还有有头项强痛，小便不利，心下满，心下指的是胃的地方。如果吃完这个药，病人心下还是胀满，而且有微痛，小便不利，桂枝汤去桂加茯苓白术汤。

什么是白术，白术张仲景用的很多，他是去湿，辨证的时候，我们知道风寒湿，有去寒的药，有去湿的药，有风的药，合在一起的时候，风寒湿就能同时把他治好。我们为什么知道有湿，帮助我们处方，这个症状病人本身就有中湿，中焦湿，平常肠胃湿热就比较盛的人，如果说桂枝汤下去，发汗发掉了，肠胃里面因为比较粘稠，津液比较多，这个时候肚子里面会微痛，因为你动到这个湿，这就是服桂枝汤的一种辩证，那我们如何知道这个人平常就湿很盛的人，舌苔看的时候，舌苔很厚，我们就知道这个人湿很盛。还有肚子比较大，也是湿比较盛。大便比较粘稠，也是湿比较盛。遇到中焦有湿热的人的时候，你桂枝汤下去，没有办法利用桂枝汤这个发表的药，把病完全去掉，就会产生这种现象，心下满，微痛，小便不利。白术加进去是去湿。为什么加茯苓？茯苓把湿从小便导掉，茯苓能够利水，所以去湿跟利水加在一起才有办法把这个小便导掉。

因为在中焦下去以后，胃有痛的时候，我们把桂枝拿掉。桂枝对胃比较不好，因为胃里面微痛。把桂枝汤里的桂枝拿掉，加了茯苓跟白术就可以。

所以如果有病人说，吃了你的药以后，胃里很难过，小便滴滴答答，小便不是很顺利，这个时候我们知道这个人有湿，换个方子，把桂枝拿掉，开白芍加茯苓白术就可以了。

### 桂枝去桂加茯苓白术汤方

芍药三两，甘草二两炙，生姜三两，茯苓三两，白朮三两，大枣十二枚。

右六味，咬咀，以水八升，煮取三升，去滓，温服一升，小便利则愈。

我们用到白术跟茯苓的时候，白术跟茯苓是等量，一般来说三两换成三钱，这个倒无所谓，正常我是二点多钱。八碗水煮成三碗，每次只吃一碗，小便利则愈，因为前面你已经桂枝汤吃了，表已经去掉了，但是中焦还有湿在那边，有些病并没有完全去掉，这个时候我们再换一个方子给他。讲到三十一条我们就知道，什么时候我们要把白芍拿掉，什么时候把桂枝拿掉，胃里面不舒服，心下满，就是把桂枝拿掉。白芍拿掉是在胸满的时候，我们要把白芍拿掉。

### 第三十二条。

原文：伤寒，脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，反与「桂枝汤」以攻其表，此误也，得之便厥，咽中干，烦躁，吐逆，谵语，脚挛急，作「甘草干姜汤」与之，以复其阳。若厥愈，足温者，更作「芍药甘草汤」与之，其脚得伸。若胃气不和，谵语者，少与「调

胃承气汤」。

当病人，有自汗。这里是说，明明是伤寒，伤寒是无汗的，而且身痛，体痛，现在伤寒病人会有恶寒，但是有流汗，小便数，心烦，这种情形不是桂枝汤症。桂枝汤症必须要有怕风出汗，有点发热，有汗，他这里有恶寒的现象，不是桂枝汤症的现象，那你开桂枝汤来攻他的表，吃下去以后，因为你开错方，得知便厥，这个厥你不要担心，吃了昏倒啊，所以桂枝汤就不敢用，没有关系，就算你误用了，误用了以后，不该发汗的时候你发汗掉，这个时候你造成喉咙里面很干燥，烦躁吐逆，这津液，肺里面的胸阳不够了，这个甘草干姜汤，这是很有名的简单又好用的处方，炙甘草还有干姜。干姜是非常温热的，温性的药，它能够把肺阳强起来，炙甘草能够强心阳，所以炙甘草越重的时候，心脏的力量越强，甘草本身是甜味的，本身应该是入脾的，但是你用蜂蜜炒过以后，变成炙过了，炙过甘草以后，这个厚味，味道是比较厚味，炒过以后带苦味，又厚味，所以它入心。这两个配在一起以后，干姜跟炙甘草，强心跟强肺，脾脏在中间，所以我们在难经里面，介绍的时候，泻南补北的时候一样，当我们在强心强肺的时候，脾脏的功能会强起来。所以炙甘草干姜汤是一个救逆的状况。专门使用在误给桂枝汤，产生误汗以后，病人会有喉咙里面干，肺里面的津液不够，烦躁，吐逆的现象，这个时候我们就用甘草干姜汤。

谗语，脚挛急，脚抽筋都是津液不够，因为你发汗发太多了，那甘草干姜汤是阳药，当心肺的阳受到干姜炙甘草的时候，阳会恢复过来，如果恢复过来以后，厥，喉咙干，烦躁这些都没有了那就好了。

如果脚温者，更做芍药甘草汤与之，其脚得伸。若胃气不和，谗语者，少与「调胃承气汤」。这里得到一个健康的标志，脚是温的，手是温的。正常人，一年四季，头面是冷的，手脚是温热的。如果说你去检测病人，你握着他的手掌心，另一个手握着他的额头，额头是冷的，手掌是热的，这是正常。额头是热的手脚是冷的，这是非常态。当你用了炙甘草干姜汤回来以后，脚热起来了，代表阳恢复了，阳恢复了为什么要用芍药甘草汤，因为芍药，是补阴的药，是补津液的药。补津液就说，虽然你阳回来了，但是你肌肉血脉里的阴还是不够，所以我们会用到芍药炙甘草汤。

用了芍药甘草汤以后，他的津液回来了，就可以伸展。很多病人脚会抽筋，脚会回收，里寒很盛的时候，我们都要靠芍药炙甘草。

女孩子脚生静脉曲张的时候，就是要靠芍药，但是你用的芍药，如果说五钱，炙甘草五钱，这两个是等量，不够。炙甘草是强到心阳，心脏，五钱的量不够。如果同样的药你用上一两的时候，力量就来了。所以如果处方是对的，剂量不够的时候，你看不到效果。从这个处方我们可以看到，让脚的循环回来的时候，必须要重用白芍。所以女孩子脚静脉不好看，回家可以吃芍药炙甘草汤。

那如果说吃芍药甘草汤的时候，粉剂不好，要汤剂，汤者荡也。扫荡的力量。

中医的寒热辨证。我们心脏到脚，脚离心脏最远，当心脏有问题的时候，第一个反应就在脚上面，初期的时候。心脏有问题的时候，脚是凉的冷的，因为最远。我们怎么知道静脉有没有淤血堵在里面？脚是冷冰的人，都会有淤血。天气冷的时候，会让液体变成固体。是冷的造成液体变成固体。那你脚是冷的冰的，脚里的血管就好像地球上的河流在冬天的地方，是结冰的。所以你脚是冷的，这

个冷就造成制造淤血块的主因，因为他会让血，血本来是液体，它会让血变成固体。造成血里面有淤血块堵到是因为脚冷，脚为什么冷，因为心脏力量不够，搏动的力量不够，所以心的热无法导到手脚边去。

西方医学在治疗感冒的时候，吃抗生素，一吃下去心脏伤到，心脏伤到，心脏产生的热就没有办法导到脚，所以脚是冷的。

所以我们怎么知道这个药对我有效，吃下去以后，手脚开始热，吃对了，如果吃下去，越吃越冷代表你错了，要换处方了，这是一个基本的概念。

所以当你脚是冷的时候，如果你用芍药炙甘草汤，一下去了以后，这个脚会热起来，你炙甘草重用，心脏热起来，白芍能够让血液循环回来。脚一热起来，这个热的温度，温度的热量，就可以把累积在脚上的淤血融化掉，所以中医活血化瘀是这样子来的。白芍炙甘草能够化瘀为什么？因为炙甘草很热，所以热度到了，就可以把这个淤血块化掉，就好像冰块遇到热融化掉也是一样的观念。所以这是中医寒热的辩证观念。

那你吃阿司匹林那些西药，越吃脚越冰。中医得四逆，如果你脚上冷一直冷到膝盖，这是极限，到顶了。如果你刚开始只是脚上冷，上面还是热的，淤血进入小腿，遇到热就会化掉，就算你脚有淤血，也不会马上发病，所以你脚冷，可能很长一段时间不会发心脏病。这是手脚冰冷。这在经方叫手足冷。为什么叫四逆？四逆就是不是从脚趾头到脚环裸了，是从脚趾头到膝盖头了，是从手指头到手肘了，而不是从手指到手掌，如果说是手指头到手掌，是手脚冰冷，张仲景称为手脚冰冷。如果说四逆的话，是说已经到手肘了。当你到了手肘、膝盖头这个阶段，可能因为血管比较大，这个时候淤血回的速度比较快，这个就会造成心脏病，这叫做四逆。

病人如果吃你的药，从冷到膝盖，变成冷到脚裸，代表进步了，不用去摸脉，去看病情是进步还是退步。如果每个病人都晓得，自己就可以感觉的到，这样子就可以预防心脏病。很多人不了解，你如果去医院做 ST，必须要你发心脏病的时候才查到，所以很多人就死在 ST 上面。

心脏病可不可以预先知道，当然可以。可不可以预防，当然可以，所以芍药甘草汤就是很好的一个处方。你说再用附子可不可以，当人可以。后面就有芍药甘草附子汤。经方是很简单的几味药，但是效果非常好。

这就是我常常跟诸位讲的，脚温的人没有心脏病。脚温必须用中药，西药不会脚温。西药应急非常好，还有牙科，西医有必要，但是急诊。

吃了芍药甘草汤以后，阴津回头了，温度也回来了，阴阳都回来了，所以脚可以伸展了。

那如果是胃气不和，谵语者，少与调胃承气汤。前面是发汗发太过了，误给桂枝汤了，病人这样子，后面，你误给桂枝汤以后，有一种情形是芍药桂枝汤，一种是你误给桂枝汤了，把胃里面的津液发散掉了，胃里面的津液发散掉了以后，这个人本来不该吃桂枝汤，结果你给桂枝汤吃了，结果胃里面的津液没了，干固掉了，因为桂枝汤可以发汗啊，不应该发汗去发汗，我们怎么知道津液没有了？胃气不和，胃里面很难过同时有谵语，因为你食物里面本来有一定的水分，结果你不该吃桂枝汤的时候，结果桂枝汤一下去水分一发散掉，食物很干就堵在里面。

堵在里面，大概堵在这一段（图胃下口肠处），临床上在腑诊的时候，就是腹部来按诊的时候，我们可以看到建立穴、下腕穴、中脘这一代到肚脐这一代有压痛点。任脉的中脘穴到神阙穴，中间这一段有压痛点，这有压痛点的时候，我们开的是调胃承气汤。我们有调胃承气，有小承气，有大承气。这里先介绍到调胃承气汤，而且是不要太多，而且是少与，一点点就可以了。把肠胃清一下就可以了。

## 1——8

### 甘草干姜汤方

甘草四两炙，干姜二两炮。

右二味，㕮咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

炙甘草的剂量会大于干姜的剂量。

### 芍药甘草汤方

白芍药四两，甘草四两炙。

右二味，㕮咀，以水三升，微火煮取一升半，去滓，分温再服之。

芍药甘草汤，芍药跟甘草是相等的剂量。这我们很有名的，让脚的静脉的血液循环回来。有的太太生完小孩，有静脉瘤就可以多吃芍药甘草汤，剂量加重。重到什么程度？我曾经治过一个太太，刚开始我们白芍八钱，炙甘草八钱，就两味药。吃一个礼拜没有感觉，把它变成白芍一两，炙甘草一两，吃完第二天打电话来，说吃你的要为什么会头昏？中医里面，药弗瞑眩疾不瘳，就是吃了中药以后，没有产生瞑眩，病不会好，在经方用的时候，常常瞑眩，你只要是对症，都会头昏。比如你开桂枝汤，开的非常好，这个人你一剂下去他就会头昏。所以病人一吃到头昏，你就知道药对症了。

### 调胃承气汤

大黄四两去皮、清酒洗，甘草二两炙，芒硝半斤。

右三味，以水三升，煮取一升，去滓，内芒硝，更上火微煮令沸，少少温服之。

一般来说，炙甘草两钱，大黄四钱，芒硝两钱。这个大黄酒洗，中药里面，讲炮制法的时候，只要用酒洗制过以后，都是取它的升提。同样的，生大黄你用的时候，吃下去拉肚子排掉。为了让这个药停在这个部分（神阙到中脘）因为我们很确定，这个本来是胃里面有食物正在消化，你医生开错处方了，一开到发表的药，他的食物还没有消化完，结果被你发表用的药，食物堵在这个地方。所以我们会用到调胃承气。那要把这个药设计的很好，停在这个位置，把这个部位清掉（中脘到神阙），而不会去清到小肠大肠，所以才会用酒去清洗他，不然的话，大黄又有一个外号，叫做川军。四川的大黄很有名，大黄是将军，如果不酒泡一下，一下去就到大肠去了，吃完大黄就要上厕所，所以用酒炮制一下。芒硝，一般来说我们都是生用。芒硝是两钱分两包，你如果把芒硝放到汤锅里面去，跟大黄甘草一起煮，煮完了芒硝就没有了，芒硝就从此消失了，真的消掉了哈，所以你不能放进去煮的，芒硝是生用。生用的时候，有两种生用。一种是，煮完以后还有一点火在里面，汤还在滚，芒硝倒下去，让它消化在里面，马上关火。还有一种是芒硝直接放到碗里面去，然后汤直接倒下去，让他化掉。倒下去的让

它化掉的，是生用取它的迅捷，迅速。我们说要排大便很快的给它排掉，我们会用这种方式。另一种方式稍微缓一点就是，汤药还在滚的时候，倒下去再关火，让它烧一下。

这个地方“以水三升，煮取一升，去滓，内芒硝，更上火微煮令沸”，就是不要那么快，再煮一下对不对，你不要煮太久了。为什么要用芒硝？这个芒硝，我们大便很干很硬的时候，芒硝叫攻坚的。所以，我们在研究神农本草的时候，如果大便很燥很硬的时候，宿便很硬的时候，你光是大黄下去，清不出来。病人想排排不出来，因为有时候大便拳头那么大，肛门很小排不出来，这个时候就是靠芒硝，所以芒硝能够软坚。

那你如果生用的时候，那个大便，芒硝好像那个马铃薯切片。你如果加了芒硝下去以后，宿便排出来像马铃薯一样一片一片排出来，芒硝就有这个功能。非常的利，那你如果说没有加芒硝，光有大黄，像小承气就没有芒硝，大承气有芒硝，那如果事情发生在你岳母，你岳母是大承气汤症，必须用芒硝把宿食清出来，结果你开成小承气，没有芒硝在里面，你岳母吃下去，就会感觉到很像上厕所，又上不出来。就是你芒硝没有加进去，他很痛啊。经方就是一个症一个处方。

第三十三条。

原文：若重发汗，复加烧针者，「四逆汤」主之。

如果说你遇到一个病人，这个医生误诊，不该发汗，发表的，结果我们重剂下去，发汗，病人津液伤到，津液丧失掉，结果还不够，还加烧针，烧的很红的针刺下去，医生认为他需要。我们最有名的，就是化脓的时候，脓很深，针直接扎进去，去脓效果很好。但是这个人你重发汗，发完汗又给人家烧针，津液丧失太多，这是四逆汤。

四逆汤症，就是手脚冰冷到，从手指头冰到手肘，从脚趾头冰到膝盖的时候，就要靠四逆汤。这样就区分开来了。我们后面有很多四逆汤出来，四逆的定义一定要知道。

四逆汤方。

甘草二两炙，干姜一两半，附子一枚，生用去皮，破八片。

右三味，咬咀，以水三升，微火煮取一升二合，去滓，分温再服。强人可大附子一枚，干姜三两。

真正我们在救逆的时候，附子是生用。我以前丈量过，生的生附子，跟我拳头一样大，大概是五钱。如果水分干掉以后，晒干以后拿来变成三钱了。这是我们临床上的经验。

过去，说生附子很毒。其实生附子很好用。生附子纤维很多，你没有用棉布包起来，直接生附子丢锅里面煮起来，好像芋头煮烂了，煮烂了毛就起来，跑到表面上，结果四逆汤上面嘿嘿一层毛，你一喝下去，毛吞不下去，粘在喉咙上面，你一直咳嗽，很痒，就说它有毒。所以我们用生附子的时候，一种情形就是，跟石膏一样用棉布给它包起来，你煮烂的话，它黑的纤维，就不会出来。

生附子和炮附子不一样。生附子针对里寒，去里寒的。炮附子专治表虚。这

个人表虚掉了，毛孔打开来了，汗流不止，脱水了，炮附子下去，汗就收掉了。这个时候，你用生附子下去，汗还是在流，它不走表，里寒的时候，用生附子下去。

所以病人在怕冷的时候，比如说，开完刀或者是意外车祸，病人失血都很冷，里寒的时候，我们用炮附子下去，让里阳回头。所以生附子在救逆。

喝的时候并不是一剂喝下去。“水三升，微火煮取一升二合，去滓，分温再服”如果这个汤剂煮完以后，你有两碗在这边，你喝下去，嘴唇舌头会麻，这是有中毒的现象，的确是中毒的现象，但是当你病人需要的时候，你这个毒是补药，所以不要怕。现在会用生附子的人不多，所以中医就是一直往下走。

四逆汤出现的时候，手脚冰冷，因为发汗太过，病人非常的冷，里面里阳要绝了，我们用生附子，来回阳。

这个生附子四逆汤，我们又叫回阳汤。后面会介绍到麻黄汤，麻黄汤又叫返魂汤，魂没了，可以救回来。

### 第三十四条。

原文：问曰：证象「阳旦」，按法治之而增剧，厥逆，咽中干，项胫拘急而谵语。师言夜半手足当温。两脚当伸。后如师言，何以知此？答曰：寸口脉浮而大，浮则为风，大则为虚，风则生温热，虚则两胫挛，病证象「桂枝」；因未加「附子」参其间，增「桂」令汗出亡阳故也，厥逆，咽中干，烦躁，「阳明」内结，谵语烦乱，更饮「甘草干姜汤」，夜半阳气还，两足当温，胫尚微拘急，重与「芍药甘草汤」，尔乃胫伸，以「承气汤」微溲，则止其谵语，故病可愈。

阳旦，讲的就是桂枝汤。看起来很像桂枝汤症，然后你按照桂枝汤的方法了，太阳症的方法，给它桂枝汤，越吃病人越坏，症状加重，厥逆手脚冰冷，这里厥逆是手脚冰冷，不是四逆到手肘，这有点差异。喉咙里面干，代表你津液都受伤了，你发表发太过了，不应该发表的，脚胫抽筋，而且会乱讲话。大便堵在肠子后面，会有谵语的现象。这种人，如果手足当温，两脚当伸。手脚温度回来了，虽然你误治了，但是半夜手脚温度回来了，两脚伸起来，不会拘挛了，为什么会这样子呢？寸口脉浮大，就是阳脉，浮而大，浮为风。我们是以浮、沉、迟、数为四大主脉，这四个脉为主要的脉。当你出现寸脉是浮而且大的时候，大、数、滑、动，动的很厉害这些都是阳脉，那浮脉就是阳脉，阳脉又出现阳脉是重阳的脉，阳重在一起，阳太盛，浮是风，大则为虚。重阳脉出现的时候，我们要很快，很迅速的把阳去掉，不然的话会往亡阳，阳太过会亡阳，病证象桂枝，因未加「附子」参其间，增「桂」令汗出亡阳故也，厥逆，咽中干，烦躁，「阳明」内结，谵语烦乱，更饮「甘草干姜汤」，夜半阳气还，两足当温，胫尚微拘急，重与「芍药甘草汤」。尔乃胫伸，以「承气汤」微溲，则止其谵语，故病可愈。这个条辨讲的是什么时候用甘草干姜汤，什么时候用芍药甘草汤。什么时候我们用调胃承气汤。这个后面的承气汤就是调胃承气汤。这个条辨跟刚刚是相类似的。一种是阳气自己会恢复过来，一种是你用药物去协助他让他去恢复过来。

### 2——1

### 三十五条。

原文：「太阳病」,项背强几几,无汗,恶风者,「葛根汤」主之。

太阳病分三种,中风,伤寒,温病。张仲景设计葛根汤最主要的目的其实就是治疗温病,温病是一种病症,症状,用葛根汤来治疗他,如何使用葛根汤,什么时机,为什么要用葛根汤?

葛根汤的观念是什么?在临床上最常见的就是小孩子,外面很冷,小孩子运动,流汗,表开得到感冒,这个大多数都是葛根汤症。所以冬伤于寒嘛。

还有一种时疫病。就是很多做苦力的人,他没办法,冬天必须去赚钱,做事流汗后外面是冷的他受到,得到伤寒,伤寒到夏至以前发出来就是所谓的温病。

### 葛根汤方

葛根四两,麻黄三两,桂枝二两去皮,芍药二两,甘草二两炙,生姜三两,大枣十二枚擘。

右七味,㕮咀,以水一斗,先煮麻黄、葛根,减二升,去沫,内诸药,煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗,不须啜粥。余如桂枝汤法将息及禁忌。

葛根汤是温病最好的处方。为什么?葛根汤的来源,桂枝芍药二两二两,两个是等量,然后配上生姜、炙甘草、大枣,这个是桂枝汤。所以葛根汤是来自桂枝汤,葛根汤的症状是恶风,所以风吹到很难过就代表你已经要吃葛根汤了。病还在表就已经治好了。为什么加麻黄,因为病人无汗。为什么加葛根,项背强几几,项背是人身最高的地方,所以利用葛根把桂枝麻黄的力量达到项背的地方,把这个地方的寒排出来。所以葛根汤吃了以后,应该是后面整个项背流汗,汗流出来就好了。我们有一种病称为刚劲,就是我们现在看到的所谓脑膜炎,脑膜样人角弓反张,人往后仰,拉的很紧,张仲景也是用葛根汤。葛根汤下去后,太阳经本来蹦的很紧,一下,得汗则解,得汗以后,刚劲的现象就去掉了,所以我们会用在脑膜炎。我们会有两种一种是柔劲,一种是刚劲,葛根汤是用在刚劲上面。柔劲桂枝汤加栝蒌根就好了。

生姜红枣甘草,在张仲景来说的话都是补阴的药,补肠胃里面的阴,津液嘛,津液不够我们常常会用生姜红枣甘草。煮菜放点生姜,对肠胃很好。红枣也是增润津液的,中医在治病的同时不管什么病,一定同时固他的肠胃。桂枝芍药下去以后会发汗,汗的源头从肠胃里来,如果没有加生姜红枣甘草的话,肠胃的津液没了,汗流掉了,结果吃完药以后,病人便秘,那你又要吃别的药。还有甘草解毒,怕肠子里面,还有坏死的食物,用甘草把它分解掉。所以一个处方,你看起来几味药,但是他考虑的很稠密。

所谓经方,经方是绝对处方,你不要去改变他。在这个做基础上,如果说有人出现了项背强几几,无汗,恶风,同时便秘一个礼拜,你可以在葛根汤的基础方加一些去大便的药,比如大黄,把大便去掉,但是基本方不能变。

经方比例是黄金比例,不能改。你看他的比例最重要,比如说你看到比例是四三二二,这个人体格大点,另一个体格稍微小点,一个比例四三二二,小的稍微减一点比例不变。或者你还是四三二二,他喝一碗,你喝半碗,里面比例还是一样。

人受到天地之间的正气,所得的病是不会传染的。冬行春令,就会有疫病出

现，疫病会传染。

吃葛根汤，咬碎，麻黄葛根都是发散的，先煮麻黄葛根，就是去掉一些杂志或者毒素的东西，再跟其他药喝一起煮。七碗水煮三碗，一次喝一碗。用比例去看他，不要用升去看。

覆取微似汗。你开方最好的时候，棉被盖一下，取微似，一点点的汗，感觉上有汗，摸到湿湿的可是又看不到寒水出来，这是最好的，如果大汗不止，就津液伤到了。

不须啜粥。徐如桂枝汤法将息及禁忌。为什么不需要啜粥，啜粥除了帮助发汗以外，实际上桂枝里面有炙甘草红枣生姜就已经能够助汗，啜粥稻谷的希望力量增强，透达到四肢上面。

为什么重用葛根，因为项强，在发病的时候我们一剂把它去掉。不会用葛根汤，如果小孩子得到，救治得太慢，或者吃的别的药，发烧病没有退，变成脑膜炎。脑膜炎是刚劲，就算你刚开始的项背强几几，无汗恶风，已经发烧了，到后来变成脑膜炎，葛根汤症还在那边。重用葛根就是到项背，脑的这一块，膀胱经的地方风寒解掉，一解掉以后，汗打开来。我们叫做表解，病从表来解。有时候病来不及，太慢了，第六天，过来第七天病进入阳明了，你在那葛根汤药还没有抓齐，等你抓到以后已经变成阳明症了，药又不对了，你又要去抓阳明症的药。病还在进吗，来不及的状况总是会有。所以针灸很好，针我们带在身上，针灸也可以治疗。

麻黄剂量比葛根少一点点，麻黄如果超过葛根的量的时候，它发汗的时候就不单单是项背后太阳经上面了，他就全身性的发汗了，就已经失掉葛根汤的意义了，所以黄金比例就是四三二二。

葛根汤就是告诉你，重用葛根，再来麻黄，再来桂枝，桂枝白芍一定等量。这是最标准的黄金比例。

过去临床上我用了很多，比如鼻窦炎。鼻窦炎分两种，你问他鼻涕流出来什么样子？清涕，很难过，每天早上打喷嚏，流出来是清涕，我们知道是里寒，里寒就是寒湿太盛了嘛，我们加点白术，附子，白术去湿，附子去寒，寒湿嘛，那你把这两味药加到葛根汤里面以后，小孩子那个葛根汤一下子到脑部去了，脑部里面有寒湿，加进去以后，小孩子的鼻窦炎也好了。

另外一个小朋友胖胖的，很肥，也有鼻窦炎，脖子也强硬，那你问他，鼻涕是黄，粘稠的，这是湿热，你同样可以用白术去湿，但是附子不适合了，你要开去热的药，比如黄芩在里面。中药处方就是这样来的。

比如来一个人，痛风，脚膝关节红肿的很大很痛，张仲景讲了热在表，骨髓里寒的。这个有时候痛左脚，有时候痛右脚，跑来跑去，风的性就是跑来跑去。所以我们去风的同时又祛风跟去寒，祛风的话桂枝，去湿的话白术，去寒的话炮附子。这三味药，我们把它配一起，经方里面很有名的甘草附子汤，专门治疗痛风的。处方就是这样来的。所以你如果研究经方的时候，了解了以后，你的处方一下子自然就开出来，不需要去记它，开出来就是这样子。当然我们慢慢以后会添一些进去，经方不足的地方，不是经方不足，我个人认为这个方子失掉了，失传掉了，因为在张仲景不是设计经方的人，而是他把古圣先贤的方子拿下来，跟



六经辨证，告诉我们如何按照这个辨证的手法，如何按照这个症，辨证的方式来下处方。经方是传了几千年了，一定有散失掉的。

所以我们后学的，现有的东西有了，然后我们再补一些我们临床上看到的，还有当代遇到的病，或者当代被制造出来的病。

我们太阳伤寒回到前面，第一个中风，第二个伤寒，第三个温病。这是温病的第一方。以后看到小朋友感冒脖子强硬，葛根汤开下去就中了。

还有临床上小孩子起水痘，发微微的烧，如果不知道用寒凉的药下去以后，他水痘会闷在里面，转头来可能会发脑膜炎或者什么的。经方家一看是水痘，那个胎毒，羊水的时候还在肚子里面，没有清出来，呆太久了产生的毒。水痘刚开始的时候在指头缝的中间，其实肠子里面都是水痘，烧在里面，闷在那个地方，里面的温，小孩子会发烧。这个时候葛根汤一下去了以后，还是粉剂，不是汤剂，第二天，全身痘痘发出来，可是昨天跟今天的眼神不一样，昨天眼神病恹恹的，今天亮晶晶的，胃口大开吃东西。你看他全身水痘很可怕，你去量他体温，烧都退了好好的，水痘也不会痒，叫小朋友也不要抓破，慢慢气收掉就好了。所以我们治疗水痘也是一剂，葛根汤。所以葛根汤用的地方很多。

如果说脸部中风，加了葛根到后项最强对不对，太阳后面才到阳明嘛，这是到了第二个阶段，桂枝汤加单味葛根的时候，葛根要重用，在治疗面部中风的时候加重。比如平时桂枝汤加葛根，桂枝白术是三，葛根四，遇到面部中风的时候，葛根六，脸部中风去的就很快。

过去我们白术附子，去湿去寒这两味药，我们有专有名称叫术附汤，术附汤是我们很有名的排脓汤，也就是说今天我们知道里面化脓了，比如说骨边化脓，摸到皮肤表面只有这一块是热的，别的地方都不热，脓又不出来，就在很深的地方，我们如何让脓透发出来，就是排脓汤，术附汤，白术跟附子等量，就可以把脓逼出来，因为它能去寒去湿。所以化脓、发炎，看起来表面是热的，里面是寒的。有一个地方你不能用术附汤。我们有两个排脓汤。另外一个排脓汤，赤豆当归散，金匱会介绍，赤豆当归散也叫排脓汤，这个是排的肛门痔疮的脓。方剂非常灵活。

如果遇到一个病人，脚破个洞化脓，因为糖尿病不能收口，偏偏又得到个葛根汤症，怎么办，还是给他吃葛根汤，你知道在脚上，除了加术附以外把白芍加倍，白芍加倍让他血液循环回来，把血拉回来，新的血会弥补上去。同时再排脓，处方就出来了。

经方这个处方成分是经典，不能动它，绝对处方，比例是黄金比例，应用之妙在你的心里面。

第三十六条。

原文：「太阳」與「阳明」合病,必自下利,「葛根汤」主之。

太阳和阳明合病的时候，一定会有下痢的现象。葛根汤也可以治疗下痢。因为葛根汤它把肠胃中间的水往上升提了嘛。你本来是下痢，水往下走，那葛根汤下去把肠胃的水提上来。下痢就止掉了，我们中医治病有很多方式，这个是一种方式。还有一种是用药物进行和解，还有一种是实在止不住了，我们利尿给利出

来，这都是张仲景利下的治病法则。

有一种状况我们千万要小心，你现在知道了，葛根汤可以把肠胃里面中焦里面的津液提升上来，所以利就停掉了。平常素有湿热的人，喜欢吃油腻的东西，人会比较胖一点，用葛根汤要小心点，如果舌头比较黄比价湿，这个时候同样用葛根汤，但你可以加一些去湿，比如白术，黄芩，黄连下去把热排掉，他就不会热冲上脸，不会整个脸红红的，有湿热你要小心，用小便把它利出来，所以会加个茯苓在里面。葛根走葛根病都表解，出汗从表来解，另外的湿热小便排掉。

第三十七条。

原文：「太阳」与「阳明」合病，不但下利，而呕者，「葛根加半夏汤」主之。

葛根加半夏汤方

葛根四两，麻黄三两，汤泡去黄汁，焙干秤，桂枝二两，芍药二两，甘草二两炙，生姜二两，大枣十二枚劈，生半夏半斤洗。

右八味，以水一斗，先煮麻黄，葛根，减二升，去白沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，覆取微似汗。

加了半夏是止呕，为什么？张仲景用生半夏，半斤，所谓生的，就是当场采下来用的半斤，因为生的刚采下来湿的还很重，所以现在剂量我们不能按照这个，待会我告诉你如何使用剂量。生半夏是毒药，有名的婆婆药，生半夏吃下去不会死人的，只是声音没了，生半夏无味，解半夏的毒就要靠生姜。生半夏涤水力量非常强，一下去，恶心马上去掉了。中药里面只有生半夏可以把脑部的积水排掉。所以生半夏可以去至高的水，脑部的水。最高的水要靠生半夏，恶心要靠生半夏。经方用生半夏很多。生半夏是毒没错，但是生半夏我们在用的时候都是跟生姜或者干姜在一起用。

2——2

汤剂解表的时候，一定是感觉有汗，实际上没汗，刚刚好，就是病出来了，但是没有伤到津液，恰到好处。

这里讲是半斤，我们真正拿到手上是已经风干了，一般说干的半夏三钱。

第三十八条。

原文：「太阳病」「桂枝证」，医反下之。利遂不止，脉促，喘而汗出者，表未解也，「葛根黄芩黄连汤」主之。

葛根黄芩黄连汤方

葛根半斤，甘草二两炙，黄芩三两，黄连三两。

右四味，以水八升，先煮葛根，减二升，内诸药，煮取二升，去滓，分温再服。

这个葛根黄芩黄连汤，我们用的非常广。太阳病有桂枝汤症，就是有汗，恶风，发热，有时头痛，这是太阳病，你用桂枝汤症就可以了，结果你反下之。伤寒论的大原则，表症有的时候，要先发表再攻里。攻里的时候一定要确定他有没有表症。所以我们承气汤，用大黄的时候，一定先问他有没有感冒发烧，摸摸脉，

脉浮到的就是有。或者不是医生攻下，吃到坏的食物，下痢。桂枝汤表没有解掉，结果吃到坏死的食物，造成下痢，结果病邪跑到肠胃里面去了。变成脉促，喘而汗出，这个时候用葛根黄芩黄连汤。

葛芩连汤（葛根黄芩黄连汤）是用在热利，什么叫热利？肛门痛，便臭，热利。有人会看到血。这是就可以开葛根黄芩黄连汤，这里是告诉你热利的来源，有时候不是这样来的，他吃坏肚子了。

葛芩连汤的时候，黄芩黄连剂量是相等的。黄芩跟黄连有点差异，黄连仔细看很黄味道很厚很重，是土，黄连是苦味，它清理胃里面的东西，黄芩也是黄，但是带有点绿色，所以肝胆的湿热，小肠的湿热黄芩用的很多，这个两个剂量相等。葛根这里是五钱。按比例抓就好了。用汤剂最好。

三十九条。

原文：「太阳病」，头痛，发热，身疼，腰痛，骨节疼痛，恶风，无汗而喘者，「麻黄汤」主之。

这是太阳伤寒，伤寒伤到当令的节气，并不是时疫，不会传染的。他恶寒到什么程度，夏天你热的要死，他一滴汗都不出，冷的要死。这个伤寒不一定是冬天的寒，而是伤于寒，伤到是来自寒，比如冷气。

主要症状，头痛，发热，身疼腰痛，骨节疼痛，恶风无汗而喘，为什么没汗？是这样子，我们常常问汗，就是想知道他的肠胃系统如何，他的心脏功能如何，心脏功能很好，你运动才会出汗，你走路才会出汗，你吃饭才会出汗，心脏功能不好，一种是完全没有汗，一种是你不动就会流汗，不该出汗的时候出汗。

我们知道治肾脏一定要去救心脏。所以肾脏有问题的病人，他再运动，一点汗都没有，你怎么知道他病治好了，他一动就出汗，就好了。病人只要有汗，就不会有积水。就是我昨天讲的那个吸管，你把按着的手一放掉，水就跑出来了。所以只要一运动以后，有汗，下身就不会有积水，小便就会恢复正常。所以这个汗很重要。这个人现在没有汗了，喘为什么？因为伤于寒的时候，毛孔整个闭锁住了，那你呼吸就靠鼻子两个孔在呼吸，你鼻孔再大，也还是喘。所以喘无汗，是伤寒的主症，还有全身骨节疼痛，寒束在身上的时候，好像被鞭子打很痛，因为水没有办法走动，当热是有恶风。

这种伤于寒的现象出现的时候要开麻黄汤。一般临床上的时候，大家看到麻黄的时候想这个发表发的很厉害，吃下流汗流的很快，比较担心。看到使用麻黄，就拿两根，称不到重量的，麻黄质很轻。比如桂枝三钱，麻黄三钱，麻黄三钱拿到手上一大票，桂枝三钱一点点，那个质不一样啊。

这里麻黄剂量比桂枝剂量多，记得是黄金比例啊，当你要用麻黄汤的时候，你确定他是麻黄汤的时候，你开出来是开比例的。桂枝比麻黄少一点点，炙甘草，还有杏仁，四味药组成汤叫做麻黄汤，麻黄汤有一个外号叫做返魂汤，所以麻黄不是说只有发表流汗，最重要是把阳气生发起来，发阳。越婢汤的时候我们会用麻黄跟石膏，前面桂枝二越婢一汤的时候，有没有，让他阳气起来。经方遇到病人阴虚的时候，我们开的是强阳的药，让他阴自回。阴，就是津液，你看的到的就是阴，脏腑吸收的能力是阳，力量就是阳。张仲景的经方的观念，就是说要把阳回来以后，阴会自己回头，这个才是真正的治愈。所以张仲景的观念是，你生

病了，我们给你个药推你一下，然后你胃气恢复了，开始吃东西了，好了，这就是经方的观念。经方不像西药一样，要吃一辈子，经方就是刺激你的身体，让你的身体功能自己恢复以后，所有的功能都在你身体自己的控制之下，这个时候你就好了，所以你受伤的伤口，我们开药就是让你自己痊愈。为什么西药不能把病治愈，因为西药只是控制，因为他认为病不会痊愈。

麻黄跟杏仁用在一起，杏仁跟石膏不太一样，中药里面，所有有人剂的，都有油脂，白色能够入肺，除了增润肺的津液以外，同时可以涤痰，把痰排掉。石膏是石头没有油，所以石膏是去热的。麻黄汤里面要用杏仁，不能用石膏。当你要发汗的时候，炙甘草下去可以让肠胃产生很多的津液，桂枝是一个马，麻黄骑上桂枝，麻黄碰上桂枝才有办法到皮肤表面上去，所以你看葛根汤里面是不是桂枝加上麻黄，汗才会走表。

如果麻黄没有桂枝的时候，它不会出汗的。它是发阳，阳气会起来。这里我们要借用桂枝，麻黄才可以到表，发汗。杏仁，因为麻黄入肺，能够把肺打开来，把毛孔打开来，所以麻黄吃下去，流出来的汗是从肺里面流出来的，肺的津液会不够，这时候就预先放下杏仁去补它的，就怕肺的津液不够，如果麻黄汤里不加杏仁，直接是麻黄杏仁炙甘草下去，病人肺里面的津液没了，燥渴，全身会发热，肺就想水箱，心脏好像引擎，水箱跟引擎比例要相等才会有恒温，如果水箱里水不够了，引擎是好的，车子温度是不是过热，所以你摸这个病人发烧，因为你没有加杏仁在里面，就好像水箱里面水没了，你光是看引擎，检查引擎没有问题，忘掉水箱里水没了。这就是杏仁的功能。杏仁七颗差不多三克，七十个差不多，二十一克了，差不多四钱五钱的量，麻黄三钱，你可以杏仁多加点，无所谓，杏仁可以超过麻黄一点没关系，但是麻黄比桂枝一定要高一点。这个才是正麻黄汤。为什么叫返魂汤。病人心脏气息都没了，麻黄一下去，肺打开，毛孔打开来，当场就呼吸了，炙甘草桂枝是不是强心阳。所以叫还魂汤。麻黄单味功能不会发表的，只是精神很好，晚上不睡觉。配上其他的就不一样了。麻黄记得不是发汗，发阳的。阳气内陷，或者阳气没了。发阳用的麻黄汤，救逆的时候可以用。

光是善用麻黄的人，所有的咳嗽，气喘，肺上面的问题，还有救逆都可以用。

麻黄、桂枝、甘草、杏仁，简单的四味，药简力专是经方的精神。他先煮麻黄。你真正救逆的时候，什么先煮，直接丢下去煮了，真正救逆的时候不要那么讲究，赶快丢下去煮。九碗水煮麻黄，去掉两碗了，在放其他药煮成两碗半，一次服三分之一。覆取微似汗，不需要啜粥。为什么要啜粥，就是刺激你肠胃的蠕动。这里不是要肠胃里面的汗，它是解肺里面的汗，所以不需要啜粥。

最基本杏仁和麻黄要等量，你可以多一点。

太阳中风桂枝汤，太阳伤寒麻黄汤。太阳温病葛根汤。

第四十条。

原文：「太阳」与「阳明」合病，喘而胸满者，不可下，宜「麻黄汤」。

我们平常有阳明症就代表病进入肠胃了，如果有合病，比如他这个还有太阳病，可是又带点肠胃的问题，有喘而且胸满是病在肺上面，因为喘而胸满我们知道是麻黄汤症，当有麻黄汤症的时候我们知道肺里面有寒，不可以攻下用麻黄汤来解。所以这个伤寒论的原则就是，当有表症应先解表，不可攻下，尤其是伤寒

的，病人体痛，恶寒的，结果你没有开麻黄汤，你开大承气汤，他又便秘，你一攻下的时候会结胸，寒会结在胸，称为结胸，有的时候是吃坏食物被攻下了，这个时候因为他是伤寒，我们这个伤寒跟西医讲的伤寒不一样，我们伤寒是一个症。绝对不可以下，万一被下了，结胸。他这个条辨就是告诉你，不要管其他的，你只要看到有伤寒的症状，喘而胸满，绝对不可以下，一定要先解表。用麻黄汤。

第四十一条。

原文：「太阳病」，十日已去，脉浮细而嗜卧者，外已解也。设胸满，胁痛者，与「小柴胡汤」，脉但浮者与「麻黄汤」。

这个太阳病过了一个七天，病会改变，有一种身体很好，肠胃很好的时候，得到太阳病自己就恢复了，不用吃药就好了。

如果太阳症没去掉，变成脉浮细，而嗜卧，这个已经是没有表症了，表症有的话不会有这种现象，有胸满胁痛，就是小柴胡汤。

小柴胡汤是少阳证的第一个处方。小柴胡汤的主要症状就是胁痛，就是胸胁，肋肋这边，我们叫胸胁苦满。张仲景讲的比较简单，实际上小柴胡汤会有往来寒热、恶心，然后肋肋痛，如果说脉浮者吃麻黄汤。

四十一条的原则就是，当你要辨证，如果太阳症已经没有了，进入少阳症的时候，你要知道它已经进入少阳症了，这时候麻黄汤不适合。如果过了十天，他脉还是浮在那边，还是在太阳的时候，这个时候还是给他麻黄汤。进入里面的时候，胁痛，胸满，尤其这个肋痛，麻黄汤症我们可以看到胸满，好像重复了，肋痛，太阳没有肋肋痛。这里肋痛实际上就是胸胁苦满，肋骨这一带很胀满，就是已经进入少阳了，这时我们可以用小柴胡汤。

第四十二、四十三我们把两条并在一起。

原文：「太阳伤寒」，脉浮紧，发热，恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁者，「大青龙汤」主之。若脉微弱，汗出，恶风者，不可服之；服之则厥逆，筋惕肉润，此为逆也。

太阳伤寒是麻黄汤嘛。

2——3

这里多了一个烦躁这个烦躁，手足燥了，睡觉不能睡，情绪不好，容易发怒，没有办法安定下来，好动，统统属于烦躁。出现烦躁的时候大青龙汤主之。

若脉微弱，汗出，恶风者，不可服之；这个是桂枝汤症啊。服之则厥逆，厥啊，手脚冰冷一下，也不是四逆。筋惕肉润，就是肌肉常常会跳动。这是有汗的时候津液已经伤了，结果大青龙发表的力量很强，一发津液伤到，肌肉里的津液不够，开始震动。此为逆也，就是开错处方了。

什么时候大青龙？四个字：表寒里热，就是大青龙。表是寒的症状，病人会出现恶寒，肌肉疼痛，脉浮紧对不对，表寒。没有流汗，恶寒，肌肉痛。里面是热的，舌苔是黄的，咳嗽，咳嗽跟喘是一样，然后病人躁动，胃口没有。表是寒的，里面是热的就是大青龙。经方是一症一方。还分不出来，你问他口渴不渴，里面热的口一定渴，咳嗽痰是黄的，里面都是热的。表面上有寒，里面有热并在一起的时候，就是大青龙汤症。大青龙汤一下去，表里双解。

大青龙汤是张仲景为疫病而设立的处方。症相同，中医是同症同治。在麻桂青龙三脚鼎力，麻黄汤、桂枝汤、葛根汤都是按照节气，就是春天是温暖的，夏天是热的，秋天是凉的，冬天是寒的，这个节气正常运作的时候得到的病就是桂枝汤、麻黄汤、葛根汤。你如果是春行冬令，或者是夏行秋令，或者冬行春令，节气不对的时候就发生时疫，就是用到大青龙了。

### 大青龙汤方

麻黄六两，桂枝二两去皮，甘草二两炙，杏仁五十个去皮尖，生姜二两切，大枣十二枚劈，石膏如鸡子大碎。

右七味，以水九升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服八合，取微似汗。汗出多者，温粉扑之，一服汗者，停后服。

大青龙汤，剂量看黄金比例，麻黄你不要真开六两啊，把我也吓到了。麻黄可以六钱，你分成三碗，一碗不过是两钱。

麻黄六，桂枝二，炙甘草二，杏仁五十个，生姜二两，大枣十二枚，石膏如鸡子大碎。这七味药里面重点是石膏，石膏像鸡子大，鸡子就是鸡蛋大小，按照现在剂量大概是五钱左右。真正在处方的时候，石膏跟杏仁按照状况来加减。病人咳嗽比较重，杏仁多加点，病人烧比较高的时候，石膏多加点。因为大青龙汤会出现高烧的症状。表寒里热，病人有时候会高热，烧很高的时候，石膏一两也会用到。

石膏又叫白虎。病人生烦躁的时候病人就比较危险。得病病人是静的都很好治，越来越烦躁就不好治，越危险就越烦躁。比如一个人是失眠，已经是失眠，他每个小时都有醒来一次，吃了要更不能睡，药不对。石膏能够除烦躁，因为它是很寒凉的药，很寒凉的药能够让情绪平静下来。你如果麻黄配上桂枝，配上杏仁配上石膏的时候，因为有桂枝在里面就会得汗。大青龙是麻黄汤变来的。麻黄、桂枝、杏仁、炙甘草是不是就是麻黄汤。麻黄汤再加石膏，再加生姜大枣就是大青龙汤。加减一下大青龙汤就出来了。

先煮麻黄，和之前的都一样。吃这个药汗出太多了，后面药就不要再吃了。

大青龙症是会传染的，因为是时疫嘛，疫症都是会传染的。伤寒论怎么定疫症，就是节气不对，冬行春令，老幼统统得到同样的病，就是疫病，就会传染，就这样看就好了。

如果汗出太多，温粉扑之，什么是温粉？温粉：牡蛎、龙骨(马骨)、糯米，三味磨粉等量，扑在身上，汗就会止掉。

如何预防汗发太过，就是你慢慢喝大青龙嘛。因为大青龙很强嘛，你喝的时候，先喝两口，没有汗再喝，感觉到发汗了就停掉了。把身体保暖，让它吃一点汗。

大青龙汤好到什么程度呢？我用的很多。我的病人说我这辈子感冒从来没有好那么快。吃饭第一碗要，三个小时就好了。

如果我们真正去研究大青龙汤的方疫的时候。你看它有没有道理。它用桂枝麻黄宣肺的时候，一开肺的时候，大量的汗一出来的时候，杏仁石膏，因为寒凉，

能够把津液再补回去。等于是把肺里面感染的津液瞬间换掉。排出去了，流汗流掉，津液再补回去。

中医再治病的时候，为什么我们叫辩证论治。因为我们不管你是什么病名，都是在肺里面，一次统统给你换掉。我们没有说针对那个病去杀他，没有这种想法，而是把整个换掉。

大青龙麻花剂量最高，比桂枝多三倍。

第四十四条。

四四：「伤寒」，脉浮缓，身不疼，但重，乍有轻时，无「少阴证」者，「大青龙汤」主之。

大青龙汤不单单是表寒，有麻黄汤的症状以外。如果是脉浮缓，身不疼，但是你又感觉到身重的现象，又没有少阴症。少阴症是脉很细很沉，常常会想睡觉，嗜眠的现象。没有少阴症大青龙汤就可以。大青龙汤但重，有时候重，有时候轻。从这里可以知道，大青龙可以治疗时疫以外，身上湿很盛的人，我们可以利用大青龙，因为大青龙发表的力量很强，一下把肌肉累积的湿统统排掉，所以还是可以用大青龙。

少阴症的症状就是但欲寐，就是什么都不想就是想睡觉。平常觉得身很重，病人水肿，小便不是很好，大青龙汤给他了。所以你不见的一定要感冒发高烧的时候。

第四十五。

原文：「伤寒」，表不解，心下有水气，干呕，发热而咳，或渴，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者，「小青龙汤」主之。

伤寒就讲的就是麻黄汤症，你全身骨节疼痛，身疼，脉浮紧，恶寒。伤寒表症你还没有解的时候，你没有开麻黄汤的时候，心下有水气，干呕，发热而咳。或，或就是有的时候有有的时候没有，主症是发热而咳，「小青龙汤」。

小青龙汤与大青龙都可以看到表有寒的症状。小青龙是表寒里寒。当你看到表寒里寒的时候，就可以开小青龙汤了。什么叫做表寒里寒，病人，发热恶寒，身体疼痛，没有汗，脉是浮紧的，咳嗽是白痰，口不渴，这就是寒，寒的人是不会口渴的，舌苔是白色的，这已经是小青龙了，表寒里寒。

心下有水气，心下指的是胃的地方。干呕，发热而咳，病人发烧，就是小青龙汤。小青龙跟大青龙，我们用在气喘上用的很多。临床上归纳，平常没有喘，夏天，天气热的时候开始喘，大青龙汤症，平时没有喘，冬天天一冷开始喘，小青龙汤症。因为你身体里面有热，身体跟着环境同气相求，一热它就发了。因为里面有伏热在里面。那里面有伏寒在里面，一冷同气相求它就发了。

当你知道以后，你用经方做你的基础方，便秘的时候加一点大黄啊，可以加减一下。

我们用青龙的意思就是麻黄，因为麻黄是青色的一根。或渴，或利，或噎，或小便不利这都是不一定有的。

里面是热的话，病人如果有口渴，他喜欢喝的是冷水。里面是寒的时候，他不能喝冷水。里寒还是里热，从病人喜欢喝什么温度的水都可以做为判断的依据。

### 小青龙汤方

麻黄三两去节，芍药三两，细辛三两，干姜三两，甘草三两炙，桂枝三两，五味子半斤，半夏半升洗。

右八味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。若渴，去半夏，加栝蒌根三两。若微利，去麻黄，加芫花如鸡子大，熬令赤色。若噫者，去麻黄，加附子一枚炮，若小便不利，少腹满者，去麻黄，加茯苓四两。若喘，去（去改成加）麻黄，加杏仁半升，去皮尖。

五味子和半夏加重，其他统统是等量的。五种味道混合在一起叫五味子，主要的功能是治疗咳嗽。为什么用半夏，半夏也是治疗咳嗽，半夏主要是祛痰。所以半夏跟五味子合在一起的话，化痰止咳。半夏就变成化痰，五味子是止咳。为什么用干姜，干姜跟生姜不太一样，生姜是散胃里面的寒，干姜是温中，肺里面太冷了用干姜。所以我们有甘草干姜汤症。所以干姜是能够去肺寒的，里面太冷了，小青龙汤是里寒嘛。

细辛是涤水，去水用的，这个不是很大的水，很大、很强的水细辛没有用啊，但是水气的水，细辛绝对有用。

如果有病人，咳嗽很厉害，喉咙痒，嘴巴不渴，他已经讲完了他要小青龙了。脉都不用摸，为什么喉咙痒，喉咙痒就是水气不断往上冒，喉咙痒是标准的小青龙汤症，小青龙汤有细辛在里面。细辛的目的因为里面有寒水，干姜去寒，细辛能够去一点水。

如果病人口渴的很厉害，因为半夏涤痰的作用很强，张仲景在伤寒、金匮里面，只要病人出现口渴的现象，张仲景一律不用半夏。半夏能够止呕，但是口渴的人吃到半夏嘴巴会更渴，因为半夏排水的力量很强。所以有口渴的时候，就要把半夏拿掉。这里看到栝蒌根，如果有口渴把半夏拿掉加栝蒌根，栝蒌根是很有名的止渴的药。糖尿病的人口渴我们常常用栝蒌根。我们前面介绍刚劲的葛根汤，葛根麻黄桂枝汤，桂枝汤加上麻黄葛根变成葛根汤，如果说我们把葛根麻黄统统拿掉，把桂枝汤加上栝蒌根的话就变成，柔劲的处方。

如果病人有下痢，把麻黄拿掉，加芫花，芫花很凶悍，芫花如鸡子大，芫花非常的轻，鸡子大还没有一钱，大概一克两克左右。会用到芫花是因为肺里面有积水。

“若喘，去麻黄。”这里不对，原文是“去”，但是大家一直认为这里是错的，喘是更要加麻黄，不可能说喘是去麻黄，麻黄本身是治疗喘的，这一定是哪个家伙哪个朝代搞错的。但是我们保留原书。这里我们改掉。如果有喘我们可以加麻黄，加杏仁，去皮尖了。实际上没有那么细，去皮尖因为比较苦嘛。

像这种加减的方法，我们后面常常有加减。比如加附子一枚，炮制过的附子，因为有噫，就是膈逆，胃里面太冷了，我们要用附子的热量，诸如此类的。

基本方一定是麻黄、芍药、细辛、干姜、甘草、桂枝、五味子、半夏这八味药组成。



要记得，表寒里寒的时候，病人咳嗽、气喘，小青龙。大青龙呢，表寒里热。

#### 第四十六条。

原文：「伤寒」，心下有水气，咳而微喘，发热不渴，「小青龙汤」主之。服汤已，渴者，此寒去欲解也。

一看有咳，有不渴，微喘，一看就知道是小青龙汤症。心下有水气，这个水气在胃的地方，累积的有寒气在这个地方。小青龙汤里面有干姜、半夏可以把这个水排掉，胃，心下的水排掉。小青龙汤吃了以后，如果有渴，这个正常了。小青龙汤本身是不渴的，因为有里寒。吃完药以后，口渴了，想喝水了，寒去掉了。服汤已，渴者，此寒去欲解也。光是这句，我们延伸了很多地方，比如你治了一个病人，肾脏病的人，肾脏病尿毒、积水，肾脏衰竭的人，都不口渴的。吃了你的药，又流汗，又口渴，这就是病要好了。所以口渴和胃气恢复是相同的结果。里寒去掉了，渴就出现了。

介绍到小青龙汤，就是太阳证的上篇。太阳证分上中下三篇。太阳篇是最多的，上篇我们列了几个重点，诸位一定要知道：

初者，病邪初起，正气尚强，邪气尚浅，则宜速攻。中者，受病较久，邪气渐深，正气渐弱，宜攻兼扶。末者，病已经久，邪气侵袭，正气消残，宜扶正气。

刚开始得到病的时候，“正气尚强，邪气尚浅”要迅速的攻掉它，这是上工治未病。病才到表面上就被你治好了，中医认为百病风之始。我们常常在治疗肝病，内科病的时候，本来是肾脏病肝病或者怎么样，他从厥阴症，寒热并结，厥阴变少阴症，变成太阴，变成少阳症，变成阳明症，你知道他不会死了，因为阳明无死症。

#### 2——4

阳明处方下去变成太阳证，知道他一直在痊愈。你在开始的时候就把他治好。只有经法在病邪初期的时候，一剂就把他治好了。

中者，受病较久，邪气渐深，正气渐弱，宜攻兼扶。扶正和攻两个并用。

末者，病已经久，邪气侵袭，正气消残，宜扶正气。要先扶正气。张仲景在扶正气的时候，病很深的时候，也不会用滋阴的药，强补的药，最终的时候用到人参。一般初浅的时候，用甘草、大枣、生姜。在中者的时候，他同样是甘草大枣，又加了白芍进去，滋阴的药，再重的话人参，就结束了。为什么这样子，观念是这样，把你的病治好了，然后你去吃食物，吃了食物以后，产生了营养，自己身体吸收了，恢复起来，这才是真正的痊愈的定义。病可以治的，方法要这样才对。而不是食物吃不下没关系，多种维他命给它吃。经方的观念是，当你没有病的时候，你要吃食物，当你有病的时候，你要吃更好的食物。现代人的观念被误导了，健康的时候吃食物，生病了吃药，生病的时候应该吃更多的食物才对，怎么会吃药呢，所以人才会短命。吃药是要吃，但是吃药是要把身体调理过来，让它自己能够恢复，所以当你生病的时候，要选择更好的食物才是对的。

#### 第四十七条。

原文：「太阳病」,外证未解,脉浮弱者,当以汗解,宜「桂枝汤」。

一直在讲桂枝汤,不单单是,你刚开始的到病,只要是你没有吃桂枝汤,结果病人得了一段时间,太阳中风的症还在的时候,还是适合桂枝汤。

第四十八条。

原文：「太阳病」,下之微喘者,表未解故也,「桂枝加厚朴杏仁汤」主之。

这个喘跟咳嗽很接近,我们治法一样。桂枝汤会加到厚朴杏仁,这个使用的时机是本身有桂枝汤症,又带有咳嗽。所以有的人感冒了,来找你肌肉酸痛,有点发烧,咳嗽。那你看看他,脉是浮的,但是不是很紧,有点汗,好像是桂枝汤症,但是前面桂枝汤症没有讲到咳嗽有喘,现在病人是桂枝汤症,带点咳嗽,带点喘,就在桂枝汤里加点厚朴杏仁就可以了。

厚朴跟白术完全不一样,两个都能够去湿。但差异在哪里?厚朴能够去脾湿,厚朴把脾脏的湿搬到小肠里去,所以大承气、小承气用到厚朴的时候能够让小肠增润津液,小肠能够增润津液就是厚朴去湿,把脾脏的湿移进来。白术也是去湿,但去全身关节肌肉里的湿,中焦里的湿它也去,所以白术用的时候用到茯苓,你如果白术不用到茯苓的时候,湿不会完全去掉。白术加上茯苓,湿就会从小便解掉,所以我们处方用到白术茯苓的时候,就是希望湿从小便排掉。如果白术跟炮附子在一起,干嘛?白术去湿,炮附子把它推到表面去,而不是从利尿解掉。因为你脓疮,不管是乳房的硬块或者你骨边的化脓,发炎,我们用炮附子把它推到表面来,用白术去湿,目的不一样。我们区分一下。

桂枝加厚朴杏仁,杏仁能够止渴、祛痰,能够增润肺里面的津液。攻下微喘,表未解。为什么讲攻下,脾湿的关系,因为有脾湿在里面,你一攻下以后,小肠太干燥了,加厚朴下去,把脾脏的湿移一下,小肠的湿补一下。

桂枝加厚朴杏仁汤方

桂枝三两,芍药三两,甘草三两,生姜三两,大枣十二枚劈,厚朴二两炙,去皮,杏仁五十枚去皮尖

右七味,以水七升,微火煮取三升,去滓,温服一升,覆取微似汗。

杏仁四钱五钱都没有关系。

覆取微汗,解表的时候,一定要微汗,感觉到湿湿,但是又没有汗最好。

第四十九条。

原文：「太阳病」外证未解,不可下也,下之为逆。欲解外者,宜「桂枝汤」主之。

当你有表症的时候,一定要先解表,再去谈里,这是大原则。当然有原则就有例外,如果有表症的时候,大便五六天都没出来了,人都开始烦躁了,烦躁就要注意了,还有表症怎么办,表里就双解了,一起解掉,那就有必要。否则的话,一定要先解表,不可以不解表就攻下。后面会遇到,表没有解出现的症状,都会介绍的很清楚。

第五十条。

原文：「太阳病」先发汗不解，而复下之，脉浮者不愈。浮为在外，而反下之，故令不愈。今脉浮，故知在外，须当解外则愈，宜「桂枝汤」主之。

给病人吃过发汗的药，再攻下，按照原则去做了，结果病人脉又浮起来，病还没有完全好，脉是浮的，我们知道病还在外，解还是用桂枝汤。只要有桂枝汤症都可以用桂枝汤。

#### 第五十一条。

原文：「太阳病」，脉浮紧，无汗发热，身疼痛，八九日不解，表证仍在，此当发其汗。「麻黄汤」主之。服药已，微除，其人发烦，目瞑，剧者必衄，衄乃解。所以然者，阳气重故也。

脉浮紧，无汗发热，身疼痛，这是太阳伤寒，麻黄汤症。如果八九天不解，照理说六天该好了，超过六天，八九天应该是入里了。太阳入里，不是入少阳就是入阳明。结果这个病人，它没有入里，八九天之后表证还是在那边，虽然过了一个候，六天，表证还是有，你还是要用麻黄汤。

如果吃了麻黄汤以后，微除，其人发烦，就一点点汗而已，没有大汗出来，病人还烦躁。目瞑，这个时候眼睛头昏，昏眩，剧者必衄，严重的时候会流鼻血出来，衄乃解。为什么会这样子？阳气重故也。阳气的关系，这常常发生在小孩子的身上，小孩子纯阳之体，小孩子好动，得麻黄汤症了，一看太阳伤寒，你开了麻黄汤给他，吃完以后他有一点点汗，同时流鼻血出来。大部分我们看到都在十四岁以下，十四岁是一个天葵的时间，纯阳之体在十四岁以下，我们处方麻黄汤，流一点汗，病人是烦躁，烦躁完流鼻血出来，这还是正常，只是小孩子纯阳之体。所以我们过去有句话，小孩子流鼻血的不会发高烧的，身体很好，阳气很旺的常常会流鼻血。

#### 第五十二条。

原文：太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，自衄者愈。

太阳病，脉浮紧，发热，身无汗，这是麻黄汤，自衄者愈，如果说流鼻血者，愈。所以流鼻血正常。不要把它当病在治。如果四十岁的人没有脉浮紧，发热，身无汗，也在那里流鼻血，你要去治他。

#### 第五十三条。

原文：二阳并病，「太阳」初得病时，发其汗。汗先出不澈，因转属「阳明」。续自微汗出，不恶寒，若「太阳」病证不罢者，不可下，下之为逆。如此可小发汗。设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之熏之。若发汗不澈，不足言阳气怫郁不得越，当汗不汗，其人烦躁，不知痛处，乍在腹中，乍在四肢，按之不可得，其人短气，但坐，以汗出不澈故也，更发汗则愈。何以知之，汗出不澈，脉濇，故知也。

二阳并病，太阳跟阳明并病。汗先出不澈，就是汗没有透发。过了六天转成阳明症。转成阳明症进入肠胃，比如有下痢，恶心，呕吐，便秘，会有这种情形。但是这个时候还是会有微微的汗出，不恶寒。这个时候，你发表没有透发，病进入阳明了，在这个阶段，你看到还有太阳证的时候，病没有完全停掉，这个时候千万不可以攻下，因为阳明症常常会产生便秘的情形。为什么会这样子，因为，当你用太阳病的处方，比如说桂枝汤或葛根汤，麻黄汤还好。你开桂枝汤或葛根

汤的时候不敢开重剂，汗没有得透彻的时候，桂枝汤或葛根汤下去，肠胃的津液跑到皮肤表面上，本来是要发汗出去的，发一点，没有透发，可是你肠胃里面的津液就没了，肠胃津液干掉以后，便秘，大便不出来。大便排不出来，这个时候你不可以下，因为你还有表症在那边，张仲景的意思是只要有表症在那边，你就不可攻下，就是怕表邪下陷。经法在救逆的时候，处方有时就一两味药。你违反了伤寒论的原则，表症还有，结果你把它攻下了，那要怎么样应辨。这里是告诉你不可下，一定要照这个原则，不然表邪还有的话会下陷，可能下陷到肺，可能下陷到三焦淋巴系统去，都不一定。所以下之会有逆症的现象产生，这样子我们可以小小的发汗一下，假设面色缘缘正赤者，阳气怫郁在表，当解之熏之。因为你已经发过一次汗了，第二次不要再发那么多了。

所以要么就给他发透一点，不要留一点下尾巴，很麻烦的。我们如何知道他汗没有透发，因为脉涩。涩脉就是脉比较细比价微。这个条辨就是告诉你，计然你用发表的药，一剂就发透。发透又不能发太过，旁边准备一些温粉，其实你喝一碗下去，应该不会发太过的。这个条辨就是要知道，只要表症还在，不管是多久了，还是可以吃发汗的药。

#### 第五十四条。

原文：脉浮数者，法当汗出而愈。若下之，身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解。所以然者，尺中脉微，此里虚，须表里实，津液自和，便自汗出而愈。

若下之，如果你没有开发表的药，开攻下的药，造成身重，心有动悸者，不可发汗，当自汗出乃解。这种现象，是本身他素虚，有的人先天体质就比较差，有的很壮，一剂就好了，有的你攻下他以后身重、心悸，遇到这种情形他是素虚之人。这个时候你不要再去发汗了，因为你前面发汗的药下去以后，他身体虚，身重的原因是他汗流掉了以后，津液没有办法马上补回来，因为他身体比较虚，还有，汗为心液，所以心脏很好的人，运动会流汗，素虚之人，你把他汗解掉以后，他会动悸，因为血里面的水不够了。如果看到这种情形，不要再发汗了，因为病人是里虚，里虚的人让他休息一下什么都不要给他，你让他多喝点稀饭，慢慢把津液补足，津液补足的时候他自己会流点汗，就好了，不要再去动他。为什么会这样子？尺中脉微，此里虚。如果按脉的阴阳来说，寸为阳，尺为阴，他现在讲尺脉很细弱，代表阴虚，阴里面阴虚掉了，比如我这是手上肌肉，肌肉里面的水分不够了，就是阴虚。

须表里实，津液自和，便自汗出而愈。因为他是阴虚，等他表里都实了，汗自出，病人自己会好。最好的方式是让他多吃点稀饭，好消化的东西。你可以吃点葱，葱是可以发汗的，生姜都可以。

#### 第五十五条。

原文：脉浮紧者，法当身疼痛，宜以汗解之。假令尺中迟者，不可发汗。何以知其然？以营气不足，血少故也。

脉浮紧者，你轻轻就摸到脉，很强硬，当身疼痛，宜以汗解之，开麻黄汤给他。你开麻黄汤之前，你摸他的尺脉很沉、迟，我们知道他里面是津液不够。这个条辨就是说，当你开发表的药的时候，结果遇到病人是没有条件开，里面是津液不够，你不可以给他开发表的药，因为他营气不足，血少故也。伤寒、中风，

如果我们用营卫来解释，中风伤到卫，伤寒营卫都伤。按照黄帝内经，卫是气，营是血。所以伤寒的麻黄汤会有麻黄跟桂枝。

上堂课第五十四条，一般摸到脉是浮，代表病在表，数就是热。法当汗出而愈，就是我们开发表的药，汗流出来就好了。你如果下之，身重心悸者，不可发汗，当自汗出乃解，什么意思就是你遇到发汗的人，你汗解的时候，是你攻下的时候心悸的人，什么叫攻下心悸，处方抓的很准，一剂透发，病人风和寒统统透发出去，没有病毒残留在身体里面，这种人一剂就好了，有的你剂量不够，表症没有完全去掉，你攻下，病邪会下陷，病人身重心悸者不可发汗，这是说，它并没坏事，张仲景的意思是该发表的时候，你发表不够或你没有发表，你误下，攻下了以后，风邪下陷下去以后，会产生结胸，那种症状很凶悍，心下痞，不能睡觉，不能躺平，咳嗽，肺里面有积水，

## 2——5

那是很严重了。这种只是身重、心悸，这种我们就不用去发汗了，等他汗自己出来。为什么？就是因为尺中脉微，尺就是阴脉，里虚了。

第五十四这个条辨就是当你发表的药，发下去以后，如果病人还没有透发，你不用急着再去攻它，就等它，因为他里虚，没有那么快。有的人很快，一剂吃完三个小时就解掉了。有的人要隔天，中午饿了吃东西了，这个就代表他的病解掉了。有的还没有完全好，病人有身重心悸的现象，你不要动他，这个是很浅的症状，病邪还没完全去，这个病你药是对的，但是病人身体比较虚，稍微等一下，让他自己流汗出就会好，不需要再去治他。

如果我们经验比较丰富的，一看到如果脉是浮数，病人有汗，恶风，我们知道是桂枝汤症，一看他尺脉比较弱，舌苔比较厚白，知道他中湿，本来他是湿气很盛，这个时候我们可以加一些白术茯苓在里面，同时开在发表的药里面，当表一解，汗流出来，同时湿从小便排出来，这种现象就不会产生了。

第五十五条，如果是脉浮紧，浮紧是伤寒，浮是表，紧是寒。法当全身疼痛，因为当你表受寒了以后，皮肤毛孔都会缩小，缩小以后汗水不能透发，影响到你的水的循环系统，这个时候全身会疼痛，一般遇到这种我们都是用汗解。如果说尺脉迟者不可发汗，因为营不足，血少故也。我们平常判断一个人的气血，寸脉为阳为卫，尺为阴为营，所以说如果尺中迟者不可发汗，因为我们在用麻黄汤的时候，麻黄配上桂枝、杏仁、炙甘草，麻黄汤吃下去速度很强，如果正常人，血里面的水会替换掉，排出来，因为这个麻黄。如果说他本身就血气不够，比如有贫血的现象，这个时候你开麻黄汤下去以后，这个血会更亏，因为汗血同源，遇到这种情形我们尽量不要发汗，可是你遇到必须要发汗他又是贫血的人。这个条辨的意思就是说，你要给病人发表药的时候，一定要确定于病人能够承担发表药，如果不能承担发表药我们怎么处理，简单讲就是这个意思。如果我们知道他营气不足的时候，血少故也，比如这个人需要麻黄汤，这个人身体又虚，我们可以先煮一些药，因为麻黄汤发汗大部分汗是从肺里出来的，肺跟心脏就像汽车的引擎跟水箱，麻黄汤下去，肺里面的津液会跑到皮肤表面来，会动到血分里面的水分，贫血的人水就不够，这是你可以给他吃一些比如水梨、西瓜，能够补津液的东西。这是麻黄汤下去就不会有这种现象。如果病人吃麻黄汤没有动悸，这个人心脏很好，心脏不好的时候，你麻黄汤一下去，心脏就开始跳加速。所以你也可以用这

个做个标准，比如在治疗一个肾脏衰竭的病人，处方下去都很好，结果一加麻黄他受不了，流汗排水，但是心脏受不了，人会倦怠，代表这个人还没有完全恢复，还承受不了麻黄的现象。

#### 第五十六条。

原文：脉浮者,病在表,可发汗,宜「麻黄汤」。

太阳中风、太阳伤寒、太阳温病都会找到浮的脉。会用到麻黄汤一定是无汗，身体全身疼痛，恶寒、无汗的很重。这就是麻黄汤。

#### 第五十七条。

原文：脉浮数者,可发汗,宜「麻黄汤」。

#### 第五十八条。

原文：病常自汗出者,此为营气和。营气和者,外不谐,以卫气不共营气和谐故尔。以营行脉中,卫行脉外,复发其汗,营卫和则愈,宜「桂枝汤」。

太阳中风一定伤到卫。太阳伤寒麻黄汤症营卫都伤。因为和则愈，宜桂枝汤，没事的时候喝喝桂枝汤。桂枝行阳，白芍是阴，阴阳的两个处方，这是调和阴阳的主力的方子。

#### 第五十九条。

原文：病人脏无他病,时发热自汗出而不愈者,此卫气不和也。先其时发汗则愈,宜「桂枝汤」主之。

你没有病，但常常觉得身体热热的，发点汗。有的时候我用这个处方，桂枝汤效果都很好，这就是平时保养的地方。

#### 第六十条。

原文：「伤寒」,脉浮紧,不发汗,因致衄者,「麻黄汤」主之。

伤寒是伤到营卫，脉浮紧，浮是表，紧一定是寒，这个时候病人没有发汗，但是有鼻血。因为麻黄汤里面，麻黄宣肺，肺打开来。杏仁能够增润肺的津液，麻黄跟杏仁配在一起的时候，本身病人不会出汗，一定要靠桂枝，因为桂枝是卫分，桂枝跟麻黄一起的时候把营卫同时解掉，张仲景怕麻黄发散的时候把肺里的津液伤到，所以加杏仁预防伤到津液。我们用麻黄发汗，伤寒是肺，肺主鼻子，一吃麻黄汤，全身血脉加速。有一种病人吃了麻黄汤没有发汗，流鼻血出来，代表病还没有去，只是集中到了鼻子上面。全身有三万六千个毛孔加两个（鼻孔），就那两个见到血，毛孔还没有发汗，汗血同源，你看到血，再给他麻黄汤吃发汗才能完全好。一般临床看到流鼻血，病人都有发高烧。

#### 第六十一条。

原文：「伤寒」,不大便六、七日,头痛有热者,与「承气汤」。其小便清者,知不在里,仍在表也,当须发汗。若头痛者,必衄,宜「桂枝汤」。

阳明篇会介绍的很详细，这里提到我就跟诸位稍微讲解一下，我们三个承气汤：调胃承气汤，小承气汤，大承气汤。胃下方十二指肠这一段，就是调胃承

气汤的时候。堵在小肠里面，会用小承气，堵到大肠里面的时候，我们才会用到大承气。这三个症状都不一样，但都是攻实热的，三个有个共同的现象，就是小便是黄的。因为里面是热，很干燥，所以最明显是小便。攻的时候什么时候停止就问他小便的颜色，小便是清色、淡黄就可以停了，代表好了，里面宿便没有了。

不大便六、七日，头痛有热者，与「承气汤」。伤寒论的原则，由表症的时候，我们不攻里，先解表。六十一条就是说，如果病人伤寒了，我们要解表，结果病人说有六七天没有大便秘了，这个病人有头痛有热者，因为燥矢造成的身上过热，一般承气汤症，大便堵到的话头痛都在印堂，我们可以给他承气汤。如果小便是清的，我们知道这个发热跟里没有关系，病还是在表，这个时候我们要发汗。如果有头痛会流鼻血，我们还是给桂枝汤。太阳伤寒的时候，遇到病人有便秘，我们尽量不要给麻黄汤，给桂枝汤来取代麻黄汤，等大便出来以后就可以了。如果有便秘，我们给桂枝汤来解表比给麻黄汤解表要好，这是他的一个大原则。临床上的时候，不要顾虑那么多，你知道他是麻黄汤，但是大便堵到六七天，小便是黄的，知道里面是承气汤症，那先解表还是先攻里，不要想那么多，人体很奥妙的，你把承气汤跟麻黄汤开在一起都没有关系，我就碰过这样子，那你怎么办，如果你是碰到两三天，先解表再攻里嘛，没有那么急。已经六七天了，算了，不要那么急，两个开在一起，结果开在一起的时候，两个同时好。为什么可以这样子做，刚开始还没有。因为美国人你给他说，这个药你先吃，吃完再吃这个，结果他忘掉了，回去两个药放在一起煮，结果表里同时解掉了。后来我们知道这个可以同时用，没有那么严格。

#### 第六十二条。

原文：「伤寒」，发汗，解半日许，复烦，脉浮数者，可更发汗，宜「桂枝汤」主之。

伤寒，麻黄汤症，给他麻黄汤了，半天很好，半天以后身体又开始不行了。这个意思是说，伤寒的时候你是营卫都伤，你给他麻黄汤以后营解掉了，卫还没有解掉，可能你麻黄汤里面桂枝开的量不够，所以麻黄汤的症没了，但是还有中风的现象，伤寒的现象没了，但是还有中风的症状，这个时候你就给他桂枝汤就可以了。从这里也可以解读出来，中风伤卫，伤到表气，表水，伤到太阳寒水，伤寒伤到水跟血，统统伤到。所以伤寒的时候，麻黄汤里就有桂枝，意思就在这里。

#### 第六十三条。

原文：凡病若发汗，若吐，若下，若亡津液，阴阳自和者，必自愈。

阴阳自和者，从哪里可以看出来？脉，寸脉和尺脉中间有关脉，两个脉缓下来，不浮了，脉是缓一息四至，就是说医生你摸他的脉，你一呼一吸他的脉跳五下，脉非常缓，从脉上面知道他脉阴阳和。从外症上也可以知道，病人说我现在很舒服，但是比较累一点，这就是阴阳合了，自己会好。还有呢，你汗法，若吐、若下，比如吃了麻黄汤流汗，现在已经不流汗了，病人没有燥渴，代表病人津液没有伤到，这都是阴阳自和的现象。这个时候自己会痊愈，你不要去给他药。

经方的大原则是，比如说你现在很健康，可以吃补，如果生病了，就要吃药，药吃完了以后，等病完全健康了，再去吃补药。张仲景，亡津液了，不开滋阴的药，处方都不开。津液不要去补它，要让它自己回头，病才是完全的去掉。

#### 第六十四条。

原文：天下之后，复发汗，小便不利者，亡津液故也。勿治之，得小便利，必自愈。

有的人有长期便秘，你攻下之后，全部清出来了，吃完以后还没有停，你再给他发汗的药，结果发汗以后，小便不利，汗和尿是同源，代表津液伤到了，小便很少了，这是因为津液不够，这个时候不要治他。你问病人，小便痛不痛，有没有血，没有什么都没有，就是小便不多，这个小便不多，我们就要考虑是不是津液伤到了。比如吃了一个坏便当，上吐下泻，上吐下泻以后病邪还在不在，这是一个技巧，当你吐、下，病去了没有，就是渴，病人说非常口渴，不要再给他药了，病好了。如果没有口渴，不行再吃。后面我们会介绍到十枣汤这些很峻的药，一剂下去以后，问他，口渴，好了，就不再给他药。口一点都不渴，代表你还没有清干净，再吃。我们依据渴不渴来知道病邪去了没有。

像这种小便不利，是因为你攻坚，发汗以后，津液没了，不代表是危险，你不要动他，让他自己好。等他津液慢慢恢复了，小便顺利了，自己就好了。

#### 第六十五条。

原文：下之后，复发汗，必振寒，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。

攻下了以后你又给他发汗，这是没有按照顺序来做，我们应该先解表再攻里才对，你先“下之后，复发汗，脉微细。所以然者，以内外俱虚故也。”这个没有坏事，只是表里都虚。张仲景写内外俱虚，他不用阴虚阳虚，他不用这个字，我们给他补进去，他为什么不用这个字，因为他怕用了这个字后，就开始开药了，张仲景很不赞成滋阴的。张仲景从不提阴虚，就是内外俱虚，我们可以吃一些很好的食物，他没有开处方。这只是虚，没有危险。危险的时候就不一样了。

#### 第六十六条。

原文：下之后，复发汗，昼日烦躁不得眠，夜而安静，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，「干姜附子汤」主之。

你如果遇到这种情形，就要开处方了。攻下，又发汗，病人出现了昼日烦躁不得眠，我每次跟病人讲，我们最怕烦躁，烦躁就很危险，烦躁不得眠，夜而安静，如果你病只发在白天，晚上很正常，白天是阳，晚上是阴，不呕，不渴，无表证，脉沉微，身无大热者，这很简单，就是阳虚，没有呕，代表胃没有问题，没有表证，攻下之前脉是浮的，现在脉沉下去了，身无大热，这种状况就代表阳虚了。阳虚的时候，晚上很正常，只有在白天，他用干姜附子汤。

#### 干姜附子汤方

干姜一两，附子一枚，生用去皮破八片。

右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

干姜你不要真的开一两，处方我们差不多两钱就够了，生附子也是两钱。这里附子为什么去皮？生用的附子去皮，生附子有纤维在皮上面，你把黑皮去掉只留肉在里面，不需要用棉布包。干姜是温中的，最主要是温胃和肺，上焦的。生附子温心阳，



所以心脏力量不够的时候，我们用生附子，还有命门火衰的时候，我们也用生附子，如果肾脏的阳不够，张仲景都用炮附子。

四逆汤症我们会用生附子，为什么？因为心脏的阳不够，心脏的阳不够怎么讲，就是搏动，跳动，比如正常阳够的，心脏是这样跳（双手摩擦状），速度是这样，很热。阳不够的人，心脏也是这样跳（双手摩擦状），但是没有心脏阳够的人摩擦力好。所以摩擦力比较小，是心阳不够，生附子一下去，就跟正常一样摩擦力了，但速度还是一样。而麻黄不一样，麻黄发阳（手指开合动作）发，发阳，麻黄下去速度就加快了，生附子不会，这两个不太一样。附子拿出来时候，你看他长得样子，不看颜色，样子就像心脏。你看它颜色是黑的，我们知道它入肾，肾脏里面有水，肾脏里面水很多，但是肾脏里面如果没有火，这个水是死水，水里面一定要有热，而这个水里面的热就是附子。

干姜附子汤，是补阳的，张仲景不补阴，当你干姜附子汤下去的时候，阳会回头，阳回来，阴自己会慢慢回来。

这个干姜附子汤，我们书上也介绍一些名家开的方，像三因方，圣济总录。三因方是三因嘛，必有三个因，内因、外因、不内不外因，三因方里面干姜附子汤。那外用像圣济总录，附子散，用附子和干姜，来治冻疮。冻疮的时候干姜附子可以用，但是你光是外敷不够，你不要说这个很好，以后小孩子光给他敷这个粉，不行！还是会截肢，内服是当归四逆汤，我们介绍到当归四逆汤再详细介绍。所以外面的方子，医术你可以看，但是一定要经方很熟，伤寒、金匮很熟了以后，这个时候你再去看其他的书，不会迷惑，不然的话你迷惑了，你认为书上写的是对的，以后你看到小孩子冻疮的时候，你就给他药粉。药粉是没错，但你不知道应该在当归四逆汤上面，先给小孩子吃当归四逆汤，同时给他外敷药粉，马上就好了。所以我不推荐很多书给你，意思是希望你们伤寒金匮很熟，用这个做你的根基。很熟了以后，你再看其他的书，你就不会迷惑，就不会有错误的现象产生。

这是干姜附子汤，救逆用的。

如果里虚，其他很正常，你不用开处方，病人自己就会好，一旦遇到烦躁，病人白天很烦躁，晚上很正常，只要有烦躁现象出现的时候，你就要用药了，千万不要忽视这个烦躁。后面非常多的地方都在讲烦躁。如果没有烦躁，病人很平稳，只是很虚，你就不要给他处方，让他好好休息，津液慢慢回头就会好，出现烦躁，就要开处方了。

第六十七条。

原文：发汗后，身疼痛，脉沉迟者，「桂枝」加「芍药」、「生姜」各一两，「人参」三两，「新加汤」主之。

你看发汗以后，很多都是开发表的药开过头了，有的时候不是开过头了，而是病人节省，第一碗喝完了，好了。第二碗、第三晚他不想浪费，喝掉了，也有可能，所以原因很多。张仲景考虑的很细腻，如果说你过于发汗，怎么弥补他，你看发汗后，身疼痛，照理说本来是疼痛，应该不痛了对不对，脉沉迟者，沉是代表里，迟代表寒，里寒。你病去了，但身体的津液伤到了，这个时候怎么弥补，

就出现了新加汤。这个新加汤跟前面的桂枝汤加附子不一样，桂枝汤加炮附子是流汗不止，表虚，一直在流汗，这个时候我们要收敛他，这是桂枝汤加炮附子。这个不是，这是发汗以后，没有流汗，身疼痛脉沉迟者，代表里虚掉了，身疼痛。我们怎么帮助他，把桂枝汤加芍药，生姜各一两，人参三两，芍药增加一钱，桂枝加三钱。所以同样桂枝汤，原来桂枝白芍是等量，这个时候等量里面的白芍再加多一点，加一点生姜，再加一些人参下去。这里看出来，张仲景在补阴滋阴的时候，他就是用人参，生姜、甘草、芍药就够了，看不到其他的药，张仲景经方的观念一直是把身体阳气恢复，代表脏腑的功能恢复以后，希望阴液自回，而不是补阴的药给你。补阴的药给病人，身体会退化，就好像，我们为什么不赞成女性荷尔蒙，荷尔蒙应该身体自己制作出来，结果你找个取代的药，身体不去制造了，身体是不是睡觉了，就好像糖尿病的人，消渴的病人，他血糖很高，就算你西医研究是对的，胰岛素缺乏了，你就给他吃人工的胰岛素，你越吃人工胰岛素，身体胰脏就越来越退化掉，我们应该研究如何把胰脏功能恢复，让这个人自己分泌胰岛素，然后才能自动。人是一个自动的机器嘛，你不能研究出个东西取代它，西医都是酵素，反正酵素就结束了，那你酵素吃的越多的时候，身体越退化。中医经方是想办法让胰脏功能恢复，恢复以后，让你身体可以正常分泌胰岛素，血糖统统正常。这是中医得观念。

新加汤是一个补救的处方

桂枝三两去皮，芍药四两，甘草二两炙，人参三两，生姜四两切，大枣十二枚擘。

右六味，以水一斗二升，煮取三升，去滓，分温服，余依桂枝汤法。

“以水一斗二升，煮取三升，去滓，分温服，余依桂枝汤法。”我们在学医的时候，要化繁为简。伤寒论说禁滑冷什么的，张仲景那个时候也没想到吃生鱼片。反过来我们直接说你可以吃什么，很简单，你像吃完这种药，吃些清淡的就好了，不要再吃油腻东西。你如果吃肉，会有浮热，比如你吃完桂枝汤、葛根汤、麻黄汤，你去吃肉，病邪不会完全出去，因为肉类不会很好消化，所以你就吃一些清淡的，米汤类的，吃面也没有关系，煮烂一点，清汤不要加猪油什么东西。解表发热的药都是很热性的药，当然寒凉的食物不要吃了。等到正常了以后再吃。什么叫正常，第二天胃气恢复了，就叫正常。

新加汤是弥补汗剂太过了用的。当你流汗不止的时候，要桂枝汤加附子，不要新加汤哦，新加汤是补津液的。为什么叫新加，就是吃了之后，瞬间把津液补回去。

病人流汗不止了，你应该开桂枝汤加附子，结果你开新加汤，他越吃越流汗。表虚的时候要加炮附子。不要弄错了。

第六十八条。

原文：发汗后，不可更行「桂枝汤」。汗出而喘，无大热者，可与「麻黄杏仁甘草石膏汤」主之。

当发汗以后，病人出汗了，不要再给他桂枝汤。当你发汗以后，病人很好，就是还有点咳嗽，喘，短气的现象或者咳嗽的现象。这个时候没有大热了，因为热已经退掉了，桂枝汤、麻黄汤、葛根汤都可以去热，小孩子发烧，大青龙、小

青龙都可以去热。看发烧是什么病，再决定给他。没有大热了，就可以吃麻杏甘石汤（麻黄杏仁甘草石膏汤）。

#### 麻黄杏仁甘草石膏汤方

麻黄四两去节，杏仁五十个去皮尖，甘草二两，石膏半斤打碎绵囊。

右四味，以水七升，先煮麻黄减二升，去上沫，纳诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

麻杏甘石汤虽然有麻黄，但吃麻杏甘石汤并不会发汗。是很有名治疗气喘的可以用。黄金比例，麻黄三钱，杏仁两钱，石膏五钱、六钱都没有关系，这个跟大青龙、小青龙不一样哦，大青龙麻黄比如说六钱，杏仁开两钱，石膏开四钱，四加二正好跟麻黄相等，绝对不会伤到津液，比例就是这样子。石膏目的是去热。麻杏甘石汤的石膏也是去热，杏仁是祛痰、润肺。因为他没有大热，所以麻杏甘石汤，跟大青龙不一样，我们不需要靠麻黄来发表、出汗，所以麻黄剂量不用很多。大青龙的时候，病人有高烧，有时候咳的呼吸呼不过来。SAS 就是这种大青龙汤症，你处方麻黄剂量不够，明明是大青龙可以治好，可是你手软处方不够，病人死掉了，所以那个时候下手要重，不要怕，就是比例。这个人如果高烧很重，咳嗽，痰不多，石膏用到五钱，麻黄还是六钱，杏仁一钱。如果说痰比较多，烧没有那么多，石膏用两钱，杏仁用四钱。可以加减，但是石膏与杏仁合起来的剂量一定要与麻黄剂量等。这个麻杏甘石汤本身没有大热，所以不用担心。也就是说，如果病人发烧，结果你开出来的却是麻杏甘石汤，你开错处方了。因为麻杏甘石汤不是要治疗发烧的。所以病人发汗以后，有喘的现象就开麻杏甘石汤。煮的时候也是一样，先煮麻黄。

开汤剂，有时你不知道时机怎么用，因为你们现在没有经验，等你们学完以后，用过一次从此就记得了。不是很难。

#### 第六十九条。

原文：发汗过多，其人叉手自冒心，心下悸欲得按者，「桂枝甘草汤」主之。

#### 第七十条。

原文：发汗后，其人脐下悸者，欲作「奔豚」，「茯苓桂枝甘草大枣汤」主之。

后面会出现很多的像脐下悸、心下悸这种现象。心下动悸，心下在两肋骨相交下面（约鸠尾穴处），你摸下去可以摸到跳动。肚脐左边肝，脐中间是脾，脐右边是肺，脐上方有动悸是从肾脏下手治疗，脐下方有动悸是从心脏下手治疗。

这里先学脐下动悸，肚脐以下动悸是心脏，所以肚脐往下走有关元穴，关元小肠的募穴，和心脏是表里。

这个你发汗过多，当我们处方使用麻黄汤的时候，肺里面的津液会往外走，跑到皮肤毛孔上流汗出来，正常身体很好的人，当津液出去的时候，人体是没有间隙的，不能有空气的，所以汗一出去，后面会自然补位。正常人，食物到胃，进入小肠，小肠是火很热，把食物分解掉，分解掉进入大肠只剩下水和食物的残渣，水在上面，小肠火在下面烧，水回头到肺里面，这是肺最好的津液。你如果没有经过这个管道，喝水，喝下去就跑掉了，根本不会经过小肠，大肠。所以有的人渴饮千杯不能止渴，肺里面的水一定要从食物里面的水来，我们取得水有两

个管道，一个是食物里面的水，食物里面的水会为我们身体所受用，这是我们阴的来源，血的源头，当你的肺里面的水排掉以后，下面的水没办法上来，顶在这个地方，就会出现叉手自冒心，心下悸欲得按，为什么要按在这边，他按着比较舒服，喜按。诸位要记得，只要喜按，代表里面没有问题，按着不舒服，代表里面有实症，就危险，肿块、肿瘤，大便堵到也是不要按。这里按到，是虚症，没有东西，只是水冲上来，这个时候是桂枝甘草汤主之。平常人，你发汗就好了，有的人就会有心下悸，他平常肠胃不好，所以汽化的功能不够，你药下去的时候，汗发掉了，水补位没那么快，不像肠胃好人，补位很快。

正常我们身上水和水气不相等，水气是我们身上所受用的，水我们身上不受用，意思是这个水的冷的，寒的，水气是热的。水冲上来的时候，才会有这种动悸的现象，因为心脏是火，比如你汽车引擎很热，结果你水倒到引擎上面，引擎正在热，你水倒上去，所以会有动悸的现象，心不受这个水，这个时候我们用桂枝甘草汤。为什么用桂枝，就是加强心脏喷射的力量，因为桂枝在本草里面，能降冲逆，就是指这个地方。我们有桂枝加桂汤，桂枝汤里加肉桂。像桂枝甘草汤，这个冲是冲脉往上升，有桂枝上来可以把这个水气化掉，因为只是中焦，心下这个地方，所以我们用桂枝就好了，这是弥补的措施。

桂枝甘草汤方

桂枝四两去皮，甘草二两炙。

右二味，以水三升，煮取一升，去滓，顿服。

剂量上四比二，桂枝四，炙甘草二。一剂喝下去就可以了。

第七十条是你发汗以后在脐下悸，脐下动悸，苓桂甘草汤(茯苓桂枝甘草大枣汤)。

六十九和七十条的差异就是，六十九条，是吃麻黄汤太过以后产生的现象，七十条，吃桂枝汤太过，所以动悸的位置不一样。六十九吃麻黄汤，发汗太过，肺里面的津液不够，下面的津液来补的时候，来不及补，耿在这（心下），所以产生心下悸。这个是桂枝甘草汤，两味药就够了。

第七十条是，你如果说吃桂枝汤太多，你怎么知道他吃过头了，就是病人有脐下动悸的现象，欲作奔豚，就是准备要奔豚还没有发奔豚，同样是桂枝甘草，但是我们同样加了茯苓红枣。茯苓可以去烦，利尿，茯苓是白色，在松树的根下面，山猪啃过的地方有茯苓，茯苓本身有滋润津液的功能，茯神能够定心神，茯神、茯苓都是在松树下面，所以茯苓本来就有除烦的功能在里面。

桂枝甘草茯苓大枣汤方

茯苓半斤，甘草二两炙，大枣十五枚劈，桂枝三两去皮。

右四味，以甘澜水一斗，先煮茯苓，减二升，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。作甘澜水法，取水二斗，置大盆内以杓扬之，水上有珠子五六千颗相逐，取用之。

第七十一条。

原文：发汗后，腹胀满者，「厚朴生姜半夏甘草人参汤」主之。

因为发汗以后，像桂枝汤你一发汗，肠子里的津液没了，肚子胀，可是他也沒有便秘，这个时候排气排的很多。这个处方用的很多，如果病人一天到晚放屁，就可以用了。

虚胀跟实胀，最简单的区别方式就是问小便，小便淡白虚胀，小便很黄实胀。如果开错处方了，他本来实胀，要开承气汤把大便清出来，结果你开虚胀了，那只是多放屁而已，没有什么影响。如果是虚胀你开成承气汤，不得了了。

有的时候是因为便秘引起的下痢。比如有病人下痢，一天十几二十次排出来都是水，糟糕，不知道他是实还是虚。你用手去按天枢周围，病人拒按，这是承气汤症，便秘引起的下痢，大便堵在大肠，很硬，只有旁边小缝隙可以通过，肠子里面的水排出来了，大便排不出来，造成一天上十几二十次厕所，排出来都是水，这个是因为便秘引起的下痢。还有一种也是大便堵到，旁边排不过，只有中间一个小缝隙可以排过，这个大便排出来细细长长的，这是便秘造成的，也是承气汤症。虚实你实在不会辩证，你摸摸肚子，很痛拒按是实，就是承气汤。最怕是虚胀，虚胀你如果不能确定，你压压肚子他不会难过，你少压一点，压太过他排气，是你压的，本来就会排气，你压更排，这是虚症，「厚朴生姜半夏甘草人参汤」下去，这种现象就会减少。减少原因，你看厚朴，厚朴实际上能去湿，对脾脏非常好，厚朴可以把脾脏里面的湿，移到肠子里面去，为什么会“腹胀满”因为你一发汗，肠子的津液没了，就干掉了，干掉以后，又没有什么宿便在里面，这个时候肠气就会比较多。希望津液补回到肠子里面，肠子就不会排气了，津液够就好了，所以厚朴。生姜，半夏止呕逆，甘草，人参滋润津液。

#### 厚朴生姜半夏甘草人参汤方

厚朴半斤去皮炙，生姜半斤切，半夏半斤洗，人参一两，甘草二两炙。

右五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

厚朴我们一般用三，生姜用三片，半夏也是三钱，人参一钱就够了，炙甘草两钱。这个处方不单这里使用，有时候胀气，肚子胀胀的，都在使用。有时候肚子很大，很胀气排不出去，都是这个厚朴生姜半夏甘草人参汤方。

#### 第七十二条。

原文：「伤寒」，若吐若下后，心下逆满，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者，「茯苓桂枝白朮甘草汤」主之。

我们在心下这个地方，就是胃的地方，刚好跟我们横膈膜靠在一起的地方。平常水从大肠升上来，进入肺。如果说这个人是伤寒，伤于寒的时候我们应该要发表，结果来不及发表，病人吃坏食物了上吐下泻，津液虚了。到你手上的时候，你没有注意他吐泻过，你给他处方，发汗的药，也就是说他先伤到肠胃的津液以后，吃了发汗的药，吃到发汗的药，吃坏肚子本来已经伤到肠胃的津液了，再一发汗，肺里面的津液不够了。上面的水是麻黄汤发汗，肺里面的津液没了，上吐下泻肠胃的津液没了，水气停在横膈的地方没有办法动。我们身上一个东西缺掉，一个东西一定会去补位，你上吐下泻以后。本身就有伤寒，表面上的汗水堵在那边，你汗水没有办法排掉，你吃坏肚子，上面的津液没有办法补位，因为水气不

通，你再开发表的药，肺里面的津液流汗流掉了，伤寒的症状没了，恶寒、头痛、身痛、发烧的症状没了。麻黄汤把肺里面津液停掉，津液会停在横膈来不及补充，这是津液受到伤害了。

脉会沉紧，代表里寒，沉就是里，紧就是寒。这个时候会晃动，晃动的原因是横膈，横膈膜像海绵一样会吸水。中医认为，中焦横膈像天平的底座，当你横膈有水，没有办法排掉，人一动水就跟着动，上面会晃动，就会产生头眩。苓桂术甘汤，你看白术跟茯苓是去中焦，桂枝能够降逆。所以苓桂术甘汤下去，中焦的水会排出来。一排出来，头昏现象就去掉了。

很多人站起来就会头昏，起则头眩，他不起，躺或坐在那就不会头眩，站起来就会头昏，就是苓桂术甘汤症。躺下去，不动就会头昏，不是苓桂术甘汤症。苓桂术甘汤就是起这头眩，动才会晕眩，中焦横膈水堵在这边。原因很多，不单单是因为你伤寒，上吐下泻以后，常常运动完口很渴，喝水喝很快，堵在中膈也会头昏。

茯苓桂枝白朮甘草汤方

茯苓四两，桂枝三两去皮，白朮二两，甘草二两。

右四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

最重的剂量是茯苓，所以茯苓利水的力量很强。如果病人起则头眩，临床上看到，不单单是这样，还有恶心，我常常在苓桂术甘汤里加一点半夏在里面，把水排掉，因为我们知道是水。

这个水饮是停在中膈。

第七十三条。

原文：发汗，病不解，反恶寒者，虚故也。「芍药甘草附子汤」主之。

吃了你的药反而怕冷，这个是他本身体虚的原因。并不是你开错了。恶寒，代表里阳不足了。

芍药甘草附子汤方

芍药三两，甘草二两炙，附子二枚，炮去皮，破八片。

右三味，以水五升，煮取一升五合，去滓，分温三服。

炮附子用的比较重，四钱五钱，剂量比较大。这个是一般芍药甘草附子汤的剂量。炮附子用的比较重，因为他是补里虚。张仲景补里虚都是用芍药甘草。里寒的时候张仲景都是用炮附子，生附子是四逆，手脚冰冷，这个只是一点里寒炮附子就可以了。

同样一个处方，当你把芍药甘草剂量加重。如果平常芍药两钱，炙甘草两钱，炮附子四钱，这是芍药甘草附子汤。如果你把白芍开到一两，炙甘草也开到一两，炮附子还是四钱，或者五钱都没有关系，看他体格多大。当你在重用到白芍、炙甘草剂量加重到五倍六倍上去的时候，病人呈现的状况不一样。临床我们知道，桂枝汤里桂枝行阳，白芍补阴的，静脉是白芍在管，芍药酸主收敛，当你用剂量比较轻的时候，它有滋阴的效果，当你加重的时候，他收敛的力量很强，所以有

静脉曲张的时候我们重用白芍和炙甘草，白芍和炙甘草是等量。如果你用一两病人静脉曲张没什么效果的时候，白芍用一两半，炙甘草不用那么多了。因为真正的主力是在白芍，炙甘草只是旁边一个滋补的药。所以白芍轻用和重用效果完全不一样。

炮附子用的时候，一定问病人的情形，比如病人脚是冷的，同时静脉曲张很严重，炮附子要重用，如果病人脚是温热的，这时静脉曲张炮附子要减量。一定要用炮附子，当你有热在身上的时候，处方下去，静脉的血会动，静脉血动里面有淤血块怎么办，要预防淤血流回心脏，引发心脏病，炮附子加重点，炮附子会产生热，这个热救可以把血融化掉。所以我们要注意，病人脚是冷的，炮附子要加重，就不会有发心脏病的现象，我们治静脉曲张的同时，可以预防病人发心脏病。

芍药甘草附子汤又名去杖汤，病人本来依靠拐杖走路，经过你的芍药甘草附子汤，拐杖都不用了。

第七十四条。

原文：发汗，若下之，病仍不解，烦躁，四逆者，茯苓四逆汤主之。

四逆，手冰冷从手指头到手肘，脚趾头到膝关节。如果只有手掌脚掌冷，这个没有什么关系，到四逆就很危险了。这个时候就要给四逆汤了。

茯苓四逆汤方

茯苓六两，人参一两，附子一枚，生用去皮破八片，甘草二两炙，干姜一两半。

右五味，以水五升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

救逆附子生用。出现烦躁，代表里面津液一定不够了。补津液就要靠人参，有烦躁，除烦的时候就要靠茯苓，张仲景用茯苓用的很多，茯苓利水。张仲景除了补水以外，同时利水。什么叫做新陈代谢，新的要去取代旧的，经方家在处方的时候不会开纯补的药在里面，一定是补泻兼顾的药。这样子新陈代谢才会回到正常，不能老是只开补药。救逆危险的时候，张仲景还要开茯苓，茯苓除了滋补，还会利水。

炮附子一枚大概三四钱。看比例最好。

茯苓四逆汤是很好的救逆的汤，但是一定出现烦躁，手脚逆冷了。如果没有烦躁不用茯苓四逆汤，就是一般的四逆汤就好了。如果说津液不够，没有烦躁，你看着发汗吐下，用四逆汤加人参就可以了。

如果你没有被汗、被吐，手脚冰冷的时候，直接用四逆汤就可以。

第七十五条。

原文：发汗后，恶寒者，虚故也。不恶寒，但热者，实也。当和胃气，与「调胃承气汤」。

如果发汗后，有里寒。本来正常人，发汗后体温就恢复了。他是有恶寒现象，这是虚。如果发汗后，他是恶寒，不会脉数的，因为你流汗，流汗脉不会再浮紧，

一定会缓下来。所以发汗以后病人有怕冷的现象。他只是里虚，用芍药甘草附子汤就可以了。

如果病人不恶寒,但热者,实也,当和胃气。诸位记得只要出现但热不寒,就是阳明症,阳明无寒症,全部是热症。

如何知道他是阳明症,完全看不到寒症,全部是热症。有病人被西医诊断是艾滋病,嘴巴张开,一条一条的就像白老虎身上的纹路,不单单是舌头,整个嘴巴里面都是一条条的。我问他口渴不渴,非常的渴,很热,摸摸都没有发烧,手脚都是热症,一票都是热症,他大便很好,就开白虎汤。白虎汤下去以后,他说,我从来没有感觉这么好。所以如果他们没吃过西药,看到的都是阳明症,阳明无死症。但吃了西药以后就出现厥阴症,所以我很肯定病人是死在西药上面,不是死在 HIV 上面。这里讲到阳明篇讲到这个症状,阳明篇就两种药,白虎跟承气。现在看到艾滋病,如果没有西医动过就是白虎汤症。

病人不恶寒,但恶热者,实,调胃承气汤,调胃承气就是没有胀满。我们知道是在胃的下方,十二指肠的地方,调胃承气很好辩证,就在下脘、建里这个地方有压痛,就是调胃承气。小承气跟大承气辩证也不太一样。

这里会有调胃承气汤,就是因为我们吃了桂枝汤,把肠胃津液发散掉了,堵在十二指肠里面。麻黄汤不会,因为麻黄汤是宣肺的药,肺里面的津液散掉。桂枝汤才会影响到小肠,肠胃的津液。如果堵在小肠里面,那就是小承气了。

第七十六条。

原文:太阳病,发汗后,大汗出,胃中干,烦躁不得眠,欲得水饮水者,少少与饮之,令胃气和则愈。若脉浮,小便不利,微热,消渴者,「五苓散」主之。

当你用汗剂发完汗以后,胃里面是很干燥的,你如果说很燥渴,大剂的水喝太快了,胃有一定的容量,你水下去,胃的热度不能当场气化掉。若脉浮,小便不利,微热,这是发汗太过。还是脉浮,小便不利,代表病邪还没有解掉。可能是另外一种感冒。

五苓散里没有甘草,就是以桂枝为主,三个利尿的:泽泻、猪苓、茯苓,白术和桂枝,不用甘草。这个药是在我们治疗瘟疫的时候使用。消渴,就是一直喝水不能止渴。五苓散能把皮肤表面的病毒导到小便里面排掉,五苓散的功能跟汗解的功能完全是相反的路径。

2——8

所以当我们遇到病人有需要利小便的时候,我们用五苓散。黄帝内经,肚脐以上有水肿的时候,我们是以汗解,下半身积水,是用利尿。五苓散是利尿。

当你得到太阳病的时候,发汗,病毒没有办法完全从汗排除掉的时候,这个时候用五苓散。这个时候他大汗出,已经烦躁不得眠了,再给他发汗,不行,已经很危险了,这个时候不要再给他汗要了,这个时候病还在,给他五苓散就可以。

五苓散很多利水的药,病人是消渴,小便已经不利了,会不会排水排的更多,会不会不好?实际上病邪排掉以后,阴液自己会回头。

当你遇到病人不能用汗去解他的时候,就靠五苓散。五苓散主症是小便不利,



口渴。

遇到桂枝汤症或麻黄汤症病人不适用，但是又有表症，病人脉浮，有表症，怎么处理？就是利尿把它利掉。有表症为什么不能用汗要？“大汗出”已经汗出了，已经津液干掉了。

#### 五苓散方

猪苓十八铢去皮，泽泻一两六铢半，茯苓十八铢，桂枝半两去皮，白朮十八铢。

右五味，为末，以白饮和合服方寸匕，日三服，多饮暖水，汗出愈，如法将息。

猪苓、泽泻、茯苓是利水的。猪苓三、茯苓三、泽泻二、白朮三、桂枝二。泽泻的功能利全身的水。不管你水积在哪个地方，用泽泻。茯苓专门是中焦的水，就是心蔽骨和肚脐中间的地方。猪苓是利下焦，肚脐以下的水。如果猪苓、茯苓、泽泻三味药碰在一起时，全身的表水都可以利掉。怎么知道他表水要利掉，药力能够达到皮肤表面上。桂枝不要用太多，用太多发表去了。用一点桂枝，把泽泻推到皮肤表面上去。中焦用白朮来去湿，茯苓把水导到下焦，导到下焦再加上猪苓在下面。所以五苓散五味药就可以把皮肤的水从小便利出来。

比如有病人吃过桂枝汤、麻黄汤没有得汗，皮肤身上很痒，汗没有透发，皮肤会痒。怎么处理？五苓散把它利掉，痒就没有了。散就是粉剂。如果熬成汤就是汤，不是散了。散肠胃吸收很快，如果是汤剂扫荡的太快了，表水还没有引出来，汤剂已经过了，所以汤剂就没有办法把皮肤表面应该透发的水，从小便导出来，所以用散剂，散剂进去比较慢，慢慢吸收，把皮肤表水从小便利出来。

临床很多皮肤病都用五苓散。瘟疫用五苓散很厉害。

#### 第七十八条。

原文：发汗已，脉浮数，烦渴者，「五苓散」主之。

发汗以后，脉在表面太浮数，代表病没有完全排掉。病人会烦渴。可能你汗剂透发的时候，剂量不够。还有一个，你发汗以后，病人得汗了，还有一些汗停在表面上，因为你素虚。第二种你还有其他的病。所以你发汗以后，病并没有完全去掉。

只要是脉浮数，烦渴者，统统可以用五苓散。平常我们都用散剂，不用汤剂。

#### 第七十九条。

原文：「伤寒」，汗出而渴者，「五苓散」主之。不渴而心下悸者，「茯苓甘草汤」主之。

伤寒汗流出来就好了，但病人并没有完全好，还有些燥渴。五苓散主之。中医治症汗吐下法。当你汗吐下之后，怎么知道他好了没有？就是口渴不渴。比如吃坏肚子，上吐下泻完了，口渴要找水喝了，代表坏的食物统统排出来了，这个时候慢慢喝点水，不要太快。如果不口渴，代表还有坏死的食物，没有清干净。

七十九条，如果汗出而渴，代表津液伤到了，用五苓散补回来。如果是渴而发烧，很燥热就不是五苓散了，五苓散只管渴，如果很热还渴的话是白虎汤症。

不渴而心下悸者，代表水还没有透发。这个时候茯苓甘草汤。

茯苓甘草汤方

茯苓二两，桂枝二两去皮，生姜三两切，甘草一两炙。

右四味，以水四升，煮取二升，去滓，分温三服。

桂枝、茯苓等量。这个是把心下动悸的水利掉。同时桂枝降冲逆，茯苓能够利水。生姜甘草把津液补回来。

第八十条。

原文：「中风」发热，六七日不解而烦，有表里证，渴欲饮水，水入则吐者，名曰「水逆」，「五苓散」主之。

病人渴想喝水，一喝水下去就吐，就是五苓散症。有时五苓散症不一定是因为中风吃了发表的药。喝水太快了，中膈水膈到，膈在中焦，连喝水都会吐出来。饮水则吐，一样是五苓散症。他什么都吐，就是五苓散不吐。我归结他的原因，里面有桂枝，轻微的桂枝在里面。桂枝有温化的功能，温在胃里面。

散就是粉剂。

第八十一条。

原文：未持脉时，病人叉手自冒心，师因教试令咳，而不咳者，此必两耳聋无闻也。所以然者，以重发汗，虚，故如此。

为什么两耳听不到，因为重发汗，人虚故也。人年龄大也会耳背。内经讲精脱者耳聋。发汗发太多，津液伤到，也会耳聋。每个人都有虚，但是虚的部位不一样，发汗太过产生的后遗症就不一样。怎么去弥补，可以加一些人参，虽然张仲景没有处方，但你前面学到，你可以加一些人参、红枣、茯苓、炙甘草或者生姜，把津液补回来就可以了。

第八十二条。

原文：发汗后，饮水多，必喘，以水灌之，亦喘。

发汗后要给病人讲，发汗后口渴代表病人正常了，不要喝水太快。当你要用麻黄汤的时候，你知道麻黄汤是会把肺里的津液发掉，你是不是多吃点杏仁豆腐，桂枝汤是把肠胃的津液发掉，可以煮点稀饭。以水灌之，不要喝太快，喝太快，因为你胃里面刚发汗过，胃里面津液很干，这个时候你水太快喝下去，胃里面会冷掉，冷掉水停在这边，没有办法气化，你呼吸横膈膜下降，结果你水隔在这边，它就会反逆，出现喘的现象。怎么处理，不要再喝了。灸也可以。

第八十三条。

原文：发汗后，水药不得入口为逆。若更发汗，必吐下不止。

这里五苓散就好了。体力好的可以自己恢复。

第八十四条。

原文：发汗吐下后，虚烦不得眠，若剧者，必反复颠倒，心中懊憹，「栀子豉汤」

主之。若少气者,「梔子甘草豉汤」主之。若呕者,「梔子生姜豉汤」主之。

「梔子豉汤」都是病愈了以后,人没办法睡觉,「梔子豉汤」是去虚烦用的。若呕者,「梔子生姜豉汤」主之,生姜能够止呕。轻微的药,并不是真正治疗重病的药,病后调理的药。

### 3——1

为什么用梔子,梔子去虚热,跟黄连、黄芪不一样。梔子也是苦味,梔子是梔子花,质很轻。黄连、黄芪是根,质很重。质重大部分都跑到很深的地方去。梔子质很轻,所以它是虚烦,并不是实症,人已经好了嘛。

必反复颠倒,心中懊憹,为什么用豆豉?豆豉能够生胃的津液。只要用到“心中”,大部分都是讲的胃的地方,伤寒论讲到胃的话,大部分是指肠的地方,往下移一个位置。心中懊憹,就是胃里面怪怪的。刚开始虚症的失眠,我们会用到梔子豆豉汤。

虚症实症分辨。摸脉,脉按下去就没有了,脉来的很虚,他就是虚,舌苔,淡黄色。实热舌苔是黄,而且是干裂。“反复颠倒”,他又讲不出来,一下说这边不舒服,一下说那边。这是病要痊愈,伤到一些津液,就会产生这种现象。弥补的方式梔子豉汤。

少气,元气不够,四肢没有力量。同样的药,加了一个甘草。张仲景在用滋补的药,甘草一味药而已。甘草、红枣、人参、白芍都是张仲景常常用的滋补的药。少气用甘草,因为甘草出来入脾脏,入肠胃生津液以外,最主要担心肠胃有坏死的食物,所以甘草下去解百毒。

呕,张仲景有时候用生姜,有时候用生姜,有时用干姜,有时用生半夏。生姜跟半夏不一样,张仲景大部分用生半夏,但他用生半夏都放生姜在里面,生姜可以解半夏的毒,会用到半夏都是会有停水,也就是说胃里面有水,经方观念里面,水可以生万物,可以滋养你,也可以生病。正常人的水在身体里,是气化的水,也就是热的。一旦发现冷水,这个水要排掉。不排掉新水不会出来。所以有时候津液不够,大量喝水下去,胃里面火很小,元气刚刚恢复,大量的水下去,胃里面会停水。有时治病的时候,病人一下恢复了,当病人本来是不口渴的,你把他治的开始口渴了,这都是好转的现象,口渴好像原来没有胃口,吃了药以后胃口来了。我们可以知道他好转了。口渴,少少与之,你刚刚恢复,不要大量喝水,病人不知道,拿起水就喝,才刚刚起来的微火,一下就浇灭掉了,这个时候胃里会有停水。停水,半夏才能利出来。用半夏一定是确定胃里面有水,才会用半夏,这个水如果不去掉,是冷水的话,肠胃里有宿食在里面,这个宿食碰到寒水,食物发酵烂掉了,这个时候,很快的用半夏把水利掉。这里不用半夏,因为津液才刚刚回来,你用半夏把津液利掉不好。所以用生姜。生姜可以止呕。女人害喜呕吐,干姜、生半夏、人参,他吃完就不吐了。

如果病人只有呕吐没有下痢,使用梔子生姜豉汤。如果有下痢就是葛芩连汤,葛根黄芩黄连甘草。

#### 梔子豉汤方

梔子十四枚擘,香豉四合绵裹。

右二味,以水四升,先煮梔子得二升半,内豉,煮取一升半,去滓,分温二服。

梔子一般五钱,豆豉也是五钱,不要把豆豉煮烂掉了,所以先煮梔子。

梔子甘草豉汤方

梔子十四枚,甘草二两,香豉四合。

右三味,以水四升,先煮梔子、甘草,得二升半,内豉,煮取一升半,去滓,分温二服。

梔子用五钱,甘草二钱,豆豉也是五钱。

第八十五条。

原文:发汗,若下之,而烦热,胸中窒者,「梔子豉汤」主之。

发汗,被攻了以后,感觉烦热,胸中窒者就是呼吸呼不过来,就是梔子豉汤。病好了,虚热还在里面。出现这种现象都是肠胃不好的人,桂枝汤有生姜红枣炙甘草,这都是健脾整胃的。有时候中湿的话,加点白术茯苓。都是健脾整胃的。如果肠胃不好,你一攻下肠胃的津液就没了,才会出现烦热。

第八十六。

原文:「伤寒」,五六日,大下之后,身热不去,心中结痛者,未欲解也,「梔子豉汤」主之。

麻黄汤症。心中结痛者,胃里面胀闷。这也是没完全好,也是梔子豉汤。

第八十七。

原文:「伤寒」下后,心烦,腹满,卧起不安者,「梔子厚朴枳实汤」主之。

腹满有实有虚。实症有承气汤。虚症,厚朴生姜半夏人参甘草汤症。但是承气汤也有厚朴,虚症也有厚朴,厚朴是专门对腹部胀满用的,不管里面是什么肝硬化腹水,厚朴都是肚子胀满。经方实症虚症都会有厚朴在里面,因为厚朴除了下气以外。厚朴能把脾脏的湿移到小肠去。白术是去湿。

脾脏主少腹。如果你开承气汤不开厚朴,很痛。腹满有时实症,大便堵到或气堵到,都会用到厚朴,增润津液。

胸满,胸痛,张仲景一律不用白芍,用枳实。梔子去虚热。枳实也能宽肠,大便和肠壁粘到一起,你如果开大黄芒硝,大便会出来,但很痛,因为你硬扯开,所以加枳实。

心脏病用枳实。枳实能治疗心烦。当人身上,心跟小肠本身是表里,枳实可以帮助小肠,大肠,宽肠,枳实能够让东西变大。比如胆管太小,我们让枳实撑开来。中医为什么可以治疗胆结石。胆汁出来是喷射状的,因为心脏不断的在搏动,心脏产生的热从心脏直接进入小肠。心脏的搏动会进入胆的上方。如何强心脏,重用炙甘草,心脏跳的力量会加强,然后柴胡,有湿热黄芩,枳实可以宽胆,这个处方已经是可以治胆结石的处方了。五倍子,海金沙,这个能消除结石。枳实可以把缩小的变大。胆管、包括我们的大肠小肠,尤其是大肠,宿粪在里面堵到,枳实下去会撑开来,为什么?就是因为枳实管心脏。枳实长得就像心脏,心

脏搏动，枳实下去跟着心脏的样子动，会造成大肠小肠蠕动增加。

腹满，不管是实满还是虚满，都会加厚朴。心烦是栀子，枳实是对心脏。

栀子厚朴枳实汤方

栀子十四枚劈，厚朴四两，炙枳实四合。

右三味，以水三升半，煮取一升半，去滓，分二服。

枳实厚朴可以等量。

第八十八条。

原文：「伤寒」，医以丸药大下之，身热不去，微烦者，「栀子干姜豉汤」主之。

用到干姜就代表里虚掉，虚是寒的虚。中焦上焦之间出现寒，统统会用到干姜。因为干姜管中焦上焦，不管下焦。下焦炮附子在管。肠胃里面寒，寒的定义是，比如内经说一息四至，一呼吸脉跳四下，这是胃气。寒的意思是，你一呼吸跳两下。肺家有寒，我们也可以用干姜。我们用攻下，大部分都是寒凉的药。像大黄、芒硝。下去以后，身热还在那边，表面上的热，实际是虚热，真正里面是寒的。还是用虚热药，干姜来温中。

恶心用生姜，微烦用干姜。

栀子干姜豉汤方

栀子十四枚劈，干姜二两，香豉四合。

右三味，以水三升，煮取一升半，去滓，分二服。

栀子四，香豉四，干姜二。

第八十九条。

原文：凡用「栀子豉汤」，病患旧微溏者，下可与服之。

病人本身常常下痢，大便比较湿、溏，不要给他吃「栀子豉汤」。因为栀子、豆豉本来就是比较寒凉的药。病人本来就有寒凉的体质。吃下去，下痢可能更多。治疗虚寒，我们可以加些干姜、白术、茯苓下去，临床看他需要什么。

第九十条。

原文：「太阳病」，发汗，汗出不解。其人仍发热，心下悸，头眩，身润动，振振欲擗地者，「真武汤」主之。

真武汤与苓桂术甘汤都可以治疗晕眩，差异在哪里？苓桂术甘汤是治疗中焦的水饮。

3——2

桂枝是在通冲脉。桂枝能够降逆，降逆就是气往上冲，桂枝能够把它压下来，加上白术茯苓把这个湿排掉，所以苓桂术甘汤是治疗中焦的水饮。

真武汤也是头昏眩，头很重，上重下轻，好像要摔倒。真武汤是温中除寒，

所以真武汤用附子。因为附子是热药。

真武汤方

茯苓三两，芍药三两，生姜三两，白朮二两炙，附子一枚炮。

右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

炮附子一枚差不多三钱。苓桂术甘汤的时候，茯苓是四，白朮是二。白朮是去湿，茯苓是把湿消导到小便排掉。你如果说，不开茯苓光开白朮，去湿没错，湿还在里面出不来。如果开茯苓就是跟药说，湿从小便排出来。这个人本身是下焦寒，肾阳不够的时候，所以我们用炮附子。炮附子下去把水就气化掉了。一方面我们要利水，一方面要把水的温度增加，小便才会导出来。导出来又怕里虚掉，所以用芍药跟生姜来做补药。真武汤就是这样来的。

还有一种人需要真武汤，中湿之人，伤寒论里面说中风伤寒，温病，还有湿热。平常就湿气很盛的人。湿伤于下，就是你久坐湿地。你居住的地方比较潮湿，从下面开始伤到的，平常都是身体湿很盛，一喝热汤，一动就开始不断的流汗，一天换好几身衣服，这是中湿的人。湿很盛的人水没办法出去，你光苓桂术甘汤清不出去的，湿在里面已经太久了。太久了就会变成寒湿，这种情况湿很盛，人会头昏眼花，晕眩很厉害，这个时候也是真武汤症，肌肉闰动也是真武汤。真武汤跟苓桂术甘汤差异就在这里，遇到寒湿的人，头昏就是真武汤症，遇到中膈有水苓桂术甘汤，苓桂术甘汤没有寒湿

寒湿脉比较细、比较小，比较慢，脚是冷的，不口渴，湿很盛的人没有什么胃口，脚没有力，因为湿伤于下，比如说脚风湿关节炎，两个踝骨或膝盖的关节。

为什么会伤到膝关节？我们三个阴骨，叫骨三阴论，出自黄帝内经。一个是头顶，小孩子两三岁后收合的骨头，耳朵后面的骨头，膝盖骨，这三个是三阴的所在。湿伤于下会伤到下面的阴骨。

炮附子用到的时候，一定是温阳化水，湿在里面，用炮附子下去把它加温。白朮去湿，茯苓去水。张仲景利水的时候，很少用甘草，因为这个甘草，不管是甘草还是炙甘草，它有蓄水的功能。所以我们津液不够的时候，我们会用甘草生津。现在排水，加甘草干嘛。所以五苓散、真武汤没有甘草。我们在治积水、水肿的时候不用甘草。

第九十一。

原文：咽喉干燥者，不可发汗。

咽喉在黄帝内经里面是三阴之汇，三阴：太阴、少阴、厥阴。咽喉干燥，代表阴津不够。讲阴就是讲血。这个时候不可以发汗，因为汗血同源，发汗的时候要忌讳的事情。用汗剂的时候问喉咙有没有干燥，是干燥，没有喉咙痛。我们常问小孩子，感冒发烧，有没有喉咙痛。喉咙痛葛根汤。葛根汤是太阳温病。太阳温病就是小朋友好动，运动之下得到感冒，流汗受到风邪，这时候是温病，因为伤于寒，发出来是温病。发出来温病，一定有喉咙痛，因为他流汗的时候得到的伤寒，津液在咽喉没有办法恢复，补他的喉咙。所以我们在看葛根汤症的时候，小朋友只要有发烧、喉咙痛，一律是葛根汤。

这里讲喉咙是干燥的，干燥跟葛根汤没有关系。这个时候千万不要发汗。

后面几条是发汗的禁忌。你要开发表的药的时候，一定要有些禁忌。

第九十二。

原文：「淋家」不可发汗,发汗必便血。

这个淋家不单是指淋病，而是小便有问题。小便滴嗒或有痛，发炎，看到白浊的东西。这个时候你发汗小便就会带血。因为汗血同源。这个时候膀胱里面有炎症，膀胱经就是太阳经，你一发汗膀胱里面的水份会没有，小便会变的很浓稠，排出来就是血。

第九十三。

原文：「疮家」虽身疼痛,不可发汗,发汗则室。

病人有皮肤病，有化脓的疮，虽然身痛，不要开发表的药。用小柴胡汤。这个疮家讲的是有化脓的，一般的皮肤病无所谓。

第九十四。

原文：「衄家」不可发汗,汗出必额上陷,脉急紧,直视不能眴,不得眠。

常常流鼻血的人，不可以发汗。这里额上指两眉尾上面，这两个地方叫天仓。天仓凹下去，先天不够，这是讲气血的地方。本来有流鼻血，汗剂再一发，天仓会凹下去。代表他血亏了。望诊的时候，病人天仓没有，这个人气血已经虚掉了。直视不能眴，阳往上亢。发汗的药都是阳药，阳会往上走，阳会亢，眼睛会闭不起来，瞪到那直直在看。阳亢其实就是阳虚了。阴虚以后会造成阳虚，本来是阴虚，血不够，又发汗，阳变成虚。阳亢实际上是虚症，它停在上面没有东西支援它。中医得观念认为阴阳要平衡，互相搭配。有阳才有阴，有阴才有阳。阳会不动，是因为阴这样配在一起（十指交叉状）。你瞬间把阴发掉，一发汗，阴伤到，阳会往上跑。阳是很轻，往上冲，冲到头上就变成直视不能眴。所以阴阳一定要搭配，桂枝汤最能协调阴阳的。

第九十五。

原文：亡血家,不可发汗,发汗则寒栗而振。

亡血家是本身贫血的人。看上去非常苍白，嘴唇都没有颜色的，就是亡血家，血不够。孔脉，脉像葱叶一样，外面很大里面是空的，孔脉。是亡血。都不可以发汗，因为汗血同源。

发汗有发汗的条件。

第九十六。

原文：汗家重发汗,必恍惚心乱,小便已阴疼,与禹余粮丸。

平时就流汗很多的人。再重发汗水分会丧失更多。小便完阴疼，不是膀胱有问题，而是津液太干了。禹余粮丸原方不见了，我从别的地方找来，对不对，不做评论。

## 禹余粮丸方

禹余粮四两，人参三两，附子二枚，五味子三合，茯苓三两，干姜三两。

右六味，蜜为丸，如梧子大，每服二十丸。

禹余粮跟赤石脂是涩剂。涩剂是止利用的。这里你不用禹余粮丸，你知道他是津液伤到了，用人参、甘草、生姜、红枣下去，津液就补回来了。不一定要用禹余粮。你知道伤寒论的精髓以后，开出来就是经方。

第九十七。

原文：病人有寒，复发汗，胃中冷，必吐蚘。

病人本身有寒症，你再用发汗的药下去，胃中冷，不动了。胃下方永远有一点食物在里面。这个食物足够你七天，不吃东西，不会死。如果说病人有寒，你给他发汗，这个寒是里寒，一发寒胃中更冷。汗剂是解表用的，这个人有里寒，里寒不能用汗剂，要用去里寒的药。结果你给他开发汗的药。所以一开始介绍伤寒论的时候，一定要脉浮，我们知道病在表。你问他有没有发热，有没有汗。有汗桂枝汤，没有寒身痛麻黄汤。这个人里寒，形瘦的人都是里寒，形胖的人都是有湿热的。这个当你下去以后，寒掉了，代表蠕动没了，蠕动没了胃中冷，水是冷水，冷水泡食物，坏死掉就会生虫，虫就是这里来的。等于胃下方有一堆坏死的食物。

一般胃寒的时候，我们用干姜。白术干姜。

第九十八。九十九。

原文：九八、九：本先发汗，反而下之，此为逆也；若先发汗，治不为逆。本先下之，反而汗之，为逆；若先下之，治不为逆。

九十八是治症的原则。你看到病人应该是表症，太阳伤寒、中风或者温病，应该先发汗，你反而下之，这个方法不对，所以不能攻下。我们在用攻下方剂之前，一定要先看有没有表症，这是治病的原则。

本先下之，反而汗之，为逆。是说他没有表症，本来是一个承气汤症，大便燥结的症，本来肠胃津液很干了，结果你开汗药给他。

第一百条。

原文：「伤寒」，医下之，续得下利，清谷不止，身疼痛者，急当救里；后身疼痛，清便自调者，急当救表，救里宜「四逆汤」，救表宜「桂枝汤」。

伤寒如果误下。本来伤寒应该开麻黄汤。你开成承气汤，攻下。表寒跑到肠胃里面去了。变成里寒，救里寒要用四逆汤，生附子、干姜、炙甘草。如果救里，里好了，清便自调者，大小便恢复正常了。还有一点身疼痛，这个时候不要再開麻黄汤了，开桂枝汤救好了，桂枝汤是调和阴阳的，因为表寒已经没有了，被你攻下去了，变成里寒了，里寒你又用四逆汤去救他。

如果表寒攻下结胸，那就很麻烦。

如果有病人下痢。大便看不到食物，很臭，葛芩连汤。大便看到食物，里寒，



四逆汤，或者他手脚不冷，没有必要开到四逆汤，你可以开干姜、白术、茯苓。

#### 第一百零一。

原文：病发热，头痛，身体疼痛，若汗之不差，而脉反沉，当救其里，宜「四逆汤」。

病发热，头痛，身体疼痛，如果没有寒，用麻黄汤。如果有汗桂枝汤。口渴用葛根汤。开药后没有好，病人脉沉下去了，这个时候四逆汤。会造成这样子，你汗剂开的太多。一般出现这种现象不多。这种现象，病人身体素虚。所以你看到病人身体素虚，开发表药不要开太重。很强壮的人，你开太轻还不行，他没有办法透发。

或者你看病人比较瘦，你怕他太过，让他煮三碗，先喝半碗，一个小时半个小时再喝半碗，有汗就停掉，不要喝了，用这种方式来告诉病人。

#### 第一百零二。

原文：「太阳病」，其人冒，先下之而不愈，因复发汗，以此表里俱虚，因冒症汗出自愈，所以然者，汗出表和故也，得里未和，然后复下之。

这个意思，你用汗剂发汗，这个病人素虚，身上津液流失过多。这里也是一种现象。如果汗出，病人没有好，遇到冒症，就是汗流不止。可以用桂枝汤或建中汤。这都是弥补的措施。得里未和，然后复下之。如果说发汗表解掉了，里面还有大便，再去攻里。这是一个原则。

从头到尾，张仲景就怕表邪下陷。现在小朋友肠病毒就是表邪下陷。肠子怎么会发炎？肠子不会发炎的。那是因为感冒病毒没有治好，跑到肠子里面去了。

补充一下，伤寒论第一百零二条，冒，有头昏是冒，还有呢流汗，头汗出也是冒，这个条辨是说，会有人出现头昏或者是头上流汗的原因，主要是太阳证本来应该是先解表再攻里。这是经方的原则。有的人先攻下，造成没有完全好，因为他应该先解表再攻里，这是治病的程序。你攻下了，没有好，你又去解表，这个时候表里都虚掉了。表里都虚掉了以后，病人如果出现，头晕眩或者是头一直在冒汗，这个症状出现的时候，代表阳明热，代笔胃气会慢慢恢复。张仲景就是告诉大家说，你不要处方没有关系。让他自己痊愈就可以了。如果说还没有好，这个时候，人的精神都恢复了，表症还没好再去表，里症还有再去解里。一般来说这个不是很严重。

#### 第一百零三。

原文：「太阳病」未解，脉阴阳俱微，必先振栗汗出而解。但阳脉微者，先汗出而解；但阴脉微者，下之而解；若欲下之，宜「调胃承气汤」。

脉阴阳俱微，寸是阳，尺是阴。寸是诊胸的位置，尺是诊腹的位置，中间就是关。

如果阴阳脉俱微，两个脉都比较小，因为太阳病你发汗以后，病人脉变小了，原来是浮脉。应该是流点汗，自然会好。如果阳脉微者，先汗出而解；阴脉微者，下之而解；这是寸脉、尺脉的差异。因为发表的时候。处方一定是桂枝或者麻黄，一定是肺胸腔里面，肺里面的津液。或肠胃里面的津液。所以这里阳指的胸阳，上焦胃的地方，汗出而解。阴脉微者，指的是腹部，少腹部。还没有好，代表里

面还有大便堵到，所以要调胃承气。调胃承气是最轻微的攻下的药。包括里面的大黄，都用酒先洗过。酒洗过大黄升提的力量，胜过攻下的力量。调胃承气里面有芒硝，芒硝攻下，大黄升提一下，这两味药和在一起，刚好可以清十二指肠堵到的位置。

### 3——3

#### 第一百零四。

原文：太阳病,发热汗出者,此为荣弱卫强,故使汗出,欲救邪风者,宜桂枝汤。

发热汗出是重点。就是桂枝汤症了。桂枝汤是调和荣卫的处方，卫会强，当人发热了。卫是阳嘛。

#### 第一百零五。

原文：「伤寒」五六日,「中风」,往来寒热,胸胁苦满,默默不欲食,心烦喜呕,或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞硬,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,「小柴胡汤」主之。

“或”就是有的时候有，有的时候没有。往来寒热,胸胁苦满,默默不欲食,心烦喜呕是主症。「小柴胡汤」主之。

病在初，都在太阳。如果太阳没有好，五六日后病要往里走了。往里走有两种可能，一种进入阳明，进入阳明，到此为止，病就不会再进了。阳明症只有两个，白虎跟承气。白虎汤，全身是热的，烦热、燥渴。大便没有了，便秘，承气汤。就是这两个症状。便秘都治不好不用看病了。

如果没有进入阳明进入少阳。如果这个阶段你没有阻止病情的演进，才会出现太阴、少阴、厥阴。所以进入少阳的时候，我们就要开始阻止他，不要让他再进。当然在太阳能阻止了最好。

怎么知道他没有进入阳明，进入少阳，“胸胁苦满”就是主症，少阳就是我们的三焦系统。上焦、中焦、下焦。也就是西医讲的淋巴系统。所有的脏跟腑之间，有黄油膜，统统属于三焦。奇恒之腑，包括脑、乳房、胸、女子胞，都是列入三焦。

进入少阳主要症状，都是“往来寒热。”太阳证也有往来寒热，热多寒少桂枝二麻黄一，往来寒热，桂枝麻黄各半汤。如果胸胁苦满,默默不欲食,心烦喜呕,这个才是代表进入少阳症。简单讲就是呕吐、往来寒热，胸胁苦满。胸胁苦满真的是在胸肋胀满，胀的很难过。有时候你听病人说感冒，肋骨之间很痛，已经看完了，小柴胡汤就开出去了。

柴胡汤专门治疗病在少阳三焦淋巴系统里面。

#### 小柴胡汤方

柴胡半斤，黄芩三两，人参三两，甘草三两，半夏半升洗，生姜三两切，大枣十二枚劈。

右七味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎,取三升,温服一升,日三服。

柴胡是五钱。小柴胡汤里柴胡跟半夏是等量。

小柴胡汤的治症。比如肝炎，不用管 B 肝 C 肝，现象是湿热，小便黄，恶心，没有胃口。肝肿起来了顶到胃。在中医来看是胸胁苦满，恶心、不欲食、往来寒热，所以主力是小柴胡汤。只要会用小柴胡汤做加减，不用管 B 肝 C 肝很快就治好了。如果没胃口，小柴胡汤里加白术，茯苓。茯苓比白术多一点。因为你有湿，白术去湿，茯苓把湿从小便利掉。常用的药除了小柴胡汤，最常用的玉金，它能行肝气，郁结在里面，靠玉金打开。如果病人身发黄，小便颜色深黄，病人精气还是很好，两眼还是有神，用茵陈，茵陈是中药里很有名的去黄的药。如果病人虚烦不得眠，加栀子。

小柴胡汤吃了，怎么知道他肝病好了。一方面你问他胃口好不好，睡觉好不好，小便颜色，大便好不好，渴不渴，有口渴就进入阳明，代表病还没有好。

病好的原则，睡好，一觉到天亮。大便正常。胃口好。小便颜色正常。体力恢复。脚温热。这些代表肝病完全好。

肝癌两年前就知道了，不管你在什么地方，当地时间，晚上一点到三点准时醒过来，肝就已经出问题了。那个时候就要下手治了。不要等到两年以后，原来肝炎的时候，只是湿热。等到变成很实的时候，就长东西。中医为什么分虚实寒热，只是湿热不是实症在里面，很好治。等里面是实症的时候，你要把实症去掉就很难了。实症如果是在腑里面，比如说是大肠小肠胃胆，都不难。在脏里面就很难清了。

当你觉得身体没问题的时候，就是每天晚上一点到三点准时醒过来，就要开始治肝了。治肝的时候，肝象木，木要疏。玉金能疏郁气。半夏把水排掉，树只有树根可以在水里面，要是上面在水里面，树会淹死。生姜炙甘草可以生好的津液。

张仲景立的小柴胡汤就是预防肝病的。用小柴胡汤做基础方做加减，没有发病可以用小柴胡汤，已经发病看到身黄的时候你可以用去黄的药，因为那是他还是湿热。

或胸中烦而不呕,或渴,或腹中痛,或胁下痞鞭,或心下悸,小便不利,或不渴,身有微热,或咳者,这都是副症，不是主要的症状。

你只要看到主要的症状，不管里面是肝病，还是肝炎或是胰脏癌，你只要看着这个症状，统统这个处方。经方是辨证论治。你不要去看病，有时候两个完全不同的病，开出的处方是一样的，因为症状是一样的。

当病从太阳没有治好，失掉治疗的时机，病进入少阳症的时候，小柴胡汤下去病就好了，就不会再进了。

如果小柴胡汤失治，来不及治，才会进入阴症。

如果遇到三焦，淋巴癌的病人，有淋巴结的地方长的是硬块、肿块，我开处方是小柴胡汤。三焦的淋巴是黄色的，三焦就是油脂，黄色的。会有结，有实在，看到长东西都是实，这个时候，我们会用一些黄色的去实的药，比如硫磺。我们用生硫磺，因为硫磺很热，它能把实去掉。所以小柴胡汤光是加一个硫磺，一下三焦系统就清的很干净。如果头昏，脑部有积水，很大，生半夏加重，生半夏可

以排脑部的积水。如果说是乳癌，也是用柴胡汤做加减。

月经来的时候，女孩子月经是心脏在管。所以心脏很好，月经一定很正常。心脏在管奶水，中医认为奶水就是月经，当月经来的时候，如果乳房有硬块，正在吃乳癌的处方，正好碰到月经。我们用桂枝下去，柴胡汤加桂枝，因为桂枝可以降逆冲脉，把奶水导到子宫里面去。

如果病人恶心、呕吐，不想吃东西，病人肾脏有问题，结果出现的也是往来寒热，胸胁苦满，这个时候我们一样用小柴胡汤。不管里面的病是什么，只要是往来寒热、胸胁苦满、不欲食、呕，统统可以使用小柴胡汤。

包括女人月经痛，你用小柴胡汤给他，小柴胡汤是在经方里唯一一个处方，就是当女人月经来的时候，你得到感冒，不管太阳中风、伤寒、温病，你要你月经来得到感冒一律小柴胡汤。肚子痛用白芍，胸满用枳实。白芍加重，加重到五钱、一两，看她痛到什么程度。

比如甲状腺肿大，统统可以用小柴胡汤来做加减，只要是身上发生的问题是在介于脏腑之间，都可以使用。最明显的症状就是胸胁苦满。

#### 小柴胡汤加减方

加减法：若胸中烦而不呕，去半夏、人参，加栝蒌实一枚。若渴者，去半夏，加人参合前成四两半，栝蒌四两。若腹中痛者，去黄芩，加芍药三两。若胁下痞硬，去大枣，加牡蛎四两。若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两。若不渴外有微热者，去人参，加桂枝三两，温覆取微汗愈。若咳者，去人参、大枣、生姜，加五味子半升，干姜三两。

这应是后人加进去的。

中药里牡蛎咸，咸味的药都是软坚的药，痞硬就是硬块，喉咙里面大脖子，腋下硬块，统统可以用牡蛎，因为牡蛎咸味，乳房硬块，照样牡蛎。

#### 第一百零六。

原文：血弱气虚，腠理开，邪气因入，与正气相搏，结于胸下；正邪分争，往来寒热，休作有时，默默不欲饮食；胸胁相连，其痛必下，邪高痛下，故使呕也，「小柴胡汤」主之。

病邪进来在三焦、淋巴系统里面会累积很多水在里面。压到胃会有恶心的现象。

病一开始都是太阳表症，失治才会进入小柴胡汤，还有就是女人月经来，气往下走，这个时候得到感冒，一下就跑到三焦系统去了。

#### 一百零七。

原文：服「柴胡汤」已，渴者，属「阳明」也，以法治之。

病人吃桂枝汤，第二天胃口开，代表病好了。如果是内脏病，半夜，因为是阴，半夜胃口开，代表病好了。渴跟胃气恢复有雷同的功能，你原来是柴胡汤症，吃过柴胡汤变成渴，进入阳明证，阳明无死症，也是好现象。以法治之，如果渴有小便不利是五苓散。如果大渴烦躁，大便正常，有壮热是白虎汤。便秘渴承气

汤。

从少阳证变成阳明证是病人好转的现象。

大肠癌很好治，不是承气汤就是大柴胡汤。本来是肠癌，你开刀，从肠癌转移肝癌，本来是阳明证，结果变成厥阴证。

第一百零八、一百零九。

原文：得病六七日，脉迟浮弱，恶风寒，手足温，医二三下之，不能食，而胁下满痛，面目及身黄，头项强，小便难者，与「柴胡汤」后必下重不渴而饮水呕者，「柴胡汤」不中与也，食谷者「哕」。

3——4

脉迟浮弱，浮病在表。沉是阴，迟是阴，浮是阳，数是阳。现在出现浮迟而且弱，代笔阴居阳位。脉上面来说，阴跑到阳位来了。

这个已经变成逆症。里面有阴实结到了。病人恶风寒，手足温。你用汗吐下三法，病人没有痊愈的时候，心里面就要想到里面有问题，必为坏病。

后必下重，下重就是肛门脱肛的感觉。治病，病人口渴，胃口好都是好的现象。病人不渴，里寒很盛，喝水吐，开柴胡汤没用。食谷者「哕」，这个「哕」是打嗝，胃气没有了。身黄，头项强，小便难者，遇到这种情形就是茯苓四逆汤，生附子，干姜，炙甘草，人参还有茯苓。

用茯苓就是因为他不渴。用茯苓四逆汤看能不能救回来。「哕」打嗝，胃气已经没有了。

一百一十一。

原文：「伤寒」四五日，身热，恶风，头项强，胁下满，手足温而渴者，「小柴胡汤」主之。

伤寒已经过了。病邪往里走了。病人有渴症出现都是有救。

身热，恶风，头项强，是太阳证。胁下满是少阳症。手足温而渴者阳明证。这个条辨可以看出，如果三阳并病，用小柴胡汤。

中医汗、吐、下、和法，和解方法就是讲小柴胡汤。

针灸有担法，如同一条手臂上，肩膀痛，手腕痛，在这两处痛的中间下针。

这个条辨意思就是，当你遇到一个病人，讲完太阳证也有，少阳症也有，阳明证也有，怎么办，到底开哪个？小柴胡汤就可以了。

第一百一十一。

原文：「伤寒」，阳脉濡，阴脉弦，法当腹中急痛，先与「小建中汤」。不差者，与「小柴胡汤」。

阳脉濡，寸脉地方是涩脉。阴脉就是讲少腹部，弦脉就是有寒水在里面。不差者，不好者。

## 小建中汤方

桂枝三两去皮，甘草二两炙，大枣十二枚劈，芍药六两，生姜三两切，胶饴一升。

右六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解。温服一升，日三服。呕家不可用建中汤，以甜故也。

芍药是桂枝两倍。小建中汤实际是来自桂枝汤。小孩子肚子痛，很皮，就是不吃东西，你看他的脸，两眼中间鼻根处，青黑的一条就是小建中汤症。肚子里寒的，就不喜欢吃东西。开处方芍药一定是比桂枝多，重用芍药的时候，肚子痛会去掉。同时炙甘草、干姜，桂枝能够降逆，麦芽糖（饴糖）是甜的，能够健脾胃。

这里是说遇到阳脉濡，阴脉弦，法当腹中急痛，先给「小建中汤」。小建中汤没有好再给小柴胡汤。

为什么小柴胡汤，因为弦脉，少阳证主要的脉就是弦脉。肚子痛，虚寒的痛，小建中汤。

小孩子不喜欢吃饭，肚子痛，腹痛，小建中汤。平常身体不好，预防也可以吃小建中汤。

呕家不可用建中汤，以甜故也。呕吐的人不要用建中汤，里面有甜的饴糖，呕吐的人吃甜的会吐。这时用小柴胡汤。只要有恶心出现就进入少阳了。

第一百一十二。

原文：呕家不可用「建中汤」，以甘故也。

第一百一十三。

原文：「伤寒」中风，有「柴胡证」，但见一证便是，不必悉具。

一证就可以了，就可以用柴胡汤。不用看其他的症。比如病人头痛恶寒体痛，但是恶心，本来想开麻黄汤，突然出来个恶心，柴胡汤。一个症就可以开了。就代表说它已经要进入了，有一部分进入少阳了，有一部分还在太阳。还是开小柴胡汤。

第一百一十四。

原文：凡「柴胡汤」病证而下之，若「柴胡汤」不罢者，复与「柴胡汤」，必蒸蒸而振，却发热，汗出而解。

柴胡汤症我们要和解，你没有用柴胡汤，你攻下，误攻下以后，本来是小柴胡汤一剂就好了，结果你开错处方了，或者他吃坏肚子。只要有柴胡症还在，就是往来寒热，病人恶心、呕吐，胸胁苦满。只要症还在，再给他柴胡汤。还可以再用，即使被误下了还可以再用，没有关系。因为小柴胡汤里面有人参。现在人参很贵，可以用党参。

第一百一十五。

原文：「伤寒」二三日，心中悸而烦者，「小建中汤」主之。

会用到小建中汤，就是里虚掉了。建中汤是专门治疗虚症的。如果说心中悸而烦，桂枝甘草汤，茯苓甘草汤都可以治心中悸而烦为什么这里用小建中汤。就是本身病人是虚的，你看他脸色很清很淡暗黄，小孩子不吃东西，身体很瘦，统统可以用建中汤。所以说得到伤寒，有表症，有里虚的，直接开小建中汤就可以了。

第一百一十六。

原文：「太阳病」，过经十余日，反二三下之，后四五日，「柴胡证」仍在者，先与「小柴胡汤」。呕不止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与「大柴胡汤」下之则愈。

意思是说过太阳症了，我们看到病人有柴胡汤症，比如往来寒热，胸胁苦满，恶心，我们开小柴胡汤。但呕吐并没有止，心下急，郁郁微烦者，为未解也，与「大柴胡汤」下之则愈。

加上前面，得出一个结论，如果病是在太阳跟少阳中间，只要有少阳症，这就是小柴胡汤。所以张仲景把小柴胡汤定义的条辨放在，病人出现介于太阳和少阳兼症的时候，用小柴胡汤。当出现少阳跟阳明兼症的时候，才是大柴胡汤的现象。这样区分什么时候用大柴胡汤，什么时候用小柴胡汤。受到阳明兼症，一定有烦躁便秘。如果没有只是往来寒热，头痛兼少阳症，我们知道小柴胡汤。所以小柴胡汤的设计适用于单纯的少阳证，或者是兼一点太阳症。但是当你没有了太阳证，进入少阳跟阳明的时候，只有一剂是大柴胡汤。这个大柴胡汤不得了，临床上大肠癌，你无法想象他效果多好。

大柴胡汤在少阳阳明。大柴胡汤里面有大黄，有时候我们会用到芒硝，少阳经也兼顾到。大柴胡汤出现的时候，病人一定兼有便秘同时兼有少阳证的现象，比如往来寒热，胸胁苦满，恶心，便秘。小柴胡汤不能治疗便秘。一定要大柴胡汤才能治疗便秘。

大柴胡汤帮助很多大肠癌的，没有开刀的，开了刀就不一样了。大肠如果有肿瘤，大肠和肝之间有个血管连通，全身上下只有这个血管没有瓣膜，所以你如果开了刀以后，癌症会从这个血管进入肝脏。这个西医都知道，但是他还是要开。到我们手上变成肝是厥阴症，厥阴证是寒热并结的一种现象。就是你是看到寒，也是看到热，可是你用桂枝麻黄葛根都不对症。本来是阳明症结果变成厥阴证。为什么会大便排不出来，西医不会用芒硝跟大黄。而且光靠芒硝跟大黄还不行，要配合柴胡汤在里面，才能够去掉它。

临床病人肿瘤长在大肠头，我就按照经方开，大黄牡丹皮汤症，把你当盲肠炎来治疗，同时薏仁附子败酱散，复方在里面。吃了大便开始排了。排到肿块没了，一直吃到大柴胡汤。进入大柴胡汤的时候，病人有便秘，有往来寒热，有恶心。他在吃大柴胡的时候，刚开始他太太弄错了，我给他吃的是一个礼拜的药，结果他三个礼拜才来找我，我叫他吃三勺，他吃一勺，吃了三个礼拜。我问他大便好不好，他说不好。我吓得赶快带他到门诊看，做给他看吃多少。他吃错了。这个还是粉剂。量加回去大便就出来了。半年现在都好好的。大柴胡汤。

大柴胡汤方

柴胡半斤，黄芩三两，芍药三两，半夏半升洗，生姜五两切，枳实四两炙，大枣十二枚劈，大黄二钱。

右八味,以水一斗二升,煮取六升,去滓,再煎,取三升,温服一升,日三服。

大柴胡汤比小柴胡汤多了枳实、大黄,小柴胡汤有人参。因为大柴胡汤有便秘,大黄把它清出来。枳实能够宽肠。如果说,柴胡汤看到病人有腹满,腹部胀满的时候,你要加厚朴下去。

大黄跟芒硝有差异,芒硝攻坚,大黄去实。攻坚,大便很硬,芒硝可以把它切碎。

硫磺你吃下去,如果真的中毒,舌头麻全身麻痹不能动,没关系,烧鸭吃一口,鸭肉解硫磺的毒。而且那个毒是热毒,不是真正的毒。

大黄去实,大便堵到,大黄只能推它,堵到的时候,有时候是软的。软的你不需要加芒硝了。硬的时候才要加芒硝。你怎么知道硬软,你去压他,拒按,不放屁,就要靠芒硝了。因为大肠被大便塞住了,当然屁都没有了。有一个人来找你,屁很多,堵在小肠里,因为大肠没有东西,所以肠气一直排出来。放屁很多小承气汤。大承气汤是屁也不放一个。所以你问什么时候用芒硝,你问他有没有放屁,没有放屁,芒硝。芒硝煮过效果就不好,生用,大柴胡汤煮完以后,你把芒硝放下,汤药冲下去喝,才有办法打出来。

没有大黄不叫大柴胡汤。有的时候会用到芒硝。如果诸位用到这个处方的话,大肠癌就是可以治的。绝对不会死人。你只要通利一段时间以后,自然而然他就恢复了,肿块就慢慢消除掉了。因为病是在阳明,少阳阳明。无死症。不要动他,一开刀,就变成厥阴,救都来不及救了。

### 3——5

#### 第一百一十七条。

「伤寒」十三日不解,胸胁满而呕,已而微下利,日晡所发潮热,此「柴胡证」,本不得利,今反利者,知医以药丸下之,非其治也。潮热者,实也,先宜「小柴胡汤」以解外,后以「柴胡加芒硝汤」主之。

伤寒,本来是在太阳证,十三日过两候,不解。胸胁满而呕,表邪下走到少阳。看到胸胁满而呕,不看后面,我们知道是小柴胡汤。病人只要黄昏就开始发热,燥热,出现这个症状,就是阳明热,阳明热都是黄昏发热。阳明热有两症,口渴,大部分都是白虎汤症。便秘,放屁,小承气汤。不会放屁,大承气汤。

这里的意思是说他兼有小柴胡汤症,又兼有阳明的燥热,病症在少阳跟阳明之间。病在少阳跟阳明之间,张仲景已经出方了,大柴胡汤。可是大柴胡汤主症是什么,用的是大黄。但是这个到了黄昏发潮热的时候,可能有燥矢在里面,干燥的大便堵在里面。大黄只能去实,不能攻坚,所以本不得利,现在反下利了,医生以药丸下之,非其治也。不对。潮热者,实也,先宜「小柴胡汤」以解外,后以「柴胡加芒硝汤」主之。这是说什么时候使用芒硝。芒硝是攻坚用的,这个坚是坚硬的大便,包含了大肠癌在内。大肠癌的病人,你只要确定了他有干燥的大便,你放心用芒硝。你如果不用芒硝,攻不出来的话,完蛋了。大柴胡汤或者小柴胡汤加芒硝,都是在阳明燥热症兼有柴胡症的时候使用。临床上去看,大肠癌病人只要没有开过刀,都是在这个症状。介乎在阳明跟少阳中间的时候,这是很好治的阶段。一动过以后,就变成阴症。所以我反对开刀。按照伤寒论理论,这个刀反



而坏事。但是如果说你不使用经方，怎么攻这个坚。

### 柴胡加芒硝汤方

柴胡二两六铢，半夏二十铢，黄芩一两，甘草一两，生姜一两，人参一两，大枣十二枚，芒硝二两。

右八味，以水四升，煮取二升，去滓，纳芒硝，更煮微沸，分温再服。

柴胡五，半夏五，黄芪三，后面都是三，芒硝是四到五，加重没有关系。当你使用芒硝的时候，芒硝生用，比如八味，以水四升，煮取二升。四碗水煮成两碗，芒硝一碗水只有一钱在里面。不要上面说二两就真的二两，我们把它换成钱，比如四钱好了。知道干燥大便在里面。你换成两钱，实际两钱就很重，一般不需要，一钱就够了，把芒硝放到碗里面，汤煮完把它冲下去，这个力量最强。张仲景是说，最好再稍微煮一下，他可能剂量比较重。我们剂量比较轻，不用煮，直接冲服下去就好了。你只要确定他需要芒硝，这个时候你用下去芒硝就是补药。只有芒硝可以把干燥的大便打出来。尤其干燥大便堵在大肠头，直肠很窄，大便很硬，你用芒硝一剂就攻出来了。不要手软，你一钱没有反应，就给他两钱，你宁可一剂把它去掉，也不要好几剂。剂量很重要。要是很严重，七天没大便秘了，我用两钱，一剂给他清出来。我们叫急下存阴。他已经燥矢的很厉害，你不把它马上清出来的话，阳明证一直在那边，一直在热的话，里面津液会伤掉。因为阳明是纯热症，等于是高热。你不清掉，津液伤到再去清就太慢了。所以我们要急下，要快下。小便颜色淡黄，很清，代表排掉了。大便清完小便颜色就变。

### 第一百一十八。

原文：「伤寒」，十三日不解，过经，谵语者，以有热也，当以汤下之。若小便利者，大便当鞭，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。若自下利者，脉微当厥，今反和者，知为内实也，「调承气汤」主之。

伤寒，非开麻黄汤不可。临床病人体重，节痛、体痛、恶寒、发热、高烧。临床上有病人一直在发抖，一个礼拜了，还没有过经。一望就知道了，大热天，他一直在发抖，棉被包着，我一摸脉，脉是浮紧的。不用问了，麻黄汤。西医讲的中风，我开的麻黄汤。一剂，好了。

那如果没有好，过经，那有两种可能，一种进入阳明，一种进入少阳。如果过了太阳经，“谵语者，以有热也，当以汤下之。”谵语就是胡言乱语，已经神志恍惚了。在经方里面来说出现谵语，都是燥矢，就是宿便。宿便发热，津液不够了，宿便变成很干燥的大便，浊气、燥气就会上升到脑部去，就会胡言乱语。“谵语者，以有热也，当以汤下之。”就是承气汤了。如果小便利者，大便当鞭，而反下利，脉调和者，知医以丸药下之，非其治也。意思是说，当以汤剂，医生没有用汤用丸药。我们该用汤药的时候用汤药，如果只是小孩子发烧感冒，开粉剂没有关系。那个人浑身发抖，汤剂。这里当以汤下，结果医生以丸药下之，结果力量不够，那你没有把它完全清出来。非其治也，就是力量不够。若自下利者，脉微当厥，今反和者，知为内实也，就是你该攻下的时候，你开的处方是对的，但是丸剂药力没有那么强。结果大便还是燥矢在里面，没有完全排出来。如果是误治，你攻下攻的很厉害，脉微当厥，就是脉很小的时候，这个人当场受不了，会昏迷过去。因为你攻太多了。今反和者，现在不是，脉很柔和，病人精神很好，代表你没有

误下，只是力量不够。当你用药的时候，有两种可能，一个是过，一个是不及。当你用汤剂的时候，为什么一碗一碗吃，就是喝到了，不要把它全部喝完。

第一百一十九。

原文：「太阳病」不解，热结膀胱，其人如狂，血自下，下者愈；其外不解者，尚未可攻，当先解其外，外解已，但少腹急结者，仍可攻之，宜「桃核承气汤」。

「太阳病」不解，没治好。其人如狂，跟发狂不一样。发狂就是已经狂了，如狂就是很像狂了，但是还没有狂。

这个汤方是在治疗血症，瘀血第一方。张仲景经方认为，有瘀血，开的方子是「桃核承气汤」，我们清朝有个很有名的名医唐容川，写了一本书叫血证论，写的非常好。认为久病必有瘀血。瘀血出现的时候，这个条辨是告诉诸位，太阳是与膀胱有关系，当你一发表的时候，如果这个病人本身有热结膀胱，比如说是膀胱有结石，或者发炎，你一发汗，膀胱的津液就不够了，变的很浓稠，其人如狂，血自下，小便里会看到血，下者愈，如果血很顺利排出来了，血没有淤在里面，这个自己就好了。

其外不解者，尚未可攻，当先解其外。如果说我们攻下的时候，一定要确定表症没有，才能攻下。如果外证还有，一定要先解外。外解已，确定他没有表症了，有没有表症，看脉有没有浮，你可以问他身体的肌肉会不会痛，会不会胸胁苦满，头痛项强，怕风、怕冷，有没有流汗，这些都可以知道他有没有外症。当你确定外证统统没有的时候，只有少腹急结者，可以攻它。

少腹这个地方急结，硬邦邦的在这边，少腹这个地方，有可能是膀胱，有可能女孩子是子宫，有可能是淋巴结堵在这个地方。到底是哪一个？怎么知道是血急结在膀胱？当少腹血急结在膀胱里的时候，一定会伴有小便不利。

如果说小便利，血自下，下就好了。他就是小便不利，堵到了。瘀血块，或者是结石堵到膀胱，尿道口排不出来了。

如果病人太太，找你肚子痛，你怎么知道他是月经痛，你问他小便好不好，小便很好，膀胱没有淤到。

如果有病人是太太来了，月经期间腹痛，你没有问她小便好不好，月经腹痛很平常嘛，你就开给她，结果没有好，因为你没有问他小便好不好。她是月经来肚子痛没错，结果他月经来刚好膀胱结石堵到，结果是膀胱结石引起的腹痛，你没有弄清楚。

当你要使用攻下的药的时候，一定要确定他没有表症，第二你要确定你攻的是哪个部位，是对的。现在是要攻膀胱，膀胱里面堵到的血块。膀胱瘀血有时常常是因为外伤撞到。你要先问他小便，小便很好，代表膀胱没有问题。

桃核承气汤方

桃仁五十个去皮尖，桂枝二两，大黄四两，芒硝二两，甘草二两炙。

右五味，以水七升，煮取二升半，去滓，纳芒硝，更上火微沸，下火。先食温服五合，日三服，当微利。

按照比例来说：桃仁三，桂枝二，大黄四，芒硝二，甘草二。

大黄四两，芒硝二两，甘草二两炙，这三味药是调胃承气汤，再加上桂枝跟桃仁就是桃核承气汤。

张仲景很厉害，他在活血化瘀的时候，用桂枝很多，包括我们桂枝茯苓丸，很多都是桂枝。活血化瘀为什么要用到桂枝，因为桂枝这个药辛甘发散，它到心脏里面，能把心脏血喷射力量加强，攻淤的时候桃仁，有心脏动脉的血在后面推他，破淤的力量会更强。所以张仲景常常使用桂枝。

血症，病人有淤血的时候有时会有很多特殊的症状，比如，嘴巴很干，口很渴，就是不想喝水。身体有淤血，淤到的时候，身体血液循环不畅通，病人就会口渴，不欲饮。还有像妇人三阴交、血海，都是血的汇穴，三阴交找到压痛点，都有淤血。这个淤不去，新血不生。所以我们在治疗贫血的时候，不是一味的说补血，淤血你没有给他去掉，新血生不出来。所以我们在开补血的时候，常常在活血化瘀。把淤血去掉，新血就回来了。病人身上有淤血的时候不受补，你开补药给他，他不接受，反而会更难过。

膀胱有淤血，就一个处方，桃核承气汤。

第一百二十。

原文：「伤寒」八九日，下之，胸满，惊烦，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，「柴胡加龙骨牡蛎汤」主之。

为什么讲八九日，不单单说是八九日，这个时间医生最容易误解，到底它传经了没有。我们该发表还是攻下。第一百二十是告诉你，他八九天了，看起来是已经是要传经了，你攻下还是太早，表证还有，还没去掉。所以他不会写个二三日，二三日一期的话六天到七天，应该是要解表才对，他已经八九天了，你一看应该是病走到阳明症了嘛，一攻下，结果他还在太阳，还没有完全下去。这个条辨就是表证未解，已经快要入里的时候，结果你先入里了，造成病人会胸满，心烦小便不利，谵语。伤寒论如果误下的时候，也就是说这个人太阳症，我们应该是解表，结果你去攻里，你攻里的时候，麻黄汤证，你开麻黄汤，结果你不敢攻，病人有大承气汤证，你攻下的时候，汗陷下去，可能会变成结胸。也可能是中风，温病，结果你应该用桂枝汤，或者葛根汤去发表，结果你不敢发，去攻下，结果他风邪进入心脏的下方，变成心下痞。

3——6

如果跑到胸腔里面去，水跑到肺里面去，肺积水怎么处理。这里下之，胸满，这种胸满会有心烦的现象。因为三焦跟心包是表里，一般来说三焦系统无所不到，我们讲三焦就是水的系统。这个水在三焦是应该气化出来的。如果说你攻下了以后，你表证没有去掉，寒症跑到三焦的淋巴系统里面去。造成小便不利，因为它跟心包是表里，会造成惊烦。惊烦就是焦虑、慌乱。一般出现惊烦，张仲景都是用龙骨、牡蛎。“一身尽重，不可转侧者，”翻个身体都不行，因为脾主四肢肌肉，解肌。“小便不利，”水道系统不通的时候就会影响到脾脏。从“胸满，惊烦，小便不利，”我们可以看出来，他有三焦系统，我们会用柴胡汤，少阳症。“一身尽重，不可转侧者，”在肌肉里面，可能需要用到桂枝来解肌。谵语，可能有大便秘到，大便秘到会有晨昏谵语的现象。小便不利是因为水堵在三焦，处方「柴胡加龙骨

牡蛎汤」主之。

柴胡加龙骨牡蛎汤方

半夏二合洗，大枣六枚，柴胡四两，生姜一两半，人参一两半，龙骨一两半，铅丹一两半，桂枝一两半去皮，茯苓一两半，大黄二两，牡蛎一两半。

右十一味，以水八升，煮取四升，纳大黄，切如碇子大，更煮一二沸，去滓，温服一升。

铅丹现在不好买，属于金石类的药，属于青铅。并不是真正的铅，青色石头类的药。无毒，镇心。龙骨，牡蛎用的很多，龙骨潜阳用的，正常人，手掌是温热的，额头的冷的。常人手掌脚掌是温热的，手背、脚背、额头是凉的。手掌脚掌跟胃气有关系，平常你手脚是冷的，热汤喝下去，手脚热起来，所以手掌、脚掌代表胃气的地方。有的是太过了，手汗脚汗比较多，可以去问题是不是大便不好，承气汤攻出来就好了，有的是虚热，手汗脚汗很多，大便很好，这就是龙骨牡蛎汤。因为他虚热，热本来是应该潜在阴里面。阳是很轻的东西。阳回来，阴会自己回来，才会痊愈。这个里面病人会惊烦，我们用牡蛎来收敛阳，阳会下来。龙骨跟牡蛎有点差异，如果身上的精和津。当你精失掉的时候，我们会重用龙骨，龙骨可以收敛，固涩的药，如果你是津失掉了，重用牡蛎。因为牡蛎是咸的，咸本身是水，能够生水。如果病人，惊烦，大小便正常，也没有梦遗，盗汗，只是惊烦，焦虑，龙骨牡蛎开等量。如果小朋友，小学六年级还在尿床，我们知道他是龙骨牡蛎汤症，你用龙骨和牡蛎的时候，知道他是失津，小便失津，重用牡蛎，龙骨少一点。如果十七八岁在梦遗、遗精，龙骨要加重，牡蛎要少一点。

一定要看到有谵语，讲话语无伦次，这个时候会用大黄，大黄就是阳明燥热的谵语症。既然是柴胡加龙骨牡蛎汤，我们重用柴胡，柴胡用到四。半夏，张仲景都是用生半夏，这里可能比柴胡多一点，用四钱左右。

这个我们用到柴胡加龙骨牡蛎汤，就是攻下的时候没有解表，攻下了，病邪跑到少阳上面，和阳明中间，这个时候我们会使用柴胡龙骨牡蛎汤。用到龙骨牡蛎汤一般来说都是素虚之人。很强壮的人，如果攻下太早，他津液可能会自己回来。

第一百二十一。

原文：「伤寒」，腹满，谵语，寸口脉浮而紧，此肝乘脾也，名曰「纵」，刺「期门」。

第一百二十二。

原文：「伤寒」，发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，其腹必满：自汗出，小便利，其病欲解；此肝乘肺也，名曰「横」，刺「期门」。

这两条看出张仲景针灸不是很强。「伤寒」麻黄汤就好了。

第一百二十一条。肝乘脾的时候，脾脏来主少腹。比如脐下悸，肚脐下动悸，脉跳的时候我们用茯苓甘草。腹满，谵语，寸口脉浮而紧，张仲景说刺「期门」。实际上刺期门穴还不如章门有效。因为章门是脏的会穴。期门只是肝的募穴。如果刺章门他涵盖五脏，同时又是脾脏的募穴。

第一百二十二条。发热，啬啬恶寒，大渴欲饮水，因为你用发表的药，比如你伤

寒开麻黄汤，下去汗太多了。麻黄汤下去发表发的是肺里面的津液。第一百二十一条。腹满，谵语，是肠子里面的津液发掉了，这个是桂枝汤才会有。第一百二十二条。伤寒大渴的话，因为你麻黄汤下去的话，麻黄汤是桂枝、炙甘草、杏仁和麻黄。它主要是发肺脏的汗，肺里面的津液发掉，肺是胸诸阳之汇，麻黄汤发散，阳虚掉了以后，阳不足，病人就会有怕冷的现象，同时因为水发汗发掉了，所以渴欲饮水。当病人津液不够的时候，我们不管是脱水，还是汗发太过了结果肠子套叠在一起，当病人失去水分的时候，只要小便利，这个病就会自己会好。小便利的意思就是津液自己恢复了。

如果小便不利，病人出现大渴，欲饮水这些现象的时候，肝乘肺也，刺「期门」。实际上肺里面的津液不够的时候，可以用麦门冬汤。像第一百二十一条，腹满，谵语，寸口脉浮紧的时候，我们会用小建中汤。或者里面有便秘，谵语的时候，我们会用桂枝汤加大黄。看当时的症状来开处方。

### 第一百二十三条

原文：「太阳病」二日，反烧瓦熨其背，大汗出，火热入胃，胃中之水竭，躁烦，必发谵语。十余日振栗，自下利者，此为欲解也。其汗从腰以下不得汗，故欲小便不得，反呕。先欲失溲，足下恶风，大便鞭，小便当数，而反不数及不多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。

“「太阳病」二日，反烧瓦熨其背，大汗出，火热入胃，胃中之水竭，躁烦，必发谵语。十余日振栗，自下利者，此为欲解也。”这个过去发生在大陆北方，会有。北方人睡在炕上面，本来得到太阳病，是应该发汗，可是这个汗是药汗来解，如果是处方麻黄汤的时候，里面会有杏仁炙甘草在里面，来补他的津液。如果你开的是桂枝汤，生姜、炙甘草、红枣，在里面。所以如果我们用药汗，会加一些增润津液的药在里面，病人不会有津液不够的现象。过去人恶寒，靠在炕上比较舒服，结果因为外面的热进来造成病人大汗出，这个汗是被蒸出来的，不是从里面发出来的。这个时候火热入胃，这个胃你把它当做胃和肠，肠也在那里，肠子的津液没了，这个时候的水竭了，病人会烦躁，必发谵语，这个谵语就是大便干掉了。如果说十余日振栗，十几天病人不热了，有点恶寒了，说明水回头了。自下利者，大便通畅了，这是快恢复了。

“其汗从腰以下不得汗，”是阳明胃经从腰一直到腿以下。“故欲小便不得，”津液不够了。“反呕，”病人恶心。“先欲失溲，”想要去小便，但是小便排不出来。

“足下恶风，”“大便鞭，”大便是干燥的，小便当数。如果是大便鞭，小便数的话还好。如果“反不数及不多，大便已，头卓然而痛，其人足心必热，谷气下流故也。”这个是因为什么，因为外面的火烤过以后，大肠津液不够了，有很多方式津液会回头，吃蔬菜喝稀饭，人参汤、水梨。津液回来以后，瞬间肠子蠕动回来的时候，那个瞬间燥气会往上冲，所以会头痛一下，不会持续，痛一下就过去了。这是一个谷气下流，胃气顺着足阳明胃经到脚上去。

千万不要用热火去烘他。如果家人有感冒伤风，冬天用火炉烧，不见得好，可以用，但要确定没有表症。如果用热炉，大汗出的时候，有可能肠胃的津液伤到了。大便津液干在里面。看看会不会有谵语。

### 第一百二十四条。

原文：「太阳病」，中风，以火劫发汗，邪风被火热，血气流溢，失其常度，两阳相熏灼，其身发黄。阳盛则欲衄，阴虚小便难，阴阳俱虚竭，身体则枯燥，但头汗出，剂颈而还。腹满、微喘，口干、咽烂，或不大便，久则谵语，甚者至「哕」，手足躁扰，捻衣摸床；小便利者，其人可治。

甚者至「哕」，出现「哕」症就很危险了。

这种现象也会发生。失火，“火劫”，“邪风被火热，血气流溢，失其常度，”这是一种特殊的场景，“两阳相熏灼，其身发黄。”这个本身的阳和火的阳碰在一起。血里面有百分之七十以上是水，血里面的水不够了，透过皮肤表面看过去的时候，就是身体是黄的。并不见得是肝胆的病。“阳盛则欲衄”如果两阳相抗的时候，阳很盛会流鼻血。流鼻血，烧就退了。“阴虚小便难，”因为津液伤到了，小便就很少了。如果“阴阳俱虚竭，”“身体则枯燥，”“但头汗出”头部是诸阳之会，如果病人精神很好，有两种但头汗出，一种是妇女一工作，做事情满头大汗，可他精神很好，这个汗出是阳明热，用汤剂，比如说白虎汤可以把它去掉。“但头汗出，剂颈而还。”因为头是诸阳之会，我们身上有六阴六阳，阴经只到喉咙，头上是六阳之会。“腹满、微喘，口干、咽烂，或不大便，久则谵语，甚者至「哕」，手足躁扰，捻衣摸床；”这种是急虚的人会有头汗出，那是很危险，阳绝掉了。还有种是阳盛，也会头汗出。

喉咙是三阴的交汇。太阴少阴厥阴。都汇在喉咙的地方。所以喉咙是一个我们查阴够不够的所在。头部是看阳够不够的所在。如果“咽烂，”代表阴经已经伤到了，头上又流汗，代表阳又虚掉了，阴阳都虚掉了。再加上谵语，大便又堵到了，津液没有回头，严重就会「哕」，「哕」就是打嗝。打嗝这个现象刚开始有间断，后来不间断，连讲话都在打嗝。快接近死亡了。

如果出现“手足躁扰，捻衣摸床；小便利者”这个人可治。手足躁扰，捻衣摸床是阳明燥症，阳明证才会出现。干燥的大便堵在大肠里的时候，病人会出现手足躁扰，捻衣摸床。真的是捻衣摸床，病人沿着床边走，两眼是直的，摸着床的旁边走。没有摸床的时候，他手就捻他的衣服，无法控制，一直在揉，只要是布类的他就会去抓。“小便利者，其人可治。”这是在阳明症，阳明症是大便干在里面，小便不利就完了，阴津都没了，小便还利，代表阴还有，这时候大承气汤下去一剂就回来了。

手足都代表胃，摸他手脚都是热的，手脚背是冷的，代表胃气很足。如果胃气不够，津液不够，开始要燥了。

我们常常看病人有没有渴，肾脏病人，之前从来不口渴，治他开始口渴，很想喝水，病人就回来了，原来没有胃口，现在胃口大开，回来了。原来小便不利，现在小便利了，代表津液回头了。

第一百二十五条。

原文：「伤寒」，脉浮，医以火迫劫之，「亡阳」，必惊狂，起卧不安者，「桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤」主之。

这个处方最有名的治疗烫伤第一方。在救逆的时候，救逆就是所谓紧急的时候使用，张仲景就会把芍药拿掉。危险的时候都会把芍药拿掉，因为芍药是收敛的药。是酸味的药，把芍药拿掉，阳回头的力量会非常强。如果芍药加在里面，

速度反而会减缓。

伤寒，脉浮，应该是发表，麻黄汤就好了。结果医生用火去攻它，流汗，出现亡阳。人在外面有阳，因为有阳所以可以把身体的津液固住，不会流失津液，你用火硬去攻它，这是毛孔打开来了，就亡阳。亡阳的现象，必惊狂、焦虑，起卧不安者。当有起卧不安，焦虑，惊狂的时候，都可以用「桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤」，不一定非是说从火灾里面跑出来。病人焦虑、害怕、你没有办法控制他，情绪不好，睡觉又失眠，都可以使用这个药。

用桂枝的原因，因为桂枝走肌肉，会到皮肤表面上去。

桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤方

桂枝三两去皮，甘草二两炙，生姜三两切，牡蛎五两，龙骨四两，大枣十二枚劈，蜀漆三两洗，去腥。

现在蜀漆用常山苗代替。蜀漆去痰的力量很强，受惊吓的时候，容易有痰涎壅塞，蜀漆或常山苗把痰去掉。

烫伤的时候，外敷：过去用牡蛎打粉，牡蛎可以排水。磨得细一点，加麻油，更好的用硫磺、大黄，硫磺就是在火山口的东西，硫磺本身外用时非常的寒凉，外敷的时候是寒凉的。吃到身体里是燥热，极热的。西医就把硫磺跟膏药一起在烫伤的时候用。

伤寒的时候我们绝对不要用火去发汗。有的人本身没有火劫，临床上，看了安眠药，抗忧郁药以后，人变的惊狂，坐卧不安，没办法睡觉，失眠，都可以使用。

这个药先煮蜀漆，因为蜀漆比较毒，实际上我现在已经不用蜀漆了。但是从这里看到，张仲景有预防蜀漆中毒的现象。

第一百二十六条。

原文：形作「伤寒」，其脉不弦紧而弱，弱者必渴，被火者，必谵语，弱者发热，脉浮，解之，当汗出而愈。

这个人发冷、恶寒、体重、节痛，肌肉也痛，又没有汗。看起来像伤寒，伤寒脉是浮而且紧。他的脉不弦紧反而弱。“弱者必渴，被火者，必谵语，弱者发热，脉浮，解之，当汗出而愈。”像这种情形，如果使用一些麻黄汤，比如这个人应该是脉弦浮紧，体格很正常的人，得到伤寒的时候脉浮紧，因为我们本身蓄血的力量很够，身体很强，所以没有问题。如果是遇到虚弱的人，你要给麻黄汤的时候，他本身是弱症，一发汗，病人会谵语，肠胃的津液会没有，本来麻黄汤是发到肺的津液，这个人太虚弱，有时候发太过。我们解他的时候，一般来说，碰到身体比较虚弱，又伤寒的时候，一般来说我们都用桂枝汤，不用麻黄汤，就怕会有太过的现象。

第一百二十七条。

原文：「太阳病」，以火熏之，不得汗，其人必躁，到经不解，必清血，名为火邪。

这条是说，用火来熏他取汗，结果不得汗，其人必躁，外面是热的，到经不

解,必清血,名为火邪。

正常人如果有太阳病,你用火一熏他就会流汗,这个人你用火熏他都不流汗,代表这个人身体里非常干,津液本来都不够,这个时候有得到太阳病。必清血,这个人大便一定会带血。里面太燥热了。

一般来说只要是津液不够的人,如果病人跟你说,吃了药口渴,代表病人要恢复了。口渴少少与之,不要给他太多。

第一百二十八条。

原文:脉浮,热甚,反灸之,此为实,实以虚治,因火而动,必咽燥,吐血。

一般来说只要有表症,我们都不会用灸的方式,此为实,表症是实症。灸是治虚用的。里虚掉,我们会用灸去帮忙他恢复。表有实症,你去治疗实症,要发汗解实症,结果你用灸来治他,灸本来是治虚用的,你治实症用它,遇到这种一定会咽燥,三阴的阴津会干燥,太阴、少阴、厥阴,会伤到阴津。这个时候病人会吐血。

有时候会吐血或大便带血。一般来说伤到阳的时候,按照内经,如果伤到阳,胸阳,病人会吐血。如果伤到阴,阴经伤到的话,病人大便会带血。

第一百二十九条。

原文:微数之脉,慎不可灸:因火为邪,则为烦逆,追虚逐实,血散脉中,火气虽微,内攻有力,焦骨伤筋,血难复也。

这种“微数之脉”本身就有虚热在里面。灸用的时候,一定是寒症,虚寒的时候用灸,实热的时候都不用灸。比如大便便秘,里面是燥热,结果你灸他天枢关元,本来他只是燥热,结果灸下去马上神昏谵语。

灸一定是遇到虚寒,比如说这个人下痢,一天好几次,吃什么排什么出来,这个时候用灸是对的。病人发烧用灸都不行。病人有热症都不适合用灸。

第一百三十条。

原文:脉浮,宜以汗解,用火灸之,邪无从出,因火而盛,病从腰以下必重而痹,名火逆也,欲自解者,必当先烦,乃自汗而解。何以知之?脉浮,故知汗出解也。

脉浮,病在表。当表邪下陷的时候。如果说应该用汗解,结果你用火灸他,一灸他,正常人,如果灸下去坏事的时候,脉会更强更盛才对,不可能流汗。如果说病人自己会自汗出,因为脉浮是中风的脉,伤寒的脉才会有脉浮紧。这个从脉症我们判断出他自己会恢复,没有因为,不该灸而造成很大的伤害。造成伤寒,但是他自己会恢复的意思。如果因火太盛,病从腰以下必重而痹。常人阳是往上升的,阴是往下降的,你如果一灸火盛的时候,灸的火是热,再碰到阳在下焦往上冲,造成下焦阳会重阳,阳会阳亢。会产生这种现象。

一二九、一三零这两条重点是有表症、实热症的时候,统统不可以灸。灸一定是用在寒症,虚寒的时候才可以用灸。

第一百三十一条。



原文：烧针令其汗，针处被寒，核起而赤者，必发「奔豚」，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，与「桂枝加桂汤」。

造成这个原因就是烧针，因为天气很冷，针下去以后，露在外面，“针处被寒，核起而赤者，必发「奔豚」，”实际上临床上看到的时候，两个地方会看到奔豚。第一个，破伤风。有太太有一个手指头肿到，很痛，有一条红线到内关，痛到没办法开车。她手上有伤口，摸到生锈的钉子，所以就破伤风。一样啊，针处被寒，等于是受到毒，“核起而赤者，必发「奔豚」，气从少腹上冲心者，灸其核上各一壮，”我在灸她的时候，她到内关的地方，我在她内关上一寸的地方开始灸，手指头再放个艾灸灸，我在灸她，红线就往回退，灸到第三壮的时候，红色已经退到手掌，一过劳宫穴我就停止掉了。她出门上车就可以开车了。回家睡一觉，早上起来全部好了。药都没有吃，光是灸。

还有一个奔豚。妇人便秘，又受到惊吓，燥矢顺着血管，大肠与肝脏之间有血管，从阳明直接进入厥阴，厥阴往上跑，跑的时候，大便沼气会进入肝脏的血，肝血会进入心脏，肝脏的血带着大便的沼气，往心脏跑，心脏本身君主之官，不受病，心脏往外推，这个时候动悸的很厉害，病人呈现的现象就是从大肠处一直跳跳，不断往上跑，心脏不断往外推，动悸的很厉害。奔豚，为什么桂枝加桂汤？第一，桂枝汤可以增润津液，和解，解肌。会加到桂，这里的桂是肉桂，肉桂跟桂枝同一个树，但是不一样，桂枝就是桂树的树枝，进入血脉。本身肉桂是树心，所以肉桂入心脏，强心的力量很强。临床桂枝加桂汤，你加桂是桂枝，效果不强。你用肉桂一下去，心脏强起来，喷的力量很强，硬把沼气推回肠子里面去。肉桂配在桂枝汤里面，因为桂枝汤解肌，解肌就是能补津液，除了太阳中风以外，桂枝汤能够补津液，桂枝汤里面有生姜、甘草、大枣，桂枝跟白芍可以让血液循环加速，同时可以补津液。如果没有桂枝汤，只有肉桂，津液会伤到。因为发表的力量很强，后面没有后援。

桂枝加桂汤方

即桂枝汤加桂枝二两

这汤剂争议很多，有的赞成桂枝，有的赞成肉桂，但临床上，肉桂极有效，用桂枝汤加肉桂，肉桂用五分，严重的用八分，不需要用到一钱，因为会太辣了。

第一百三十二条。

原文：火逆，烧针汗之，因烦躁者，「桂苓甘草龙骨牡蛎汤」主之。

桂苓甘草龙骨牡蛎汤方

桂枝一两，甘草二两，牡蛎二两，龙骨二两，茯苓四两。

右五味为末，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

桂枝、甘草，前面介绍过，动悸的时候我们会使用。茯苓脐下有动悸的时候我们会使用。临床上甲状腺，我们用这个处方做加减。甲状腺亢进，心动悸会很厉害，同时会潮热。用这个处方来做加减。

在病人出现烦躁的时候，张仲景都喜欢用茯苓。茯苓不单单是色白入肺，它入脾脏、利水。茯苓能够生津液。所以脐下悸我们用茯苓，因为茯苓能够把旧水

排掉新水补回来。

如果是火劫，发汗，病人津液伤到了，已经伤到津液的时候，我们重用茯苓。病人会烦躁，这种烦躁，除了大便便秘有烦躁，那个烦躁实际上是惊狂，有点谵语。

这个汤剂里面，可以看到，桂枝在治烦躁的时候，茯苓可以把心脏血里面水分补回去，我们常常用到茯苓。临床用甲状腺来治疗甲状腺很有道理，牡蛎本身是海里面东西，有碘在里面，牡蛎可以攻坚，同时牡蛎又可以生津液，盗汗的时候可以用牡蛎。喉咙的地方是三阴的地方，太阴、少阴、厥阴统统在这个地方。

扁桃腺发炎。一般来说喉咙痛，桂枝汤加葛根，可以加一些连翘清热，银华、蝉蜕。光是喉咙痛，桂枝三芍药三，葛根用四就可以了。要是还有脸部中风，葛根用六，大剂的。同样一个处方，剂量的多少，运用要存乎一心。一定要知道药性，这样就不会错。

茯苓一定可以去补心脏里面水不足的部分。茯苓止热生津除烦的功能。茯苓碰到龙骨牡蛎的时候，就可以让心脏的阳、热回到水里面。如果说心脏里面水不够了，茯苓，然后用龙骨潜阳，龙骨、牡蛎把它固定在里面，所以常常心烦、烦躁的时候，我们用龙骨、牡蛎、茯苓。

第一百三十三条。

原文：「太阳」、「伤寒」者，加温针，必惊也。

“必惊也”津液伤到。

3——8

心脏里的水不够了。就会造成惊。

你只要有表症，一定要解表，解表的方式，是用汤药，不要用外面的其他方式，什么火烤啊，温针、灸啊，都不要。

第一百三十四条。

原文：「太阳病」，当恶寒发热，今自汗出，不恶寒发热，关上脉细数者，以医吐之过也。一二日吐之者，腹中饥，口不能食；三四日吐之者，不喜糜粥，欲食冷食，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。

太阳病，病人还没吃发表药，就因为一些原因开始吐。如果吐了一两天，肚子感到恶，但是嘴巴不能吃。我们会觉得饿，是脾脏阳回头了。口不能吃是胃气还不足。三四日吐之者，吐太过，肠胃津液伤到以后，吃不下东西，想吃冷的，朝食暮吐，以医吐之所致也，此为小逆。

吐口不能食，中医有个大半夏汤，我们用生半夏止呕，人参来补脾胃丧失的津液，用白蜜，蜂蜜补回去。用等量半夏三，人参三，蜂蜜三。

朝食暮吐，是里虚的人。处方吴茱萸汤。临床只要病人胃酸，逆流，只要里虚的都可以用吴茱萸。吐的严重的我们把生姜换成干姜。干姜比较热，能够温中。这里是里虚，朝食暮吐。

有一种实症，朝食暮吐。阳明篇介绍。

恶心、呕吐，刚开始很浅的时候，大半夏汤就去掉了。如果吐的很严重了，烦逆、烧心、胃酸，吴茱萸汤。嗝气很厉害，下面冲上来，冲到食道的时候，这个力量就不够了，加旋覆花代赭石汤。如果胃里面寒症，很酸，吴茱萸汤，西医讲的胃下垂，一剂就好。如果火烧心，酸逆到食道里面来，旋覆花，代赭石是石剂，降气力量很强。

胃虚寒不好的话，后面等到他的就是胃癌、胰脏癌。所以它有胃酸、呕酸的时候就把他就回来，或者有食道癌，食道烧坏。

肠胃这个用粉剂比较好，因为你粉剂吞下只到胃里面去了。

第一百三十五条。

原文：「太阳病」，吐之，但「太阳病」当恶寒，今反不恶寒，不欲近衣者。此为吐之内烦也。

人吐会解表。过去有人太阳病，他不用桂枝麻黄葛根，他用吐剂，一吃就吐了。一吐人就会流汗。流汗表就解掉了。

吐太过，津液补足的时候，如果太热，我们用人参白虎汤。

第一百三十六条。

原文：病人脉数，数为热，当消谷引食，而反吐者，此以发汗，令阳气微，胃气虚，脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

病人脉数，数照理为热，代表胃气很强，吸收力很强。我们有三消：上消、中消、下消。西医分两种，一种是胰岛素依赖型。这是打了B肝疫苗，打下去胰脏就坏掉了。所以第一类糖尿病是西医制造出来的。第二类，是你吃宵夜，吃完马上睡觉。

中医分三种，第一中渴饮千杯不止渴。第二种是胃口非常大。第三种阳不举。

这里指的是中焦。“当消谷引食，”脉很数，应该一直吃才对。“而反吐者”没有胃口，吐的很厉害。“此以发汗，令阳气微，胃气虚，脉乃数也。”这个数是因为发汗才造成的。因为吐者发汗。我们发汗是用桂枝汤、麻黄汤、葛根汤，这个人发汗是以吐来发汗，造成这样子，所以张仲景说尽量用发表的药来发汗，不要用吐法，来发汗。这个用吐来发汗，结果造成胃气虚。脉乃数也。数为客热，不能消谷，以胃中虚冷，故吐也。

有时候不是医生吐法发汗，病人吃坏食物。这个是不赞成用吐法来发汗。胃中虚补救的方式，甘草干姜汤。炙甘草用四，干姜用二。胃太冷可以加吴茱萸，人参。

第一百三十七条。

原文：「太阳病」，过经十余日，心中温温，欲吐，而胸中痛，大便反溏，腹微满，郁郁微烦，先此时，自欲极吐下者，与「调胃承气汤」；若不尔者，不可与；但欲呕，胸中痛，微溏者，此「非柴胡证」，以呕极吐下，故知也。

「太阳病」,过经十余日,心中温温,欲吐,而胸中痛,大便反溏,腹微满,郁郁微烦,先此时,自欲极吐下者,与「调胃承气汤」;这什么意思?就是平常感觉胃不舒服,吐掉会比较舒服。幽门下方,十二指肠这段,就是调胃承气汤症,触诊,可以在中脘穴以下的建里、下脘的地方,可以压到压痛点。拒按,很痛里面是实,调胃承气就是把这一段清掉。

若不尔者,如果调胃承气下去没有好,但欲呕,胸中痛,微溏者,此「非柴胡证」,以呕极吐下,故知也。如果他没有好,就不要给他了,让他自己恢复。这个吐跟柴胡没有关系,这里的恶心是因为食物堵在小肠里面,调胃承气清,还没有完全清掉的时候,让他自己恢复就可以了。会有这种现象,调胃承气没法清,就是吐太多了。十二指肠疲乏掉了,肠子蠕动不是很好。

还有一种。吃东西想吐,是发生在很平常。喝酒。酒客不喜甘。吴茱萸汤就是很好治酒客的方子。加苍术,泽泻。苍术五,泽泻六比例。苍术跟白术不一样。根茎是白术,树顶上是苍术,苍术到脑部去湿,喝酒的湿热跑脑部去,苍术能够清掉。泽泻加重,酒精从小便排掉。

如果说一个恶心的现象,我们是开小柴胡汤。

遇到必须喝酒的场合,小柴胡汤反过来用。小柴胡汤你把半夏加重,半夏利水,你加重,在喝酒前一个小时吃,同时加泽泻、苍术按比例加在小柴胡汤里面,你半夏加进去,它水利的很强,你酒喝下去,马上到下面去了。根本没有到肝脏里面去。不断的喝,就不断的小便。

喝酒喝的很多的人,胃会不舒服,看起来都是胃下垂,都是吴茱萸汤症,胃家的寒症,舌头是白的厚的,吃东西就吐掉,人瘦瘦的都是寒症。胖子都是热症。

#### 4——1

#### 第一百三十八条。

原文:「太阳病」,六七日表证乃在,下之,脉微而沉,反不结胸,其人发狂者,以热在下焦,少腹当鞭满,小便自利者,下血乃愈。所以然者,以「太阳」随经,瘀热在裹故也。「抵挡汤」主之。

这个人表症仍有,应该发表,结果攻下。这个攻下不见的是医生攻下,有时是吃坏肚子。“脉微而沉”本来表症是浮的脉,浮在表,现在沉,反不结胸,其人发狂者。前面介绍的是如狂,看起来好像要狂,但是还没有狂,那是血在膀胱里面。这里发狂是已经发狂了,神智不容易控制、焦躁。“以热在下焦,少腹当鞭满,”鞭就是硬的意思。硬块,你摸到非常硬。大便出来像鞭,这个鞭不是硬,是像鞭子。为什么形容像鞭,摸病人肚子,摸到硬邦邦的一条,就是鞭满。“小便自利者,”小便都很好,代表膀胱没有问题。可能就呆在子宫里面了,男人就是腹腔里面。下血乃愈。为什么呢?以「太阳」随经,瘀热在裹故也。「抵挡汤」主之。

抵挡汤这个药很骏。真正在使用抵挡汤的时候,是用在妇人子宫里面有肿块,肿瘤。男人腹腔里面血结住。有时候外伤伤到,小便很好,膀胱里面没有血,腹腔里面有淤血。抵挡汤吃下去血会从大便排出来,大便是黑的。

#### 抵挡汤方

水蛭三十个熬，虻虫三十个去翅，桃仁二十个去皮尖，大黄三两酒洗（浸）。

右四味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，不下再服。

吸血的水蛭，小小细细像一个小铁钉一样。虻虫，牛虻，生长在牛棚专门叮牛，指甲大小。水蛭、虻虫都是吸血的，这两个药碰在一起非常凶。可以活血化瘀，肿块里面的淤血，它会把它吸收掉。中医用动物药的时候，用动物的性，比如背后膏肓痛，膏肓痛是淤血在里面，放血火罐拔掉就好了，过去有人用水蛭治膏肓痛，放身上，有淤血的时候，它吸你的脏血，不会吸你的好血，天性如此。

血症第一个方子就是桃核承气汤，第二个方子就是抵当汤。抵当汤主症就是瘀热在里，少腹当鞭，小便自利，代表膀胱里面没有问题，专对子宫。古时案例，妇人怀孕，子宫有肿瘤，肿瘤和胎儿一起长，压迫小孩子长不大，抵当汤下去，淤血排出去，肿块消除，小孩子就长大。

水蛭越细越小越好，虻虫越大越好。

陈逊斋氏曰：盖少腹硬满，有「血结」，有「水结」，有「水血两结」。「血结」必见狂妄。小便是利的，病人发狂，用「抵当汤」。小便不利的，病人如狂，还没有真正的发狂，用「桃核承气汤证」。「水结」，如果水结下焦，必小便不利，「五苓散证」是也。「水血两结」必小便难，少腹满如墩状，如「大黄甘遂汤证」是也。

东洞翁本方定义曰：治有瘀血者，凡有瘀血者有二：少腹鞭痛而小便快利者，其一：腹不满而其人自觉满者，这都是淤血在里面。其二。急则以汤，缓则以丸。急症的时候用抵当汤。病人你怎么知道他血结在里面，肚子感觉胀满，摸摸看没有胀满，如果是膀胱有尿胀满，肚子会胀的，可是他肚子平平软软的，就是里面有淤血。小便不利者就是瘀血在膀胱，就是桃核承气汤，小便快利者就是抵当汤。

陈自明与此方中去「大黄」加「地黄」用之，这个人如果大便很通利，大黄不需要了，我们改成地黄，配上这几个攻坚的药的话，补泻兼顾，同时可以把子宫里面淤血攻掉，同时把血补回来。

有一种症状叫「干血劳」。病人表现的表证就是小腿上「肌肤甲错」。长得像鱼鳞，只有小腿这一段变的很干。这个代表腹部有干血，血干在里面了。就可以把大黄拿掉，换地黄。如果说这个人又便秘，你就还是用抵当汤，加地黄上去。因为地黄有增润津液的功能。因为他太干了，你去增润他一点津液的时候，它变湿了、变滑了你去把它清掉。有干血劳的时候你可以用。子宫里面有干血劳在里面的时候，因为子宫是血室，直接落到肝经，子宫又是受奶水下降的地方。所以如果有干血劳的人，你如果不把它治好，他的乳癌的机率会比较高。因为奶水下来，没有办法完全停在子宫里面，可能有干血劳堵到一部分，奶水还有一部分累积到乳房里面。干血劳在腹部也能看到，大部分是在小腿。

第一百三十九条。

原文：「太阳病」，身黄，脉沉结，少腹鞭，小便不利者，为无血也；小便自利者，其人如狂者，血证谛也，「抵当汤」主之。

太阳病，脉应该是浮的，但现在脉是沉在里面的。遇到贫血的病人不是一味开补血的药就好的，瘀不去，新不生。你一定要查造成瘀的原因，把源头去掉才

会好。绝大多数贫血都便秘，清便秘，大便一正常，胃口一恢复，补血药还没开，光吃饭血就补回来了。

临床遇到久病、癌症都会有淤血。

附骨脉：你手摸他的脉，摸下去沉到骨边才摸到它，你按它越按跳的越快。附骨脉就是里面有阴实。

第一百四十条。

原文：「伤寒」，有热，少腹满，应小便不利，今反利者，为有血也，当下之。不可余药，宜「抵当丸」。

就是发现病的时候赶快下。这个是抵当丸。抵当丸是少腹满，没有鞭满，硬满，很强烈的。抵当丸症比抵当汤症稍微轻一点，不是那么急，急的时候要用汤。缓的时候用丸。

抵当丸方

水蛭二十个熬，虻虫二十五个熬，去翅，桃仁二十个去皮尖，大黄三两酒浸，右四味，杵分为四丸，以水一，煮一丸，取七合服之，晡时当下血，若不下者，更服。

4——2

抵当丸与抵当汤处方一样，只是做成丸剂。

第一百四十一条。

原文：「太阳病」，以饮水多，小便利者，必心下悸；小便少者，必苦里急也。

太阳病喝水多有两种现象，一种喝热水，小便马上就排出来，心下动悸。一种是喝的多小便少。“必苦里急。”里面有东西堵到。

第一百四十二条。

原文：问曰：病有「结胸」，有「藏结」，其状何如？答曰：按之痛，寸脉浮，关脉沉，名曰「结胸」也。何谓「藏结」？答曰：如「结胸」状，饮食如故，时时下利，寸脉浮，关脉小细沉紧，名曰「藏结」；舌上白苔滑者，难治。

「藏结」，脏和腑本来是相通的，脏和腑中间有寒湿，寒湿像白痰，黏黏稠稠的梗在中间。藏界的成因是慢慢累积起来的，比如居于湿地，或汗每次没有透发，慢慢在关节累积起来，日积月累到里面去，这个寒湿慢慢就会停在脏腑中间，脏和腑分隔开来，就是藏结。

「结胸」，一般误治才会有结胸。比如伤寒表证，是寒证，应该用麻黄汤去发表。结果攻下，一攻，皮肤表面表邪的水，应该发汗发掉的，跑到肺里面去，产生结胸。

藏结饮食如故，他消化系统没有问题，饮食很正常。就是常常下痢，消化的食物，消化以后，要把食物转给内脏的时候，有问题，因为有寒湿当在中间。藏结很难治。你看他舌苔，舌苔是看胃气的地方，白白湿湿的，这是寒湿在里面。

第一百四十三条。

原文：「藏结」，无阳证，不往来寒热，其人反静，舌上苔滑者，不可攻也。

没有阳证，不可解表，没有往来寒热，没有少阳证，不可以小柴胡汤。照理说进入阳明证应该燥热烦躁，其人反静。没有表证，没有少阳证，又没有阳明证。舌上苔滑者，不可攻也。攻就是攻下。经方用攻下会用到芒硝跟大黄。芒硝跟大黄是寒凉的药，你再用寒凉药去攻他，就害死人。

阳不足的人，动作就看出来，他喜欢躲在黑黑的地方。

第一百四十四条。

原文：病发于阳，而反下之，热入。因作「结胸」。病发于阴，而反下之，因作「痞」。

结胸，我们有大陷胸汤，小陷胸汤。「痞」，心下痞，我们有五种泻心汤。这两个都是应该解表你反攻下。病发于阳，在皮肤表面上。病发于阴，指肠胃。“病发于阴，而反下之，”这个人有表证，再加上肠胃有问题。这个时候你攻下的时候，因为你肠胃比较虚弱，表邪跑到肠胃里面去，就会造成心下痞。

第一百四十五条。

原文：「结胸」者，项亦强，如「柔痉」状，下之则和，宜「大陷胸丸」。

大陷胸丸方

大黄半斤，葶历半升炒，芒硝半升，杏仁半升去皮尖熬黑。右四味，捣筛二味，纳杏仁、芒硝，合研如脂，和散。取如弹丸一枚，别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升，温顿服之，一宿乃下；如不下，更服；取下为效；禁如药法。

大黄、葶历、芒硝、杏仁这四味药是等量。把杏仁熬黑，再放下去。把大黄、葶历捣碎，纳杏仁、芒硝。杏仁里面有油脂，熬黑以后油会出来，跟其他的药活在一起就像脂一样，黏黏一块。取如弹丸一枚，差不多一钱的量。

别捣甘遂末，甘遂末是生用，这里一钱你就是一钱。平常甘遂都是生用，甘遂去水力量非常强，几乎无水不去。“别捣甘遂末一钱匕，白蜜二合，水二升，煮取一升。”把甘遂跟白蜜煮在一起，温顿服之，一宿乃下；如不下，更服；取下为效。

大黄攻实。葶历祛痰。芒硝攻坚。杏仁温补肺，同时也能涤痰。葶历去水，其实痰水都可以去。杏仁比较趋向于涤痰。甘遂末排水力量很强。

大陷胸丸，大陷胸汤最主要症状结胸。有小孩，胸前凸出一块出来，里面可能被西医判定肺炎、肺积水、肺脓样，有时候挺在胸口，有时候在中间。还有龟背，里面都是痰，这都是陷胸汤症，所以大陷胸汤症，我们会用到甘遂、大黄、葶历、芒硝、杏仁，这种剂量下去的时候，都是能够把胸腔里面的痰水去掉。这个看起来是累积肺里面，不是在肺的下方，完全是痰水。

大黄去热，葶历去水，芒硝攻坚，芒硝不单单可以把硬便打散以外，老痰，结痰，非常硬的痰打散掉。芒硝攻坚，坚包含肿块，硬块在内。肺脓疡的时候会用，病人吃下去会大吐大下，隔夜吃完，一宿乃下。下完整个胸部凹下去了。就是胸部凸出去，吃过陷胸汤会凹下去。如果没有下，再吃第二剂。甘遂药非常峻。如果体格比较小，剂量可以减一半。体格比较强壮的，用一钱都可以。

跟白蜜煮过以后，甘遂的力量就比较缓，没有那么强。

结胸的原因，伤寒误下。实际上原因很多。可能他的感冒一直没有好，肺咳嗽痰累积起来，以后突然整个肺化脓样。

平常这些药不要做成丸剂，用的时候再去熬。杏仁火一烧就是黑的，一磨就变成杏仁霜。杏仁霜很粘，跟其他药混在一起，做成弹珠那么大一个。

第一百四十六条。

原文：「结胸证」，其脉浮大者，不可下，下之则死。

临床看病，最怕阴阳分隔。阳不在乎多，要密，要潜。这里脉浮大，代表阳药绝了，结胸证，阳药绝了，你一攻下，他里阳就没有了，攻下需要体力，一攻下他阴阳的更快，下之则死。

第一百四十七条。

原文：「结胸证」悉具，烦躁者，亦死。

人一烦躁代表阳要绝了，阳要离开身体了。

第一百四十八条。

原文：「太阳病」，脉浮而动数，浮则为风，数则为热，动则为痛，头痛发热，而微汗出，及恶寒者，表未解也，医反下之，动数变迟，客气动膈，膈内拒痛，短气躁烦，心中懊恼，胃中空虚，阳气内陷，心下因鞅，则为「结胸」，「大陷胸汤」主之。若不「结胸」，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄也。

浮，代表病在表。数，脉动很快。“头痛发热，而微汗出，”桂枝汤症。如果恶寒项强，葛根汤症。有汗就不是麻黄汤症。这个应该是解表，结果“医反下之，动数变迟。”

心下就是胃的这一带，中脘穴与心蔽骨中间，这个地方是胸阳，阳气下降的地方，如果「结胸」，代表被痰、水，还有热，梗到这个地方，才造成结胸，所以我们开处方的时候，祛痰、去热、去水三种药合在一起，才能把这个结胸去掉。为什么用白蜜，就是能够解毒，滋润津液。

寒在表，里面大便便秘，攻下，阳气往下走，阳气就下陷，下到胸膈这个地方，堵在这个地方。有的时候不会，如果你误下，病人变成口渴，慢慢胃气恢复了，喝些水慢慢就恢复了。有的回不来就变成结胸。

“若不「结胸」，但头汗出，余处无汗，剂颈而还，小便不利，身必发黄。”因为你误下，把肠胃的营养攻掉了，血的源头没了，这个时候看到身体发黄的现象，比如黄疸。流的汗就是靠肠胃里面津液，源头还是来自食物。

针灸讲过，水和食物残渣在大肠走，小肠火一烧，大肠水就往上走。膀胱贴到小肠，小肠是火，在后面烧，膀胱里面水气化入肝。肝排出胆汁有水。这些水的源头都来自大肠。应该发表，结果你攻下，肠子里面好的坏的食物水统统被你攻掉了，水一没有，马上看到血的颜色。

肝有问题，不单单是看到身黄。鲜黄是胆，暗黄是肝脏受伤了。如何知道肝脏有问题，常常晚上一点到三点醒过来，肝有问题。肺是白色，心是赤色，肺比较多，心脏比较少，配在一起是粉红色。手掌是上焦的地方，所以常人手掌掌面



是粉红色。如果肝有问题，长东西，肝有实症，硬化或长肿瘤。身上血回到心脏，肝脏里面已经有东西在里面了，容积变小了，这时很多的血回肝脏，一看已经有东西了，大量血进入心脏，红色加多，白色就变少了，手掌就开始红，肝病越来越严重，手掌慢慢变成暗红。

### 大陷胸汤方

大黄六两去皮，芒硝一升，甘遂一钱

右三味，以水六升，先煮大黄，取二升，去滓，纳芒硝，煮一二沸，纳甘遂末，温服一升，得快利，止后服。

大陷胸汤比丸要强。这里甘遂等于是生用。甘遂下去一定会上吐下泻。临床看泻的比较多，而且是泻水是从大便出来。

剂量大黄四钱，芒硝两钱，分两包，每包一钱。甘遂生用。

### 4——3

大陷胸汤比丸剂量少，当处方越少，越峻的时候，力量越强。

大陷胸汤使用时机，结胸证有二，第一个，是热实结胸，第二个是寒实结胸。大陷胸汤症是用在热时结胸，病人是热，舌苔是黄的，很厚，人都是气色很旺很亮，光鲜亮丽声音很大，焦躁，都是热症。脉是浮数也是热。张仲景一直强调寸和关，因为关是指肚子中间，寸在关之上，结胸结在这个地方，你只要确定他是热实结胸，这个实里面可能是肿瘤，积痰生瘤或者淤血生瘤，都有可能。十枣汤也是一种结胸的症状，但是十枣汤完全是水积在里面，病人咳嗽很厉害，但坐不得卧，肺底下积水，是十枣汤症。

肺里面化脓样的时候，你如果遇到病人西医诊断是肺癌，但是你看他是热实结胸，照样用大陷胸汤。

如果结到肠中，大承气汤，后面阳明篇会介绍。

过去经方家，除了小儿胸满心下石鞭，肺脓疡，脑模样重症的时候都可以使用。只要小孩子痰一直在哪呼噜呼噜，呼吸很短，一直发热，痰潮壅塞，眼睛呆滞，都瞪直了，摸到脉都很数，身上很烫，只要是热实结胸，只要有需要，统统可以使用大陷胸汤，只是剂量多寡而已。

【勿误药室方函口诀】是日本经方家在用。

第一百四十九。

原文：「伤寒」六七日，「结胸」热实，脉沉而紧，心下痛，按之石鞭者，「大陷胸汤」主之。

心下痛，按之石鞭者。心下就是胃的地方，非常硬，硬邦邦的一个。

伤寒误下结胸。我们有伤寒中风温病，这里指的是伤寒，应该是麻黄汤症，结果被误下产生的结胸。这是热实来源。大陷胸汤一般来自该用麻黄汤的时候不用，把他用成承气汤，或者怎么样攻下了，产生热实。

第一百五十。

原文：「伤寒」十余日，热结在里，复往来寒热者，与「大柴胡汤」。但「结胸」无太热者，此与水结在胸胁也，但头微汗出者，「大陷胸汤」主之。

也是伤寒，十几天了，应该是传经了。热结在里，复往来寒热者，我们给他大柴胡汤。如果是往来寒热、胸胁苦满。胸胁苦满包含什么？胸胁讲的两个肋的下方，胀满。如果病人没有胀满，只是右上腹这里一点痛，或者是右变肝区痛，就一点痛，还是属于胸胁苦满，所以我们治疗胆结石或者肝有问题，都是以柴胡为主，至于柴胡里面加什么药，看他什么位置如何加减。

这个我们给他大柴胡汤，如果是结胸，没有大热者，此与水结在胸胁也，但头微汗出者，「大陷胸汤」主之。也就是说如果是你水停在胸膈这边的时候，大柴胡汤一定会有便秘的现象，胸胁苦满会有便秘、而且比较燥热，因为大柴胡汤症比较介于少阳跟阳明中间。所以才会兼有渴和便秘的现象。

如果说这个人没有大热了，代表表邪完全下陷，水结在胸膈。一般水结在胸腔的时候，心下都会胀满痛，有时候不按都会痛，拒按。喜按的时候小陷胸汤，比较轻微，按下去比较舒服。像这里水结在这边，会用到大陷胸汤的时候都是拒按，拒按为实。虚症，里面没有东西，喜按。就好像肚子腹满，你压他感觉很舒服，喜按。腹胀喜按，厚朴、生姜、半夏、人参、甘草汤症。如果按下去很痛，拒按，是大便堵到。腹诊拒按跟喜按很明显。

第一百五十一。

原文：「太阳病」，重发汗，而复下之，不大便五六日，舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹鞭满而痛不可近者，「大陷胸汤」主之。

「太阳病」，发汗太多，又攻下，造成病人五六天不大便，被你清干了。发汗汗已经虚掉了，干掉了还把他攻下了，整个没有了，被你攻下了。病人只要燥渴出现，黄昏的时候，三点到五点有潮热的现象，从心下至少腹鞭满而痛不可近者，也是「大陷胸汤」。

所以大陷胸汤不单单是横跨胸下，直的从心一直到腹部来，

腹诊可以知道，你摸到的非常紧。从心下胃的地方到少腹，鞭满，整个硬邦邦的，你一压就知道，大陷胸汤症。

这种情形会出现的原因就是因为本来是太阳证，医生给他发汗，发完汗又给他清大便，吃完后变成这样子。

所以大陷胸汤症我们可以制造出来。麻黄本来开三钱就够了，一两下去，开麻黄一两不会有事，当你要发汗，麻黄开一两的时候，杏仁也开一两，你只要麻黄跟杏仁是等量，麻黄永远不会出事。

心下痞硬直的一直到少腹，都是大陷胸汤症。

第一百五十二。

原文：「小结胸病」，正在心下，按之则痛，脉浮滑者，「小陷胸汤」主之。

按之则痛，意思就是不按不痛，大陷胸汤症不按就痛，因为你结石在里面很深，痰水热结在里面，不按自痛。

脉浮滑者，「小陷胸汤」主之。脉浮滑者代表里面有热，滑代表里面有痰。结在心下就是结在胃的地方。

### 小陷胸汤方

黄连一两，半夏半升洗，栝蒌实大者一个。

右三味，以水六升，去滓，纳诸药，煮取二升，去滓，分温三服。

黄连不要开一两，一两很苦。有时候我开两钱，九碗水煮成三碗。我常常开稍微重一点，为什么？黄帝内经说肾苦急的时候，急食苦药以坚之。这句话再加上本草里面说，黄连解毒，解什么毒？解尿毒。尿毒的病人肾苦急，病人头昏，尿里面的毒跑血里面去，跑回心脏里面，苦味入心，大家吃黄连以为是寒凉的，实际黄连是苦味，能够坚肾，所以我在治疗病人肾脏有问题的时候，心脏有问题，胃里面太热了一定会用到黄连，肾脏有问题我一定会用到黄连，预防他中毒，效果很好，病人本来要洗肾了，坚持不洗肾。

半夏生用，半夏吃了如果声音没了，吃点姜就解掉了。栝蒌实用来开结。什么结，一个是痰造成的结，一个是气造成的结。所以在治心脏病的时候也会用到栝蒌实，心脏痛，结在里面痛的时候，会用到栝蒌实。痰结的时候，也可以用，如果痰很多的时候，会用半夏去痰去水，栝蒌实开结，黄连苦味入心能够去热，合并在一起，也就是得到小陷胸汤的人一定中焦有热，同时有水，有痰，结在这个中间，胃很不舒服。

小陷胸汤症本来也是该发表，没有发表就攻里，造成结在这个地方。每个人体质不一样，你误攻下以后，产生的后遗症不一样，有的人需要大陷胸汤，有的人需要小陷胸汤。临床上，小陷胸汤即使没有被误下，肠胃里有问题的时候，看病人舌苔，看舌苔是看胃气，舌苔是黄的，里面有热，喉咙有痰音，痰水，已经可以开小陷胸汤了。不一定非是有结胸才可以开，结胸是胸下，所以小陷胸汤常常用在肠胃方面，效果也很好，但是你一定要确定他胃是热的。如果是寒的，开个黄连下去太冷了。

临床上，黄连开一钱，半夏开五钱，栝蒌实开五钱。我常常黄连用两钱，其他用五钱。比例是这样。

### 第一百五十三。

原文：「太阳病」，二三曰，不能卧，但欲起，心下必结，脉微弱者，本有久寒也，反下之，若利之，必作「结胸」；未止者，四日复下之，此作「协热利」也。

身体里面就有寒的人，得到太阳病。这种人也会产生结胸。结胸的原因因为病人本来就有寒。应该发表没有发表，反下之，若利之，必作「结胸」。如果下痢的时候，没有止他，会产生协热利。

为什么会有协热利，本身表有病，这个人肠胃不好，你一攻下以后，他病毒跑到肠子里面去了，肠胃很好的人，病毒进到肠子里面没有影响，你再攻下，病人利不止的时候，表邪一直下陷的时候，本身里面肠胃不好的人，就会变成肠病毒。小孩子感冒，吃坏肚子，表邪下陷，造成肠病毒应该葛芩连汤。

### 第一百五十四。

原文：太阳病，下之，其脉浮，不结胸者，此为欲解也；脉促者，必结胸也；脉细数者，必咽痛；脉弦者，必两胁拘急；脉紧者，头痛未止，脉沉紧者，必心下痛；脉沉滑者，「协热利」；脉数滑者，必下血。

太阳病，应该发表，结果你攻下。

促脉就好像皮球，你往下打，它往上跳，慢慢越跳越小，你攻下，阳气往下陷，又会弹回来，弹上弹下，越弹力度越弱。你摸到脉的时候，跳跳跳停下，过一下又跳跳跳，停下来。这是促脉，这个时候，我们知道这个人会结胸了。

脉细数者，必咽痛。喉咙三阴之汇，本来表寒在外面，攻下后，阳气往下走，这个寒束的更紧，阳气被你往下导，往下导又弹回来，弹回来皮肤外面挡到又出不去，阳气会集中起来往喉咙跑，脉是细，细代表还有寒，数代笔还有热，寒热并结。脉会数就是阳没有办法从毛孔发散，所以阳会集中到喉部，会造成喉咙痛，并不是真正的喉咙发炎，而是误下造成这样。

脉弦是指你攻下，病毒跑到胸胁的地方，少阳三焦的地方，造成两胁拘急。

脉紧者，头痛未止，这个是寒还有，再开发表药就可以。

脉沉紧者，必心下痛；沉代表病在里，紧代表里面有寒。

下血，大便小便带血，脉都会数滑。中医治疗下血，也是一剂知，二剂已。

第一百五十五。

原文：病在阳，应以汗解之，反以冷水<sup>xùn</sup>澀之，若灌之，其热被却不得去，弥更益烦，肉上粟起，意欲饮水，反不渴者，服「文蛤散」；若不差者，与「五苓散」。

病在阳，病在表。应该用汗解，被冷水浇，还没发表，你没有用冷水刺激他的时候，热还在表面上，你用冷水刺激他，发的更厉害，肉上粟起，皮肤上起鸡皮疙瘩起来。想要饮水，反不渴者。这种情形，服「文蛤散」；文蛤散方是很轻的一个剂。

这里是说当你用汗剂发表，发不出来。有的人皮肤很紧，毛孔天生很紧。前面讲过，用麻黄汤三钱下去一滴汗都不流，五钱还是不流，你问他小便有没有，小便比以前多很多，他已经好了。因为他表太实了，毛孔太小。如果你开下去没流汗也没有小便，张仲景意思是皮肤紧，恶寒、起鸡皮疙瘩，这种人表很实，不要用麻黄汤了，用利尿剂利出来，五苓散就是可以把表水，皮肤表面的，皮肤和肌肉中间的水统统导出来。如何喝了文蛤散没用可以用五苓散。

文蛤散方

文蛤五两

右一味，为散，以沸汤和一钱匕服，汤用五合。

文蛤散是很轻的剂，经法在使用蛤蜊壳的时候，有一个是牡蛎。牡蛎咸，能软坚。所以甲状腺肿瘤，我们用牡蛎去攻它，腋下淋巴也在用牡蛎。菜市场有血蛤，壳面像屋瓦，翻开里面都是血红红的，那个壳就是瓦楞子。瓦楞子也是攻坚用的，因为长得很像乳房，取它的象。

第一百五十六。

原文：「寒实结胸」，无热证者，与「三物小白散」，「陷胸汤」不可服。

4——4

如果遇到寒实。寒会用到热的药，实用到攻坚的药。为什叫「三物小白散」，这三个东西看起来是白色的，因为剂量用的不多，叫小白。这个剂量太强了，所以用一点点就可以了。

白散方

桔梗三分。巴豆一分，去皮心熬黑，研如脂。贝母三分。

右三味，为散，纳巴豆，更于臼中杵之，以白饮和服，强人半钱匕，羸者减之。病在膈上必吐，病在膈下必利。不利，进热粥一杯，利过不止，进冷粥一杯。身冷皮栗不解，欲引衣自覆者，若以水噀之洗之，益冷，热却不得出，当汗而不汗，则烦。假令汗出已，腹中痛，与芍药三两，如上法。

桔梗三，巴豆一，贝母三。三一三的比例。巴豆两粒为一分。巴豆是最热的药，热起来比硫磺还热，也是在攻坚的时候用。但是这个药，千万要记得，是一剂就知道，只要被西医处理过的，我不用它，因为会产生盲点，不能确定，如果没有碰过，我敢下巴豆，如果体格比较大，三颗四颗加上去。一般的剂量两颗就够了，贝母跟桔梗剂量是等量。巴豆把皮心去掉，在锅里一过热就变成黑色，油脂很多。

桔梗是非常有名的去痰的配方，而且去的是寒痰，白痰。贝母也是祛痰。

巴豆是很凶的药。当寒实结胸的时候，就可以使用三物小白散，临症上看，遇到肺癌的病人，只要有结胸，他非常痛，或者是没有办法躺平，没有热症在外面，用三物小白散。所谓没有热症就是病人没有发烧。往往癌症的病人会有低烧，比如一百度是高烧，他就是九十八，九十九低温，这个不算烧。我们所谓无热症，病人你问他渴不渴，不渴。那晚上睡觉冷不冷，冷，喜欢喝热水。我们知道他没有热症在里面，里面是寒实。

吃巴豆唯一的后遗症是下痢不止，就是吃什么拉什么。怎么处理？有三个方法，第一个喝杯冷开水就好了。如果喝热开水越喝他越燥利。冷开水一下去下痢就止掉了。吃黄连，黄连下去也可以止掉他，黄连是冷的，巴豆是很热的。豆浆也可以。

经方里最凶的药就是巴豆。

三物小白散一定是肺里面寒实，堵到了，临床上肺癌都在用。

巴豆除了三物小白散，六种的使用。

（一）巴豆、桔梗等量同用，巴豆一颗或两颗，专门使毒化成脓，有的时候身体里面的结毒、硬块、痞块在身体里面很深的地方，发不出来，要让它化成脓排出来：例如肺中的脓疡属寒实者。

巴豆跟桔梗等量在用的时候，巴豆跟桔梗在一起一定是用在肺上面的脓疡，很深排不出来，我们会使用它。巴豆用的地方一定是寒症，寒实结到了。热实不

可以用巴豆，因为巴豆是很热的药。如果你把巴豆里面的油提炼出来，变成一颗颗豆子，就是现在的咖啡豆，咖啡豆跟巴豆是一样。所以咖啡不要喝。他们知道咖啡里面的油是有毒的，他把油脂提炼掉变成干的，所以你拿到咖啡豆是巴豆碳。这种毒药的东西很香，味道很重。巴豆深部的脓、寒实在里面，都可以使用。

如果病人被西医判断肺癌。病人晚上三点到五点失眠，如果是寒实，你才可以用，去掉以后，这段时间还是不可以睡，代表没有效，如果吃了以后睡过去了，代表有效。

（二）巴豆和贝母同用，专门去喉咙、咽喉之堵塞，癌症到末期的时候，东西都没有办法吞下去，这通关利结的力量很强。

如果光巴豆跟贝母，贝母也去痰，但是贝母去的痰跟桔梗的不一样，桔梗是在肺里面，贝母去的痰是喉咙的部分。所以川贝枇杷膏专门去喉咙的痰。经方在使用的时候，开喉结的时候，一般来说只是痰或食物梗到，不是癌症人，半夏苦酒汤就可以治疗。再严重点可以用硝石，就是炸药，可以打开它。还有巴豆和贝母可以让喉咙打开，通关利结没有比它效果更强了。如果化疗开刀的，效果就没有了，如果没有化疗开刀，就是喉癌，整个梗到了，这个巴豆和贝母。你不敢用太凶了，那你要病人死还是用？当然用了，但是如果病人做过开刀化疗，再肿回来的，效果就不好了，下手都没有效了，所以我一直在呼吁大家不要做。

轻症用半夏苦酒汤、严重的用硝石，或用经方中的巴豆和贝母。但是如果是西医开刀或化疗过的病人，再肿起来的，用了就效果不好。

（三）巴豆、杏仁同用，叫「走马汤」，马一边走一边大便，意思就是说，这两个药吃下去就跟马一样，到处大便，忍都忍不住。巴豆、杏仁同用，是用在心胸的结毒，肠胃里面如果说有食物坏死在里面，病人或者有胶痰，梗在胸腔肺的地方，再加上坏死的食物，食物在大肠胃小肠里面，肠胃整个堵到，再加上胸腔里面有痰的时候，这个走马汤很厉害。心胸结毒的时候，非常的痛，拒按，病人会跟你说非常的痛，吃东西吃不下，吃了又吐出来，里面就是梗到了。大便又排不出来。这个时候用走马汤。走马汤使用的时候，比如说巴豆三颗，杏仁十颗、十二颗都没有关系。这个不煮的，生用的。你把巴豆的壳剥掉，里面的芯拿掉，光是巴豆的仁，仁是黄白色的。跟杏仁放在一起，挤一挤，压一压，两个都有油，生的，用棉布包起来，加热水下去，你如果冷水下去，巴豆药性就没了，巴豆最怕冷水，冷水就没有用了，热水下去沾湿了以后，一拧汁就出来了，再去泡一下，这样来回大概四次左右，剂量差不多是一汤匙的量。这个一剂下去，从食道到肛门，统统出去了，没有东西可以挡他。但是这个是用到寒结到的时候，我们才会使用它。

（四）巴豆和大黄、干姜并用，专门用在下腹结痛，肚子结痛的时候，可能是大肠癌，或者是肿瘤，大便排不出来了，这个时候用巴豆打出来它。目前用在大肠癌的就是这味方剂，大肠癌到后期都不大便，癌细胞长满了，西医可能做个人工肛门，巴豆下去可以打个洞，看它多凶悍，有点腐蚀性的，用这药要有「必死的决心」，这是很危险的时候用。

（五）巴豆和炮附子、吴茱萸同用，这个炮附子已经很凶了，再加上巴豆那么热的药，专门治心胸寒痛，胃里面冰凉的，病人的陈述说胃里面有冰块在里面，一般我们常常用的干姜，附子热药下去，半天冰块还在那里，寒到如此之寒，实在

没有办法了，可以用到巴豆，不用五颗十颗，两颗就够了，胃热起来了，非常的凶，加上炮附子能够去寒，吴茱萸能够止呕，恶心呕吐的时候常常会用到吴茱萸，但是是寒症的呕吐，再加上巴豆。

（六）巴豆与芫花同用，能去大腹积水与痞块积聚。如果说腹水，肝病的病人水肿，一定要确定里面是寒实，热实你不要啊，热实很简单，有时候一发表，越婢汤水就排掉了，五苓散水就排掉了。寒实结到会使用到巴豆和芫花，巴豆和芫花是等量，芫花非常轻，所以当你拿两颗巴豆去秤可能是三分之一钱，芫花的三分之一钱一坨，芫花非常轻，就这两味药做成药丸。巴豆打碎油脂很多，芫花打碎和到一起就变成药丸，吃下去开始排水，水排的很快，痞块、硬块寒实的积聚统统可以用。只要确定是寒实。实都是拒按，硬块，里面是寒症。寒症病人口不渴，你只要把不渴治成渴就好了，寒变热，寒实会死，热症不会死。

用到巴豆，必须病人没有被西医处理过。

处方到这个阶段是经方的极致。我们用生附子，硫磺还没有到极限，这才是极限。但是一再提醒诸位必须病人没有被西医碰过。如果开过刀，做过化疗，栓塞，肝栓塞，效果就不好，效果不好为什么我不敢用，因为你效果不好的话，你用巴豆，万一救不回来，病人不了解，病人说死在巴豆上面，实际上不是死在巴豆上，他忘记他得什么病了，很麻烦，所以下手的时候，我在处方下手的时候，最怕病人家属，有一个不相信我，我就不敢动手，就像越南那个胰脏癌的，我叫他不要喝，我开好处方了，第一次吃完的时候，第二次来的时候，他已经开始打嗝了，还有很好的药还没有用，他儿子在旁边问我要吃多久，中药要吃多久？你爸爸都快死了，还在问我中药吃多久，可能他只能活一个礼拜，两个礼拜，你还在问我中药要吃多久，代表你不相信中医，我手就不敢下，不敢下手他死掉了，一个礼拜就死掉了。可是另外一个美国人我救回来了，他一进来，说海夏，随便你怎么做，交给你，一家人统统赞成，硬把他救回来了，我已经救他两次了。

第一百五十七。

原文：「太阳」与「少阳」并病，头项强痛，或眩冒，时如「结胸」，心下痞鞭者，当刺「大椎」第一间、「肺俞」、「肝俞」，慎不可发汗。发汗则谵语，脉弦，五六日谵语不止，当刺「期门」。

慎不可发汗。因为他兼有里症。只有纯太阳症的时候会去发汗。先大椎放点血，热消导下，观察下看他需要什么。穴道很多可以用，像遇到谵语的话，里面可能是大便不通，或者是脑膜炎怎么样，支沟、照海、天枢都可以下针。这个条辨就是说确定有伤寒表症，太阳表症再用，如果有点少阳症出现的时候，不要用发表的药。所以一再强调发表的药，要发表的症状才用。

第一百五十八。

原文：妇人「中风」，发热恶寒，得之八九日，经水迟来，热除而脉迟身凉，胸胁下满。如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而泻之。

妇人「中风」，就是得到桂枝汤症，得到八九天，本来要传经了，正好月经来了。女人如果是伤寒，月经来的时候，不用吃药自己会好。只有中风的时候，就是桂枝汤症，才会需要。桂枝汤症病人发热流汗，有汗无汗可以分桂枝麻黄，桂枝汤症有点汗，麻黄汤症没有汗。热除脉迟代表病往里边走了。病是顺着三焦

淋巴系统走到子宫里面去了，到了胸胁的地方。造成胸胁下满，如结胸状，但是这个不是结胸。结胸一定是心下这个地方痞非常硬块。

第一百五十九。

原文：妇人「中风」，七八日，续得寒热，发作有时，经水适断者，此为「热入血室」，其血必结，故使如「疟」状，发作有时，「小柴胡汤」主之。

我常常跟太太小姐讲，只要有感冒，同时你有月经，不用去管它，之前之后，月经刚好来，一律给小柴胡汤。

女人只要有月经，因为阳气、经血往下行，从胸腔往下行，她的表寒跟着往下走，这个时候你一发汗的时候，经会逆着走。所以月经来的时候，你给他发表的药的时候，鼻子一定会流血，因为逆经，月经没了，可是鼻子出血。就是因为你开了发表的药在里面。

小柴胡是少阳证的第一方，这里先提到。因为是太阳证会移转，移转的很快。

这种情形就发生在妇女身上。那如果是中风，中风本来该发表，结果女人有月经，正值月经期间，，不要太过忌经水适断或刚开始，或者正值月经中间，处方都是一样。这里分了两个，一个中风，第一百六十条是伤寒。

第一百六十。

原文：妇人「伤寒」发热，经水适来，昼日明了，暮则谵语，如见鬼状者，此为「热入血室」，无犯胃气及上下焦，必自愈。

伤寒发了以后，经水适来，这个病自己会好，不用去治。如何知道她是伤寒，伤寒麻黄汤，表证，无汗、脉浮紧、身体痛，结果还没开麻黄汤，月经来了。怎么知道她月经来了，如见鬼。因为这个是逆行，本来人体的免疫系统，人体的抵抗力，阳气正在跟病邪相抗，因为伤寒的力量很强，正好月经来，身体没有办法应付两种问题，中风和伤寒，女人月经期间得到结果是不一样的。伤寒不治自己也会好，实际上一样用小柴胡汤。

第一百五十九。中风，发热有汗，要开桂枝汤，结果来不及了，正好月经来，「热入血室」，其血必结，会影响到女人排月经，血结到的话，当月的经血没有办法完全排出来，因为有淤血停在里面，才会发生入虐状，就是往来寒热的现象，这个时候就是小柴胡汤。

如果把它简化就好用了，女人只要一感冒，有没有月经，就已经结束了，不用再去想葛根麻黄桂枝了，有就可以开小柴胡汤，这个时候要和解。那如果开错了，开发表的时候，血会往上走，上走可能逆经，月经从鼻子出来。

4——5

第一百六十一。

原文：「伤寒」六七日，发热微恶寒，支节烦疼，微呕，心下支结，外证未去者，「柴胡桂枝汤」主之。

「伤寒」六七日，发热微恶寒，支节烦疼，这里看起来麻黄汤症没有问题。心下支结，代表心下有苦满的现象。外证未去者，这个时候要用柴胡桂枝汤，不要



用柴胡麻黄汤。

伤寒失治七天后，进入少阳，出现少阳症的时候，不要再用麻黄了。所以经方里面看不到柴胡麻黄汤，只看到柴胡桂枝汤。因为麻黄汤是在皮肤表面上，很外层的，表邪下陷以后，它就在肌肉里面，所以桂枝汤是对的。因为半表半里所以才用柴胡，柴胡麻黄各用一半的剂量。

### 柴胡桂枝汤方

柴胡一两半，桂枝一两半去皮，黄芩一两半，人参一两半，甘草一两炙，半夏二合半洗，芍药一两半，大枣六枚劈，生姜一两半切。

右九味，以水七升，煮取三升，去滓，温服。

小柴胡汤与桂枝汤是等量。等量的意思是说正好这个表邪下陷的时候它走在中间，一半在太阳，一半在少阳。

用麻黄汤一定是很确定病在表，完全是在皮肤上面。这里是只要表邪不在表面上面，一律不用麻黄。

临床上不能刚刚好一半在太阳一半在少阳，你问病人怕风比较多，恶心比较多，怕风比较多，你不能说让他回去等一半的时候再来，一般我们遇到这种处方的时候，不用考虑，小柴胡汤是和解的方剂，所以在遇到半表半里的时候，我一般重用柴胡，我不管他是到什么程度，原方会用等量，那我会用柴胡，重用柴胡有时到三钱四钱。因为柴胡也可以发汗，柴胡本来设计的就是在半表半里中间。你一加重柴胡的时候，会把桂枝推上去，比各半的时候发汗来的多。如果没有加柴胡，大部分是从小便利掉。临床上我是重用柴胡，它能通利三焦，是三阳主要的药物。

最好的柴胡是一半在土里面，一半长在外面，这一节最好。我们用这一节柴胡就半表半里。因为柴胡能通利三焦，而三焦在中医的定义当然是上焦、中焦、下焦。实际上这个三焦通到奇恒之腑，包括女人的女子胞，子宫卵巢，脑，骨髓，内脏之间，心包，胆，和脏腑之间的油网统统属于三焦。都是需要柴胡。

诸位不要看病名，我曾经用柴胡桂枝汤，就是加一味牡蛎，就把淋巴瘤去掉了。同样是柴胡桂枝汤，但是他是喉咙上面甲状腺，我还是加牡蛎。淋巴腺甲状腺我们同样用牡蛎攻坚，同样都好。

如果你不知道这个少阳跟太阳的处方可以并用，微呕，心下支结，你开小柴胡汤，吃完以后，病人恶心，心下支满没有，表症还有一点，桂枝汤症。你要分两次，先吃小柴胡再吃桂枝汤。

### 第一百六十二。

原文：伤寒五六日，已发汗而复下之。胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也，「柴胡桂枝干姜汤」主之。

这是经方里面有几个处方专门治疗癆。就是说怎么吃也吃不饱，看着像桂枝汤，处方下去，汗也不流一滴。开什么处方都没有用，癆症。癆症原因是什么？病有风湿，如果风湿在关节，就是风湿关节炎，如果是寒湿，如果在胃里面，胃家的寒湿，如果这个湿跑在肾里面，把肾脏包住了，肾脏功能就不好，现在这个

湿是在血脉里面，怎么知道是在血脉中。他比平常我们正常的血管粗，怎么吃都吃不胖，他的血管一半跟正常的血管容积是相等的，另一半是湿。所以这个风湿跑到血脉里面去了，称为痹。就是因为这个风湿在血脉里，你开去风湿的药去不掉，因为风湿的药去关机的。有的在脏结，吃不到，就是没有办法。这个人血管是正常人的两倍，血管系统很大，平常人就带一个血脉系统，他两个，等于他带了另外一个人在走，所以很容易疲劳、倦怠，没有办法持久的工作。

张仲景除痹的第一方就是柴胡桂枝干姜汤。

伤寒五六日，已发汗而复下之。胸胁满，微结，就是胃里面微微胀到。小便不利，因为发汗发掉了，又攻下了，病人津液没了。渴看起来像阳明症，而不呕，没有少阳症。但头汗出，往来寒热，心烦者，此为未解也。胃和肠，攻下的药，肠子的津液被攻掉，发表的药，胃的津液已经没有了。这个时候微结的时候，代表胃里面已经没有东西了，津液伤到了，小便没有了，渴而不呕，如果胃里面有宿食，你发汗，又攻下，宿食没有发掉，才会恶心。发汗攻下，宿食没有了所以不会有恶心的现象。但头汗出，我们阴阳要平衡，阴是津，胃火是阳，胃的蠕动是因为有津液把热存在里面，津液没有了，热就往上冲，因为热的性就是轻，所以他就往上冲，一冲就冲到头上，所以但头汗出。

有往来寒热，有心烦者，此为胃结，在一些少阳症里面，兼一些太阳症，可是胃的津液有没有了，这个时候开处方「柴胡桂枝干姜汤」。

临床上只要听到病人口渴，肌肉没有力量，小便不好，胃里不舒服，不恶心，没有胃口，这个已经是柴胡桂枝干姜汤。里面的病可能是肝癌，肝硬化，可能是胃癌、胰脏癌，不用管他，所以当病人给你陈述病的时候，你要中虚，病名拿掉。最简单的就是，只要有往来寒热，柴胡一定要用，只要病人肌肉酸软，已经有发汗，汗出的时候，桂枝就可以用了。无汗才会用到麻黄。干姜跟生姜不太一样，干姜最主要是温中，生姜是能够散水，胃里面有水的时候，生姜能把水散掉，所以生姜跟干姜都能够止呕，但干姜胃家有寒的时候，我们会用，胃里面太热或者有积水的时候用生姜去把水散掉。这里发汗又复下了，胃里面没有东西，这个时候用干姜温中。

柴胡桂枝干姜汤方

柴胡半斤，桂枝三两，干姜二两，黄芩三两，栝蒌根四两，牡蛎二两，甘草二两炙。

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎，温服一升，日三服：初服微烦，复服汗出，便愈。

柴胡到六钱。桂枝三钱。干姜二钱。黄芩三钱，黄芩是跟着柴胡来的，只有有热，这个热从胃上面发上来的，有两种黄芩黄连，石膏都是去热的，什么时候用石膏，什么时候用芩连，黄芩黄连味苦，石膏味辛甘发散，这两种都是去热。但是石膏与黄芩黄连去的热不太一样，黄芩黄连去的是胃家的虚热，石膏去的是胃家的实热，我讲胃家并没有讲肠家，比如说大渴，一直要喝东西，这就是石膏，因为是胃家的实热。病人有渴，但是没有大渴的现象，会选用黄芩。这里柴胡汤会用到黄芩。第二个，会用到石膏的时候，只看到病人是热症，看不到寒症，所以这里有往来寒热，有寒症出现的时候，石膏就不对，石膏一定用在纯热症。

这里用黄芩，因为胃家有虚热，因为胃里面津液没有了，热往上走。口渴的厉害，我们用栝蒌根。病人只要有渴，我们都是用栝蒌根。现在市面上你去买写栝蒌根或者天花粉，他拿给你的东西是一样的，如果我们真正去追究，实际上是有点差异，现在人不太讲究。栝蒌根我们用四两，如果口渴的严重，我们加重点。栝蒌根治疗的口渴，是治疗血管里的水不够了，所以说，血脉的水不足，我们就会用到栝蒌根。糖尿病的人就是血管的水不够了，所以你去验血，看他血糖很高，他是水不够，所以病人会自救，所以他会一直口渴，喝水小便就排掉了，我们平常喝的水没有办法进入血脉里面，一定要吃的食物才能进去。

如果很难判断血管里的水。这样讲，肺的津液伤到，心和肺都在上焦，胸是诸阳之汇，因为血在这里交换，肺里面是气，肺里面的气像天上的云雾一样，肺气的来源就是大肠气化以后上来，所以这个水是非常好的水，这个水是可以进入血脉里，栝蒌根就是补肺里面的水，栝蒌根拿出来也是白色的，天花粉也是白色入肺。石膏是胃热，栝蒌根是肺热。

胃热就是蠕动很快，开栝蒌根就不对了，应该开石膏。一寒胃就会缩起来。所以使用经方的时候，你要很明确经方的功能是什么。

后面讲刚劲、柔劲的时候，柔劲出现的时候，柔劲出现的时候张仲景会用栝蒌根，不会用石膏。

这个药为什么要用牡蛎，牡蛎降浮阳，你怎么知道他浮阳？但头汗出。胃的阳气往上升的时候，我们要把阳气降下来，干姜只是温中，同时要把浮阳降回来，阳要收。牡蛎就是收敛阳的一个动作。如果阳跑到四肢上，外证，大部分我们统统用到牡蛎。如果说阳在外，还有心阳也外走，肾阳也外走的时候，就要加龙骨下去了，所以柴胡龙骨牡蛎汤，或者桂枝汤去芍药加龙骨牡蛎，救逆汤。

#### 4——6

肾阳外出的时候，我们用龙骨把它收回来。龙骨牡蛎会合并在一起。有时候单用牡蛎，这里他只有但头汗出，只有胃热上去，你不需要用到，龙骨。

炙甘草，甘草炙过津液会更多，而且性会比较热一点，会用到干姜大部分会用到炙甘草。甘草蜂蜜炙过以后，除了对肠胃很好以外，他能够强心脏，重用的时候会强心脏，这里我们知道他胃里津液不够了，所以我们用到干姜，甘草汤，等于是温软胃的功能在里面。

这七味药十二碗水煮成六碗，把渣去掉再煮，煮成三碗，初服微汗，复服汗出，便愈。这个人已经津液不够了，为什么会有得汗出，就是本身的汗在血里面，湿在血里面，湿在血里面的时候，你用柴胡干姜汤，吃下去的时候病人会流汗，流汗才粘嗒嗒的，这个人如果已经发汗，已经复下了，是不是已经津液不够了，吃这个为什么还会有流汗，就是因为血脉里面的津液出来了。一般来说我们不会得到这种病的，只有痙症的人，素虚，平常很瘦弱，才会有胸胁满，微结，小便不利，渴而不呕，但头汗出，这种现象出现。像我没有痙症，你帮我发汗攻下，我也不会有这种小便不出，微结，但头汗出，我不会有，因为我没有得痙症。

临床上治疗的时候，我们才会发现到，柴胡桂枝干姜汤实际上是张仲景治痙症的第一方。我们有好几个方子，这是他第一个方子。平常没有痙症的人得不到这种病。

如果病人跟你说开桂枝汤也没有感觉，开葛根汤、麻黄汤还是没感觉，这就是告诉你我要柴胡桂枝干姜汤。因为他是癆症。

白朮去湿，白朮是关节、脏腑、之间，肠胃里面你可以用白朮。血脉里面白朮用不到。

### 第一百六十三。

原文：「伤寒」五六日，头汗出，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉沉细者，此为「阳微结」，必有表复有里也，脉沉细，病在里也；头汗出，病在表也，假令「纯阴结」，不得复有外证，悉入在里，此为半在里半在外也：脉虽沉细。不得为「少阴病」，所以然者，阴不得有汗，今头汗出，故知非「少阴」；可与「小柴胡汤」，设不了了者，得屎而解。

伤寒五六日就是要传经了，没有好。手足冷是手足指尖到手足掌，跟四逆不一样四逆是手足指间到手肘，膝盖关节。四逆就很危险了。

这个人传经的症状是头汗，坐到那不动也会流汗，微恶寒，手足冷，心下满，口不欲食，大便鞭，脉沉细者，此为「阳微结」，必有表复有里也。脉沉细，代表病在里。这个人表症里症统统有，这个人阳气没有办法发散，有一个名称叫「阳微结」，这是一个症状，并不是胃癌、肠癌。

微恶寒，手足冷，这些是表症，口不欲食，大便鞭，这是里。

阴结的时候完全看不到阳症，热症。

这个条辨的意思就是告诉大家，脉沉细不一定是阴症，有一种就是表里证都有的时候还是会摸到沉细的脉。千万不要摸到是沉细的脉判断是纯阴症，中医望闻问切，切脉是留在最后，最好是望闻问。我们看阴症望就看到了，你看那个人不太讲话静静的，就是阴。那个跑来跑去动来动去就是阳。阴阳并结的时候就是癌症很危险的症状。

### 第一百六十四。

原文：「伤寒」五六日，呕而发热者，「柴胡汤证」具，而以他药下之，「柴胡证」仍在者，复与「柴胡汤」，此虽已下之，不为逆，必蒸蒸而振，却发热汗出而解；若心下满而鞭痛者，此为「结胸」也，「大陷胸汤」主之：但满而不痛者，此为「痞」，「柴胡」不中与也，宜「半夏泻心汤」。

结胸，前面介绍的热实结胸，大陷胸汤与大陷胸丸有差异。大陷胸汤剂，结胸的症状在心下鞭硬有两种，一种是心蔽骨正中间下非常强硬痛，第二个是从心下一直痛到关元，这个痛是往下直着走的，大陷胸汤症。所以病人结胸的时候，你摸到有硬块，可能他被判定是肺脓样，可能是淋巴癌，乳癌，不管病名是什么，内症，结胸结在这边，有这个症状，大陷胸证。大陷胸汤里面的芒硝，不单单是去干燥的大便，芒硝是攻坚的。

大陷胸丸不是，大陷胸丸心下痞，但它是往上走的，痛一直往上升，大陷胸丸。因为往上升，所以我们用丸剂慢慢吞下去，用汤剂走太快了，还来不及走。结果病人是大陷胸汤症，你开成大陷胸丸，病人是大陷胸丸症你开成大陷胸汤。都有的不对症，你一点之差，就没有办法做到一剂知的效果。

但满而不痛者,此为「痞」,这是结胸和痞区分开了。结胸拒按,因为他非常硬,像鞭痛,摸上去硬邦邦一个。满而不痛,摸上去软软的,按他不痛,这是痞。「柴胡」不中与也,宜「半夏泻心汤」。

基本上心下痞和结胸,起因都是被伤寒误下,不应该下被下了,才会产生结胸,心下痞。痞症出现是平常肠胃就不好的人。表病,还没有治,被攻下了。表邪下陷造成心下痞。肠胃很好的人反而不会有心下痞。

结胸,痛往上走大陷胸丸,痛往下走,大陷胸汤。

半夏泻心汤方

半夏半斤洗,黄芩三两,干姜三两,甘草三两,人参三两,黄连一两,大枣十二枚擘。

右七味,以水一斗,煮取六升,去滓,再煮取三升,温服一升,日三服。

人参、甘草、大枣、干姜,这是张仲景滋阴的药。最轻的干姜甘草大枣,中级的白芍干姜甘草大枣,加重的人参甘草大枣干姜。张仲景不用其他的补药,经方是治病用的。张仲景用补药是因为病情的发展,造成病人津液不够了,才会使用。心下痞就是被误下了,本来该发表结果被误下,造成病人肠胃津液不够了。

这个时候甘草,在治疗肠胃的时候用生甘草,不用炙甘草。当发现病人有寒的时候,才会用到炙甘草,心脏不够力的时候。甘草生用有几个好处,第一个甘草能够蓄水。因为肠胃津液没有了,我们希望补进去津液蓄在里面,人参放进去的时候,我们就不用炙甘草,只用生甘草。甘草本身解毒,按照神农本草经解百毒,就是食物的毒。肠胃不好的用生甘草蓄水,津液就会补回去,干姜就是胃里面寒的,我们用干姜,干姜能够温中。黄芩三钱的话,黄连是一钱,半夏的目的,因为他认为胃周围有水。呕吐有恶心,胃的周围不在胃里面,周围有水结在这边,用半夏,所以小柴胡汤里面我们会用半夏。小柴胡汤是用在胃跟脾中间网膜,三焦油网,用柴胡加半夏。半夏的主要功能是把围绕在胃的周围的水排掉。如果这个水是在胃里面,干姜排掉了,如果是有寒还有水,我们把干姜跟生姜并用,就可以把胃里面的水排掉,你要是在胃里面排水,不能加生甘草下去,甘草有蓄水的功能,排水肿的时候都不用甘草,甘草会把水累积起来。

半夏泻心汤,就是表邪误下以后,跑到肠胃里面来。黄芩跟黄连,一般黄芩用三钱,黄连用一钱。半夏利水把胃周围的水排掉,用半夏的症状一定是病人不渴。同样是止呕,但半夏是不渴。黄芩黄连是去热的药,黄连解血里面的毒素,黄芩是解肝胆三焦淋巴系统里面的热毒,热中医定义为毒,就是说你东西累积在里面排不出去,要想办法疏通他,就会用到黄芩。

治疗肠胃方面的病大部分是空腹的时候吃。这个汤剂,用粉剂也可以。主要的症状,因为里面有热,看舌头最清楚,舌苔上面是黄湿的,舌苔代表胃,如果舌苔很黄很厚,就可以吃黄芩黄连了。人不可以积寒,也不可以积热。所以在寒热中间调整的时候,我们在一发觉到有点热就把它去掉,不要等到大热再去,小毛病就开始调整。如果是黄但是很干很燥,就不是黄芩黄连了,就是石膏,因为里面是燥热。所以从舌苔也可以分辨出来,什么时候用黄芩黄连,什么时候开石膏。这个是张仲景开出来专门治疗肠胃的处方,半夏泻心汤。

# 第一百六十五。

原文：「太阳」「少阳」并病，而反下之，成「结胸」，心下鞭，下利不止，水浆不下，其人心烦。

太阳少阳并病可以用柴胡桂枝汤，这两个病症都出现应该是和解跟发一点点汗。而反下之，成「结胸」。

这是比较危险。因为出现结胸的时候，应该是便秘的，表邪下陷，成结胸的时候是便秘的，根本没有大便的，所以大陷胸汤跟小陷胸汤会有大黄跟芒硝。这里病人是结胸，非常硬应该是便秘才对，结果病人还下痢，还吃不下去。上面没有办法补充，下面不断在流失，中间又卡到硬块，其人心烦，一开始烦躁就代表危险了。这里告诉你，如果说你没有处理的好，而反下之，会造成这个问题。

## 4——7

所以病人胃痛、下痢，喝水喝不下去。这个看起来是胰脏癌，处方：干姜黄芩黄连人参汤症，四味药。

# 第一百六十六。

原文：脉浮而紧，而复下之，病反入里，则作「痞」，按之则自濡，但「气痞」耳。

脉浮而紧，是伤寒，结果被攻下了。按之则自濡，就是按它软软的。结胸的话不能按，你不按他就在痛，你按他更痛。这个区分他是心下痞还是结胸。结胸跟痞都是表症，没有开发表的药，被误下造成。

# 第一百六十七。

原文：「太阳中风」，下利，呕逆，表解者，乃可攻之：其人<sup>zhí</sup>𦵿𦵿汗出，发作有时，头痛，心下痞鞭满，引胁下痛，呕即短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，「十枣汤」主之。

太阳中风本来是桂枝汤症，病人有下痢有呕逆，我们一定要先解表，再攻下。这个病人已经有下痢呕逆的时候，我们解表有下痢不会说再用承气汤攻他，也就是说下痢可能是邪热利，葛芩连汤什么样子。一定要先解表。要确定没有表症我们再治里。如果这个人汗，一直流出来，发作有的时候好，有时候不好，头痛，心下痞，鞭满，引胁下痛，呕即短气，汗出不恶寒者，此表解里未和也，「十枣汤」主之。

表症没有了，十枣汤你是被误下，该发表你没有发表，被误下。十枣汤的现象病人出现的是汗出不恶寒，完全没有寒症，一派热症。十枣汤又名朱雀汤，

## 十枣汤方

芫花熬。甘遂。大戟。大枣十枚劈。

右三味等分，分别捣为散，以水一升半，先煮大枣肥者十枚，取八合，去滓，纳药末，强人服一钱匕，羸人服半钱，温服之，平旦服；若下少，病不除者，明日更服，加半钱；得快下利后，糜粥自养。

剂量：甘遂三分之一钱，芫花三分之一钱，大戟三分之一钱，这三个加起来是一钱。重量来说的话，三个都是同样等量。但是芫花最轻，所以看着多。实际上比例是相等的。十枣汤的时候一剂，不要给他多。吃完以后看他好了没有，没好再给第二剂，一定要管制。太过了不得了了。

十枣汤使用时机，第一个肺里面积水。但坐不得卧，病人坐在那里不能躺下去，躺下去会咳嗽，水往上冲，坐到那至少不咳，但是心下非常痛，横着一圈沿着肋边痛。看起来像结胸，但不是结胸。也是鞭满，但是他会引胁下痛。结胸是在正中间，正心下，如果痛往下移就是大陷胸汤，痛往上走，大陷胸丸。这里痛是引两肋痛，因为它在肺下方。所以肺里面积水会用十枣汤。肋间积水就不一样了，金匱里甘遂半夏汤，会介绍。

这里介绍的是十枣汤。十枣汤是用粉剂，生用，统统打粉。比如有人是十枣汤。你让他早上六点钟吃。张仲景说旦服，空腹吃。因为十枣汤十分的峻，吃下去上吐下泻。你如果吃饱了，食物堵到胃里面，上吐下泻很危险，如果你胃里面有食物在里面的时候，肠里面它不会动，就是胃里面有食物，一吐，在喉咙里面梗到，呼吸呼不过来，会梗死的。你药对症，吃的时间不对，所以一定是平旦六点钟，不要吃东西。一剂下去大概维持三个小时。为什么叫十枣汤，药的粉剂抓在手上面十颗红枣，怕他胃伤到十五、二十颗没有关系。红枣汤把枣打碎去煮，才会煮的粘稠。你可以两碗煮一碗，三碗煮一碗都没有关系，你看病人，药粉不好吞下去，你就煮多一点，讲十并不真的是十。红枣煮起来非常的粘，所以可以取代胃的液，而且红枣能够和中，芫花，甘遂，大戟都是碱性的，胃里面是酸的，如果你只开芫花，甘遂，大戟，没有开枣下去，他吃下去不得了了，吃完肺积水去掉了，胃很痛，整个胃壁贴在一起，津液完全没有了。所以我们开下去用的时候，芫花，甘遂，大戟，红枣汤配合吃，红枣可以把碱和酸分开。病人上吐下泻的时候，六个小时大概跑六次到七次。十枣汤清肺里面的水，清干净以后不会再回头了。西医没有动过一剂就出来了。为什么去水要去那么快？这个水是冷水，肺法像天，天上有水，但是云气才是正常，现在水在天上是冷水，所以赶快要排掉，不然水生万物，不排掉，他一直感冒，肺炎，肺癌什么都来了。所以要很迅速的排掉，十枣汤是唯一处方。

里面内症，可能是肝硬化肝癌，但是只要他出现十枣汤症都可以用。如果不是十枣汤症不能用。但坐不得卧，一定要到这个阶段，心下痞鞭满，呕即短气，汗出不恶寒者，不断的流汗。如果他是流汗，就是一般的水汗，这个十枣汤下去就解决了，他如果流的是油汗，这是元阳，元气要没了，所以病人在死之前你摸他的脸油油的，油过了就走掉了，早上起来，鼻子脸上油油的，这是你的气，阳气。十枣汤症就是流汗，可以下。如果他是油出来，这个危在旦夕，不要下了，下去的话，一口痰梗到，他说你杀他的。

当我们严格区分甘遂，大戟，芫花的时候。甘遂这个药去水，力量非常的强，去肺，还有子宫，里面的水，肺周围。大戟，三焦系统里面有积水，用大戟。芫花也是去水，去腹部、胸部积水，芫花完全是去水。甘遂可以去水，但是甘遂，涤痰效果非常好，得到十枣汤症，或者甘遂半夏汤症，或者甘遂大黄汤症，大部分都是痰水聚结在里面。如果遇到痰水热聚结在里面，就是结胸，所以我们用到甘遂大黄芒硝。就不会用到芫花大戟。甘遂，大戟，芫花三个用的时候，一定是肺积水在底下，这个胸胁的地方痛。

当病在表的时候，刚开始在伤寒，伤寒的时候，我们用麻黄汤解表，结果医生不懂，五六天以后，病进变成小青龙汤。小青龙汤症的时候，病人出现心下有水气，小青龙汤是使用在表寒，里寒的时候用的，所谓表寒就是病人全身关节痛，恶寒，脉浮紧。里寒舌苔是白的，口不渴，咳嗽咳出来的痰是白痰，表寒里寒是小青龙汤。小青龙汤失治，没有治好，或误下，陷下去，变成结胸。

十枣汤跟桂枝汤一样，桂枝汤是你吃了桂枝汤以后，用稀饭，缀点稀饭，慢慢喝下去，发点微汗出来，十枣汤上吐下泻以后，不要马上吃，差不多要发三个小时上吐下泻。上吐下泻完以后，病人的胃缓，代表药力已经过去了，这个时候要喝稀饭或面煮的比较烂，不要放调味料，油的东西，可以放一点点海盐。一般发过汗或吐下了以后，尽量不要吃肉类的东西，因为这个时候胃消化不是很好，会有伏热现象，也就是病人已经好了，还会有点发烧的现象，实际上病已经去了，因为在发汗吐下的时候病人有吃到肉。

第一百六十八。

原文：「太阳病」，发热恶寒，医发汗，无阳而阴独，因复下之，遂心下「痞」，表里俱虚，阴阳气并竭，复加烧针，因胸烦，面色青黄，肤润者，难治，今色微黄，手足温者，易愈。

无阳而阴独，发汗以后阳气没有了，所谓阳气没了，一下热症没了。所谓阳，举例：比如你看到我的气色，光线，阳很足，讲话音量大，阳很足，口渴也是阳症，如果说发了汗无阳，再下之，则造成心下痞。这是表里俱虚，阴阳并竭，如果再加烧针，津液已经伤到了，阴阳两虚了，还攻他，造成胸烦，面色青黄，肤润者，难治，今色微黄，手足温者，易愈。这个肤润，油脂，阳往外走，阳要绝的时候，皮肤是润泽的，好像油粘哒哒的，跟流汗完全不一样，所以在救危症的时候，摸病人身上，发油出来心就凉掉了。

如果微黄，手足温者，易愈。如果微黄，代表虽然你攻下了，只伤到一点点，没有很严重。还是会痊愈的。

这个人是按照规矩做了还是会出现这种现象，这个病人身体比较虚。

第一百六十九。

原文：心下「痞」，按之濡，其脉关上浮者，「大黄黄连泻心汤」主之。

按之濡，按下去，胀胀不痛，软绵绵的。其脉关上浮者，「大黄黄连泻心汤」主之。这个是从脉诊上面判断。关上，寸脉是浮脉，是上焦比较热一点，只此而已。「大黄黄连泻心汤」，这个心就是胃。在读伤寒论的时候，你看到心就把它当做胃。心下就是胃下，看到胃就当成肠。

大黄黄连泻心汤方

大黄二两，黄连一两。

右二味，以麻沸汤二升渍之，须臾，绞去渣分温服。

剂量：大黄二钱，黄连一钱，你不要真正二两，不得了。不是煮的，要取它的药气，就好像泡茶，把大黄，黄连丢到杯子里面，热水冲下就可以了，当不去煮的时候，是取它的药的气。如果煮，取它的药味，大黄黄连味都很厚，所以当



我们要这个药进入血分的时候，比如说黄连是苦寒的药，同时黄连是解毒的药。那我们需要他跑到心脏、血脉去解毒的时候，是不是煮了以后它就会进去，这里的不是，这里泡茶一样泡下，取它的气。因为他的胃中有热，简单讲舌苔是黄的，脉浮上来就可以用。取它的气，他可以降热。

上焦热统统可以用。简单看就是流血，出血。这个药如果是煮就没有用了，煮过大黄跟黄连往下走，麻沸汤就是滚水。五官无缘无故出血就是上热，胃中太热，胃热上浮，冲上去。就用这个药大黄黄连。

这个药如果打成粉剂，收敛伤口用。这个如果制作粉，去热的，你在粉里面加白术，去湿的，如果加没药、乳香，收敛伤口、排脓的。三七化瘀，活血化瘀。这些药加在一起，伤科的皮肤，化瘀没办法收口，外敷就可以收口。处方中药的好处就是既可以内服，又可以外敷。

经方皂荚，过去没有肥皂，有皂树，把皂荚拿下来洗。皂荚洗污浊，黏浊的油渍。皂荚是碱性，一定要跟红枣。

4——8

红枣跟十枣汤意思是一样的。能够把胃液阻绝开，否则皂荚下去，碱和酸一中和胃就很难过，红枣跟皂荚就好像，秤不离砣，砣不离秤，用皂荚就要用红枣，用甘遂芫花大戟就要用红枣。

痰很多，有天南星。口不渴用半夏，口渴的话不用半夏。戒烟体胖，用石膏，看他体格，三四百磅的八两，个子小的用一两。石膏能够去胃热，石膏是寒凉的药一下去，胃蠕动就减缓，胃热就下降，胃口就下来了。知母能够去湿，把肺里面的湿收敛起来，再配合一些祛痰的药就能够把烟戒掉。老烟枪，不抽晚上睡不着，加些柴胡下去，里面有黄芩了，加些疏肝的药，比如说玉金。柴胡三钱，黄芩三钱，皂荚也是三钱，南星也是三钱，知母五钱，玉金可以用五钱疏肝气，这样肝脏功能起来的时候能够帮助解毒，他欲望就没有了。如果不开柴胡黄芩，玉金，你没有开清肝的药，光是开上面的药，会把肺里面的烟痰清干净，可是他还是像抽烟。你加这些下去就不想抽烟了。按照这个方法不但可以戒掉烟，还可以瘦掉。

大黄如果是泡制的，泡过水吃的不会清肠，不会清大便的。是去胃家的热往上冲的。

第一百七十。

原文：心下「痞」，而复恶寒，汗出者，「附子泻心汤」主之。

心下「痞」，心下就是胃，胃里面很难过，又怕冷，胃寒掉了，又有寒出者。只要病人恶寒怕冷，又流汗，就是代表病人表虚了，表虚的时候才会有汗出。一种流汗是身体很好的流汗，这种不会恶寒，有的人身体很虚弱的，他本身怕冷的，流汗，这种是表虚的。张仲景在有表虚出现的时候，一律使用炮附子，炮附子可以固表。表阳虚的时候，专门固表阳用的。汗血是同源，有的人失血过多，跟汗出恶寒是同样的处方，还是可以用炮附子，所以炮附子用救逆上也是用炮附子，失血的时候也会用炮附子。阳不足的时候用生附子。炮附子是固阳用的，固守的用的。病人遗精很严重，龙骨牡蛎下去还是不能收，炮附子下去。南派就会用锁

阳，不是说不能用锁阳，而是在经方的基础上面增减。

会用附子泻心汤，一定是病人除了胃有问题以外，兼有表虚，所以我们附子常常会用。

举例，有病人，你给他发汗，发太过了，汗流不止了，再给他吃桂枝汤，但是这次加炮附子下去，为什么？收表。会灵活运用。

精子出来带血，也可以用炮附子。小便失禁，年龄大的人，晚上不停上厕所，这个时候炮附子就可以用，可以收表。汗血同源，尿跟汗也是同源。

#### 附子泻心汤方

大黄二两，黄连一两，黄芩一两，附子一枚，炮，去皮破，别煮取汁。

右四味，切三味，以麻沸汤二升渍之，须臾，纳附子汁，分温再服。

既胃有问题，又有表寒，炮附子一枚差不多三钱的量。大黄黄连黄芩加上附子，热药跟寒凉的药用在一起，张仲景常常在用。里面胃热归胃热，炮附子是表虚。胃热还是要降，表虚还是要取固。大黄黄连黄芩是去胃热，这里只有炮附子用煮的，其他三个还是泡的，热水泡一泡当茶喝，炮附子煮过倒进去。或者先煮炮附子，煮过之后，炮附子丢掉，用炮附子水泡大黄黄芩黄连。这是附子泻心汤标准的使用方式。

会用到大黄黄芩黄连的人，舌苔一定是黄的，同时大便会有一点便秘，不是很秘，因为它用泡制的，不是用煮过的，然后胃热一定很盛的人才会使用。这里我讲的胃热很盛就是胃有点不舒服，有点发炎。用现在的话来说，大黄黄芩黄连这些是寒凉的药是消炎用的。黄连是解血中的毒。如果是另外一个胃热，胃口大开，他胃里面没有发炎，吃饭吃很多还是很饿，西医看到糖尿病，喝水不能止渴，这个时候你拿这里麻沸汤泡了一点用没有，要开大剂的石膏白虎下去才有用，那也是胃热。

这里是胃热兼有表虚，只要表虚想到附子就好了。有的时候你看不到汗，又很怕冷，恶寒，这个人就要吃炮附子了。不一定要恶寒盗汗出来再说。

#### 第一百七十一。

原文：表以下之，故心下「痞」，与「泻心汤」。「痞」不解，其人口中渴，而烦躁，小便不利者，「五苓散」主之。

该用解表的药，结果你去攻下了，所以产生心下痞，给泻心汤，这是正确的手法了，结果给了以后，痞还是不解，胃里还是不舒服，其人口中渴，渴，烦躁，小便不利，就是「五苓散」。所以五苓散对心下痞，对胃非常好。

五苓散：桂枝、猪苓、白术、茯苓、泽泻。五苓散一定用在渴、小便不利。当你发表又攻下了，病人津液不够了，你这个时候还不舒服的话，病人口渴了，津液已经伤到了，不要再去发表。五苓散，去水而生水。会造成渴小便不利，除了表以外，主要是你发表的时候，一发表，你发表剂量开的不够，病人很多汗水从肠胃里面跑到皮肤表面上去了，有些透发出去，有些没有透发出去，停在肌肉皮肤表面上，所以我们开发表的药，让他透发，所以说才会怕不能透发，吃了桂枝汤以后让病人喝点稀饭，让他汗出来。这个表水停在表面上下不来，五苓散。

只要看到病人渴、小便不利就可以开五苓散，小便就会利出来。这个五苓散在使用的时候，并不代表病人膀胱有结石，肾有结石，跟猪苓汤不一样。五苓散是表水没有透发用的。

第一百七十二。

原文：「伤寒」，汗出，解之后，胃中不和，心下痞鞭，干噫食臭，胁下有水气，腹中雷鸣，下利者，「生姜泻心汤」主之。

当病人告诉你胃里面不舒服的时候，同时兼有下痢，就已经是生姜泻心汤了。

胃中不和，胃里面有停水。病人拉肚子，肚子里面咕噜咕噜，你问他胃里难不难过，胃里面不舒服，干噫食臭，就是恶心呕酸，舌苔都是黄的。生姜泻心汤，这里强调重用生姜。生姜就是把胃里面的水排掉。胃外面的水产生的恶心，那是半夏，这里并没有恶心，只是干噫，这个时候用生姜。所以胃里面的水要靠生姜。胃外面的水要靠半夏。

生姜泻心汤方

生姜四两切，甘草三两炙，人参三两，干姜一两，黄芩三两，半夏半斤洗，黄连一两，大枣十二枚擘。

右八味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。

生姜四片就可以了，治肠胃病的时候大部分用生甘草，这里炙甘草的原因，因为不是要食物里面的水，而是要把水排掉，水排掉的时候不能用生甘草，生甘草是蓄水的，所以要用炙甘草，因为胃里面有水。记得要利水不要用生甘草，必须要用甘草的时候用炙甘草。

这里生姜干姜一起用。干姜是温中，胃里面有寒的时候用干姜。可是寒里面有水的时候，水干姜去不掉，一定要用生姜来排水。如果是胃外面的水，病人会往来寒热，有恶心的现象，会用半夏，胃外面的水，水把胃包到了，影响到胃的蠕动，产生呕逆。

泻心汤胃有问题的话都是有胃热，胃热用黄芩，黄芩黄连都是热症，胃发炎的时候最好用。葛根黄芩黄连也是邪热利，也是肠胃的热，只是他是下痢，我们用葛根来提水。这里黄芩黄连在胃里面是消炎的，用半夏一定会有恶心现象。

这个是煮汤剂生姜泻心汤，只要病人胃里面不舒服，伴随下痢，呕酸出来就可以使用生姜泻心汤。

邪热利用葛芩连汤。肠胃不舒服，肠鸣肚子里咕噜咕噜叫，排利水出来，用生姜泻心汤。这些都是属于热利。

中医观念，空灵为常态。宁可你稍微饿一点，也不要过饱。尤其治病的时候，我治一个胰脏癌，这个人在大陆，他从早眼睛张开就要喝咖啡，喝到一直睡觉。人整个是黑黄的，东西也吃不下去，瘦干干的。开给他处方的时候告诉他什么不能吃，甜的，加了人工的都不能吃。他很遵从我的意见，不喝咖啡，晚上肚子饿，在北京找一圈没有一个他能吃的，就买了一个卤蛋，吃完还是很饿，他的饿把他救回来了，脾胃功能恢复的很快，吃了药两个礼拜，气色已经变回来了，饿是一个治疗的方式，病人看病的时候，要告诉他怎么吃，不要吃太多，清淡一点点的。

宁可少，不要多。吃太多把病都养起来了。经方很少用补药，都是用攻坚、疏导、和解、去热的药在治疗。

## 5——1

### 第一百七十三。

原文：「伤寒」、「中风」，医反下之，其人下利，日数十行，谷不化，腹中雷鸣，心下痞鞭而满，干呕，心烦不得安，医见心下「痞」，谓病不尽，复下之，其痞益甚，此非「热结」，但以胃中虚，客气上结，故使鞭也，「甘草泻心汤」主之。

确定是实症的时候才会攻，你攻下的时候胃更难过，代表处方错了，不要再攻了。这里讲的是本来病人是虚症，结果你看到痞鞭以为是实症，虚实的辩证很重要。你看到病人脸上很光鲜，亮丽讲话声音很大是实症，实症拒按，虚症你按他会比较舒服，实症舌苔比较黄，苔比较厚。虚症看不到舌苔不厚，但是黄。如果你以为他是实症误下了，结果他不是热结，其实他胃中是虚，客气上结，下焦的气往上跑，跑到胃里去，摸起来以为是实症，实际上是气结在里面，气结在里面的时候，你压他他是喜按，实症的时候才会拒按。你如果摸脉很厉害的话，你摸到实症的脉都是很数，很强，重按它都有。虚症的脉浮在上面，你轻轻一按他就没有了。甘草泻心汤。

几个泻心汤有三味药从头到尾都在，半夏黄芩黄连。半夏是利水，去呕。黄芩黄连只是消炎，胃家有热，虚热用黄芩黄连。有实热的时候才会有大黄攻下来。泻心汤，心就是指胃，肠胃系统发炎的时候使用的汤剂。这个地方被攻下了，张仲景重用甘草，重用甘草的时候甘草泻心汤。重用生姜的时候生姜泻心汤。附子半夏的时候，半夏泻心汤。这里胃伤到了，重用甘草。

### 甘草泻心汤方

甘草四两，黄芩三两，干姜三两，半夏半升洗，大枣十二枚劈，黄连一两。

右六味，以水一斗，煮取六升，去滓。再煮，取三升，温服一升，日三服。

甘草解毒，生用能够蓄水。甘草泻心汤饭前吃。甘草泻心汤症状下痢，谷不化，肚子里听到咕噜咕噜响，我们知道里面有水在里面，所以才会用到半夏。这个下痢清谷是比较轻的症状。

### 第一百七十四。

原文：「伤寒」，服汤药，下利不止，心下痞鞭，服「泻心汤」已，复以他药下之，利不止，医以「理中」与之，利益甚；「理中」者，理中焦，此利在下焦，「赤石脂禹余粮汤」主之，复利不止者，当利其小便。

有的时候并不是有了伤寒，你服药没好才会这样子，有的时候他一开始就是大肠炎。

这个条辨是讲下痢不止，下痢是清谷。这个下痢会用到赤石脂，禹余粮的时候痢非常的凶，有时候会看到便血。一天跑个三四十次。如果止痢止不到，张仲景说用涩剂，你如果是没有下痢，吃赤石脂禹余粮汤马上便秘，大便马上干掉，因为很涩。排都不容易排出来。如果用甘草泻心汤，很多的汤剂，如果热利，葛苓连汤都没有办法去的时候，就可以考虑使用涩剂。

「赤石脂禹余粮汤」大部分用在大肠发炎的时候。怎么知道大肠发炎，先便后血，这个是痔疮，外痔。先血后便，内痔。血便混合在一起的下痢，这个是肠炎。

利不止，用收敛的药，涩剂，还是下痢，最后一条路利小便，把大肠的水利到膀胱里去，小便排出来，利就止掉了。如果没有办法止痢的时候，痢小便。

利小便有很多处方，五苓散、猪苓汤可以利小便。甚至说本来里面就有利，他是热利是葛芩连汤症，葛芩连下去了，好很多了，大便原来很臭，现在不臭了，还是有下痢，葛芩连汤里可以加一些猪苓茯苓，泽泻，一些利尿剂，张仲景的意思就在这里面，车前子也可以，车前子利尿。经方做基础。

赤石脂禹余粮汤方

赤石脂一斤碎，禹余粮一斤碎。

右二味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

赤石脂红色的，这两个都是石头类的药。这个药下去还下痢的时候，张仲景后面还用，赤石脂一半煮一半生用。

第一百七十五。

原文：「伤寒」八九日，吐下后，虚烦，心下痞鞭，胁下痛，气上冲咽喉，眩冒，复发汗，脉甚微，经脉动惕者，久而成「痿」。

「伤寒」八九日已经传经了。气上冲咽喉，正常人阳气应该往下降，阴往上升，攻下，阳气虚掉，会往上跑。

这个是你给病人吐下后，不知道把津液补回去。张仲景补津液的时候有人参，白芍，甘草，生姜，大枣。如果不知道补津液，一直在吐下，胁痛，持续在虚症的状态下，你没有好好调理治好他，到后来病人会筋脉动悸，津液伤到筋脉，这个时候久而成痿。痿症就是这样来的。

内经讲肌肉萎缩，外证看到小儿麻痹，我们不管他的病名是什么，当我们看到痿症的时候，黄帝内经说治痿，独取阳明，所以阳明就是讲消化系统。如果我们把病人消化系统弄好了，就可以治疗痿症。因为脾主四肢，主肌肉。前面桂枝汤很好，解肌的。你再仔细研究桂枝汤，桂枝汤对脾脏非常好，脾脏管胃口，小孩子不吃饭你把白芍加重，麦芽糖下去，这个都是小建中汤，张仲景第一个滋补，补阳的方式，一下去小孩子就开始吃饭。

痿症取阳明的时候，并不是说用阳明的药，而是把脾胃建起来。最好健脾胃的药就是小建中汤。

第一百七十六。

原文：「伤寒」，发汗，若吐，若下，解后心下痞鞭，噎气不除者，「旋覆代赭石汤」主之。

不一定非得伤寒，发汗吐下才会有这个症状。平常正常人也会有这种病。心下痞鞭就是胃里面很硬，胀闷很难过。噎气不除就是有胃酸，「旋覆代赭石汤」。

胃酸，会伤到喉咙，食道。「旋覆代赭石汤」一剂下去，胃就很舒服，如果不舒服，好点，还是有胃酸逆流的现象，那就是食道喷门破洞了，太久了。如果没有破洞，一剂下去就好了。

现代人得到胃酸就是甜食吃太多了，现在人工糖造成胃酸。你治好他，告诉他甜食不能吃。真正的天然的糖可以吃。

自然界甘味是土，现在科技造出来，吃到嘴里是甘的，到胃里是酸的。

旋覆代赭石汤方

旋覆花三两。人参二两。生姜五两切。代赭石一两。大枣十二枚劈。甘草三两炙。半夏半斤洗。

右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎，取三升，温服一升，日三服。

旋覆花三钱，重用。代赭石一钱，代赭石是金石类的药。旋覆花，浓痰在里面，代赭石降逆，噎气打嗝，胃酸往上走。

如果病人很重的时候，旋覆花可以用到四钱，代赭石用到两钱三钱四钱上去没关系。你只要记得，代赭石是要降逆的，所以如果病人告诉你气一直往上升，冲上来很难过，代赭石加重两钱三钱加上去没关系，这些都是没有毒可以吃的。遇到人参生姜大枣甘草就是补肠胃的津液，滋阴用的，代表这个人已经肠胃的津液伤到了。在发汗的时候都会伤到肠胃的津液。所以治病的同时把津液补回去。半夏是止呕的，但是半夏一定主胃周围旁边的水。胃里面有水的时候靠生姜。

生姜泻心汤为什么会有食臭，因为他胃里面有水，食物泡水里面，两三天就会臭，就是食臭，这个时候用生姜泻心汤。

痰、酸很多，重用旋覆花。如果说气一直往上冲，酸往上冲，代赭石多一点，三钱四钱五钱没关系。这些都是没有毒的。

第一百七十七。

原文：下后，不可更行「桂枝汤」；若汗出而喘，无大热者，可与「麻黄杏仁甘草石膏汤」。

「麻黄杏仁甘草石膏汤」使用时机是汗出而喘，这个喘可以跟咳连在一起。病人咳嗽气喘，舌头黄的，里面是热。「麻黄杏仁甘草石膏汤」是热症，没有发烧，不怕热，也不难过，有汗，就问完了，「麻黄杏仁甘草石膏汤」。

如果麻杏甘石汤，病人无汗大热的时候，就变成大青龙汤，大青龙汤就是来自麻杏甘石汤。麻杏甘石汤加上桂枝生姜大枣，七味药组合就变成大青龙。大青龙汤一定是无汗而喘，有热有咳。

病人气喘咳嗽，舌头是黄的，没有汗，身体痛，还有发烧，这个时候要用大青龙汤。

临床，病人一到夏天就开始喘，不用问了，大青龙汤。

病人如果被攻下了，不要开桂枝汤。肠胃津液伤到了，你桂枝汤再下去，肠胃的津液又没了，里面就干掉了，就是担心这个。所以才说不可更行桂枝汤，就

是怕津液一伤再伤。

如果病人是长期的便秘，本来便秘就很久了，你攻下去以后，张仲景也说积下成阴，一攻下以后，他大便清出来，津液回头，本来燥渴，津液回头，这个时候得到桂枝汤症你还是可以用桂枝汤，因为他没有伤到津液。伤到津液的时候就要小心。

第一百七十八。

原文：「太阳病」，外证未除，而数下之，遂协热下利，利下不止，心下痞鞭，表里不解者，「桂枝人参汤」主之。

误下后有两种处方，用寒热来区分。如果误下后出现热利，张仲景是葛苓连汤。如果是寒利，以桂枝人参汤，还有刚刚的甘草泻心汤。这个甘草泻心汤和桂枝人参汤又差一截，桂枝人参汤里面寒的很重。

5——2

桂枝人参汤方

桂枝四两，甘草四两炙，白朮三两，人参三两，干姜三两切。

右五味，以水九升，先煮四味，取五升，纳桂更煮，去滓，取三升，温服一升，日再服，夜一服。

人参出现的时候一定是津液受到伤害，病人比较贫苦，可以用党参代替人参，没有关系。所以小柴胡汤里常常有人参，我们常用党参来取代人参。

病人有寒利的时候津液一定会伤到，我们用人参去补丧失的津液。白朮能够去湿，白朮去湿，是去关节上的湿，所以张仲景在处理风湿关节炎的时候，会用白朮，还有肠胃里面的湿，因为白朮是健脾的，市面上有生白朮，有黄土炒的白朮。如果下痢的很厉害，白朮用赤石脂炒一下，赤石脂本来涩剂，这个很凶，一下就止掉了。健脾选黄土炒的白朮就可以。寒利桂枝能够行阳，能够让心脏的力量加强。心脏会移热到小肠，肺法像天，它能把热往下降，降到小肠里面去，所以小肠跟心脏同样是属火，如果寒利的时候，小肠的火没了，所以用桂枝，再严重的话用到炮附子都可以。

九碗水先煮四味药，桂枝最后再煮，不要煮那么久。温服一升，日再服，夜一服。每六小时喝一次，晚上再吃一次，治疗肠胃的，让肠胃的功能恢复的很快，一天吃四次。半夜让病人再起来吃。这是服药方法。

主要就是这个病人外证未除，所以我们会用到桂枝，一个原因就是桂枝能让心火进到小肠，第二个因为桂枝还有一点外证。桂枝汤症还有，所以用桂枝发一下表。

干姜和生姜不一样，如果是热利的话，病人有恶心，用生姜。干姜用寒痢。炙甘草有寒症的时候才会出现。

什么时候用桂枝人参汤，当他有太阳表症的时候，兼有寒痢下痢的时候，使用他的。

怎么区分他是寒症热症，热症下痢病人口渴，因为津液伤到，舌头是黄的，

寒痢的时候舌苔是白的，病人不渴，下痢出来可以看到清谷，水，都是清水，食物都可以看到，热利的话食物消化掉了，排出来很臭，因为里面有肠胃炎，有发炎的现象。

#### 第一百七十九。

原文：「伤寒」，大下后，复发汗 心下「痞」，恶寒者，表未解也，不可攻「痞」，当先解表，表解乃可攻「痞」，解表宜「桂枝汤」，攻「痞」宜「大黄黄连泻心汤」。

「伤寒」，大下后，复发汗 心下「痞」，寒气结在中间，病气跑到胃上面。病人经过发汗、大下，还有表症，不要去治痞，应当先解表，先不要管胃，先把表解了以后，再去治疗痞，这是治症的原则，解表的时候，适合桂枝汤，只要病人经过发汗了，经过大下了，你不要去想用麻黄用葛根，一律用桂枝汤。桂枝汤除了能够解太阳中风，能够发一点汗以外，本身桂枝汤就是阴阳最好的调和的方剂，也就是说可以把它当补药吃。所以平常你没事吃吃桂枝汤，平常做久了腰酸背痛，那都是桂枝汤症，洗完澡出来很热，吹点风，也是桂枝汤症，腰有点酸就已经是桂枝汤症了，所以平常没事就吃吃桂枝汤。解表一定是桂枝汤，不要考虑其他的方子，病人只要有汗、被攻下过、被发汗过，还有表症在的话都用桂枝汤。攻痞用大黄黄连泻心汤。

病人这里为什么那么确定用大黄黄连泻心汤，因为病人被大下后，肠胃没有东西了，胃里面有痞，这个是有虚热在里面，大黄黄连泻心汤的时候，大黄用二，黄连用一，麻沸汤，用热水泡，挤出来的，不用煮。同样的药，煮的话，你吃的是他的味跟质，味厚，吃完就下痢了，如果是泡的话，吃他的药气，气往上走，他大黄敢用二，用热水泡取他的气，大黄往上走，走的比黄连还上，所以黄连只是清胃里面的热。肺上面，喉咙上面还要靠大黄，头部眼睛出血，眼白地方突然出血出来，或者鼻子流鼻血，这时候都要使用大黄，但是不是煮的，要用泡的。

这个条辨简单讲就是当你遇到一个病人，本身肠胃不好，胃常常不好的人，很多人胃不好，这个时候，如果有得到感冒，不要管他的胃，先去治他的表症，治完以后再去治疗里症。

#### 第一百八十〇。

原文：「伤寒」，发热、汗出不解，心下痞鞭，呕吐而不利者，「大柴胡汤」主之。

大便会有问题，恶心、呕吐。诸位要知道什么时候可以用大柴胡汤的时候，病人有小柴胡汤症，同时兼有一点便秘的现象。呕就是小柴胡汤了，恶心。没有说一定要往来寒热，胸胁苦满，其实不用，恶心就是小柴胡，大便不利，这个时候就可以使用大柴胡汤。大柴胡汤方剂里面有大黄，如果是在肛门口堵到，这个时候你可以加一点芒硝下去，把干硬的东西打掉。芒硝攻坚，咸味的药都有攻坚的效果。即使他的硬块是燥矢，干燥的大便，或者是大肠癌的肿瘤，都可以使用芒硝，一定要让他大便通出来。

#### 第一百八十一。

原文：病如「桂枝证」，头不痛，项不强，寸脉微浮，胸中痞鞭，气上冲咽喉，



不得息者,此为胸有寒也,当吐之,宜「瓜蒂散」。

病像桂枝汤症,但是他头没有痛。项不强,寸脉微浮,胸中痞鞭,胃的地方非常的硬,气上冲咽喉,上下气不通,一个东西梗到,不得息者,此为胸有寒也,这个寒应该把它当作实。比如吞到骨头、铜币梗到,当吐之,就是有异物梗到里面的时候,中医是采用吐法,宜「瓜蒂散」。越甜的瓜,瓜蒂越苦。

#### 瓜蒂散方

瓜蒂一分熬黄。赤小豆一分。

右二味,各别捣筛,为散已,合治之,取一钱匕,以香豉一合,用热汤七合,煮作稀糜,去滓,取汁,合散顿服之。不吐者少少加,得快者吐乃止,诸亡血虚家,不可与瓜蒂散。

瓜蒂熬黄,就是烤一下变黄,不要放水里面去熬,是烤一下变黄。配合赤小豆等量。这两个和在一起吃下,当场就吐掉了。我们确定他有东西梗到的时候使用。表面上就是吃了这个瓜蒂散就吐,张仲景只有这个方子在吐。

临床上,治很多病,根本没有用到吐剂,病人是吐了而解掉,所以吐是一种解病除的方式。

肾结石,在太溪穴到复溜穴这一段,这一段有压痛点,就是有结石结到,一般的处方有猪苓汤,病人验尿试纸咖啡色就代表有结石,扎针的时候,痛已经去掉,开汤药给他,第二天他说他好了,他说试纸变成蓝色正常了,痛也没有了,小便看到有石头排出来。他说可是头天晚上很不好过。他吃完药吐,一吐完小便又大下。

开猪苓汤的时候,想的他根本就不是吐剂。吐解有两种,一种是真正是服药去吐它。还有一种是因为他是肾结石,上面有痰梗到,所以尿才会在肾里面一直累积起来,排不出去,尿垢慢慢累积起来变成结石。吃一些钙片,结石更快。

#### 第一百八十二。

原文:病胁下素有「痞」,连在脐旁,痛引少腹,入阴筋者,此为「藏结」,死。

病胁下素有「痞」,硬块,有痛。连在脐旁,痛引少腹,入阴筋者,俗话就是到睾丸里面去了,此为「藏结」,死。

这个我解读原因,他疝气,肠炎腹膜破掉在里面,也可能是盲肠炎死掉。

病例,女性痛在小腹旁大腿根,强痛,痛了十五年。医院说她没有病,说她大脑有问题,十五年呆在家里不能出门。我一按,拒按。再压她的足三里下一寸,阑尾点,压痛。她的手掌生命线上一块褐灰色的。处方的时候,我用大黄牡丹皮汤,金匱的方子,我认为她是肠子破裂掉了,她大便非常的不好,所以我用薏苡附子败酱散和大黄牡丹皮汤,刚开始吃汤剂后来改粉剂。这个人连续吃六个月,我用汤剂,前三个月一天一次,不给她吃她一礼拜上一次厕所,一点点出来。越吃她开始越收,手上褐斑完全退掉正常,她大便正常了,我就该粉剂给她吃,装到胶囊里面,她跟我讲十五年没有办法出门,痛。现在可以出来走动了。你以为腹膜炎盲肠炎美国医生可以查到,我告诉你他照样查不到,可是病人骗你干嘛,痛的要死,他干嘛骗你痛,西医说她神经有问题。验血说她没有发炎,都是好的,

实际上就是藏结，堵在这个地方，连在阴筋上面。

当年他写死，实际上这个是不会死的，也有可能大肠癌，睾丸癌。

第一百八十三。

原文：「伤寒」，若吐，若下后，七八日不解，热结在裏，表裏俱热，时汗，恶风，大渴而烦，舌上干燥，欲饮水数升者，「白虎加人参汤」主之。

阳明证分经热跟腑热，腑热就是便秘。经热就是大渴。经热用白虎。腑热用承气汤。

诸位晚上去吃米粉汤，回来后大渴，光是味精当场就把你变成白虎汤症。所以你如果到外面吃东西，吃完以后让你口渴的都不能吃，你好好的没有太阳证，吃完他一餐，当场就把你变成白虎汤症，这就是味精不能吃的原由。为什么用味精，隔夜的食物不新鲜，味精下去吃起来好像很新鲜，就是为了这个。害的我们到外面吃完，回来就是白虎汤症，一直喝水嘛。

若下以后，七八日不解，热结在裏，胃里面非常的热，津液伤到，这个恶风是里面很热，你风吹到了很难过，并不代表他有表症。阳明证出现的时候，病人但热不寒，只热看不到寒症。加人参就是津液伤到了。

我们在使用的时候，白虎汤，石膏剂量一两，知母五钱，已经很热了，你不需要用炙甘草，用生甘草。梗米，糯米就可以，甘草两钱，不要梗米五钱，你煮了变成干饭，两钱就够了，加一点点下去，我一般放糯米下去。石膏重用，你如果说石膏三钱五钱，力量不够，开处方就要上两，既然要用到石膏，剂量要大，一剂下去就够了，有时候口渴，饮水数升不能止渴，那个时候刚发糖尿病，突然血糖很高，那个口渴，你知道他是白虎汤，开出去剂量不够，一点用都没有，要大剂的用，还有病人饿，肚子饿的要死，慌的马上要找东西吃，这都是血糖太低了，也是白虎。

病人出现燥渴现象的时候，就是白虎。如果说开的剂量不够，燥渴的现象去不掉。这个白虎汤，血糖很高的时候，病人渴喝完一样燥渴，喝一杯水，小便排一杯的量，白虎汤。血糖太低，症状肚子一饿，马上要放东西吃下去，一定要有东西下去，不然会发抖，冷汗，也是白虎汤。当病人渴饮百杯不止渴，饿吃百碗不解饥，也是白虎汤症。

5——3

第一百八十四。

原文：「伤寒」，无大热，口燥渴，心烦，背微恶寒者，「白虎加人参汤」主之。

一八三和一八四都是白虎加人参汤。临床病人有燥渴或者烦躁，就算病人无大热，病人有高烧、高热的现象，舌苔是黄、干裂的，口又渴，又要喝水，没有一点寒症，就算有高烧，也一样用白虎汤，白虎汤加人参的原因就是你确定他津液没有了，药下去烧一样退，白虎是退烧的很好的处方。

病情在阳明症的时候，包括大承气汤症，承气汤症也会出现高热的现象，我们如果把阳明症出现的高热，跟太阳篇出现的高热放在一起比的话，阳明篇是大热，太阳篇是小热，进入阳明的时候高热很高，诸位就要考虑承气、白虎。

## 第一百八十五。

原文：「伤寒」，脉浮，发热，无汗。其表不解者，不可与「白虎汤」。渴欲饮水，无表证者，「白虎加人参汤」主之。

脉浮，发热，无汗看着像是麻黄汤症，可是麻黄汤症一定要有恶寒，他没有恶寒。有表症的时候不要用白虎，确定无表症，也就是但热不寒，无汗是一个很好的指标。病人只要没有汗，就代表表没有解，要先解表。

临床上病人恶风、有汗，一看是桂枝汤症。结果病人又很燥渴，渴欲饮水，摸他的脉是浮大，我们知道他是太阳有问题，表有问题，阳明也有问题，这个时候把白虎汤跟桂枝汤和开在一起给他，一剂表里双解也可以。

## 第一百八十六。

原文：「太阳」「少阳」并病。心下鞭，头项强而眩者，当刺「大椎」、「肺俞」、「肝俞」、慎勿下之。

「太阳」「少阳」并病。心下鞭，胃的地方很硬，项强而头昏的。只要项强出现的时候就可以使用葛根汤。如果有少阳病出现的时候，恶心，心下鞭，可以用葛根汤跟柴胡汤复方。

伤寒论归伤寒论，条辨归条辨，临症的时候非常灵活。

## 第一百八十七。

原文：「太阳」与「少阳」合病，自下利者，与「黄芩汤」；若呕者。「黄芩加半夏生姜汤」主之。

光是太阳有下痢的时候，我们会使用葛芩连汤，如果讲少阳太阳合病，意思是告诉你，这个病人是有下痢，但是兼有太阳症，恶风、有汗，身体肌肉酸痛，同时兼有往来寒热，恶心，我们知道这个病人太阳证兼有少阳症，又出现下痢，这个时候，最好选择是黄芩汤。纯太阳的下痢我们是葛芩连汤。

## 黄芩汤方

黄芩三两，甘草二两炙，芍药二两，大枣十二枚擘。

右四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再服，夜一服。

张仲景用到芍药，除了补阴不足，用到芍药就是有腹痛。芍药跟枳实，张仲景在有胸满的症状的时候，一定会加重枳实，有腹痛的时候，一定会重用芍药。如果弄错了，有胸满的时候，重用芍药，他会更满，胸会更胀。所以治疗心脏病几乎不用到白芍，胸满气喘用不到白芍。治疗肚子痛的时候，用不到枳实，但是在胸满的时候，一定会用到枳实。

黄芩肠胃炎的时候一定会使用到，如果是在胃里面张仲景用大黄黄连，如果到了肠子里面去用黄芩。如果胃肠统统出问题，大黄、黄芩、黄连，三黄汤。如果问题出自肠子里面，下痢跟胃没有关系，下痢跟肠子有关系，所以他用黄芩，病人下痢的时候用炙甘草，因为炙甘草入小肠，小肠跟心脏是表里。所以我们会用到甘草的时候，如果是生甘草大部分是在胃里，肠子里面用炙甘草，白芍能够去腹痛，去腹痛是因为腹部非常多的静脉在里面，白芍下去可以把静脉收起来，

还有就是下痢，白芍能够滋阴，同时可以在腹部肠子，肠壁上里面产生滋润的功能，芍药是滋阴的药，四物汤里面有芍药，实际上芍药是止腹痛的，同时又可以滋阴的。

如果你知道药性，同样是开四物汤，一般比例是二三三二，当归、芍药、川穹、熟地。月经痛，白芍一两，同样处方，但是白芍加重。一看岳母，要年轻点，生地加重点，生地滋补的药，加重，年轻美丽。但是四物汤是身体很健康的时候吃。平常没事吃点桂枝汤，把肌肉不舒服的地方解掉，那你身体常年是好的，可以吃补。

恶心加下痢，同样的黄芩加半夏生姜。单味生半夏、生姜，这两个药放在一起的时候，叫小半夏汤。小半夏汤专门止呕去恶心。生半夏平常制过，半夏跟生姜煮在一起，因为生姜可以解半夏的毒，煮过以后，切片，烘干就是制半夏。制半夏其实就是生半夏跟生姜混合的东西。但是炮制过跟生用，炮制过以后就不用加生姜了，比如止呕，没有生半夏，用制半夏就不用加生姜了，如果用生半夏加生姜下去，生姜解生半夏的毒，可是你生用直接入汤剂的话，一剂下去恶心去掉，比制半夏治恶心力量强。

#### 黄芩加半夏生姜汤方

黄芩三两，芍药二两，甘草二两炙，大枣十二枚劈，半夏半升，生姜一两半（一本作三两）。

右六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再服，夜一服。

这个处方有下痢、有腹痛、恶心。什么时候用黄芩汤，什么时候用黄芩加半夏生姜汤，就是看恶心不恶心，这两个处方都有腹痛。葛芩连汤没有腹痛，就是下痢，病人热利怎么知道用葛芩连汤，什么时候用黄芩汤，热利大便很臭，肚子痛黄芩汤。还恶心黄芩汤加上生姜半夏。都不痛，葛芩连汤。从痛就可以确诊，不会错。止痢效果非常好，过去霍乱我们都会用到这些处方。

#### 第一百八十八。

原文：「伤寒」，胸中有热，胃下有邪气，腹中痛，欲呕吐者，「黄连汤」主之。

这个腹中痛，不一样的。这个腹中痛，不是小肠子的肚子痛，这个腹痛是胃痛。伤寒胸中有热，胃的地方，胃下有邪气，都在上焦的地方。“腹中痛”这个是胃痛，呕吐，这个时候用黄连汤。黄连汤的处方，黄连跟大黄用在上焦的热，胃和肺的热，用黄连大黄。

如果说是以胃做标准，胃有发炎的话，我们经方开的是黄连，在胃之上还有热的话就是大黄，胃之下小肠里的话就会用黄芩。寒凉的药能够去热，以现代医学讲的话，就是消炎。黄连能够去胸腔和胃热的毒，黄芩去小肠发炎的毒。

#### 黄连汤方

黄连三两，甘草三两炙，干姜三两，桂枝三两，人参三两，半夏半升洗，大枣十二枚劈。

右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服一升，旦三服，夜二服。

剂量全部是等量。这里呕吐是用干姜来治疗呕吐，并不是用半夏，因为里面胃家寒到。人参补他的津液。黄连跟桂枝是，黄连能够去热，桂枝能够强他的心阳。一般使用黄连汤，恶心呕吐的话才会使用半夏、红枣，恶心很强。

这个方子如果分解开来，前面介绍过桂枝甘草汤，是心下悸，动悸的时候，心下悸。心下动悸是心下有水，水气会凌心，心脏是火，结果水往上冲，而不是真正的气往上冲，心会动悸，这个时候是用桂枝，用甘草。所以说，桂枝本身对心下中焦这个地方本来就是很好（这个腹中痛要把他改成胃痛），本来就是对胃非常好。桂枝这个药，解毒上是活血，能够活动脉的血，当心脏的血出来的时候，血会带很多很好的抵抗力。这时候桂枝下去，可以带很多大量的发散出来到全身，四肢上去。所以即使胃痛，都还在用桂枝。一般温病派他们胃有问题，不会使用桂枝。经方除非有吐血，里面有吐血出来的话，桂枝不要用了。干姜能用，但是桂枝不要用了，如果胃不吐血，但是胃不舒服，还是用到桂枝。

半夏，是胃周围有水的时候，会用到半夏来止呕。

黄连是解毒的，黄连是寒凉的药，胃发炎。这个处方常常用在胃炎。

其他的药，你只要看到津液不够的时候，人参对胃非常好，津液不够的时候加人参。红枣是补他胃的津液。

黄连汤这个汤是补泻兼顾的，同时消炎，同时把津液补回去。同时又把水排掉。水不排掉，水生万物，水在胃里面，病毒还会回来，因为水还在里面。所以半夏使用的很多，呕吐的时候，经方里面用生姜也可以止呕，用半夏也止呕，生姜是胃里面的水，半夏是胃旁边周围的水，吴茱萸也可以止呕，介绍到吴茱萸汤的时候会介绍。

前面讲过，甘草干姜汤，这里又用到，所以诸位看到，这个胃痛的时候，里面一定有寒热并结，有胃家寒症，同时又有发炎，那我们就寒热要并用在一个处方里面，没有关系。前面介绍过了，用附子，用黄芩黄连。这里桂枝干姜都是温热的药，跟黄连用在一起都没有关系。所以有寒热冰结的现象，所以才会用黄连汤。你如果说这个汤剂不记得，但是你看这个病症，你开出来就是黄连汤。剂量都是一样的，你只要看到恶心呕吐，半夏，这里没有讲到口渴，代表胃是寒的，胃是寒的干姜就用了，炙甘草，胃家是寒症。有热，胸中有热，黄连去热，开起来处方就是这样子。

读伤寒论的时候，每一味药，如果说他的功能很清楚，处方你一看就懂。就知道什么时候该用这个处方。而且这个一定讲的是胃，不是肠。所以这个胃会痛。胃会痛的话，诸位要使黄连汤，肠子有痛，有下痢的话，黄芩汤。这就是黄芩汤跟黄连汤的区分。

第一百八十九。

原文：「伤寒」，八九日，风湿相搏，身体烦疼，不能自转侧，下呕，不渴，脉浮虚而濡者，「桂枝附子汤」主之；若其人大便溏，小便自利者，「桂枝附子去桂枝加白朮汤」主之。

再来，这个处方。我们三个处方治疗风湿、痛风，源自这个地方。

「伤寒」，八九日，一候已经过了，过了六七天了，应该好了。病人风湿相

搏，身体烦疼，不能自转侧，下呕，不呕就是病没有在少阳，少阳才有恶心。也不渴，病也没有在阳明。不在阳明，也不在少阳。脉是浮的但是虚的，也不在太阳。代表他表症没了，没有表症了。脉是浮而且是涩的，桂枝附子汤主之。

### 桂枝附子汤方

桂枝四两。附子三枚，去皮炮，破八片。生姜三两切。甘草二两炙。大枣十二枚劈。

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

桂枝、生姜、甘草、大枣，是不是像桂枝汤，他少了一个白芍。把白芍拿掉，变成炮附子，就是桂枝附子汤。桂枝汤是用在太阳中风有表症的时候。现在这个人表症没了，但是全身关节痛，翻身都不能翻身，你摸他脉又是浮的，但是是涩脉，张仲景意思就是这种人是素有湿，本身就有很多湿，过去在黄帝内经说湿伤于下，久住湿地，或者你住的房子比较潮湿。湿是从脚下面开始伤害到人体的。现在人比如说在冷气间呆久了，工作很辛劳，该流汗又没有流汗，外面空气很冷，把你表束到，汗又没有流。室内你常常走来走去很辛苦，因为里面很热，你动来动去，汗流的很多，汗出来以后，从身体的肠胃经过三焦系统，走到皮肤表面上来，应该毛孔打开来要流汗，可是冷气开着，汗又出不去，出不去汗要回来，但又回不来，汗出去它不会走原路回来，结果就停在皮肤表面上，日积月累以后，这个汗水慢慢累积在肌肉关节里面，就是风湿相搏，湿就是这样子来的。风湿相搏，如果这个病人素有湿，那你用汤剂开下去，他发表的时候，湿还在那边，因为你桂枝汤有桂枝白芍，麻黄汤里面麻黄桂枝杏仁炙甘草，葛根汤里面是桂枝汤加上麻黄葛根，都没有用到去湿的药，所以病人湿不会去，表症会去。张仲景开的第一个治疗风湿的药，就是桂枝附子汤。

解读炮附子。炮附子去寒，桂枝去风。所以使用桂枝附子汤的时候，他是有风有寒，风的意思就是说全身到处游走，所以治这种风湿，他不能转侧，但是他的风湿并不是偏重在只在一个关节，只在一个地方，不是永远发在一个地方，肌肉也有，风的定义就是到处游走。所以当我们遇到痛是到处游走的时候，第一个要想到就是桂枝。中医是辨证论治，你只要看到到处游走性的痛，就是桂枝。寒我们用炮附子。炮附子去寒。

一般来说，只要有痛，大部分都有寒，所以如果开处方下去，只是开个止痛药，效果不会很好。你如果开炮附子，附子很凶，附子去寒的力量很强，所以从这里解读到一件事情，张仲景在汉朝的时候就知道，他认为这个痛不是发炎而来的，发炎来的黄芩，黄连，大黄就可以解决，他认为这个痛是寒堵到，因为有寒，本来人身上是很热的，热水是一直循环，人身上是这样子，水一直不断的循环。你这个地方有寒的时候，寒水冻在这个地方的时候，水过不去了，慢慢在这个地方累积，累积越来越大，这个时候因为有寒挡到去路，所以痛是从压力产生痛，并不是从发炎产生痛。张仲景当时就了解了，所以他治疗痛的时候，他开炮附子。那你说炮附子那么热有没有错，其实炮附子一下去就好。我们怎么证明很简单，你牙齿肿起来，牙龈肿起来，牙医说你要做根管治疗，他根管治疗，牙齿发炎，他在牙齿上面打洞，一打洞，穿孔的时候，那个脓一出来，压力减轻掉了，是不是痛就去掉了，所以你是压力减轻掉了，痛去掉了，可是炎症还在那边，所以牙医让你一个礼拜去一次，给你抗生素，消炎，所以你很明确的知道，痛是来自压

力，而不是来自炎症。炮附子是无所不入，很凶悍，吃下去到处跑，他把寒去掉。寒去掉，阻塞在寒水上面的这个寒突然蒸发掉了，全身水的循环回来了，水的循环一回来，痛就去掉了。所以桂枝跟附子用在一起的时候，全身的肌肉痛，不能转侧，一剂下去就中了。如果说你忘掉了，只开桂枝跟炮附子，生姜、炙甘草大枣你忘了开，那就叫桂附汤，你自己创新的，一下去痛也去掉了，但是便秘，为什么？因为你没有把津液补回去，所以全身，整个经方，中医在治病的时候，中医在治水，好像大禹治水，西医是验血，所以你拿验血报告去开药鸡同鸭讲，不能这样子开的，我们是治水。

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。用六碗水煮两碗，分温三服，就是早中晚吃。这个剂量里面附子三枚，这个处方最重是附子。这样子讲，如果桂枝四两当场四钱的话，附子是一两二钱。我平常处方是，桂枝附子汤，炮附子我是五钱，桂枝是两钱，生姜两片，炙甘草两钱，红枣十枚，我常常喜欢用十枚，因为简单。有的人说三钱四钱，无所谓，不要那么计较。当中医不需要那么龟毛，因为我们用的是食物，但是你要用化学的毒就要计较了。中药的甘遂、芫花、大戟就要计较了，那个是很凶悍的，红枣多一颗少一颗不要去计较。最重要是桂枝和炮附子的剂量，我们知道他的痛是来自寒，炮附子很快，炮附子走表，全身下去像扫描一样，一下全过去，没有一丝会漏掉。这是处方的方义在这里。

#### 5——4

张仲景前面说，如果这个人大便很溏，小便自利，就是说，他本身是素有湿的人，他已经在排湿了，因为湿很盛了，“小便自利”他这个湿可以自己出来，不用吃药也可以自己出来，大便很溏，粘稠的。小便很顺，一直在排小便。这种情况下你就不需要桂枝了，直接用白术和炮附子。

#### 桂枝附子去桂加白朮汤方

白朮四两，甘草二两炙，附子三枚炮，大枣十二枚劈，生姜三两。

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。初服其人身如痹，半日许，复服之，三服尽，其人如冒状，勿怪；此以「附子」、「朮」并走皮内，逐水气未得除，故使之尔，法当加桂枝四两，此本一方二法也。

附子是去寒的，白术是去湿的，当病人已经有小便自利，下痢的时候，我们知道是寒湿，风没有。如果风寒湿都有，就是桂枝附子白术同用。这个人又又湿，肌肉关节又很痛，痛又到处游走，今天痛这边，明天痛那边，又有寒，三种都有，这个是把桂枝拿掉，就是病人湿可以自己解。

这里重用炮附子，炮附子五钱，白术可以三钱，我们常常开的剂量很重，因为老美是你的两倍，他们都很大，吃东西吃不对，他身材变形，那实际都是有问题的。炮附子八钱一两我常常开的，这是美国人。你的剂量我不会开八钱，最多是五钱。白术给他三钱，这个剂量才能够去全身的游走痛，把他去掉。

初服其人身如痹，这你以为是炮附子，其实不是，是他湿太重，一动你会有种麻痹的现象，半坦你再给他吃，三服尽，其人如冒状，勿怪，这是附子和白术并走皮内，逐水气，水气还没有清出来，就是因为白术附子在赶水气，白术去湿，附子去寒，水气是寒实在里面，我们怕他太干，所以后面才有炙甘草，红枣，生姜在里面。其人如果还有冒状，可以把桂枝加回去没有关系，因为它在游走嘛，

只要一游走你把桂枝放回去。

你要是说这样子很麻烦，我干脆一开始就是附子、白术、桂枝加进去，可以，一点问题都没有，希望一剂就把它去掉。有时候很忙的时候，实在分不清楚，干脆一剂就开在里面了，无所谓。这是风湿在肌肉，在关机上面的处方。这个吃下去，一剂下去头就开始昏了。全身开始麻，昏。你以为附子中毒，不是。你看张仲景用三枚炮附子。肌表在全身周围的时候，一定会使用炮附子，不是使用生附子。

中医讲药不瞑眩疾弗廖，吃下去力量到的时候，病人会开始产生瞑眩的现象。所以我开白虎汤，一剂下去他就头昏了。有时候昏半天，昏下去他很不舒服，有时打电话来问我就放个牌子在那边。

第一百九十。

原文：风湿相搏，骨节烦疼，掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出，短气，小便不利，恶风不欲去衣被，或身微肿者，「甘草附子汤」主之。

“近之则痛剧”碰都不能碰，“汗出”痛的流汗，不是这个病会汗出，是痛到流汗。

这个现象就是现在的痛风。

痛风的时候皮肤表面上红红的，肿肿的，摸上去是烫的，实际上里面是寒的，一定要用热药。甘草附子汤。

甘草附子汤方

甘草二两炙。附子二枚，炮去皮，破。白朮二两。桂枝四两。

右四味，以水六升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。初服得微汗则解，能食，汗止，复烦者，服五合；恐一升多者，宜服六七合为始。

“附子二枚，炮去皮，破”破就是打开。炮附子八钱，桂枝六钱，白朮三钱，白朮剂量最少，再来是桂枝，最重是炮附子，两枚。你桂枝跟炮附子等量都可以，但是还是炮附子加重。

这个炮附子是去寒，桂枝去风，白朮去湿。三味药各有各的功能，怕不能合在一起，所以加了炙甘草下去。炙甘草能缓和各种药性。同时有强心的作用，同时也好吃一点。

甘草附子汤是经方里面最有名的治痛风的处方，一剂就知。外面很痛很热，里面是寒实。这个时候大剂的用。

能食，汗止，他一副已经好很多了，能吃东西了，复烦者，又来一点烦。服五合，第二次就不要喝那么多了，因为已经去很多了。比如第一次喝一升，一碗。第二次只有五合，半碗而已，不要喝一升，减量喝。恐一升多者，宜服六七合为始，就是你喝半碗，慢慢减量下来。

第一百九十一。

原文：「伤寒」脉浮滑，此表有寒，里有热，「白虎汤」主之。



真的是表有寒，里有热，这里没有很清楚。表有寒的话，病人恶寒、体重、节痛、无汗，才是真正的表有汗，如果是表寒里热的时候。我们开出去的处方是大青龙，大青龙就有石膏。这里的脉是浮滑，浮是表，滑是里面有痰，里面很热。表有寒是身体里面太热了，他感觉到外面空气冷，实际上都是热症。使用到白虎汤出现的时候，一定是纯热症，不会有寒症出现的。

#### 白虎汤方

知母六两。石膏一斤碎。甘草二两。粳米六合。

右四味，以水一斗，煮米熟，汤成，去滓，温服一升。日三服。

粳米六合，不要放六碗，两钱就够了。知母四钱五钱都没有关系，石膏用一两以上。

用白虎汤，石膏要重用，石膏要用棉布包起来。汤倒出来，还有黏黏白白的粘稠的东西，那个不用吃了，汤喝掉就可以了。

白虎汤高热的时候，壮热的时候，像脑膜炎，肺炎，只要有白虎汤症统统可以用。白虎汤症就是壮热燥渴。

实际上这个条辨我个人认为应该放到阳明篇去。

第一百九十二。

原文：「伤寒」，脉「结」「代」，心动悸，「炙甘草汤」主之。

「结」「代」，这两个属于阴脉，阴的脉。心动悸，「炙甘草汤」主之。

「结」「代」，这两个属于阴脉，血伤到了。

#### 炙甘草汤方

甘草四两炙。生姜三两切。桂枝三两。人参二两。生地黄一斤。阿胶二两洗。麦门冬半升。麻子仁半升。大枣三十枚擘。

右九味，以清酒七升，水八升，先煮八味，取三升，去滓，纳胶烊消尽，温服一升，日三服，一名「复脉汤」。

讲炙甘草的时候，他一定是重用炙甘草。张仲景在使用甘草、生姜、红枣、人参都是滋阴补津液的药。

炙甘草汤，心脏有结、代的现象。会有脉跳几下停一下，这种现象，如果我们去分析身体里面的情形是这样子：小肠很长，中间有个动脉在腹腔里面，如果说小肠套叠在一起，大便通到这边通不过去了，后面还不断的累积，慢慢大起来，大起来瞬间通，你的脉会动一下，这个动脉会动一下，心脏会跳一下，所以跟小肠很有关系。所以我们治心脏的时候会去治小肠。根据内经的定义，失掉一个脉，少掉一个脉的时候，五十四下是被允许的，就是你跳五十四下，或者五十四下以上，少掉一个脉，这是正常。五十四下以下就是有病。

按照黄帝内经，如果跳两下一停，代表说心脏还可以用两年。三下一停，代表心脏还可以用三年。这个要以一个促脉为主，如果病人出现结脉或代脉就是这样子。如果是跳两下停一下，跳三下停一下，是促脉的时候没关系。有人一辈子

就是心律不整，它不会影响到生命的，它不是结脉代脉。促脉是阳脉，就像皮球，打下去，跳跳跳，停一个，然后又开始跳跳跳，很有力，弹起来有力，跳下去也有力，这是促脉，阳脉，这不会至病的。这个促脉也不需要给他炙甘草，没有关系。

一定是结脉，或者代脉。结脉好像绳结一样，一个结一个结，你把一条绳子打了很多结，你拉绳子感觉到的，那就是结脉。代脉就是跳起来以后，停掉了，停掉以后回来的力量很慢，好像很挣扎脉才回来，这就是代脉。这是结脉跟代脉不太一样。但是两个都是属于阴。遇到这种阴受伤的时候，代表心脏有问题。我们知道原因是来自肠子，为什么要用麻子仁，因为这个人又不是很严重的便秘，不是像阳明证的燥热，还会发高烧的，不是。他是阴症。麻子仁，任何的仁剂里面，只要有仁，都能够通利大便。麻子仁是针对小肠来的，所以我们用麻子仁的时候，小肠里面堵到了，比如说小肠，因为小肠比较小，所以小肠里面堵到的时候，病人排大便的时候，就像羊大便一样，然后一颗颗黑黑小小的排出来，就知道是麻子仁丸症。所以麻子仁是增润小肠津液用的，所以大便会恢复到正常。

阿胶是山东最有名。阿胶是驴的皮，阿胶是冲服。

以清酒七升，水八升，你不要真的酒七碗水八碗，没有那么多。三碗清酒，米酒，水四碗。先煮八味，阿胶不煮的。煮成三碗，去滓，再放阿胶，温服，这个叫「复脉汤」。

伤寒论有两个处方，一个是小建中汤，来源是桂枝汤，白芍加一倍，重用白芍一倍，煮汤成以后，放麦芽糖下去。饴糖，就是麦芽糖。就是小建中汤。张仲景的小建中汤是补阳用的。所以说就算是你没有生病也可以吃小建中汤。

炙甘草汤补阴用的。张仲景很少用补药。经方是治病的。炙甘草汤是他唯一开的补阴的药，阴就是血。小建中汤补阳就是补气。所以他只有小建中汤和炙甘草汤这两个滋补的方剂。

炙甘草汤方，麦门冬是专门润肺的，炙甘草补心的，中医得观念里面，如果健忘，原因是心肺上焦虚，肠胃实。照理说肠胃吸收到五谷杂粮以后，应该把心肺气补起来，血也补起来。

这里会用到人参、麦门冬还有炙甘草，心肺强起来就不会健忘，所以常常忘动忘西，就可以炙甘草了。如果心肺虚，你没有把心肺补足的时候，吃下去的东西就停在下焦，造成下焦实上焦虚，这就是健忘的原因。这个都出自灵枢。黄帝内经分灵枢跟素问，灵枢我们没有专门讲，我的想法是在介绍的时候就把灵枢讲进去。这是在灵枢第二十九篇师友，名称就叫师友，讲的就是这个。

炙甘草汤，麦门冬，跟人参补津液。炙甘草下去心脏的虚会补足。桂枝能够活血，活心脏的血。桂枝是辛甘发散，任何药物，只要它的药性是辛甘发散都是属于阳药，经方都在用阳药。他认为阴阳不和的时候，你调阳，阴会自回，这叫自愈。定义就是说，比如有伤口，要伤口自己恢复才叫痊愈，如果他不能恢复，你用药物去帮助他，让他自己恢复，这才叫痊愈。经方用阳药，阳就是身体的动能，阳药下去的时候，五脏的功能会因为这个药而恢复，恢复以后，阴慢慢自己会回头，这个才是真正的痊愈，所以用很多的阳药。有两种阳药，一种是辛甘发散，一种是甘淡渗利，甘味的药，淡味的药它能够渗利。甘淡渗利，也是为阳。

酸苦涌泄的药是阴药。生地黄目的是滋阴液。

## 5——5

灵枢里面决气篇，第三十一篇，讲到津液，津就是肌肉腠理里面的水分，汗水滚滚出来，叫做津。流汗出来，身体上是杂调他的津，津不足的时候是人参，人参补津液。液定义是什么？灵枢里面决气篇，说谷气，五谷杂粮吃到肠胃里面去，就会产生营养，这个营养再注入骨节，骨髓里面去。到骨节里面，骨节可以伸曲，注入骨髓能够补益脑髓，皮肤的润泽，头脑的智慧，骨节的伸曲，是液。津和液一个是阳，一个是阴。我哦我们用生地的时候就是补液，如果要把津液解释的时候，津液就是这样子，张仲景当时就是看了灵枢，把津液定义下来。病人津不够，液也不够，生地。当你要用生地的时候，张仲景用生地就是生地，就是粘哒哒的，丢到墙上会粘到的，有的把生地弄成碳了，津液都没了，轻飘飘的，一丢都散掉了，那个没有用了。我们用生地就是用他滋润，黏黏的，润泽在里面，能够补他丧失掉的液。所以补阳补阴都有。生地既然要补阴，生地用三钱，五钱补不到，经方一两。我开炙甘草汤的时候，生地是一两大剂的才补的到。生地补他的阴液。

阿胶是生用，不能煮，一煮阿胶就没有力量了。阿胶是补心血用。心血不够会用阿胶滋补。阿胶除了补血还有止血的功能，所以女人月经来的时候不能吃阿胶，一吃阿胶月经就停掉了。阿胶是给虚症的人用的，你给身体很强壮的女人用阿胶月经会停，但是你给虚人用，包括她月经来的时候，你给她吃阿胶，她还是有月经，并没有吃阿胶停掉。如果她月经该来的时候，你用阿胶把她月经止掉了，她胸部奶水很胀。

炙甘草是补阴用的，它在心脏上面，把心脏的血补足，桂枝把这个血打到四肢上面去，麦门冬、人参同时把胸部津液恢复，心脏和肺的津液补回来。然后麻子仁能够稍微通利一下肠子，炙甘草汤没有便秘的人吃了大便会比较多，因为有麻子仁。如果你大便很不规则，常常有时候便秘有时候下痢，然后你又是炙甘草汤症，麻子仁下去的时候，一剂大便就恢复正常了。麻子仁是取它的仁剂。一般在攻坚的时候，如果这个病人大便有点燥矢，偏偏又不是很硬，如果不需要用到芒硝大黄，芒硝大黄太过，给他一点麻子仁就可以把大便清出来。

治心脏要去治小肠，炙甘草汤看起来是滋阴，因为心脏是阴，所以说遇到脉结代的时候，用炙甘草汤。

这九味药，用水四碗，酒三碗来煮，用酒煮发散效果会比较强。先煮八味，阿胶不要入锅，煮成三碗，把渣丢掉，再放阿胶。温服一升，一天吃三次。炙甘草汤又有一个名称叫复脉汤。你不要很死板，脉跳少掉一个再用，当脉不正的时候，或脉失掉的时候，都可以用复脉汤。就好像用麻黄汤，当你看到病人有太阳伤寒的时候，他关节痛，全身关节痛，如鞭打，恶寒，有高烧是麻黄汤症，但是你看一个人也是恶寒，但你看他神不在，麻黄汤另外一个名称叫返魂汤。麻黄是发阳的，让他神会回来。

经方补阴的时候，用的还是阳药，绝对不会开一个全部是阴的药在里面。

这个处方，任何的心的问题，只要他脉不整的时候，当你用复脉汤，就是炙甘草汤，吃到什么阶段可以停药？第一个，安眠，心脏出问题，第一个症状就

是失眠，睡不好。吃了炙甘草汤，睡着代表对症，吃了一两天还不能睡觉，那你处方要换掉了，经方是一剂就知道。第二个，大便。心脏和小肠是表里。当心脏功能不好的时候，大便一定不规则。常常便秘或下痢。大便正常了，代表心脏好了。第三，手脚温热，心脏有问题手足冰冷。第四，无胸痛。心脏有问题，很多人会兼到有胸痛气闷的现象。这个都是心脏出现问题了。如果你有失眠，大小便不规则，手脚是冰冷的，胸又痛，你去医院检测的时候，搞不好在机器下面你还是正常，因为那个机器一定是等你发心脏病的时候，才知道你是生病了。

第一百九十三。

原文：脉，按之来缓，而时一止复来者，名曰「结」，阴也。又脉来数，而中止更来，及小数中止能自还者，名曰「促」，阳也。脉来缓，而中止不能自还，因而复动者，名曰「代」，「阴」也；得此脉者，必难治。

此条漏掉未讲。

脏结汤方

柴胡五钱，白朮五钱，茯苓五钱，炮附三钱，生附一枚。

主方在此，其余需临证视情况而定。

后面出了一个藏结方。藏结就是阴结，寒湿堵在里面，处方柴胡、白朮、茯苓，等量，生附子跟炮附子用在一起，大概不多人会这样子用。生附子去里寒。炮附子壮里阳，所以桂附八味丸，里面的附子，就是炮附子。生附子去里寒，使用的时机是发现病人心阳不足，心脏快要停了，我们用生附子下去刺激他，让他心脏跳起来，温静脉，血脉经络太寒湿的时候，会用到生附子，温血脉神经。炮附子，肺阳不足，表虚，表虚的时候病人大汗不止，我们会用到炮附子。生附子也可以通利三焦，可以壮命门火。实物上看，生附子是黑色的，长得像心脏，心脏是红色，心中有阴。心脏是火，用易经看的比较清楚，离中虚，中间是阴，阳在外面。肾是水在外面，阳在中间。火里面有阴，所以当你阴很盛的时候，心火（离火）会慢慢变小，就好像水慢慢多了，心脏慢慢停下来了，生附子下去就可以把这个（离火）阳壮回来，心脏的力量就会跳起来，把外面的阳补回来。（坎水）里面的阳跑掉了，肾脏的阳虚的时候，用炮附子去壮它。当你把炮附子生附子并在一起的时候，是不一样的。藏结就是腑和脏，消化系统和内脏系统中间隔了一道痰湿，这个痰湿是白白黏黏的，很多慢性病都常常会一口白痰出来，后面金匱会介绍，白津出，这个白津有时候从嘴巴吐出来，有时候开药下去，病人大便很溏，一直下痢，排水，小便又很多，你看看这个人有没有脱水，你问他口渴不渴，不渴，代表这个药下去把寒湿排出去了。代表寒湿去掉脏腑的功能会接触，本来脏腑就是表里，表里之间寒湿梗到了，就用夹杀的方式，炮附子跟生附子把它夹在中间，就把这个寒湿利出来，这是常常使用的一个手法。什么时候排干净？口渴了。那个肾脏病外面寒湿包住一样，他都不会口渴的，吃了药都口渴了，有病的人心脏比较衰弱的人，内脏比较衰弱的人，运动半天都不流汗，也不口渴，也不流汗，这种人就有病了，运动流汗是津在换，腠理的肌肉水在换，是调津的动作。这个人调津的动作都没有了，代表内脏伤了，吃了中药后原来不流汗，现在流汗了，原来不口渴，现在开始口渴了，都是好的现象，不单单是胃气恢复，正常人运动都要流汗的。

藏结处置的时候，临床上用到很多癌症都可以使用他，治疗癌症的观念也是一样，不要想他癌症，就按辩证论治，把这个寒湿去掉，让他脏腑功能疏通，他自然而然就会好起来。

### 辨阳明病脉证并治法

进入阳明的时候，诸位看看灵枢，第二十九师、三十决气、三十一肠胃，三十二平人绝谷，三十三海论。这几篇跟阳明篇有很密切的关系，生理解剖就是从这里来的。像肠胃就告诉你食道有多长，从嘴唇到牙齿九分长，牙齿到舌根是三寸半，舌头是七寸。平人绝谷，就是正常人如果没有吃东西，为什么可以活七天，皇帝问岐伯，岐伯说常人吃饱是三斗五升，一天五升，五七三十五，刚好七天用完。正常人不吃食物，七天会走人，还是要喝水。

阳明篇专门讲肠胃，当你病了，在太阳证，没有治好，这个病可能跑阳明，也有可能你发汗太多了，阳明病是你制造出来的。还有本身病人来的时候就是阳明症。如果太阳证没治好，你能够在阳明病治好，也很好。当太阳病没有好，进入阳明症，阳明症不会传经，到此为止。有的一辈子便秘没有事，有没有必要治好，当然有，看历史过去的医案，所有长命百岁的人，他过世以后，医学家解剖，按照现在的医学定义他有这个癌，那个癌，可是共同的结论是，这些人不是死在癌症，这些人死是老死掉了，看他们一生都生活很简单，所以，生活富裕没有关系，吃一定要简单，生病的时候五分饱，让刺激你的胃气，你不要吃太饱，平常吃七八分饱，不要吃十分饱。平常吃七八分饱，生病吃五分饱，硬逼你胃气，你会饿，多饿久一点，让身体自己会恢复，这都是阳明篇要介绍的。如果病能够阻止在阳明，他就好了。不要用很多仪器去挖病，就好像一张白纸，你硬要拧出一滴水，到时候纸烂掉了，太过度的检测，有时候要忽略掉，不要检测。中医认为，一个人能吃能喝，能拉能睡就好了。

阳明的时候，是纯热，纯实症，阳明无寒症。看不到里寒的症状。

### 第一百九十四。

原文：问曰：病有「太阳阳明」，有「正阳阳明」。有「少阳阳明」，何谓也？答曰：「太阳阳明」者，发汗脾约是也；「正阳阳明」者，胃家实是也；「少阳阳明」者，利小便，胃中燥实，大便难是也。

“「太阳阳明」者，发汗脾约是也；”这个阳明是在太阳表症失治以后，转成阳明的。“发汗脾约”，是因为发汗是用到肠胃的津液，肠胃津液的来源是脾脏，所以发汗太多脾脏会受到约束的。

“「正阳阳明」者，胃家实是也”本来这个病就发在阳明上。太阳转阳明的时候，按照伤寒论，还要一候，六天到七天。我们去吃饭，吃到味精，当天半个小时就变阳明证了，就是正阳阳明，味精很不好就是这个，哪有太阳症跳过去，直接变成正阳阳明，很不好，我就很恨这个。

“「少阳阳明」者，利小便，胃中燥实，大便难是也。”也就是说这个阳明症是由少阳症转过来的。

在太阳篇传经有两种可能，第一个阳明，第二个少阳。进入少阳以后，才有可能从少阳进入太阴，再到少阴，再到厥阴。如果直接传经到阳明的话，到此

为止。

## 5——6

阳明篇就是胃中燥实。讲到胃不单单是胃，阳明包含胃、十二指肠、小肠、大肠都在内，不单单是胃，里面有干燥的大便，是实症，大便难。这就是所谓阳明症。

第一百九十五。

原文：「阳明」之为病，胃家实是也。

太阳篇介绍过，如果是肠子下痢，肚子痛，黄芩汤。真正的胃痛黄连汤，胃炎，发炎。它不是实，它是热。阳明一直在讲实，他没有讲热。黄芩汤黄连汤都是去热的，发炎的病症的药。这讲胃家实，实就是有东西堵在里面。

有几种实症，比如印堂的痛，舌苔黄黄很干很燥。口很渴，想喝冷水。当肚子里面有实症的时候，一定是拒按，你按他的肚子一定会更痛，因为里面燥矢堵在里面会更痛。

头痛分三个。前额印堂痛就是胃家，阳明头痛。如果是两侧，偏头痛，就是少阳头痛。如果是后头痛，就是太阳头痛。如果头顶，正头顶百会痛，也是阳明头痛。所以从头痛也可以区分病在哪个地方。

第一百九十六。

原文：问曰：何缘转「阳明病」？答曰：「太阳」、「少阳病」，若发汗，若下，若小便利与亡津液，胃中干燥，因转属「阳明」，不更衣，内实，大便难者，此名「阳明」也。

阳明病是因为津液被伤到造成。“不更衣”就是便秘，过去人上厕所就要换衣服，不更衣就是不用上厕所。

当肠胃里面的津液受到伤害，不足的时候，产生的燥矢，一律称之为阳明症。

第一百九十七。

原文：问曰：阳明病，外证云何？答曰：身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。

阳明病外面看起来长什么样子呢？“身热，汗自出，不恶寒，反恶热也。”这里是说阳明是纯热症，看不到寒症的意思。

第一百九十八。

原文：问曰：病有得之一日，不发热而恶寒者，何也？答曰：虽得之一日，恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。

“得之一日”就是一候，六天左右。“恶寒将自罢，即自汗出而恶热也。”就是得了一天以后，有的人不发热而恶寒还有，意思已经过了一候，病要传经，一者完全好了，不然就是要传经。传经的话，如果“自汗出而恶热”代表病从太阳传到阳明去了，会有这种现象。这里一日并不是一天，是一候，等于是六天到七天。你白天开始算是六天，晚上开始算隔夜的话是七天，实际上是六足天。

第一百九十九。

原文：问曰：恶寒何故自罢？答曰：「阳明」居中土也，万物所归，无所复传，始虽恶寒，二日自止，此为「阳明病」也。

“恶寒何故自罢？”为什么有表症，一进阳明表症就没了。阳明病无所复传，因为万物所归，因为脾土肠胃的功能非常的强大，它能够消化任何东西，就像大自然界的土一样，能够承载万物。

病到阳明就停住了，停住不代表不去治疗他。大便很好，皮肤会非常的润泽，皮肤黑色出来，大便不好，肠胃不好。脸上阳明经很好，皮肤很好。

第二百条。

原文：本「太阳病」，初得病时发其汗，汗先出不彻，因转属「阳明」也。

这个条辨意思说，你要发汗就把病治好。如果你没有治好，并不是因为汗不透彻，而是过了六天了，过了一候了，他的太阳病并没有因为你的汤剂把他治好，这时候就算你不给汤剂还是会转阳明。

你怎么知道他太阳病好了，你用桂枝汤、或者麻黄汤、葛根汤，处方下去，第二天中午他胃口恢复，中午胃气从巳时到未时，胃气恢复，这个人就正常了。他汗出彻了，也不会传阳明了。

第二百〇一条。

原文：「伤寒」发热，无汗，呕不能食，而反汗出濇濇然者，是转属「阳明」也。

「伤寒」发热。无汗，麻黄汤症。病人呕不能食，看起来进入少阳症，而反汗出濇濇然者，是转属「阳明」，不是转属「少阳」。当有一个主症就可以用方子。

第二百〇二条。

原文：「伤寒」三日，「阳明」脉大。

过了三个候，有的一候，有的三个候。阳明症出现的时候，脉一定洪大。伤寒是浮紧。

第二百〇三条。

原文：「伤寒」脉浮而缓，手足自温者，是为系在「太阴」；「太阴」者，身当发黄；若小便自利者，不能发黄；至七八日，大便鞭者，为「阳明」病也。

“「伤寒」脉浮而缓，”照理伤寒应该是浮而紧。缓脉是胃脉，脾胃的脉是缓脉。四肢末梢手脚的温度也是胃气在管。病进入「太阴」者，身会发黄。

中湿之人，湿很盛的人，发表，没有加排湿的药在里面，表汗透出来了，里面的湿还有。

“「太阴」者，身当发黄；”太阴主腹部，应该是发黄。身上汗液，从胃到肠子里面，肠胃津液四散经过三焦油网，到皮肤表面，到毛孔，汗就排出来。汗的源头是肠胃的津液，经过三焦到皮肤毛孔排出去。平常中焦湿很盛的人，湿跟水

不一样，湿很粘稠，一般去湿的方法，湿没有用发汗的方法，一般都是利尿，湿在身上，发汗没有办法把它发掉。身上的水分是经过三焦的网跑到皮肤上面去。三角的网是黄油，鲜黄的颜色。三焦在管内脏的往来，能量，三焦是一个传达的系统。三焦无所不在，三焦一定有点油，所以三焦在跑的时候，有油跑的很快。人在死之前是油跑出来。三焦的油跑出来，粘哒哒的，这个人就差不多了。如果汗发掉，没有汗了，三焦的油就会跑到皮肤表面上。这个时候身会发黄，如果小便自利者，不能发黄，小便自利就是他的小便还很好，汗解并没有伤到他的津液，他津液自己会回头，所以我们常常看，吃麻黄汤不知道发汗有没有过，你打电话问他小便怎么样，小便不利，口渴，津液伤到了，吃点人参、甘草、生姜、大枣补补津液。

七八日，大便鞭，为阳明病，鞭就是硬。

第二百〇四条。

原文：「伤寒」转系「阳明」者，其人濇然微汗出也。

很多伤寒的人就会转成阳明证。伤寒的人是无汗的，发表下去，有时候发太过，就转阳明症。怎么知道他是阳明症，非常容易出汗，动一下就出汗。

第二百〇五条。

原文：「阳明中风」，口苦，咽干，腹满，微喘，发热，恶寒，脉浮而紧，若下之，胃中空虚，客气动隔。

很多人不晓得张仲景一再强调，攻下的时候，一定要确诊他是纯阳明证。如果有其他的症状，像口苦是少阳的症状，胆汁往上逆，小柴胡汤有口苦的症状，胸胁苦满。咽干，腹满，看起来像是阳明证，但腹满有虚症，有一肚子气在里面，排气的。微喘，发热看起来像是阳明症，但病人有恶寒。你不能确定他是纯阳明的时候，不要去攻下，一定要确定他是纯阳明的时候。你如果攻下，胃中空虚，这个胃不单单是胃，包括大肠小肠，中间空虚掉了，客气动隔，因为你一攻下里虚掉了。心肺为阳，横隔到肚脐是中焦，肚脐下面是下焦，如果从中焦分一半加上上焦是阳，下一半加下焦是阴，中焦在半阴半阳的中间。当你攻下以后，阳气会往下陷，阳气往下陷，不该呆在下面，阳气会回头，所以会震动，造成病人喘满的现象，这就叫做客气动隔。

第二百〇六条。

原文：「阳明病」，若能食，名「中风」；不能食，名「中寒」。

阳明病，如果能吃东西，就是中风，胃热还在。不能吃东西，就是中寒，胃寒，胃冷掉了。

第二百〇七条。

原文：「阳明病」，若「中寒」，不能食，小便不利，手足濇濇然汗出，此欲作「固瘕」，必大便初鞭后溏，所以然者，以胃中冷，水谷不别故也。

正常人喝水，胃的温度是正常的，喝进去的水到胃里就气化掉了。当吃的食物到胃里面，咀嚼，进入小肠进行消化，再到大肠，大肠的水再回到肺。这个条辨讲你的「阳明病」中寒，胃本来是冷到的，吃东西吃不下，小便不利，因为里



寒。「固瘕」就是水和食物统统混在一起，必大便初鞭后溏，就是因为胃中冷，胃中冷马上想到甘草干姜汤，吴茱萸汤，都治是胃寒的时候。不能食，吃不下东西就是胃寒。

这种中寒，胃家寒症的时候，喝进去的水，没有办法跟食物分开，水谷不别，这种下痢就比较顽固，我们要从胃的寒开始治疗，让他水谷能够分别，让他把痢才能治好。

阳明病都是热，他有寒的症状的话就会出现这种。

手足寒出，阳明热会手足寒出，胃寒也会手脚出汗。手足的汗肠胃在管。

第二百〇八条。

原文：「阳明病」，欲食，大便自调，小便反不利，其人骨节疼，翕翕如有热状，奄然发烦，濇然汗出而解者，此水不胜谷气，与汗共并，脉紧则愈。

胃里面的热除了能把水气化掉以外，同时能把食物咀嚼，弄碎，到小肠去消化，这是正常的胃。如果病人小便不利，骨节疼。人身上有津有液，这个液是食物吃到胃里面去以后，到小肠消化掉产生的液，液充足的时候，骨节可以屈伸，补脑。这个人吃了以后，小便不利，肠胃的功能还是不是很正常，没有办法把食物化成液，补到骨髓，才会有骨节疼的现象。

第二百零七跟二百零八一样，水和食物还是会混杂在一起，没有办法完全区分开。第二百零七条，大便初鞭后溏，大便从头到尾都是硬的才是正阳明。大便初鞭后溏，并不是正阳明，所以不可以攻。还有就是二百零八条，这种人小便不利，大便会自调。都不要攻它，都不是纯正阳明。从这两条得出的结果是，要攻下的时候一定要是正阳明。阳明实症才会去攻他。

第二百〇九条。

原文：「阳明」病，欲解时，从申至戌上。

卯和酉时就是阳明的时候。如果阳明病好了，好的时候一定是在申戌时。所以，反过来就是，阳明病还在的时候，这段时间一定特别难过。这段时间正好黄昏的时候，燥热烦热。

第二百一十条。

原文：「阳明病」，不能食，攻其热必哕；所以然者，胃中虚冷故也，以其人本虚，故攻其热必哕。

纯阳明实症的时候，胃的蠕动非常强，吃的很多。如果不能食，实际上他是寒症，你攻他的热。胃家是寒的，你不知道，以为他不能食是大便堵到了，太多了，不能吃东西了，实际上他不能吃的原因是胃里面太寒了，肠胃虚冷之下，你误诊，这是假热你攻他，胃气就没有了，会打嗝。

5——7

胃太冷的时候，想蠕动又不能蠕动，就会影响到中膈。有打嗝的现象出现。一般出现打嗝的现象就很危险了，所以一般治疗肝病，到后期病人开始打嗝，已经很危险了。大概一个礼拜之内就走人了。

## 第二百一十一条。

原文：「阳明病」，脉迟，食难用饱，饱则微烦，头眩，必小便难，此欲作「谷疸」，虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

阳明病，照理说是脉很洪大，因为是实症热症。

这一个条辨就是吃东西吃不饱。水的汽化是靠胃，谷的消化是靠脾。如果脉迟，食难用饱，吃一点点就撑到。「谷疸」，也是全身发黄的现象，腹满如故，这是全身伤到脾脏了。

阳明病如果病人大便不是很好，脉是迟的时候，治脾脏才对，不是治胃，谷的消化靠脾。这一段强调的意思是，如果不是阳明证，是肠胃功能不是很好，尤其脾脏功能消化不强的时候，“食难用饱，”你硬吃下去，会不消化，不消化的现象就是「谷疸」，造成腹满。脉迟就是里面比较冷。

阳明篇我们一定要确定他是有实症，大便堵到才会用攻下的方法，千万不要随笔攻下。

## 第二百一十二条。

原文：「阳明病」，法当多汗，反无汗，其身如虫行皮中状者，此以久虚故也。

阳明篇本身就是汗很多，因为是燥热的，结果这个人久虚了，这个汗没有透发出来，在皮肤的里面，肌肉的外面，造成如虫行皮中状者，皮肤很痒，这个跟运动流汗，突然跑到冷气间流汗是一样的意思。这是病人久虚，并不是阳明证。

所以如果看到一个人，汗没有透发出来，就算是阳明症，也是他本身是久虚，也可以当阳明症来看，不要说阳明证一定要有汗，因为这个人本来就是虚的。虚的人也会有阳明症的现象。如果体格很强的人得到阳明症，流汗就流掉了，他的体格比较虚，他得到阳明症的时候，汗没有办法透发，他的力量只能透到肌肉，没有办法从皮肤毛孔发出来，就出现身如虫行皮中状。

## 第二百一十三条。

原文：「阳明病」，反无汗，而小便利，二三日呕而咳，手足厥者，必苦头痛；若不咳，不呕，手足不厥者，头不痛。

阳明病都会有汗，他现在反而没有汗。而小便利，二三日呕而咳，呕的时候在少阳。咳嗽的时候在肺在太阳在上焦的地方，“手足厥者”手脚冰冷的，必苦头痛；这就代表还有其他的症，太阳少阳，不是纯阳明。如果是纯阳明痛的时候，头痛是在印堂的地方，如果有其他的头痛，属于少阳或太阳。阳明证有头痛，但是在阙上痛，阙上痛就是两眉之间的印堂痛。印堂痛中脘穴下去，一针痛就去掉了。胃的气，分清浊，清气上升，到胃的气街。胃在消化的时候，清气上升的时候，从胃到头这一段，称为气街。浊气下降到足三里（合穴）的地方。为什么要知道这个，当你的胃病，是吃东西吃坏肚子，得到的肠胃病，你得到的是浊气。浊气不会往上走，它是往下走，走到足三里。所以你吃坏肚子，扎足三里肚子很舒服，原因就在这里面。这里的头痛，如果是清气上升是不会头痛的，只有浊气上升。

看起来是阳明症，呕而咳，代表太阳证、少阳症没有去掉，一定会有头痛的

现象，手脚是冷，也就是说阳明证出现的手脚是热的，这个太阳表证并没有去掉。

#### 第二百一十四条。

原文：「阳明病」，但头眩，不恶寒，故能食；若咳，其人必咽痛，若不咳者，咽不痛。

阳明证没有寒症，看到的统统是热症。如果这个人又咳嗽，代表肺里面还有一点表证。当肺里面还有一些伤寒表症的时候，胃热会往上冲，这时会有喉咙痛。有时候去看病人喉咙痛，没有看到扁桃腺发炎，也没有看到很鲜，很暗红的喉咙发炎，这是胃的热气往上走，这个痛是燥热造成的。

#### 第二百一十五条。

原文：「阳明病」，无汗，小便不利，心中懊憹者，身必发黄。

无汗，小便不利，代表他津液不够了，三焦油网里面水没有了，这个时候情绪比较烦躁，身必发黄。这属于阳明症，津液不够了。

#### 第二百一十六条。

原文：「阳明病」，被火，额上微汗出，小便不利者，必发黄。

本来阳明症就是纯热症，津液不够才会造成，燥矢在肠胃里面，如果津液再丧失的时候，就会看到发黄的现象。

#### 第二百一十七条。

原文：「阳明病」，脉浮紧者，必潮热，发作有时；但浮者，必自汗出。

潮热都发生在黄昏，像潮水一阵一阵的来。只要有浮脉，代表表虚掉，毛孔打开来了。浮紧毛孔数束到的。阳明症都会有汗，很容易出汗的。

#### 第二百一十八条。

原文：「阳明病」，口燥，但欲漱水，不欲咽者，此必衄。

经方里面讲口渴，想喝水，但是不想吞下去，嘴巴漱漱吐出来，这种现象统是有淤血。唐容川讲，只要是口渴，不欲饮水，他是有淤血。意思是他燥热上去到鼻子，鼻子的血管很小，他的血一直冲上去，到鼻粘膜的时候，冲不过去，因为血量太大，血管太小，血管还没有破的时候，他就会但欲漱水，不欲咽者，等于是淤血。血管一破裂，鼻血出来，高热也推掉了，同时口渴现象也会去掉。

#### 第二百一十九条。

原文：「阳明病」，本自汗出，医更重发汗，病已瘥，尚微烦不了了者，此大便必鞭故也。以亡津液，胃中干燥，故令大便鞭。当问其小便日几行，若本小便日三四行，今日再行，故知大便不久出。今为小便数少，以津液当还入胃中，故知不久必大便也。

这个病人本来阳明病，已经汗出了，肠胃津液干了，结果医生更重发汗。如果他原来还有一些自汗太阳中风的症状，再给他发汗的时候，病好了。但是“尚微烦不了了者，此大便必鞭故也。”大便开始硬了。这里意思是说医生看他是阳

明病，阳明病就是有汗的，他看到有汗，桂枝汤，很自动的开桂枝汤，实际上已经进入阳明了。这个时候会造成大便更干。因为他亡津液，胃小肠里面非常干燥，所以大便便秘，大便里的水分，因为发表的药统统变的很硬。这个时候问病人小便一天几次，如果小便“日三四行，今日再行”小便并没有改变，所以我们常常会他小便。当你确定他津液有没有亡失掉的时候，你问他小便好不好，小便很好，你不用担心这个人的津液自己会回头。津液回来以后大便就软掉了，大便自己会出来。如果是小便数少，“以津液当还入胃中，故知不久必大便也。”

第二百二十条。

原文：「伤寒」呕多，虽有「阳明证」，不可攻之。

伤寒有呕的话一定在少阳。伤寒有少阳，病在太阳和少阳中间。不可以攻他，如果你攻他会有其他的变症出现。你看到少阳太阳的兼症出现，虽然有阳明症便秘，不要去攻他的大便，把他的表症先去掉再去攻他。如果你攻他，表邪下陷可能有结胸，结胸有寒实结胸，有热实结胸。

第二百二十一条。

原文：「阳明病」，心下鞭满者，不可攻之，攻之，利遂不止者死，利止者愈。

“心下鞭满者”胃非常硬的，不可以攻，这个攻是承气汤的攻。心下鞭满，硬的时候有大陷胸汤，跟大陷胸丸，大陷胸汤是往下走，大陷胸丸是往上走。不可以攻他，不可以用承气汤攻他，如果用承气汤攻他，利遂不止，津液会丧失掉，如果下痢不停，就是有危险。如果下痢自己会停，代表他自己会恢复，胃气会恢复，这没有问题。你不能确定他的时候，大便没有燥矢，千万不要攻。不要看到利不止你就站到旁边观看，你问他下痢下什么东西，如果是清谷，是里寒，白术、茯苓、白术去湿，茯苓利水出来，人参把他津液补足，炙甘草，这就是很好的处方，不行再加炮附子。

第二百二十二条。

原文：「阳明病」，发热，面含赤色，不可攻之。攻之，小便不利者，必发黄也。

「阳明病」本来就是纯热症，脸上有赤色的时候，代表津不足，津不足的时候，不要攻，攻之，小便不利。津不足，再一攻，津液更伤的时候，病人会三焦的黄你会看到。

攻他的时候有几种条件，像这种条件，你不要去攻他。

第二百二十三条。

原文：「阳明病」，不吐，不下，心烦者，可与「调胃承气汤」。

「调胃承气汤」在中脘穴到肚脐有压痛的时候，就是调胃承气。调胃承气为什么不吐不下，因为他堵到十二指肠里面，又吐不出来，因为它不在胃里面，又下不去，它不在小肠里面。梗在这个中间，造成很心烦。调胃承气汤用炙甘草，大黄还有芒硝，大黄是用酒洗过，酒洗过它攻下的力量就没有那么快，大黄芒硝速度本来是很快的，结胸的时候用大黄芒硝跟甘遂，如果同样大黄芒硝，我们用炙甘草就变成调胃承气汤症，专门清这一段，炙甘草能够让大黄芒硝速度没那么

快，停在中间十二指肠的地方。如果光是大黄跟芒硝下去，没有炙甘草在里面，这一段清不出来的，大黄芒硝多块，一下就透过去了，跑到小肠大肠去了，结果大便是出来了，胃还是梗到，宿食还是在里面，没有清掉。诊断的方式就是中脘到肚脐这一段拒按，有压痛，这是有东西堵在里面。

## 第二百二十四条。

原文：「阳明病」，脉迟，虽汗出，不恶寒，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。手足濇然而汗出者，此大便已鞅也，「大承气汤」主之。若汗多，微发热恶寒者，外未解也，其热不潮，未可与「大承气汤」。若腹大满不通者，可与「小承气汤」，微和胃气，勿令大泄下。

“「阳明病」，脉迟，虽汗出，不恶寒，其身必重，短气，腹满而喘，有潮热者，此外欲解，可攻里也。”意思是说，一定要等外解掉了，再去攻里，这个是外证要解掉了，本来是恶寒现在不恶寒了，汗出了，外证还没有完全去的时候，会有身重的现象，但是他已经在出汗了，脉缓下来了，代表他自己会恢复的状态。有潮热是阳明症，前面告诉诸位太阳证要去掉了，阳明证要出来了，这个时机就可以攻里。如果手脚汗出，这个潮热，知道大便已经硬掉了，「大承气汤」。

在介绍这一段的时候，我从金匱抓几个方子来，就会比较完整，整个消化系统你从此就不会犯错了，我现在讲的是实，没有讲热，热就是发炎，你不要胃炎，肠胃炎也拿来，不行的，不能乱攻。这是实证。在金匱里面有个处方，叫大黄甘草汤，这个使用时机是，在胃里常常会有二斗，在灵枢第三十一篇，肠胃篇里说，吃饱是下去的时候，胃里面是三斗二升，胃底下常常会有二斗，胃下方这个食物可以等七天，但是如果这个食物坏死掉了，吃到不干净食物，怎么清楚它，就是大黄甘草汤，你怎么知道是坏死的食物？朝食暮吐，早上吃进去，黄昏吐出来，就代表食物在胃里面并没有消化掉。经方有两个地方朝食暮吐，一个是虚症，胃虚的时候，朝食暮吐，吴茱萸汤症，胃寒的时候会用到。这是实证，胃家实证，阳明证第一方应该是大黄甘草汤，朝食暮吐，舌苔一直是黄的，胃恶心，所以吃坏食物的时候，经方开出来的时候，就是大黄甘草汤，两味药而已。

第二个才是到十二指肠这边，这个才是进入到调胃承气，调胃承气就是吐，吐不出来，幽门挡到了，梗到中膈的位置，调胃承气出现的时候，在下脘建立水分的地方一定有压痛，梗到这边，心里很难过，知道里面有东西梗到，有实的时候持续二十四小时，如果是虚的话，他就会有时候很好，有时候不好，实症梗到不管白天晚上都不舒服。你问病人也问出来，你看他舌苔是黄的干的，你问他，胃痛，肚子痛是断续的痛还是持续的痛，持续的痛，结实了，因为他舌苔很黄，你摸他的脉，结实的脉很强硬。这个时候就是调胃承气。调胃承气有炙甘草，大黄，芒硝。

如果到了小肠，小肠堵到，实发生在小肠里面，你怎么知道是发生在小肠里面？张仲景这里说，腹大满不通者，可与小承气汤。小承气汤是解阳明的燥矢，大便堵在小肠里面，病人有个主要的症状，就是排气，你问他便秘实不实，便秘肚子胀满，一直不断的放屁，因为大肠没有堵到，大肠里面是空的，堵到小肠里面，大肠空的很多气在里面，他就不断的放屁，这个屁是从大肠出来的。不断放屁，脉很实，舌苔很黄，又是持续的痛，你压肚子，很痛拒按，就是小承气汤。小承气汤里又大黄，厚朴，枳实。

第四个，如果是堵在大肠里面。

5——8

也是腹满，没有大便，堵在大肠里面是用大承气汤。大承气汤又四味药，大黄、芒硝、厚朴、枳实。如何判断是堵在大肠里面，问病人便秘多久？七天没有大便，小便是黄的，任何的阳明燥实，小便一定是黄色的，因为燥热，小便很黄，屁也不放一个，这个就是大承气汤症了。因为他大便统统堵到干掉了，根本连气都排不出去了，这是大承气汤症。

经方有几个地方，一个是没有放屁，屁没有了，还有如果排出来大便是像鞭子一样，原因是你的大肠有很多干燥的大便在周围，只有中间可以通过，排出来像一根长鞭一样，也是大承气汤症。还有一种，大便很大一个，只有旁边有一个小缝，只有水可以通过，糟粕没办法通过，这个时候，病人一天十几次下痢，你一摸肚子是硬的，你问小便是什么颜色，深黄色的，肚子拒按又非常硬，这个下痢是因为便秘引起的下痢。大肠的时候，你在大肠的募穴天枢穴，可以找到压痛点，小肠的话是小肠的募穴关元穴，可以找到压痛点。所以当排气都没有了，完全堵到，大承气。大便长长一条，也是用大承气。下痢不止也是用大承气。这是几个大承气汤。

如果说大便是梗到阑尾了，你怎么知道他梗在这个地方？急性盲肠炎发的时候，因为盲肠刚好足阳明胃经经过这个地方，有盲肠炎出现脚会弓起来，右脚弓起来会比较舒服，所以他来看你的时候，右脚是弓到的。他右脚弓起来，肚子痛会减缓，缓冲一下，你压他足三里下一寸，阑尾穴，阑尾穴压到，他有压痛，再加上他脚弓起来比较舒服，我们就很肯定他是盲肠炎。这个时候用大黄牡丹皮汤。经方拿到手上，不要担心不要怕，一定要有信心。你说，老师西医说肠破裂化脓就死人了，很危险，还是给西医开刀。不要，盲肠还是有用的，介绍金匱会讲，虽然小小一段盲肠，还是很管用的。大黄牡丹皮汤专门清这个阑尾发炎的地方。阑尾发炎大部分痛在孕妇，有的还痛在左边，脚还是弓到，脚弓到是一样的。大黄牡丹皮汤重用大黄，一剂下去全部清出来了。“老师，如果太慢了？碰，破掉了，我怎么知道，他破掉了？”很简单，原来他肿胀堵到里面，不断的痛，不断的加强，瞬间他痛去掉了，不痛了，你摸他这个地方，非常的烫，其他都是冰的，你知道他破裂了，破裂转腹膜炎，你如果给西医治疗，不断的用抗生素。中医这个就不用大黄了，用当归赤豆散，就当归跟赤小豆两味药，你用当归赤豆散的时候，赤小豆一定要发芽，所以我们平常把赤小豆发一些芽放到那边冷藏，预备一些。发芽的赤小豆我随时准备着。只要他发芽发的跟豆芽一样，就给他冷冻那边。当归赤小豆，赤小豆一定要发芽的。当归赤豆散不单单用到肠子破裂，胆如果胆结石堵到，里面胆囊破裂的时候一样的症状，本来是剧痛，瞬间痛去掉了。破裂以后腹膜会把它包住，他不会散乱，为什么赤小豆发芽才会好，取他的药性，本来是一根，破裂以后，腹膜把它包住是这个形状，赤小豆发芽后一根一根可以伸到很深的地方去。当归赤小豆就两味药，不用煮，当归跟赤小豆打在一起，粘哒哒的就吃下去，跟生菜沙拉，效果非常好，吃下去他就可以动，原来不能动，他躺到那不动就不痛，一动就痛，因为腹膜炎。

还有一个情形，妈妈回家，儿子躲到哪吓她，有的人是发奔豚，有的不是，大便秘到这边，大肠这边有一个血管，直接络到肝脏，一紧张，干燥的大便顶到血管这边来，当干燥大便顶到这边，有一个特殊的症状，叫肠子中间有水气。病

人便秘，这个地方痛，你压他肚子，一压咕噜咕噜水声很多，不是大承气，也不是小承气，这是受惊吓发的，用己椒茱萸黄丸，防己、椒目、葶苈子、大黄，做成丸剂，外面三钱的芒硝在汤里面，丸剂吞下去，芒硝汤冲下去，把这个大便打掉。一打掉整个大便大下。但是这个一定要用丸剂。

当你堵在大肠里面，兼有恶心的时候，就是大柴胡汤症，阳明症不会有恶心。大柴胡汤会用大黄，什么时候会柴胡汤加芒硝，就是屁都不放一个，就要加芒硝，这个知道燥矢的大便秘到大肠里面了，梗到直肠那边了。

还有一种情况也是用丸剂，他跟小承气互为表里，小肠堵到的时候，小肠津液没有了，我们用小承气，还有一种是脾约，麻子仁丸症，麻子仁丸症是小肠堵到，小肠比较小，一节一节，大便堵到排出一粒一粒的，麻子仁丸症大便像羊便一颗颗排出来，这就是麻子仁丸症。你用麻子仁汤不行，必须要用麻子仁丸，丸剂下去，这个能够增润津液，大便排出就正常了。中医光是一个便秘肠胃就分这么多处方，实证，燥矢的话就是这样子，全部是用大黄。这样就不会辩证错误。至于剂量多少，后面会介绍。

如果你很了解这个病，你把病挡在这个肠子里面，病在阳明就走掉了，病就不会传。

还有一种不是用大黄，堵在盲肠这个地方，大肠头这边，这个病人陈述，大肠盲肠这边，很多食物堵在这边，压这里会痛，这一块地方出现问题就是薏苡附子败酱散，这个是在金匱里面。病人右下腹痛，不是很强的痛，隐隐作痛，也是拒按，你问他用不用脚弓到比较舒服，他不用，薏苡附子败酱散专门清大肠头这一块的东西。这一块破裂堵到的时候，手上左手的生命线有一个开心果那么大的紫斑。

只要是实证，都是持续的痛，不会断续的痛实证出现的时候，病人是拒按。实证出现病人会比较阳亢，讲话声音比较大，比较烦躁焦虑，睡不好。阴证出现的时候，比较缓慢，沉静。

小承气没有芒硝，调胃承气和大承气有用芒硝，大黄甘草汤也没有芒硝。攻下的药最强的就是大承气汤。芒硝不单单是攻坚硬的大便，芒硝攻肿块，积聚，癌症肿瘤都可以攻。炎症脓痒化脓积水统统可以使用芒硝。使用芒硝跟大黄的时候，芒硝都不煮很久，煮芒硝成盐巴了，完全没有攻下的力量。中药生用的时候比较强。

#### 调胃承气汤方

大黄四两去皮，清酒洗。甘草二两炙，芒硝半斤。

右三味，以水三升，煮取一升，去滓，纳芒硝，更上火微煮令沸，少少温服之。

大黄四钱，用清酒洗，你不要真的酒洗，意思是泡一下酒就可以了。大黄酒洗过后药性比较缓，甘草两钱，芒硝一般两钱。煮的时候，先煮甘草，大黄，最后再放芒硝，稍微煮一下让芒硝能化掉。单味大黄非常好用，没事眼白忽然血出来，或者没事流鼻血，上焦比较热的时候，用大黄泡茶，很快就消掉了。

#### 小承气汤方

大黄四两酒洗。厚朴二两炙去皮。枳实三枚大者，炙。

右三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服，当更衣；不尔者，尽饮之；若更衣者，勿服之。

大黄四钱。厚朴两钱。枳实三钱两钱都可以，枳实就是橘子，小橘子，淮河以北产的橘子叫枳实，淮河以南叫橘子，枳实小小的像金桔一样。厚朴是取树的皮，本来厚朴是生的，炙过干掉，二两比较轻。主力还是大黄。

我介绍的阳明实症里面用的大黄，其他地方我们也会用到大黄，因为不在这个篇里面，就不讲了。

现在主要讲阳明热实，肠胃的燥实为主，才会有一系列肠胃从胃到肛门口大便怎么出去。

临床上很多地方在使用大承气汤。我们也曾经用过梅毒，病人来的时候，西医讲的梅毒，可他陈述出来七天不大便了，屁也不放一个，小便很黄，大承气攻下去，梅毒也好了。所以我常跟诸位说，要离，离卦，中间是虚的，心里面要不着相，不要被病名绑住。

## 第二百二十五条。

原文：「阳明病」，潮热、大便已鞣者，可与「大承气汤」；不鞣者，不可与之。若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与「小承气汤」，汤入腹中，转矢气者，此有燥屎，乃可攻之，若不转矢气者，此但初头鞣，后必溏，不可攻之，攻之必胀满，不能食也，欲饮水者，与水则哕。

「阳明病」，潮热，潮热就是一阵一阵的热，阳明病潮热一定在黄昏的时候。阳明证有两个，一个时候腑实，一个是经热。承气汤症就是腑实，腑就是胃胆大肠小肠膀胱此类，经热就是在阳明经上的燥热。经热是白虎汤症。阳明讲的就是白虎和承气。承气会用到大黄和芒硝，白虎汤会用到石膏。

潮热的时候病人有壮热，壮热就是发高烧，你只有两剂。一个是大便的燥矢造成的高热，还有一个是大便很通畅，经热也会有壮热。所以你只要确定他有没有大便，如果实在不知道看小便。经热的话小便是白的，腑热大便燥结在那边，小便是黄的。承气汤症小便是很深黄的。或者他一直在放屁，小承气汤。你只要确定他是承气汤症，快下，一剂就够了。

“大便已鞣者，可与「大承气汤」；不鞣者，不可与之。”你确定他是大承气汤症，你只有大承气唯一处方，不要再去考虑其他了，大承气汤完全不放屁。

“若不大便六七日，恐有燥屎，欲知之法，少与「小承气汤」，汤入腹中，转矢气（放屁）者，此有燥屎，乃可攻之，若不转矢气（放屁）者，此但初头鞣，后必溏，不可攻之，攻之必胀满，”这里告诉你，你如果开的不是大承气，开的是小承气，大便没出来，一直在放屁，你知道错了，大承气汤。真正临床你只要问他有没有屁，没屁就是大承气讲完了。阳明燥热一定是舌头很黄，严重的话很黑，而且很干。黑有两种，一种舌苔，很寒，寒到极寒的时候舌苔也是黑色的，但是这个黑有润泽有津液。大承气汤那个黑根本就是干掉了，一摸脉脉跳的很大很数，再一摸额头，全身发烫的，眼睛都往上翻的。



这个症状，前面是硬的后面是溏，代笔这个人肚子里面是寒湿的，大承气汤有大黄芒硝都是寒凉的药，本来已经溏了，溏就是有寒湿在里面，寒凉药再下去会加重，所以攻之胀满，不能吃东西了，欲饮水者，与水则哕。他想喝水，胃里面太冷了，喝水下去就打嗝。严重的话可以用茯苓四逆汤。如果攻下去他只是气很多，肚子胀满，排气很多，用厚朴生姜半夏人参甘草汤，如果是人体虚掉了以后，人非常虚，或者被你攻下，你也可以用理中汤。甚至他说胃口没了，吃东西都不能吃了，小建中汤也可以，小建中汤里面重用白芍。

打嗝很严重，但是你不能看到打嗝就不治了。中医经常说，男怕脚肿，女怕头肿。不能说很危险不治了。

第二百二十六条。

原文：夫实则谵语，虚则郑声，郑声，重语也。

“郑声”根据我的想法，郑声当年小国家里有个郑国，可能那个国家人很喜欢讲话，所以形容郑声。谵语就是乱讲，胡说八道。

这里就是闻诊，听。

谵语和郑声是区分虚实的时候。实症的时候要攻坚攻下，虚症的时候要补虚，像附子理中汤，茯苓四逆汤都可以。

第二百二十七条。

原文：谵语，直视，喘满者，死；下利者，亦死。

如果这个人讲话已经胡言乱语了，同时出现直视，喘满者死症，下痢者，也是死，意思就是阳要脱了。

阳绝的时候，一直往上升，眼睛往前呆呆的看，已经没有神了，喘满，呼吸非常的短促，咳嗽都属于喘满，就是死症，还有下痢也是死症，代表人阳往上。正常人阴阳互相协调的，孤阴不生，独阳不长。正常人上面是阴，下面是阳。阳绝的时候，阳就没有办法把阴固住，皮肤固表，就是阳。阳没有了阴就往下走了。控制不住了，下痢则死。如果有人上吊，大小便还没出来，代表人还有救，如果大小便出来就完了。下痢则死，因为阳绝了。

第二百二十八条。

原文：发汗很多，若重发汗者，亡其阳；谵语，脉短者，死；脉自和者，生。

发汗很多，若重发汗者，亡其阳；津液不够了，发汗太多，肠胃里面的津液被发掉了，才会造成燥矢。桂枝汤发出来都是流出来肠胃的津液。一般用炙甘草不太容易造成，因为桂枝汤有炙甘草，红枣。可能用麻黄汤葛根汤才会有这种嫌疑。脉短者，死；短脉就是阴脉，代表里面已经没有办法自己回头了。不会自己痊愈就很危险了。

第二百二十九条。

原文：「伤寒」，若吐，若下后，不解，不大便五六日，日晡所发潮热，不恶寒，独语如见鬼状；若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，微喘，直视；脉弦者生，濇者死。微者，但发热，谵语者，「大承气汤」主之，若一服利，止

后服。

「伤寒」就是麻黄汤症，表实，而且寒，恶寒怕冷，全身痛。应该发表就好了。若吐，若下后，不解，不大便五六日，日晡所发潮热，不恶寒，代表表症没了，即使你是不对症，应该用汗法，结果你是用吐法下法，病还是会入里，因为你误治了，不大便五六天，失治以后传到里面去了，不恶寒，阳明无寒症。独语如见鬼状；若剧者，发则不识人，循衣摸床，惕而不安，遇到这种知道是实证。微喘，直视；脉弦者生，濇者死。就是津液伤到了，阴虚掉了，用承气汤，可以用些补阳滋阴的药，肉苁蓉是很好补肾阳的药，肉苁蓉有仁在里面，又可以滋阴。再加些人参都可以。微者，但发热，谵语者，「大承气汤」主之，若一服利，止后服。意思是大承气汤症，大便一通出来，可以停掉。但是这个讲的是汤剂。你如果用的是粉剂，出不来的。应急的时候非要用汤剂。

承气汤的时候，芒硝除了把大便燥矢打碎，最主要攻坚，包括肿瘤大肠癌，肿块或者是痰水梗在里面，大陷胸汤痰水梗在里面很硬很强，里面有芒硝。

第二百三十条。

原文：「阳明病」，其人多汗，以津液外出，胃中燥，大便必鞕，鞕则谵语，「小承气汤」主之。若一服谵语止，更莫再服。

胃中燥，包括肠，不单单是胃。大承气跟小承气的区分就是，小承气有放屁，大承气没有屁，小承气在腹部的胀满。大承气在天枢穴会找到压痛点。两个都有燥矢在里面，但是一个是小肠一个是大肠。

第二百三十一条。

原文：「阳明病」，谵语，发潮热，脉滑而虚者，「小承气汤」主之，因与「承气汤」一升，汤入腹中转矢气者，更服一升；若不转矢气，勿更与之。明日不大便，脉反微涩者，裏虚者，为难治，不可更与「承气汤」也。

“脉滑而虚者”病人应该是脉实的，结果病人脉滑虚，虚脉就是你按下去脉就没有了。

这个条辨是当你看到病人大便不出来的时候，承气汤下去，大便没有排出来，就不要给他了，等下看看情形。隔天还是没有大便，摸他的脉，里虚了，只是难治而已，不是不治。可以把里虚补足，用一些补阴的药，不要再给他承气汤了，里虚再给承气汤会更虚。

第二百三十二、二百三十三条放在一起。

原文：「阳明病」，谵语，有潮热，反不能食者，宜「大承气汤」下之，胃中必有燥屎五六枚也；若能食者，但鞕耳，宜「小承气汤」。

这个条辨是用能吃和不能吃决定是给大承气还是小承气。这样子也可以作为诊断依据。

不能吃东西大承气，肠胃堵到了，干燥大便往回逆，不想吃东西。大承气的症状比小承气严重很多。

第二百三十四条。

原文：「阳明病」，下血，谵语，此为热入血室，但头出汗者，刺「期门」，随其实而泻之，濇然汗出而愈。

“热入血室”血室就是女子胞，子宫，男人下腹部。不会下期门，热入血室，小柴胡汤。如果便秘，大柴胡汤。如果病人纯热证，大便很好，白虎汤，大便便秘，小便黄用承气汤就可以。

#### 第二百三十五条。

原文：汗出，此为风也，谵语者，以有燥矢在胃中；此表虚里实故也，须下之，下之则愈，宜「大承气汤」。过经乃可下之，下之若早，语言必乱。

（在6——2集最后补讲）汗出，有流汗就是风。谵语者，以有燥矢在胃中，这个胃就是肠子里面，里实。“过经乃可下之”过经，就是从太阳到少阳到阳明就是过经，过经就是纯阳明症出现才可以下。有少阳症出现要先解少阳。解完太阳少阳的时候，这个时候叫过经。单纯的阳明症再去攻下。如果下太早，攻下他本来就已经津伤了，一攻下表邪又跑到里面来，里面大便被攻掉了，里面是虚的，表邪跑到里面来，也会造成言语必乱讲话不是很正常。跟谵语不太一样。

#### 第二百三十六条。

原文：「伤寒」四五日，脉沉而喘满，沉为在裏，反发其汗，津液越出，大便为难，表虚里实，久则谵语。

伤寒失治的时候，这个病人一半在太阳症，一半要进去了，脉沉下去了，已经往里跑了。反发其汗，变成阳明的燥矢症。阳明证是但热不寒。桂枝汤症很少成承气汤，因为桂枝汤里又炙甘草、大枣、生姜，不容易造成，一般伤寒容易造成。

#### 第二百三十七条。

原文：「三阳合病」，腹满，身重，难以转侧，口不仁而面垢，谵语，发汗则谵语甚；下之，则额上出汗，手足厥冷，遗尿；若自汗出者，「白虎汤」主之。

「三阳合病」太阳、少阳、阳明合病。前面介绍，三阳合病的时候，和解少阳，用担法。如果看到病人有太阳表症，又有少阳往来寒热，胸胁苦满，又有阳明症的大便不通，然后又有太阳症，这个时候你用小柴胡汤。

#### 6——2

你不要管他大便，什么都不要管，就用小柴胡汤。小柴胡汤三阳并病的时候唯一的处方。

“「三阳合病」，腹满，身重，难以转侧，口不仁而面垢，谵语，”当阳明有燥矢的时候，阳明有热的时候，脸上的气，光鲜亮度统统会干掉，像有灰尘在上面。如果这个人精神很好，大便很好，身体没有不舒服，脸看到灰灰的，这是准备坐牢，或刚从牢里出来，或正在坐牢。这个腹满，谵语，面垢看起来，以为是燥矢，你不知道他不是，他是里面虚掉了，你再去攻他，手脚四肢冰冷，遗尿，下痢遗尿大便出来都是危险的症状。若自汗出者，白虎汤主之，自己流汗出来，代表虽然攻下了，但是病人没有伤到，津液慢慢回头，这个时候白虎汤。白虎汤救逆也可以用，肠胃津液不够用白虎汤。

## 第二百三十八条。

原文：「二阳并病」，「太阳证」罢，但发潮热，手足濇濇汗出，大便难而谵语者，下之则愈，宜「大承气汤」。

可能太阳少阳，或者少阳阳明，太阳阳明。「太阳证」罢，因为二阳有一个太阳，太阳症没了，表症没了。手脚汗出很多的时候，实症，里面确定是阳明燥矢造成的手脚汗多，这个时候可以开大承气汤。如果手脚汗多，他不是承气汤症，是里虚的时候，你可以开桂枝汤，有汗，太阳在表，加一些龙骨牡蛎，收敛一下他，让阳潜下去。

## 第二百三十九条。

原文：「阳明病」，脉浮而紧，咽燥口苦，腹满而喘，发热汗出，不恶寒，但恶热，身重；若发汗，则燥，愠愠及谵语，若加烧针，必怵惕烦躁不得眠；若下之，则腹如故，小便难也。

脉浮而紧，伤寒会脉浮紧。咽燥口苦，少阳症。腹满而喘，阳明承气汤会有喘。

## 第二百四十条。

原文：「阳明病」，心中懊憹，舌上胎者，宜「栀子豉汤」主之。若渴欲饮水，口干舌燥者，「白虎加人参汤」主之。若脉浮发热，渴欲饮水，小便不利者，「猪苓汤」主之。

“心中懊憹，”胃里面很难过。栀子专门去上焦的虚热。渴欲饮水，口干舌燥，白虎加人参汤。渴欲饮水，小便不利者，猪苓汤。

### 猪苓汤方

猪苓一两去皮。茯苓一两。阿胶一两。滑石一两碎。泽泻一两。

右五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，纳下阿胶烊消，温服七合，日三服。

都是一两，等量。猪苓汤出现的时候，一定小便痛，膀胱炎或者是尿道结石，肾结石的时候，会用到猪苓汤。

滑石，按照本草也是攻坚的，把石头打烂通利出来。在通利的时候，从肾脏到膀胱，中间还有输尿管，那个石头很锋利，会把尿道刮破，小便就带血，痛。阿胶放里面，阿胶止血。茯苓能利中焦的水，猪苓能利下焦的水。泽泻是上焦。全身水都往下走，把全身的水集中下来，用滑石打下来再用阿胶止血。这个方子根本就是肾结石，膀胱结石在用的。结石以外，只要病人出现渴欲饮水，小便不利，统统可以用。五苓散小便不利也可以用，可是五苓散用在时疫，经方有发表的药，你公开发表的药，剂量不够，汗发出去的时候，肠胃本来该发到皮肤表面上，结果你开的剂量不够，一部分出了表面了，一部分停在肌肉皮肤中间，五苓散是收表水，表面的水没有透发的时候，五苓散把它收集起来小便排掉，猪苓汤直接攻下。五苓散有桂枝，就是强心阳，希望能够解肌，把药带到皮肤表面上。白术收敛它的湿。

猪苓汤，四碗水煮成两碗。再放阿胶。服七合就是，一碗你喝七分就好了，不用全部喝掉。阿胶如果说是一钱，四碗煮两碗，一碗只有半钱的阿胶。这个是原来的方剂。如果有病人，肚子痛的要死，不知道是肾结石还是大便堵到，所以介绍针灸的时候就讲，如果遇到结石的时候，在脚的内踝落，太溪穴到复溜穴会找到结石的压痛点，结石痛的时候非常的痛。如果懂针灸，用手压到痛点，针扎到痛点的时候，痛就去掉，病人会感觉石头在动，一直在移动。药房煮猪苓汤再攻，有时候用药丸丸剂也可以。急的时候汤剂，不急的时候丸剂就可以。阿胶烊尽的时候，病人排尿石头下来，病人一滴血都没有。这是绝对比例。

五苓散和猪苓汤不一样的，五苓散要大剂的利尿，所以重用泽泻。猪苓汤剂量统统一样。肾结石，膀胱结石都可以用，病人只要小便滴滴答答不通，就可以用。小便痛排不出来，里面是石，或者是尿道炎，或者是淋病，无所谓攻。

第二百四十一条。

原文：「阳明病」，汗出多而渴者，不可与「猪苓汤」，以汗多胃中燥，「猪苓汤」复利其小便故也。

这是一个原则，如果真有小便不利，是因为堵到东西的话，你要用猪苓汤，把它清出来，我们叫急下存阴。这里确定病人津液很伤的时候，不要再给他猪苓汤，因为猪苓汤会把小便利出来。

第二百四十二条。

原文：脉浮而迟，表热裏寒，下利清穀者，「四逆汤」主之。若胃中虚冷，不能食者，饮水则哕。

四逆汤专门用在里寒的时候用的，如果病人里寒，胃是冷的，再喝水下去，会打嗝的更厉害。如果病人口渴，给病人喝水，一喝的时候，病人打嗝，代表胃里面寒掉了。承气汤症绝对不会你喝水下去会打嗝。里寒的时候才会打嗝。

第二百四十三条。

原文：脉浮，发热，口干，鼻燥，能食者，则衄。

能食者，代表胃里面没有问题，在经热上，代表腑没有问题，承气汤不需要，他还能吃嘛。鼻子干燥，肺主鼻，这个会流鼻血，这个都在肺上面。

如果病人有发热的现象，一流鼻血烧就应该退掉。如果病人没事一直流鼻血，又没有发烧，可能是鼻炎癌，或者肺癌之类的。

第二百四十四条。

原文：「阳明病」，下之，其外有热，手足温，不结胸，心中懊憹，饥不能食，但头汗出者，「栀子豉汤」主之。

这里有个饥不能食，栀子豉汤。因为里虚掉了。虚热的时候就会有这种现象。还有一种，饥马上就要吃，如果不吃冷汗就冒出来，手发抖，白虎汤症，肚子一饿，马上就要找东西吃，白虎汤症。出现嘴巴渴，大量喝水，喝完水小便又很多，小便完又继续喝水，这也是白虎汤症。能吃东西是小承气，不能吃东西是大承气，那是燥矢结到了。这个是虚热，就可以用栀子豉汤。失眠病后调理身体都可以

用。

## 第二百四十五条。

原文：「阳明病」，发潮热，大便溏，小便自可，胸胁满不去者，「小柴胡汤」主之。

「阳明病」，发潮热，黄昏就开始潮热。大便溏，大便硬才是对。百分百是阳明证，才使用承气汤，有一丝牵扯到其他地方，就不要用大承气，先去解其他的病。胸胁满大便溏，这个时候用小柴胡汤给他。如果大便硬，胸胁满就是大柴胡汤。

我希望你们先不要去看其他东西，不要去学其他东西，把经方金匱统统学完再去看其他东西，不会迷茫。诸位一定要学会绝对处方，这个处方不需要你改变的。

## 第二百四十六条。

原文：「阳明病」，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与「小柴胡汤」，上焦得通，津液得下，胃气因和，身濈然而汗出解也。

“「阳明病」，胁下硬满，不大便而呕，舌上白苔者，可与「小柴胡汤」，”这不大便而呕，看起来像大柴胡，实际上大柴胡也可以用，这里为什么写小柴胡，我也不是很了解，看起来像大柴胡，如果是我碰到这个，我一定是给大柴胡，可能是小徒弟摔倒竹筒搞错了。

一般来说，我们吃了药以后，流了汗出来，这个汗是微汗，你摸上有点湿湿的，不是大汗。病解的时候，一定是微汗出，或者是胃口恢复了，大小便正常。

## 第二百四十七条。

原文：「阳明中风」，脉弦浮大，而短气，腹满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，嗜卧，一身面目悉黄，小便难，有潮热，时时哕，耳前后肿，刺之稍瘥。病过十日，外不解，脉续弦者，与「小柴胡汤」。脉但浮，无余证者，与「麻黄汤」。若不尿，腹满加哕者，不治。

脉弦浮大，弦是少阳的脉，浮是表症，大是阳明热症的脉。所以少阳阳明太阳都有。

比如有病人肝癌，他就是腹满，心痛，鼻干不得汗，正常人早上起来抹鼻子油油的，实际上这个是三焦气机很流畅。鼻子都灰尘污垢，出来你去坐牢压力很大，还有就是胃气没了。

“耳前后肿”耳朵一圈是少阳，耳朵后面骨头，我们有骨三阴，身上有三个阴骨，耳朵后面这个大骨头，头顶的骨头，就是小时候收起来的骨头，膝盖的骨头，叫做三阴股。

阳明的中风，耳前后都肿，我们身上三个阴骨，一个是泥丸，就是卤骨。

6——3

小孩子两三岁这个骨头开始收。第二个就是耳后高骨。第三个就是膝盖骨。

过去，我们知道有这个东西，没有很肯定，后来黄帝外经出来就看到了里面写的骨三阴。临床上怎么解释？如果光看这个不知道它是做什么，曾经治疗血癌的时候，小朋友做化疗骨髓移植，结果做完西医宣布无治了。无治以后来找我了，给他吃中药，两个礼拜之后，小孩子胃口也开了，元气也恢复了，再回去一查，没有血癌。没有血癌的时候，西医说是他骨髓换的有效，你已经换了半年前了，做了化疗没效到我手上来的，病人快死了。结果病人家属倾向西医，又找西医治疗，到十一月的时候，有一天突然小朋友，耳朵后面高骨，肿起来一大块，这是骨三阴，代表病进入阴了，这很危险的症状。耳前后肿，小孩子受惊吓的时候，耳朵后面又鸡爪的血脉，刺刺放点血，受惊的时候可以用。

骨三阴如果出现在实症的时候，代表阴实，为什么会造成阴实？我告诉他爸爸，感冒的时候一定要吃中药，绝对不可以吃抗生素，结果小孩子感冒，吃两个礼拜抗生素，吃完以后骨头就肿起来了。阴骨肿起来，病到阴实。

病进入阴实的时候，阴里面积实的时候，实症在里面。阳明证是阳实，简单讲就是大便堵在肠子里面而已。很好处理，当人你处理不好也会死。大肠癌是不会死人的病，但是大肠癌你开刀，大肠癌手阳明大肠经阳明经，开刀以后大肠癌移转，大肠癌如果承气汤，大柴胡汤去攻的时候，芒硝可以攻坚，肿瘤可以打开，再严重里面结石很盛的话，大不了用巴豆，如果开刀，移转变成肝癌。从阳明证变成厥阴症，死掉了。临床上西医没有开刀，可以救的回来。动了刀以后，跑到肝里面去的时候，就看运气了。

“腹满，胁下及心痛，久按之气不通，鼻干不得汗，”这是很危险了，肚子胀，里面阴实结到，一身面目悉黄，眼睛都是黄的，小便难，有潮热，时时哕，常常打嗝。看起来像阳明症，实际上，里面阴实结到了。耳前后肿，代表病已经入阴了，有的人在头顶，大多数看是在耳朵后面，西医叫多发性骨髓瘤，这种东西长在膝盖骨里面，膝盖骨也是阴骨，西医不知道膝盖也是阴症，代表阴结实，也可以从这个地方判断病好了没有。比如说治疗骨髓瘤，骨髓瘤长得关节上都有。刺之稍瘥。病过十日，外不解，脉续弦者，与「小柴胡汤」。脉但浮，无余证者，与「麻黄汤」。若不尿，腹满加哕者，不治。

临床上看到这种肝硬化，肝癌腹水的时候，如果病人没有动过，就是没有做过切片，也没有栓塞，就是没有动过，我们已经知道他是阴实，这种情况之下，你做栓塞，阴更实。现在告诉诸位怎么治疗，前提实西医没有碰过，西医动手就没办法了。

肝产生的腹水，你不用管他肝硬化还是肝癌，一个是实症，一个是虚症。实症有个名称叫分消汤，这个分消汤是从《万病回春》找出来的，这个是对实症，实症上面看到的常常是肝硬化，病人精神还是很好，跟你讲话还是很有力气，颜色很暗但是没有那么虚，肚子胀的很大，脚、下焦肿起来。如果病人给西医动过，处方只有一条路，就是加重剂量，一搏嘛。临床上，只要西医没有碰过，效果都很好。分消汤：苍术三、白术三、茯苓三、陈皮二、厚朴二。

虚症的时候用补气建中汤，在金匱谈到，治肝先实脾。实症跟虚症，苍术、白术、茯苓、陈皮、厚朴这五味药是相同的。实症加香附子二，猪苓二，泽泻二，实症用枳实一，大腹皮一，西砂仁一，木香一，灯心草一把，灯心草非常轻，它是包好的，一把还不到一钱。干姜一，生姜一。这是实症。分消汤如果把枳实，

改为枳壳，就叫做实脾饮，万病回春的。枳实跟枳壳差异在那里？过去淮河以北称为枳实，淮河以南叫橘子。枳实是先采的。晚点收，里面都干掉了，就剩壳了，就叫枳壳。会用枳实，是因为他里面腹水很多，枳实能够开胃，是木的果实，味是酸的，肝木克到土，肝脏有问题的时候会克到脾土，所以腹部里会有积水。腹部是脾脏在管，所以一律是健脾利湿的药在里面。我们称为甘淡渗利。甘淡渗利为阳，辛甘发散为阳，处方的时候，麻黄桂枝下去辛甘发散为阳，甘淡通利的药也是阳药。如果肝硬化，脾脏肿大，都是用这个药。

如果病人气色变了，病人气色很暗黄，元气没有了，形没有了。瘦干干的，肚子大，这个来不及了，实症变虚症了，虚症的时候，苍术、白术、茯苓、陈皮、厚朴这五味药不变，但是其他的药要该一下。补气建中汤，加人参三，泽泻三，麦门冬三，黄芩二，前面五味药加上这四味药，叫补气建中汤。补气建中汤来自《济生方》的臌胀门，有谈到补气建中汤。当你在使用的时候，剂量药开大。看到病人有积水的时候，马上就要用。他不是说都会中，太慢用有时候还是会来不及。当你发现的时候，有时候可以加重剂量。

如果病人告诉你很冷，心脏力量不够了，这两个处方不管是实症还是虚症，用不到甘草，因为甘草会蓄水。这个时候可以增加生附子，生附子救急的时候，五钱都没关系，把它包在棉布袋里。煮的时候，九碗水煮三碗，一碗不过一钱多。生附子能够壮里阳，心脏里面的阳，把心脏的阳会强起来，所以把心脏的阳强起来并不是炮附子。生硫磺，硫磺是黄色的，三焦系统，命门火就是黄色的，脏腑中间是黄色的，三焦是水道出焉，排水的系统要靠硫磺，所以说治水肿的时候，麻黄加术汤，我加一点点硫磺下去。用硫磺你用到六钱八钱，一两都没有关系。硫磺实际上并没有毒，硫磺吃下去很热。过去水肿，全身积水都在用硫磺，脚没有力的时候会用硫磺，硫磺是补命门火的。道家有个金液丹，那就是硫磺。生硫磺取它的迅捷，速度很快。可以把生硫磺跟附子包在一起。附子黑黑的，生硫磺黄黄的，一个入肾一个入三焦命门，配上补气建中汤。你如果会针灸更好。我治病人肝硬化水肿，连续两次，就是分消汤。

临床上，肾脏病水肿，也是肿的肚子大，肾脏衰竭，整个脚都肿到，手也开始肿。肾脏病的水肿跟肝病的水肿不太一样，所以用甘淡渗利，甘淡渗利为阳。绿豆甘淡渗利，有个四神汤，专门用在肾脏病积水的时候，四神汤：芡实，莲子，薏仁，白果，我有时候白果改成淮山。冬天的时候绿豆改成红豆，加点龙眼肉，海盐，蔗糖。夏天的时候，绿豆和四神汤混在一起的时候，煮成稀饭。甘淡渗利的时候是阳，用在肾脏积水。临床上这样做的。

这种结果出现都是失治。

如果处方下去，病人最迟三天小便就开始排。如果小便没有出来，堵到里面，严重起来，有几种变化，第一个，会成为十枣汤症。有十枣汤症的时候，一定要确定病人还有元气，趁有元气的时候赶快下去。十枣汤把肺里面的痰水统统排掉。病人是但坐不得卧。

6——4

躺下去不断的咳嗽。十枣汤攻下去病人会上吐下泻。这个时候都是在利小便，张仲景说下痢则死。你如果攻大便就死掉了，你一定要把小便攻出来。如果不是十枣汤，梗在里面，过去经方家有用甘遂，牵牛。甘遂牵牛等量，不是只有这两



味药，这是其中两味。会用甘遂牵牛在皇帝外经提到。加减处方，病人胸胁苦满，小柴胡汤的加减，如果病人没有胃口，没有胸胁苦满，没有恶心的现象，用桂枝汤的加减。如果病人已经没有元气，打嗝的时候，用茯苓四逆汤的加减，茯苓四逆汤加上甘遂牵牛，甘遂牵牛可以各三钱，吃下去病人会大下，小便出来，呕吐。临床上病人会小便出来，但是如果西医碰过，尤其做过栓塞，效果都不好，切片更坏。

如果开始没有积水的时候，不需要去实脾。半夜一点到三点醒来，两年会看到肝癌。脸色很暗的时候，这个时候就开始动手了，眼睛周围是青色的，眼睛周围是脾土，木克土，眼周围是青色，就要开始动手，这个时候很简单，小柴胡汤的加减，如果便秘大柴胡汤的加减，加些行肝气的药，比如玉金，龙胆草，胸胁苦满，小柴胡汤，大便排不出来大柴胡汤，胃口不好，加点陈皮。中湿比较盛加些白术茯苓。这个时候就治好，不会有那种结果的。如果治好之后，不用去检测，可能还在里面，可是他是无害的。真正生病的时候，按照中医的观念看起来的话，张仲景赞成吃的简单，而且不要吃太多，五分饱。随时保持一点饿的状态，这样刺激你的胃气，胃气就会起来。这个时候你要吃很原始的食物。病治到无害的阶段就是好的，不要再去找西医检查，硬去挖病，它是无害的了，你自己给自己吓死。我救回来肝硬化腹水的病人，我跟他说，再去给西医检查，从此我就不理你。跟那个血癌小朋友一样，你只要吃西药我就不救你了，他一吃西医，耳后阴骨就出了问题了，三个阴骨一出现问题，我们就知道，阴实了，里面已经结实了，阴实则死，结果死在西医医院里面了。

## 第二百四十八条。

原文：「阳明病」，自汗出，若发汗，小便自利者，此为津液内竭，虽鞭不可攻之，当须自欲大便，宜蜜煎导而通之，若「土瓜根」及「大猪胆汁」皆可为导。

津液亏损的时候，不要急着下手，先等一下，看会不会回头。有的是年老气衰，没有力气排，用土瓜根，大猪胆汁，都是导便的方式。

### 蜜煎导法

蜜七合，一味，纳铜器中，微火煎之，稍凝似饴状，搅之勿令焦着。欲可丸，并手捻作挺，令头锐，大如指，长二寸许。当热时急作，冷则硬。以纳谷道中，以手急抱，欲大便时乃去之。

这种情况是津液内竭，人年老气衰。过去的通大便的方式。

### 土瓜根方

#### 方缺

### 大猪胆汁方

大猪胆汁一枚，泻汁，和醋少许，以灌谷道中，如一食顷，当大便出。

## 第二百四十九条。

原文：「阳明病」，脉迟，汗出多，微恶寒者，表未解也，可发汗，宜「桂枝汤」。

阳明病脉应该洪大，现在脉是迟。阳明病只要有汗，开桂枝汤。即使开的很重都不会丧失津液，因为桂枝汤有三个滋阴的药在后面。不要用麻黄汤。

第二百五十条。

原文：「阳明病」，脉浮，无汗而喘者，发汗则愈，宜「麻黄汤」。

脉浮是表症。麻黄汤治喘，还有咳嗽，咳嗽也是喘。麻黄入肺。他表症还有，要先把表解掉。阳明病攻下要先把表解掉，再去攻下。

第二百五十一条。

原文：「阳明病」，发热汗出，此为越热，不能发黄也。但头汗出，身无汗，剂颈而还，小便不利，渴饮水浆者，此为瘀热在里，身必发黄，「茵陈蒿汤」主之。

“越热”热往外走。不能发黄，黄的定义，是热没办法往外出。黄有两种，一种阳黄，一种阴黄。如果黄很暗，是很危险的症状，只要接触到阴都是很危险的。阳黄，虽然黄但是很光鲜亮丽的黄。现在讲的是阳黄。金匱还会讲到黄汗，黄汗发生在以前黄河边，摆渡为生，天气很热流汗，跳水里，造成黄汗。这里讲阳黄，瘀热在里面排不掉。「阳明病」，发热汗出，此为越热，发热汗流出来了，热跑出来了，不会发黄。“但头汗出，身无汗，剂颈而还，”阴经到喉咙边。消化系统肠胃在中焦，肠胃有热的时候，汗发出去，热就卸掉了。现在有表邪，固到，汗没有发出去，胃里很热一直往上冲，造成头汗出，胃里非常热。当热一直往上越的时候，叫越热。当胃热越出来，里面空掉了，中焦会空掉，湿来补位，一般这种平素有湿的人，胖子湿很盛，瘦的不会，湿都排掉了。湿来补位变成湿梗在中间，整个腹部都是湿，上面是热的。湿在中焦很盛的时候，正常的津液，是这样走向，水从大肠到肺里面去以后，肺是肾之母，肺里面的津液除了主皮毛以外，鼻孔以外，津液会慢慢回到肾脏里面去。肺水往下降，肺法像天，天下雨了，肾接到，小便排出来，这是常态，结果上面太热了，中间湿隔到，水上去下不来了，小便不利，上去的水，“但头汗出”排掉了，中间是空的，病人渴，肺里没水了，很想喝水。为什么小便不利，他是有热有湿，有实。这个症状上面是热，中间是湿的，下面是实的，有三个症在里面。所以我们要开三个药，去热，去湿，去实。茵陈蒿汤这样来的。

茵陈蒿汤方

茵陈蒿六两。栀子十四枚。大黄二两去皮。

右三味，以水一斗，先煮茵陈，减六升，纳二味，煮取三升，去滓，分温三服，小便当利，尿如皂角汁，色正赤，一宿腹减，黄从小便去也。

茵陈蒿不要六两，茵陈蒿和栀子是等量四钱，大黄两钱。大黄在调胃承气汤，和大承气用到的时候用酒泡一下，因为调胃承气跟大承气里有芒硝，芒硝是很咸寒的东西，大黄酒泡一下比较温热，不会怕肠胃伤到。其他地方就是大黄直接丢下去。茵陈蒿专门去湿，大黄去下焦的实，栀子去上焦的热，因为他是阳黄，吃茵陈蒿利出的小便非常黄非常暗，有时候黑的。茵陈蒿汤是去黄的专剂。临床上看到急性肝炎都是茵陈蒿汤，都是阳黄。

临床上用的很多，只要看到病人一黄，大便没有，就结束了。

先煮茵陈，煮取它的药味，药味很重，湿很多梗到，茵陈多熬一下。“尿如皂角汁，色正赤，”颜色会有这种反应才对。如果不是这样反应，你开错处方了。

第二百五十二条。

原文：「阳明证」，其人善忘者，必有蓄血，所以然者，本有久瘀之血，故令善忘；矢虽鞭，大便反易，其色必黑，宜「抵当汤」下之。

「抵当汤」代表里面有瘀血。血症最明显的症状就是渴不欲饮。

诊断的时候，问大便黑色，代表里面有瘀，在排瘀。在治肝病的时候，大便都是黑色，在排毒。

“善忘”可以看灵枢第八十篇大惑论，提到上气不足，下气过实，其人善忘，人如果说阳明燥矢，大便都堵在肠子里，或者下焦有湿热，大便堵到也是一样。上焦是虚的恶，这个时候，血气没有办法供应到上焦，到心肺脑部去，就会产生善忘的现象。常常忘东忘西的，看看他大便好不好。如果上气能够补足，善忘就会治好。

这个人善忘有蓄血，下焦是实，大便堵到。抵当汤，一般是腹腔有瘀血，或者里面肿瘤有瘀血。如果是膀胱有瘀血堵到，会小便不利，这个时候处方，是桃核承气汤。桃核承气汤是调胃承气汤加上桃仁跟桂枝。抵当汤就会用到水蛭，蟅虫这种东西。

遇到瘀血用抵当汤。抵当汤是张仲景出的第二个活血化瘀的处方，这个处方一定要有这个症，善忘，大便黑色的，一定有蓄血。

一般穴道触诊的时候，三阴交会找到压痛点。还有舌头齿轮很多也是有瘀血。

6——5

正常人舌头是平整的，有瘀血的他的舌头齿痕很多，代表内有瘀血。口渴不欲饮，这都是有瘀血。这都是抵当汤的使用时机。

第二百五十三条。

原文：「阳明病」，下之，心中懊憹而烦，胃中有燥矢者，可攻。腹微满，初头硬，后必溏，不可攻之。若有燥矢者，宜「大承气汤」。

“心中懊憹而烦”胃里很烦恼，难过。

大承气攻后，阳明症没了，烦躁，舌苔黄，小便深黄，承气汤攻出来，他还有，要不要继续吃看小便颜色，小便颜色淡黄，可以停掉了，承气汤症晚上会很烦躁，燥热，喜欢喝冷水，脉都是洪大的，攻下去脉会小下去。

第二百五十四条。

原文：病人不大便五六日，绕脐痛，烦燥，发作有时者，此有燥矢，故使不大便也。

这里承气汤就可以用。“绕脐痛”肚脐周围是大肠，这就是大承气汤症。小承气汤症的时候，脐下关元的地方。

承气汤，汤剂是取它的迅捷。有的人已经发谵语了，还用粉剂太慢了。如果平时就知道他有承气汤症，但是还没有发狂奔走，但是你知道他有燥矢在里面，已经如见鬼了，给他吃承气汤的时候，粉剂没有关系，吃到小便颜色变淡了，就代表燥矢没了。大承气汤颜色都是深黄的。如果你还是会弄错，你问他，屁都不放一个大承气汤，放屁多小承气。

#### 第二百五十五条。

原文：病人烦热，汗出则解，又如疟状，日晡所发热者，属「阳明」也；脉实者，宜下之；脉浮虚者，宜发汗。下之与「大承气汤」。发汗宜「桂枝汤」。

“病人烦热”这个烦热不见的情绪，而是病人觉得很燥热，烦躁，流汗出来就觉得很舒服。“又如疟状，日晡所发热者，”看到忽冷忽热像虐，但是只要是黄昏看到发热，就已经到了阳明了就可以承气，白虎来挑。

“脉浮虚者，宜发汗。”脉虚浮代表病还在表。有表症的时候，绝对忌下。因为有热，所以绝对不好用麻黄汤开表。麻黄汤一开表，不是大承气汤就被你变成大承气汤，因为你不需要麻黄汤，结果你麻黄汤下去，发汗太过了。发汗的时候你用桂枝汤，实际上你真正发汗的时候，你用桂枝汤一两三两上去的，你用再多也不会变阳明症，因为后面有生姜甘草大枣。桂枝汤是经方家调和阴阳最好的方子。

#### 第二百五十六条。

原文：大下后，六七日不便，烦不解，腹满者，此有燥矢也，所以然者，又有宿食故也，宜「大承气汤」。

攻下之后，可能还有宿便没有完全干净，肚子还是很胀满，其实可以问病人，你觉得干净没有，病人最清楚。没有完全攻出来，再攻。有宿便赶快攻，以我的看法，至少百分之八十的癌症跟便秘都有关系。

#### 第二百五十七条。

原文：病人小便不利，大便乍难乍易，时有微热，喘冒不得卧者，有燥屎也，宜「大承气汤」。

大便如果太干的时候，下焦太热的时候，小便都变得很短赤，这个不利不是没有，而是变得很短，赤，颜色很深。这都是大承气汤症。

现在讲阳明的燥矢，有的时候，他有便秘，但是跟阳明症没有关系，后面会介绍到。

#### 第二百五十八条。

原文：食谷欲呕者，属「阳明」也，「吴茱萸汤」主之。得汤反剧者，属上焦。

「吴茱萸汤」实际上是胃虚的时候。朝食暮吐，有两种，一种是实症，胃里面有坏死的食物堵到，大黄甘草汤。有一种是虚症，虚症的时候吴茱萸汤，胃虚掉了，吃东西不消化，用吴茱萸汤。

湿热的时候大黄甘草汤，比例是大黄是二，甘草是一。大黄甘草汤可以用粉

剂，一般来说大黄的三分之二钱，甘草的三分之一钱，加起来是一钱。

### 吴茱萸汤方

吴茱萸一升洗。人参三两。生姜六两切。大枣十二枚劈。

右四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服七合，日三服。吴茱萸用三钱，重证的时候可以用到五钱，人参、生姜、大枣酌量的用。

临床上病人说很恶心，恶心两种处方，一种半夏是止恶心的。吴茱萸也可以止呕。两个差异在哪里？半夏是水饮造成的，病人有渴就不可以用半夏。有渴恶心，我们用吴茱萸或者是生姜。如果病人不渴，代表胃里面有积水，这个是水饮造成的恶心，这个时候要用半夏。水饮的脉，关脉非常的弦细。弦细的脉就代表水饮的脉。

### 第二百五十九条。

原文：「太阳病」，寸缓，关浮，尺弱，其人发热汗出，复恶寒，不渴，但心下痞者，此以医下故也。如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属「阳明」也。小便数者，大便必鞭，不更衣十日，无所苦也；渴欲饮水；少少与之；但以法救之。小便不利而渴者，宜「五苓散」。

张仲景对阴脉阳脉的标准，寸脉是阳脉，尺的地方是阴脉，中间的关就是阴阳交汇的地方。他的观念就是这样子，所以他写出来的脉症就是这样子。以后我讲阳脉就是寸，阴脉就是尺。

“「太阳病」，寸缓，关浮，尺弱，其人发热汗出，”看起来像太阳病，这个是桂枝汤症。

“复恶寒，不渴，但心下痞者，此以医下故也。”心下痞有时候被误下的。本来是太阳中风的表症，结果没有解表攻下了，一攻下造成心下痞。

“如其不下者，病人不恶寒而渴者，此转属「阳明」也。”这个是有太阳病，即使你下了，并没有出来。病已经转「阳明」。阳明症出现的时候，一定没有太阳症的症状。不恶寒的话就是纯热证。阳明证才会口大渴。

如果一个人十天不大便，不为所苦的时候，他已经不是阳明症了，它叫做寒实。阳明是热实。寒实十天不大便完全没有感觉。热实的时候，小便深黄。寒实小便淡白。

热实用去热的药配合去实的药才行。寒实，配合去寒去实的药。去实的药是一样的，大黄只去实，不管寒热。

阳明燥矢十天不大便已经发狂奔走，捻衣摸床了，见鬼了。

“小便不利而渴者，宜「五苓散」。”上次介绍猪苓汤，猪苓汤跟五苓散区别。如果是表水，小便不利而渴，五苓散是利水的药，皮肤表面的水没有办法排出来的时候，小便排不出来的时候，用五苓散利出来。五苓散一般是在热症，五苓散故去是在解疫病。有瘟疫还不清楚是解表还是攻里，带五苓散可以把身体的毒排掉。小便不利而渴，里面津液伤到了。五苓散不但可以排小便，同时可以把津液救回来。

猪苓汤，肾结石猪苓汤。但是结石跑到膀胱，变成膀胱结石，小便堵到的时候，已经堵到膀胱口了，小便排出来不利，又带血。根据症状，小便不利又带血，应该桃核承气汤症。桃核承气汤症是急性膀胱堵塞，尿道堵塞的时候用桃核承气汤，不会用猪苓汤。猪苓汤肾脏肾结石的时候用，猪苓汤，病人腰后面痛，太溪穴有压痛点。

如果渴，大便不出来会用大承气汤攻他。如果大便很正常，小便不利而渴，才会用到五苓散。

第二百六十条。

原文：阳脉微而汗出少者，为自和也；汗出多者为太过。阳脉实，因发其汗出多者，亦为太过。太过为阳绝于里，亡津液，大便因鞭也。

如果是阳明病，脉摸到是洪大的脉，如果脉现在变微，变小了，汗出代表津液回头了，自己会好。

阳脉实，寸脉摸上去非常强硬非常大。这个时候可能发表汗太多，寸是胸阳。发汗发太多，造成津液丧失，大便太硬。造成阳明证。

第二百六十一条。

原文：脉浮而芤，浮为阳，芤为阴。浮芤相搏，胃气生热，其阴则绝。

这是一个虚症的表现。浮脉在表面上，表症。芤脉是中空的脉，像摸到葱叶，这是血虚的脉。

也就是说这个人贫血，已经血不够了，再得到阳明燥矢症，阳明燥矢本来就是肠胃里面造成宿便，血的源头就是食物，食物吃下去又不消化，血的源头没了，本身又贫血，其阴则绝，阴就是血。

胃气，有阳的地方一定要有阴，胃气才会存在胃里面不往外跑。阴不够，阳会往外走，阴阳会分离。这个血会更亏，贫血的人兼有便秘，血会更亏。

第二百六十二条。

原文：「趺阳」脉浮而濇，浮则胃气强，濇则小便数，浮濇相搏，大便则难，其脾为约，「麻仁丸」主之。

「趺阳」脉，就是脚上冲阳穴的地方。

这个跟承气汤不一样。承气汤是热而且实。麻仁丸是燥实。燥和热不一样。热还有津液，燥的话津液就没有了。

麻子仁丸方

麻子仁二升。芍药半斤。枳实半斤炙。大黄一斤去皮。厚朴一斤炙去皮。杏仁一斤去皮尖，研作脂。

右六味，为末，炼蜜为丸，桐子大。每服十丸，旦三服，渐加，以和为度。开处方的时候照比例开，麻子仁二，白芍六，枳实六，大黄十二，厚朴十二，杏仁十二。

遇到病人很虚弱的时候，大黄芒硝下去病人元气受不了，用麻子仁。麻子仁有仁剂，仁剂有通便润肠的功能，不像芒硝大黄全部打出去了。

这个为什么叫脾约麻仁丸，脾主思虑，思伤脾。脾脏管湿，但是脾脏喜燥，不喜欢湿。当湿完全没有也不行，思念太过的时候会越来越焦躁。小肠里面的津液来自脾脏，脾在内经主少腹，腹部讲的是小肠，小肠水分不够，为什么会不够，就是思，思伤脾，这个是情志引起的。当脾没法提供津液的时候，小肠会干掉。小肠干掉的时候，出现的症状是大便难，这个症状是脾约。你如何知道，你问他大便什么样，像羊大便一样一颗一颗，堵到小肠里面。小肠因为渠道很多，大便堵到弯道的地方，排出来一颗一颗的，而且非常的干。

这里用丸，不用汤，因为汤太快了。

麻子仁二。芍药六。枳实六。大黄是十二。厚朴也是十二。杏仁也是十二。

6——6

如故遇到腹痛的时候，白芍专门治腹痛。麻子仁丸的时候，可以看到病人有腹痛，所以张仲景放了白芍在里面。

所以从张仲景开的处方可以回头看本草的药性，芍药腹痛一定会用到，不管女人月经痛还是阳明证肚子痛，都可以用到芍药。

早上五点到七点是大肠经流注的时候，所以晚上睡前吃麻子仁丸，刚好隔夜第二天早上排出来。二十颗就够了，三十颗半夜就起来上厕所。小孩子十颗五颗。每个人燥结的程度不一样。如果吃了麻子仁丸，大便通利了，形状会改变。正常的时候，一样小便是淡黄清色的。临床上麻子仁丸用在老年人气血两虚，便秘的时候。如果宿便堵到肛门口了，在吃麻仁丸的时候可以用半钱的芒硝，放水里面化掉，用这个水来吞麻仁丸，就可以把这个燥矢打掉。

第二百六十三条。

原文：「太阳病」三日，发汗不解，蒸蒸发热者，属胃也，「调胃承气汤」主之。

太阳病每个人不一样，有的人发汗就解掉了，有的人不解是本身肠胃功能就不好，你一发汗里面津液就没了。这个是调胃承气。

第二百六十四条。

原文：「伤寒」吐后，腹胀满者，与「调胃承气汤」和之则愈。

伤寒病照理说就是麻黄汤症，如果遇到病人，没有开麻黄汤，吐完滞后，可能烧没了，表症没了，但是腹有胀满。调胃承气腹胀满就在中脘穴到肚脐。每个人都不一样，比如这个人伤寒，刚好吃坏食物吐掉，或者碰到医生用吐法，会遗留一些症状出来，一吐肠胃的津液伤到了。肠胃津液伤到就要用调胃承气，因为吐在上面，吐不会用到小肠津液。

第二百六十五条。

原文：「太阳病」，若吐，若下，若发汗，微烦、小便数，大便因鞣者，与「小承气汤」。

还是太阳病，你什么都用了，结果病人还是大便排不出来，这个时候就是小承气汤，如果光是吐就是调胃承气。如果说汗发太多了，可能就是大承气了。

#### 第二百六十六条。

原文：得病二三日，脉弱，无「太阳柴胡证」，烦躁，心下鞭，至四五日，虽能食，以「小承气汤」少少与微和之，令小安。至五六日，与「小承气汤」一升。若不大便，小便少者。虽不能食，但初头鞭，后必溏，未定成鞭，攻之必溏。须小便利，矢定鞭，乃可攻之，宜「大承气汤」。

无「太阳柴胡证」，表症，怕风恶寒，体重节痛，有汗、发烧项强都没有，柴胡的往来寒热、胸胁苦满、恶心都没有。

腹中湿很盛的时候，攻下，张仲景的意思是要等，怎么知道湿很盛？第一个腹满，第二个，大便是溏泻，比较软比较稀。张仲景意思是，等他湿小便排利出来，等他大便完全称为干燥的时候，乃可攻。用大承气汤。

我们有很多处方可以治疗他，比如说知道他有湿，加些去湿的药让他小便利出来，可以用五苓散，但是病人一定要有小便不利，口渴的现象，用五苓散。五苓散配合承气汤一起就可以使用。

伤寒论的条辨是很死的，临床上用的时候是很活。你只要记得，大承气汤是用在纯燥矢的时候，完全没有其他的副症在里面，如过有其他的症状，里面有湿，大便还没有结硬，还有溏的时候，光是大承气下，张仲景不赞成，因为还没有纯阳明症，那你要用利湿的方法，去湿的方法就是利小便，除非湿在关节的时候，用汗解来去湿，否则的话都是利小便。

中医治病汗吐下法。下法分两个，一个是便秘攻坚，攻大便，一个是攻小便。在阳症的时候，攻大便是最快的。当阴证才会去利小便。不管是实脾饮，分消汤，或者是补气建中汤，都是去利湿，利小便出来，所以在阴证一般都会去利小便，很少去利大便。阳症的时候利大便。利小便的力量没有利大便那么好，所以能够把病阻止在阳明证的时候，通大便的药会比利小便的药来的快，几乎无所不通。小便就不见的利出来了，因为他是阴证。

#### 第二百六十七条。

原文：「伤寒」六七日，目中不了了，睛不和，无表里证，大便难，身微热者，此为实也，急下之，宜「大承气汤」。

“目中不了了”眼睛看不清楚了。

阳明证燥矢的时候，沼气会往回逆。回逆不单单是会捻衣摸床，发狂奔走，还有眼睛看不清楚。没有表里证，伤寒没有恶寒体痛，没有高热脉浮，出现这个症状要考虑大便通不痛。阳明的燥矢会影响到眼睛的视力。

#### 第二百六十八条。

原文：「阳明病」，发热汗多者，急下之，宜「大承气汤」。

当有大承气汤症，大便堵在肠子里面的时候，会造成很多人很快热起来，流汗流很快，津液会丧失的很快，遇到这个急下，赶快下。急下存阴，不敢快下，



因为很热，干燥的大便，会把津液发散掉。等到津液伤到了，已经完全没有津液了，药都吞不下的时候就危险了。

第二百六十九条。

原文：发汗，不解，腹满痛者，急下之，宜「大承气汤」。

“腹满痛者”有痛的现象，拒按，实症。我们要急下，急下存阴的时候，不会用到调胃承气小承气。快下的时候用大承气。

第二百七十条。

原文：腹满不减，减不足言，当下之，宜「大承气汤」。

如果腹满大便攻了，排出来还是肚子胀，宿便很多，当攻下，大承气汤。

第二百七十一条。

原文：「阳明少阳合病」，必下利；其脉不负者，顺也；负者，失也；互相克贼，名为负也；脉滑而数者，有宿食也；当下之，宜「大承气汤」。

少阳脉弦的，阳明脉比较大。如果摸到脉是相符的，阳明兼少阳症，摸到脉是浮的弦细，这个脉是顺。如果脉和症不合，互相贼克，就是阳明和少阳在互相冲突了。病进入少阳有机会进入太阴少阴厥阴。如果进入阳明就不会再进了。

如果脉滑而数，这是里面燥矢结到了。赶快攻大承气汤。

临床如果遇到阳明少阳并病的时候，有下痢，再摸他脉也有燥矢，肚子硬，拒按。胸胁又苦满，这个时候常常开柴胡承气，合在一起开。像大柴胡汤里面已经有枳实芍药大黄，如果再加厚朴就是大承气汤了。如果把炙甘草拿掉，标准的承气汤了。柴胡汤跟承气汤开在一起没关系。

第二百七十二条。

原文：病人无表里证，脉浮数者，虽发热六七日，勿下之。假令已下，脉数，不解，不大便者，有瘀血，宜「抵当汤」。若脉数，不解，而下不止，必协热而便脓血也。

“脉浮数者”浮代表表，数代表热。就是表热，不要攻下。

如果遇到病人没有解表，直接攻下，造成协热痢，就是葛芩连汤症。便脓血，本来这个人病在表，攻下跑到里去了，或者没有把病治好，他跑到肠胃里面去了，就变成肠病毒。

攻里的时候只要有瘀血要用抵当汤。没有瘀血还是承气汤。

第二百七十三条。

原文：「伤寒」，发汗已，身目为黄。所以然者，以寒湿在里不解故也。以为不可下，于寒湿中求之。

「伤寒」，发汗已，身目为黄。因为这个人本身有寒湿在里没有解。如果有寒湿的人，开麻黄汤，寒湿会往外走，会看到黄的现象。脾为土，土是黄色。黄色本身是脾脏的营养，脾脏有问题，不接纳营养。

当中焦有寒湿的时候，麻黄汤下去发汗的时候，药里没有去寒去湿的药，去寒药靠附子，去湿要靠白术，麻黄汤里根本没有，一发汗脾脏梗到，湿是脾脏在管，这个时候湿堵在中焦，你不动它可能围在脾脏外面，你发汗动到它，寒湿跑到脾脏，侵占脾脏空间，这个黄本来是属于脾脏营养，营养的空间被寒湿占据，没有办法进去，外往走，跑到外面是黄色。这是里面有寒湿。

如果看到发黄，有的是胆结石堵到。怎么知道黄是胆结石堵到，胆汁逆流，急性肝炎，慢性肝炎，怎么知道这个黄只是湿热的黄或者寒湿的黄？这个就是告诉你，伤寒发汗后身目变黄就是里面有寒湿，不是热湿，热会口渴，寒不会口渴。

协热利，大便出来看不到血，就是葛芩连汤，肚子痛用黄芩汤，大便有血可能是大肠炎。

这个是里有寒湿发汗会发黄。如果有湿热的人，热是往上走，寒还不会往上走，就是堵在脾脏里变黄。如果有湿热的人，一发汗，表症去掉了，但是脸变成浮肿。

如果看到伤寒，开处方的时候，看看舌苔黄，除了麻黄汤以外还有湿热在里面，同样是麻黄汤，但是会加一点黄芩黄连白术，加点茯苓利小便，就不会有这种现象。

第二百七十条。

原文：「伤寒」七八日，身黄如橘子色，小便不利，腹微满者，「茵陈蒿汤」主之。

「茵陈蒿汤」栀子、大黄、茵陈。这个是湿热的人，上焦热，中焦湿，下焦湿。三个症状同时存在就会有这个现象。一定会有便秘。所以茵陈蒿汤里有大黄。当有湿热的时候，会影响到小便，因为湿热很盛，整个堵到小便排不出来。如果茵陈蒿汤下去，大便一出来看小便，小便刚排出来像皂角的颜色深红。

「茵陈蒿汤」是专门去湿热实三个症状。没有实不会用到茵陈蒿汤。一定有便秘才会用到茵陈蒿汤。

第二百七十五条。

原文：「伤寒」瘀热在里，身必发黄，「栀子蘗皮汤」主之。

茵陈蒿汤和栀子蘗皮汤，茵陈蒿汤是有湿热实。栀子蘗皮汤没有表症，淤热在里，没有实症，大便很通畅，只是里面有淤热。

栀子蘗皮汤方

栀子十五个擘。甘草一两炙。黄柏二两。

右三味，以水四升，煮取一升半，去滓，分温再服。

栀子上焦的热，黄柏下焦热，中焦因为没有湿，处方就没有了，用甘草

湿很盛的时候小便不利，因为堵在里面，小便排不出来。临床，只要有湿的人舌苔都会很厚，很粘，燥症舌苔干掉了。

黄柏能去下焦的热，小便痛，肾脏痛，里面只要发热发炎都会用到黄柏。

实物上栀子蘖皮汤可以做眼科的洗剂，洗眼用的。洗眼睛不要煮太浓，用棉布洗眼睛，眼科发炎，角膜炎都可以用。

在伤寒里面一共三个方子，治疗全身发黄发高热者：

- 1、无汗，病人没有汗的时候，用麻黄连翘赤小豆汤。
- 2、病人有汗且实热在里，就是茵陈蒿汤。
- 3、无表证无里实而身发黄，栀子蘖皮汤。

6——7

栀子蘖皮汤剂量是栀子三，炙甘草一，黄柏三，栀子和黄柏剂量一样，能够去热的药，药性都比较寒凉，寒凉药都会比较苦一点。

第二百七十条。

原文：「伤寒」身黄发热者，「麻黄连翘赤小豆汤」主之。

这个除了身黄以外，我们治疗皮肤病，很多皮肤病都会使用大麻黄。麻黄是发阳，阳气的阶段，所以还魂救逆汤，病人失魂的时候，麻黄下去把他救回来，但不是单开一个麻黄，开麻黄会开杏仁，比如开麻黄三钱，杏仁最少三钱和麻黄等量。这样下去绝对不会说汗太过。

会用到麻黄，比如一些疮病，尤其是凹陷下去的疮，如果是平头或者凸起来的疮都很好治。疮凹下去了，阳陷下去的疮很危险。这个时候麻黄下去，阳会浮起来，会发阳出来。所以阳气会发起来。刺激他的阳气发起来就要靠麻黄。

所以光是青龙，我们放到太阳篇的时候有麻黄汤，配合杏仁桂枝，炙甘草。放到少阴篇或者阳明篇的时候，还会用到麻黄。所以麻黄是发阳用的，麻黄本身是阳药，他不像桂枝，光会发汗，麻黄除了发汗，它有阳的性在里面。所以用麻黄不一定会出汗，有时候要小便解，汗吐下，下就包括了小便，所以在全身水肿的时候也会用到麻黄，一下去水就退掉了。

要记得使用麻黄的时候，麻黄跟杏仁的剂量是相等的。不会有问题。

赤小豆在腹膜炎的时候，赤小豆要发芽用。赤小豆本身去湿很好的药物。赤小豆去湿，大部分是化脓的湿。

如果病人痔疮，不用管便秘不便秘，都会下仁剂在里面，有便秘的话用大黄芒硝，痔疮的地方是每天都要使用的地方，所以同时使用的状态下让他大便收口，所以一定要他大便软化。用赤小豆收敛的时候加一些仁剂，如果他大便不是很好，当归吃多一点可以利大便，柏子仁，麻子仁可以通利大便，在治疗痔疮的时候，保持他大便比较溏泻，比较稀的。如果光开痔疮药，没有把大便变软，痔疮不会好。硬大便一通过就会把痔疮撑破。

麻黄连翘赤小豆汤方

麻黄二两。赤小豆一升。连翘二两炙。杏仁四十个去皮尖。大枣十二劈。生梓白皮一升去节。生姜二两。甘草二两炙。

右八味，以潦水一升，先煮麻黄再沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，

分温三服，半日服尽。

生梓白皮现在没有了，用桑白皮取代它。这个除了全身发黄，兼有表症以外，有点伤寒表症以外，皮肤病都可以使用。在经方里面，这是一个治皮肤病的方子。还有一个麻杏苡甘汤。

麻黄连翘赤小豆汤一般用在疥疮，皮肤有癣，疮，皮肤科。麻黄性非常轻，连翘桑白皮对皮肤非常好，可是需要一个东西把它带过去，金银花，蝉蜕对皮肤都很好，主方是这个，这个是去黄疸的。针对皮肤的时候可以加一些皮肤的药，以经方做基础方增加。

从处方看，这个是因为伤寒表症，束到，热排不出去，造成全身发黄，用发汗的药去。实际这个条辨不应该在阳明篇。

以上讲的是阳明证。

辨少阳病脉证并治法

少阳不单单是半表半里就结束了。你要去了解什么叫半表半里，所有介于肌肉中间的油网，脏腑中间的网络，奇恒之腑统统属于少阳，少阳是全身上下无所不到。少阳证会延伸出太阴症、少阴症、厥阴证。

在三阳症，太阳阳明少阳，这是无死症。如果失治才会进入阴症，这个才会出现死症。如果病人是少阴症，治疗一段时间之后变成少阳了，都是病要出表了，是好的现象。

比如乳癌，乳癌是少阳，如果不动它，从少阳到厥阴十四年。乳癌的处方怎么来？第一个她是在少阳所以用柴胡汤做加减，第二个看他经络，乳头正下方是肝经，所以加的有疏肝的药，还有肾经经过，所以加一些肾经的药，咸味入肾，软坚。心包经也经过，胃经也经过，经过乳房的经络都开在里面，让经络顺畅，淤积的东西去掉，当然不会有乳癌，硬块就去掉了。

少阳是表邪要入里了，一定会经过这个阶段。现在的里症并不一定经过这个阶段，因为现在的西药造成的。

第二百七十七条。

原文：「少阳」之为病，口苦，咽干，目眩也。

少阳病，嘴巴是苦的，少阳管胆，胆汁往外走。在胸胁苦满的时候，除了整个胀满之外，如果只有一点痛，也称为胸胁苦满，不是一定说要一片。他里面可能是胆结石，或者肝硬化到。

三焦是水道出焉，三焦有病水道会不顺畅，喉咙会非常干燥，眼睛会昏花。少阳证管眼鼻喉咙耳朵。肝开窍在眼睛，是因为少阳连到眼睛，所以肝开窍在眼睛，脾开窍在唇，心开窍在舌，肺窍在鼻。之所以能开窍在五官，是因为有少阳连贯到，才有办法。

第二百七十八条。

原文：「少阳中风」，双耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐、下，吐、下则悸而惊。

灵枢决气篇第三十篇提到，人有精、气、津、液、血、脉，如果精脱，耳聋。如果液脱耳鸣。

精：两神相搏，阴阳互相协调的时候，产生的就是精，人阴阳很协和的时候产生的就是精。如果精脱了，耳朵整个听不到了。

气属于上焦，上焦开发，能宣五谷味，吃了五谷杂粮，产生的气，进入上焦到胃，到肺来滋润它。食物到了小肠里面以后，小肠是火，只有糟粕跟水到了大肠，大肠刚好在小肠的上面，气化掉以后，食物的精气再回到肺里面。

皮肤腠理汗出就是津，津很足的时候，新的津不断去换旧的津，流汗是一个调津的动作，所以人一定要流汗，运动出汗，旧的津液出去，新的津液补肌肉的里面津液，这是津的动作。

液就是吃五谷杂粮进入气海，从气海跑到骨髓关结，所以关节能够活动。液伤到的时候会产生耳鸣。液能够增益脑髓，比如生地，我们要产生液在身体里面，不能用生地炭，没有用，产生液才能滋润骨头脑髓。

如果要生津，流汗太过，津不够了，加人参，可以生津。我只是举个例。

血，中焦受气，就是吃到食物，化生为赤，红色血的来源是来自食物。

脉是规范，血按照这个脉管来走。管道。规范营气用的。有几种情形会裂掉，一种是太热，热会膨胀，破掉。

6——8

还有一种是太冷，太寒的时候血脉变的很小，水通不过去，撑破。过寒过热都不好。

当遇到两耳无所闻的时候，一种是突然什么都听不到，是精脱了。精补回去。精是阴阳相搏，代表把阴阳补回去。调和阴阳最好的是桂枝汤。力量不够，加一些龙骨牡蛎。张仲景很少用补药。

少阳中风，少阳是耳朵、眼睛、鼻子、口、舌头，统统属于三焦系统，是少阳症。

“双耳无所闻，目赤，胸中满而烦者，不可吐、下，吐、下则悸而惊。”眼睛耳朵同时出问题，胸中满，就是这个人病不在表，不在里，他在半表半里。所以不要光去依据胸胁苦满、恶心、往来寒热。只要耳朵、眼睛同时出问题，这些统统不可以用吐下。吐上焦有热实，下是阳明症，少阳证是和解。用吐下汗法都不好。这种统统用和解的方式。

如果眼睛赤，两耳无所闻，用小柴胡汤，如果耳朵好了，眼睛还赤的话，可以用大黄茶喝。

如果吐下，就会悸而惊。心是君主之官，心要有很好的津液在里面，阳才会藏，心神才会在里面守住。如果吐下之后，一定会伤到津液，神就会不藏。就会容易受到惊吓，还有动悸，心下悸。张仲景在心下悸的时候用桂枝甘草，脐下悸茯苓甘草。桂枝能够把心阳壮起来，不要再受惊吓。

小孩子十五六开始有梦遗的现象，精脱了，用桂枝龙骨牡蛎。表面上看龙骨

牡蛎能够收敛阳，能够让阳潜下去。实际上张仲景的意思就是，你只要调和阴阳，精自然而然就回头了，然后再加龙骨牡蛎敛阳。龙骨镇惊。

少阳证不要吐不要下。

第二百七十九条。

原文：「伤寒」，脉弦细、头痛、发热者，属「少阳」，不可发汗，发汗则谵语。此属胃，胃和则愈，胃不和则烦而躁。

「伤寒」脉应该是浮而且紧，伤寒就是表实。如果脉是弦细，弦就是进入少阳。伤寒本经已经过了，进入少阳症了，脉是弦细了，你即使看到头痛发热，都不要去发汗。

如果病人没有手，你问他恶不恶寒，怕不怕冷，关节肌肉痛不痛，只要有表症再发。如果只有头痛发热，不要依据这两个症状来开。有少阳证出现的时候，病人一定兼有往来寒热。或者有点恶心的现象。

第二百八十条。

原文：本「太阳病」，不解，转入「少阳」者，胁下鞭满，干呕不能食者，往来寒热，尚未吐、下，脉弦紧者，与「小柴胡汤」。

这是很标准的小柴胡汤症。

依据这个“胁下鞭满，干呕不能食者，往来寒热，脉弦紧者，”症状就知道病入少阳了。进入少阳一定要用和解的方式。

小柴胡汤重用柴胡，其他是等量。柴胡能够治半表半里。如果不单单是少阳症，还有一点点太阳症的时候，小柴胡汤会发表，所以病人会有点流汗，有点表症小柴胡汤可以去。

第二百八十一条。

原文：若已吐、下、发汗、温针，「柴胡汤证」罢者，此为坏病；知犯何逆，以法救之。

如果只是一般的太阳表症或者是温病，你按处方开下去应该是对症的，吃下去没有好。你吐下什么方法都用了，还没有改变，这是坏病，就是病很严重了。看他问题到底是哪里，来治他。

第二百八十二条。

原文：「三阳合病」，脉浮大，上关上，但欲眠睡，目合则汗。

三阳同时病，一定是小柴胡汤来解他。目合则汗，躺到那不动都流汗，就是表症还有。

第二百八十三条。

原文：「伤寒」六七日，无大热，其人烦躁者，此为阳去入阴故也。

「伤寒」六七日，应该转阳明或少阳，转阳明就是大热，无大热就是没有进入阳明。跑到太阴少阴厥阴去了。

中医按照黄帝内经，认为脾胃后天之本。桂枝汤出来也是脾胃的一个处方，能够健脾，解肌，脾主肌肉。桂枝汤也是在解肌肉，在脾胃上使用。

把脾胃固的很好的人，伤寒得到不会传经的。会进入里面一定是肠胃不好的人。

第二百八十四条。

原文：「伤寒」三日，三阳为尽，三阴当受邪，其人反能食而不呕，此为三阴不受邪也。

这里伤寒三日是二十七天，太阳少阳阳明走完了。开始进入阴了。其人反能食而不呕，胃气恢复了，不用治他，自己会恢复。

第二百八十五条。

原文：「伤寒」三日，「少阳」脉小者，欲已也。

只要脉变小，就代表阳气恢复了。小就是缓而有力。脉很快很数的，或者太慢的都是很危险的。

第二百八十六条。

原文：少阳病欲解时，从寅至辰上。

病要解的时机。

少阳病只有几个条辨，因为少阳病进去的时候，只有两个，好和不好。好就是病到此结束了，没有了。不好就传经，传经传太阴少阴厥阴，它会顺着顺序下来。

临床常常会碰到不按照六经传变顺序走很正常，因为现在时代不一样了，很多西药营养剂介入。都会让症状改变。

7——1

辨太阴病脉证并治法

在进入阴经之前，要有一个概念。

肺和脾是太阴。病刚开始，从阳，从表要走到里的时候，他走到腑停止了，如果是走到半表半里，进入三焦，三焦是少阳证，进入少阳证病没有好，就开始进入脾脏了。肺和脾，肺是管气，脾是管血。如果病进入阴经的时候，就会影响到血，影响到气。张仲景气虚的时候，会用人参。血虚的时候用白芍，来补血，白芍酸能够补血。生病的时候不要吃补药，补药是没有病的时候可以吃，生病的时候吃治病的药。

如果太阴失治，跑到少阴去了，少阴心肾。会造成心脏肾脏衰竭掉。再不行最后就到肝脏。

黄帝内经讲脾主湿，身上的湿是脾脏在管，但是这个湿不是越多越好。人体进入的东西一定要能代谢出来，如果吃的东西连残渣都没有这个东西不能吃的。阴证的时候，不断累积可能累积在身体某个地方，变成实症就是凶，这个实就是

里面长肿块了。

内经说，湿伤脾。湿太盛会伤到脾脏，忧太过的时候会伤到肺脏。

如果人思虑很多，再加上忧，外因内感，治起来非常不好治。

先讲太阴，太阴是阴之初。少阴是阴之中。厥阴是阴之尽，到了尽头会回来。阴在走的时候都是寒症，看不到热症，到了厥阴的时候，看到热症了，深处还有热，寒热并结的现象，阴尽阳会出来。阳会回头，这是最难突破的地方。看太极图，人是圆的旋转的东西，阴到了极限了会生阳。阳到了极限也会生阴。

第二百八十七条。

原文：「太阴」之为病，腹满而吐，食不下；若下之，必胸下结鞭，自利益甚，时腹自痛。

脾主腹，肚子脾脏在管。一个人肚子肿起来，肿很大，我们知道脾脏不行了。脾主湿，腹里面湿很盛的时候，就是脾有问题。脾喜燥，不喜欢湿。这里腹满，当病从少阳进入脾脏的时候，脾主湿，有病在里面，脾没有办法把湿代谢掉，如果没有脾脏人就会过湿，湿就会很盛。湿累积起来以后，肚子越来越大，脾脏肿胀起来以后，会顶到胃，胃会变小会吐，东西吃不下去。

中医生理学，胃下面有甜肉，其实就是胰脏。当吃不下的时候，问病人，肚子很饿，饿就是脾，脾脏在管饿不饿。胰脏在管胃，吃东西有没有味道，是胰脏。

腹满，我们知道里面中湿很盛，如果你看到肚子大腹满，以为是阳症，攻下，一攻下的时候，“胸下结鞭，自利益甚，时腹自痛。”他里面并没有结实，燥矢宿便在里面，你攻下，攻下都是寒凉的药，湿会往下沉，肚子会更难过。药不对症。

主症腹满，吐，吃不下。这都是太阴病的主症。

第二百八十八条。

原文：「太阴中风」，四肢烦疼，脉阳微阴涩而长者，为欲愈。

如果有太阴病，又有太阳中风。四肢烦疼。脾主四肢、肌肉。脾有问题，新的津液没有办法去取代旧的津液，湿很盛，黏在里面。很久没有运动，脾脏比较容易酸痛，运动汗出，新的津液把旧的津液补回去，酸痛就去掉。

四肢烦疼，津液累积在里面了，最好的津，流汗是要调津。旧的津液会被新的津液取代。

如果是太阴中风，中风伤到肌肉，产生四肢烦疼，新的没有办法去取代旧的。

“脉阳微阴涩而长者，为欲愈。”进入阴症摸脉，越摸脉越小，代笔病往里面走。摸脉慢慢阳脉回来了，阴原来是涩，但是变的很长，代表阳气要回头。

太阴中风可以开桂枝汤，也可以发表。但是里面湿很盛，你没有办法把湿完全发出来。所以你可以开桂枝汤加白术茯苓。一般，但求无过，白术茯苓可以开等量，一般肌肉里面都开等量。但是要了解，茯苓是利尿，白术是去湿。如果说桂枝汤，桂枝三钱，白芍三钱，然后生姜，甘草、大枣，然后白术三钱，茯苓三



钱，绝对可以治好。

第二百八十九条。

原文：「太阴病」，欲解时，从亥至丑时。

太阴是子到午，他把亥丑放两边。真正太阴开始时间是子午。

第二百九十条。

原文：「太阴病」，脉浮者，可发汗，宜「桂枝汤」。

即使有太阴病，只要肚子大腹满的，可以发汗，用桂枝汤。让他快点好，加点白术茯苓。

第二百九十一条。

原文：自利不渴者，属「太阴」，以其脏有寒故也，当温之，宜服「四逆」辈。

有下痢但是不口渴，因为太阴管湿，太阴有燥就不是太阴病了，燥就是阳明病了。湿太盛才会有太阴病，湿就是水累积在里面，有太阴症的人不会口渴，湿太盛没地方排。拉肚子，口渴都是阳症，不会死人的。最怕拉肚子拉半天还不口渴，阴病，因为他脏有寒，里面是冷的，寒盛的时候阳会虚，阳除了会固表，肛门伸缩也是固表力，大便小便失禁都是固表力不够。毛孔流汗流不止你知道用炮附子，小便止不掉，大便止不掉也是炮附子，只不过是洞比较大一点，比毛孔大一点。

为什么要知道寒，因为有热药有寒药。里面有寒又有湿，在腹腔里面。“当温之，宜服「四逆」辈。”四逆汤都可以用。

张仲景用生附子用的干姜。用炮附子用的生姜。有的时候干姜生姜一起用。张仲景生附子炮附子不会用在一起，我生附子炮附子还会用在一起。我知道张仲景在想什么。

当用炮附子生姜的时候，是去水，去积，水积。生附子和干姜。干姜温中，生附子因为非常迅捷，全身的血脉神经都会用到，所以在救逆的时候，这个人又水炮附子生姜。如果这个人心脏不行了，里寒了，里面虚掉了，用硬炮附子干姜。胃口都没了干姜重用上去，生附子一颗下去。

什么时候生附子和炮附子会用到一起，水很大的时候，炮附子和生姜只能有一定的能力，但是这个水侵犯到心脏的时候，心脏的水太多了，心脏本来是火，水太多了，火要熄灭掉了。心脏快不行的时候，生附子和炮附子用在一起。水排出来速度很快。

我们有很多去湿的药，白术去湿，炮附子去寒的药。

第二百九十二条。

原文：「伤寒」，脉浮而缓，手足自温者，系在「太阴」；「太阴」当身发黄；若小便自利者，不能发黄；至七八日，虽暴烦，下利日十数行，必自止，以脾家实，腐秽当去故也。

“手足自温者”代表肠胃的功能还是有。太阴症身体会发黄，因为太阴湿太盛了，营养没有办法跑到脾脏，脾脏肿大了，本来这个黄色营养要给脾脏，脾脏里面都是湿，他不受这个营养，反逆出来，应当发黄。若小便自利者，不能发黄。小便利出来湿有地方宣泄所以不会发黄，反过来讲，治太阴症，治阴症一定要利小便，只要利小便就不会发黄。所以肝癌肝硬化之类，一定要利小便。实脾的时候，不是在利大便，是利小便。小便利出来，随时保持小便通畅，病人病情就不会恶化。

如果小便利，身体就发黄，湿没有地方去。

“脾家实，腐秽当去故也”脾的功能很强的时候，残渣腐秽自己会去。脾家实小便自利。如果治疗腹水的人，你问病人小便，小便没有，就是大便出水，状况还不是很好，此为坏病。病人大便十几次，小便出来很多，有点口渴，代表津液要回头了。

病人如果有下痢的时候，有小便的时候，他黄就开始退。治症的时候，脾家实很重要。我们在实脾的时候，不管是分消汤，实脾建中汤，实脾饮的时候，一定会问病人小便如何。

所以在阳症的时候，我们通利大便，阴证的时候通利小便。

第二百九十三条。

原文：本「太阳病」，医反下之，因而腹满时痛者，属「太阴」也，「桂枝加芍药汤」主之；大实痛者，「桂枝加大黄汤」主之。

本来是太阳证，医生该解表，结果没有解表攻下。

“大实痛者，「桂枝加大黄汤」主之”这个实痛是一阵一阵。

太阳篇有建中汤，小建中汤。这边是桂枝加芍药汤，他不写小建中汤，桂枝重用芍药，桂枝重用芍药再加饴糖就是小建中汤。这里只加重芍药，所以这里看出来，白芍专门治痛，痛的原因是肚子里面有寒，寒水累积在里面，所以静脉血液循环不好。女孩子月经痛也可以用白芍。肠子痛也可以用白芍。

腹痛，隐隐作痛，一阵一阵的痛。桂枝重用白芍。

大实痛拒按，很强烈的痛，桂枝汤加大黄。

桂枝加芍药汤方

桂枝三两。芍药六两。甘草二两炙。生姜三两切。大枣十二枚擘。

右五味，以水七升，煮取三升，去滓，分温三服。

甜味的东西会生湿，本来是湿就不要加饴糖下去。

临床治血癌，血癌是太阴症。小孩子得到血癌就是打小儿麻痹疫苗，小儿麻痹疫苗的后遗症，一个是脑瘤，一个是血癌。用桂枝汤重用芍药，他脾湿肚子很胀，然后加生附子，小孩子两钱，大人五钱六钱，重用，因为里寒很盛。他肚子胀，口不渴，晚上睡觉非常冷，里寒盛，胃口也不好，这个处方里我加了白术 茯苓，利湿，生附子，里寒湿一去掉，阳恢复就好了。怎么知道他好了，本来不能

睡的可以睡了，不能吃的可以吃了，大小便不好的，正常了，手脚本来冰冷热起来了。背后第五椎压痛是诊断血癌的，第五椎按下不痛了，好了。很多方法可以诊断。

#### 桂枝加大黄汤方

桂枝三两。芍药三两。甘草二两炙。生姜三两切。大枣十二枚擘。大黄一两。

右六味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

桂枝三，大黄一，因为是在脾脏阴脏里面，脾湿很盛，这时候攻下不要给他四两，如果阳明证可以四两，桂枝三两。芍药三两。大黄一。微下就可以，不要太重，他拒按，有燥矢在里面，又腹满，肚子很胀，桂枝汤加一点大黄就可以了。

#### 7——2

#### 第二百九十四条。

原文：「太阴」为病，脉弱，其人续自便利，设当行「大黄」、「芍药」者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。

这个人大小便本来就很多了，攻下的药要减轻，还有脉弱下去，原来是芍药加重，芍药减少，本来桂枝三，芍药六，芍药减少到五四，不需要。

太阴篇就是两症。他讲太阴没有讲到肺，因为脾统血，脾脏太湿，就会影响到造血功能，当影响到造血功能以后。脾和肺，脾是血，肺是气，治疗脾脏，脾功能恢复了，肺就恢复了，因为脾是肺的妈妈，所以重用治疗肺不一定非要去治肺，妈妈治好，儿子就好了。所以张仲景没有讲肺，太阴的时候是以脾为主，不以肺为主，当肺有问题，金匱有专门讨论如何治疗肺。太阴以脾为主。脾肿大，“以其人胃气弱，易动故也。”胃气不够强，药加重容易动到胃气。

以上讲的是太阴证。

#### 辨少阴病脉证并治法

少阴是心脏、肾脏。病会跑到少阴去，是因为在脾没有治好。心是火，肾是水，在血脉系统里是连到，所以用生附子会从肾脏一路跑到心脏去。

太阴积湿太盛有问题了，就介入到心和肾中间了，当湿往里走，还没进入肝的时候，会先经过心和肾，在这个阶段还有能力去阻止它。

脾统血，心生血，肝藏血，这三个脏有问题都会影响到造血系统。人会贫血的意思。

#### 第二百九十五条。

原文：「少阴」之为病，脉微细，但欲寐也。

少阴病，主要症状，脉是越来越微细，脾脏是浮而缓，脾脏脉慢慢变得长起来有力起来，代表自己恢复了。如果太阴的脉越来越细小，代表病一直在往里走。摸上去的脉是细微。

“但欲寐也”就是常常倦怠想睡觉。

脉微细，寒一直往里面跑，越跑越里面，就出现脉微细。为什么？影响到心脏了，心主血脉，脉变细小，心脏力量越来越小。

第二百九十六条。

原文：「少阴病」，欲吐不吐，心烦，但欲寐，五六日，自利而渴者，属「少阴」也，虚，故引水自救；若小便色白者，「少阴病」形悉具。小便白者，以下焦虚，有寒，不能制水，故令色白也。

少阴症太阴症不同的就是，太阴症湿很盛，自利不渴。少阴症自利会渴。自利下痢，津液伤到了以后，心上还有肺，津液跑掉，虚热会上来，会有渴的现象。少阴症会出现很多咽喉干燥。就是因为寒湿跑到心肾中间去以后，影响到心，心正常搏动产生的热，往下移进入小肠，现在中间隔到，寒湿太盛，心脏的火没办法下来，就会回逆，热往上，肺里面的津液会被蒸发掉。中间寒湿又很盛，在下痢。所以下面在下痢上面在口渴。当病还在脾脏的时候，心肾没有影响，所以没有口渴的现象。

“虚”张仲景说虚掉了，湿在中间。实的话，中焦有实要攻，这个是虚，不能攻。所以会“引水自救；若小便色白者，「少阴病」形悉具。”病人小便淡的跟白水一样，少阴症。小便正常是很清的淡黄。少阴里寒很盛，比太阴寒湿还盛，所以小便出来是白的，一点颜色都没有。

小便很黄，中黄，有放屁，小承气。深黄，屁都不放一个，大承气。小便很重要。小便白，少阴。

下焦虚要去补它，寒要用热药去它。“不能制水，故令色白也”不能制水不单单说小便不利，小便不能控制它，不是这个意思。而是说，小便没有气化出来。常态，中间没有湿，心的火往下导的时候，造成小肠火，小肠是阳，心是阴。阴火和阳火都是火，照理心脏和小肠的温度是一样的，这是常态。膀胱挡在小肠前面，膀胱里面有水，正常人，还有肾脏的水下来，进入到膀胱里面去，小肠挡在中间，小肠很热会把肾脏的水气化，气化以后从督脉上去滋润大脑。浊水进入膀胱，膀胱贴到小肠，再汽化一次，好的水汽化进入肝脏，水生木，肝脏得到水把肝的毒素清出来，变成胆汁，小便把浊水排出来。

因为中间寒湿隔掉，下焦冷掉了，心脏的火没办法下来，病人很渴，下焦小肠冷掉，水没法气化，肾脏的水直接流到膀胱里面去，从膀胱里面就流出来了，膀胱里面本来是热水，热水像气球一样会上升，膀胱里又四百毫升水是膨胀的状态，气往上升膨胀，有气才会有力量把小便喷射排出去，小便力量很强是正常。如果是冷水，在膀胱里面压迫到，冷水很重，如果是汽化的不会很急要上厕所。心藏神，神就是神灵欲望。肾脏病到后来便意都没有了，心神在上下不来了，他已经不知道他要小便了。

如果小便白，吃了药变成淡黄，代表药对了。

第二百九十条。

原文：病人脉阴阳俱紧，反汗出者，亡阳也；此属「少阴」，法当咽痛，而复吐、利。

病人寸脉迟脉都是紧的脉，应该给他发汗，还没有给他发汗，病人汗出。这

是亡阳。

阴寒在中间挡到心和肾的时候，里面是寒在里面，阳会往外跑。阳本来要进去，阳是什么，心和小肠中间的阳。心脏在不断的跳动，产生的热，这个热往下走进入小肠，现在心热下不去，里面寒掉了，阳会往外走，往外走的时候流汗，亡阳。心的阳要衰竭掉了。

“咽痛”心脏热没办法下去，就往上走，所以少阴就会有喉咙痛。

“复吐、利”湿很盛，湿往上走就会吐，往下走就会利。咽痛一定会有。

第二百九十八条。

原文：「少阴病」，咳而下利，谵语者，被火气劫故也，小便必难，以强责「少阴」汗也。

这个条辨就是讲，少阴症出现的时候，因为是里寒湿，绝对不要用汗法。汗法下去病人阳会更虚。里阳已经不够了，汗药都是阳药，一发汗他更受不了。

强发汗，病人心脏会受不了，严重的话，上面会咳，下面会下痢谵语，因为里面是阳虚掉了。

少阴症不要强力去发汗。

第二百九十九条。

原文：「少阴病」，脉细沉数，病为在里，不可发汗。

细代表寒，沉代表里，湿很盛。病为在里，不可发汗。是原则。但是在治症湿时候，里面寒湿去掉的时候，心肾开始交了，心火开始往下走，运动就会流汗。

第三百条。

原文：「少阴病」，脉微，不可发汗，亡阳故也；阳已虚，尺脉弱濇者，复不可下之。

少阴有的症状很像太阳伤寒。脉微，但欲寐，昏昏沉沉没有力，绝对不可发汗，亡阳。为什么会亡阳？病人少阴症阴很盛，又虚掉了，还在发阳，亡阳。

第三百零一条。

原文：「少阴病」，脉紧，至七八日，自下利，胸暴烦，手足反温，脉紧反去者，为欲解也，虽烦，下利，必自愈。

“胸暴烦”这里胸指胃的地方。

脾肺中间的寒湿到心肾中间的时候，寒湿去掉，他会自下痢，胸会爆烦，手足反温。

临床看，病人心脏痛，心脏病医院查不出来。自己失眠睡不好。他的脉也不是少阴病的脉。我就凭他一个失眠看，用少阴症的，黄连阿胶汤症。我用黄连阿胶汤加减。“胸暴烦”，他的脉很快速但是人没有力，他是虚数的脉，他的心脏好像引擎在空转，心脏在跳但是跟身体是分离的，对身体没有帮助到。病人说就是这个感觉。药吃下去，就好像引擎的力量突然爆发出去，会跑了。原来是空挡在

那边踩。一个礼拜回来，他说吃药以后，第三天中午，突然胸口很痛，就好像转轮那个带子，带子突然上去了，引擎那个动力回来了。一痛手脚开始热，之后精神来了，当天晚上就可以睡觉了。“爆烦”他的感觉就是这样子。

第三百零二条。

原文：「少阴病」，下利，恶寒而蜷卧，若利自止，手足温者，可治。

光看恶寒，像是伤寒，伤寒没有下痢。少阴症有下痢，因为寒湿很盛，拉肚子，会拉出来。

“手足温者”就是胃气还在。

治病只要有胃气在都是好治的。

第三百零三条。

原文：「少阴病」，恶寒而蜷，时自烦，欲去衣被者，可治。

“欲去衣被者”阳气回来了，体温回来。人的体温回来，心和小肠的热接轨了，心要移热到小肠，小肠移热到膀胱。

小朋友晚上踢被子都是正常。小孩子胃口不好，印堂中间一条青的，肚子痛。小建中汤症。小朋友晚上肚脐要遮好。不管怎么踢被子，肚脐不要露出来，把肚脐遮起来，吃小建中汤。

小孩子眼睛是偏的，晚上一定只点一盏灯。小朋友脖子没有力量，头不会动，眼睛找亮的东西。点两盏，小孩不知道看哪一盏，就正常了。

小孩子踢被子，因为小孩子纯阳之体，手脚很热，被子盖肚子上就好了。

第三百零四条。

原文：「少阴中风」，脉阳微阴浮者，为欲愈。

7——3

少阴症脉细沉。非常小的脉。现在微，而且慢慢浮起来了，阴阳要调和了。这是要好转的现象。

第三百零五条。

原文：「少阴病」，欲解时，从子至寅上。

第三百零六条。

原文：「少阴病」，吐，利，手足不逆冷，反发热者，不死；脉不至者，灸「少阴」七壮。

如果病人有吐、下痢的时候，手脚是冰冷的。手脚还发热者，代表胃气还在。可以灸少阴。太溪穴，复溜穴都可以灸。灸可以行少阴经的阳气。

第三百零七条。

原文：「少阴病」，八九日，一身手足尽热者，若热在膀胱，必便脓血也。

临床上看，都是肾脏、膀胱有结石才会出现热症。如果热在膀胱，必便脓血，便血有两种，小便利抵当汤，小便不利桃核承气汤。

第三百零八条。

原文：「少阴病」，但厥，无汗，而强发之，必动其血，未知从何道出，或从口鼻，或从目出，是名下厥上竭，为难治。

“但厥”有点昏迷的现象。“而强发之，必动其血”如果强发汗，动到他的血，有时候从口鼻出来，有时候从眼睛旁边流出来。所以少阴症的人不要强发汗。因为里面阴寒很盛，不可以用汗。

一般少阴症太阴症，利尿比较好。因为寒湿在中膈的时候，利尿是最短最近的路。

第三百零九条。

原文：「少阴病」，恶寒，身蜷而利，手足逆冷者，不治。

手足冷到手肘。这个不单单是手脚冷，都水肿起来了。

如果病人肾脏或心脏有问题，你帮他治以后，本来下痢不下痢了，手足冷也退掉了，也不会那么疲劳，就是阳回来，治对了。

第三百一十条。

原文：「少阴病」，吐，利，躁烦，四逆者，死。

吐和下痢手脚又病了的。这里烦躁，不单单是情绪，而是手脚躁动。阳要离开身体，最后一个挣扎的现象。这都是死症。

第三百一十一条。

原文：【少阴病】，下利止，而头眩时时自冒者，死。

在治疗尿毒肾脏病的时候，有两个最明显的症状，病人晕眩，呕吐。东西吃下去就吐。

“头眩”如果小肠的热跟心脏是同温度，肾脏的水会第一次征用，水气会非常好，从督脉进入脑部去。这个水会去滋润脑部。

肾脏功能衰弱下去了，病人在下痢了，津液往下走，脑部会缺水。却这个营养的时候会头昏。

进入少阴症会影响到心脏和肾脏。一般进入阴症，造血功能就不行了。相对一定会看到贫血情形。当在治他，把小肠的温度恢复的时候，肾脏里面有阳，命门有阳，阳气很盛，水气从督脉进入脑部。这个水气化上来以后，到脖子，把水稍微冷一下，进入头部。肾脏的水进入头部，昏眩的现象就没有了。

第三百一十二条。

原文：【少阴病】，四逆，恶寒而身蜷，脉不至，不烦而躁者，死。

讲到四逆就是，手指头已经冷到手肘，脚趾头已经冷到膝盖。

“不烦而躁者”手脚在抖了。阴阳要相隔了，阳要往外走了。寒湿非常盛。还没有到厥阴，心肾衰竭死掉了。

第三百一十三条。

原文：「少阴病」，六七日，「息高」者，死。

「息高」呼吸很短，吸一点气就吐出来。吸气的时候，气要到肺，心肾衰竭，肺没有办法完全张开来，水已经满到很高的地方，横膈膜没有办法下降，呼吸会非常短。

**进到少阴症的时候，就看到死症了。**

第三百一十四条。

原文：「少阴病」，脉微细而沉，但欲寐，汗出不烦，自欲吐，至五六日，自利，复烦躁不得卧寐者，死。

少阴症无汗，用小便排出来，你帮他治疗精神好起来，运动才有汗，是对的。

“但欲寐，汗出不烦，”睡觉不动还在流汗，代表阳一直在往外走。里面阴很盛，阳一直在往外走。

**里面寒湿很盛，少阴症兼有下痢的情形。又烦躁不得卧，当阳要绝的时候，要离开身体的时候，都会但坐不得卧。做到那边没有办法躺平睡觉，或者会烦躁。这些都是死症。代表阴阳相隔，阳要离开身体了。**

第三百一十五条。

原文：「少阴病」，始得之，反发热，脉沉者，「麻黄附子细辛汤」主之。

麻黄附子细辛汤方

麻黄二两去筛。细辛二两。附子一枚，炮，去皮，破八片。

右三味，以水一升，先煮麻黄，减二升，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

处方比例：麻黄二钱。细辛二钱。炮附子三钱。

麻黄附子细辛汤最主要是利小便。

当心肾中焦是寒湿的时候。炮附子如果跟细辛在一起。细辛能去积水，下焦积水，在肠子里的积水。细辛去积水跟茯苓不一样，茯苓泽泻猪苓这些只是利水。细辛比较热，所以能把寒水化掉。细辛还有一个功能，细辛在寒咳的时候，也会用到细辛，最主要是它能去水。

麻黄能发阳，把阳气发起来，所以他也是能够利水的一个药。所以说如果把麻黄附子细辛放在一起的时候，这个药不会走表，也不会发汗，它会跑到身体的正中间去，因为它是阳的重用的部位，少阴症本来就是里阳不足，里面是寒湿阳往外走。这个时候开麻黄细辛附子可以把里面的寒湿去掉。炮附子，是有固阳的功能。这三个药吃下去是小便解，不是得汗解，次数会很多，量会很大。吃到脉浮起来，吃到小便正常。



麻黄附子细辛汤是但欲寐，脉沉细，主力的方子。它能够把中焦的寒湿都能够去掉。如果是关节上的寒湿这个没有用，会用炮附子去寒，桂枝祛风，白术来去湿。

#### 大黄附子细辛汤方

大黄二。细辛二。附子三。

这个处方用的时候是寒实。麻黄附子细辛汤是寒湿在中膈。大黄附子细辛汤是寒实在大肠。大肠没有蠕动，便秘，没有屁，七八天不便秘也不难过。如果是阳明燥矢，承气汤症的时候，他便秘一定很痛，很难过，肚子会绞痛。完全没有感觉痛，小便淡白，这个时候，小便淡白代表病在少阴。大黄附子细辛汤方，大黄能够去实，附子能够去寒，细辛能够去中间湿。药吃到小便颜色变成淡黄，手脚温热起来，就可以停掉了。

攻下的处方遇到寒实的时候会用到大黄附子细辛汤，热实才会使用承气汤。

#### 第三百一十六条。

原文：「少阴病」，得之二三日，「麻黄附子甘草汤」微发其汗，以二三日无里证，故微发其汗也。

本来少阴症不发汗的，这里可以微发汗，因为刚得到少阴症，里寒还没有结很实，稍微发一点汗没有关系。这时候用「麻黄附子甘草汤」甘草可以润肠。发一点点汗，没有关系。这是少阴症，脉弦细，但欲寐。但是刚得到，发一点汗没有关系。

#### 麻黄附子甘草汤方

麻黄二两，去节。甘草二两，炙。附子一枚，炮，去皮。

右三味，以水七升，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。

#### 第三百一十七条。

原文：【少阴病】，得之二三日以上，心中烦，不得卧者，【黄连阿胶汤】主之。

【黄连阿胶汤】是少阴症虚烦不得眠的主力处方，我常常用到心脏功能不好，肾脏功能不好。心肾中间是少阴，寒湿很盛的时候，梗在中间，造成心火没有办法下达。心肾没有办法相交，水火不相交。

#### 黄连阿胶汤方

黄连四两。黄芩一两。芍药二两。鸡子黄二枚。阿胶三两。

右五味，以水五升，先煮三物，取二升，去渣，纳胶烊尽，小冷，纳鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

这五味药蛋黄和阿胶先不煮，黄芩黄连芍药五碗水煮成两碗，把渣去掉再放阿胶，不要煮，煮过之后阿胶就没有力量。等温的时候，放鸡蛋黄下去，蛋白不要。热的时候成蛋花汤没有用，一定温的时候，生鸡蛋黄丢下去，和一和。

因为寒湿很盛的时候，为什么会失眠？因为心血不够，心生血，脾统血，一旦影响到心脏脾脏的时候，就会贫血，黄连阿胶汤是治疗心血不足的时候使用。苦味药入心，黄连苦味入心，对心是滋补的。心藏神，肝藏魂，肺藏魄。心中永远有一滴血停在里面，神就藏在那一滴血里面，新的血取代旧的血，这滴血永远是在中间。少阴症很重的时候，血会伤到，这滴血会没有，当这滴血失去之后，心藏神，神就没有办法藏在心里面了，神就往外游，会失眠。阿胶能够补血，阿胶补血怎么那么凑巧补到心脏？这就要加鸡蛋黄，中药是取药性，要让阿胶悬浮在正中间，正好就像心脏那一滴血一样，只有鸡蛋黄永远是浮在中间，所以要用鸡蛋黄的性，把它导到里面去。这才是真正黄连阿胶汤的意思。生蛋黄下去，阿胶下去，苦味的药入心，苦味药把阿胶带到心脏中心，停到那就要靠蛋黄。所以这个药吃下去，就补那一滴血。不用鸡蛋黄不行。不加蛋黄药吃下去不能睡，蛋黄一下去就能睡。

临床上碰到脉沉细，手脚冰冷，口渴，大便一天三四次，溏泻，失眠。就是黄连阿胶汤。一剂下去就中。

第三百一十八条。

原文：【少阴病】，得之一二日，口中和，其背微恶寒者，当灸之。

少阴病，“其背微恶寒者”背上哪里冷灸哪里就好了。少阴病只要是没有口渴，津液没有问题，可以用灸的方式把寒湿去掉。怎么知道灸哪里？寒湿在哪里哪里就冷。少阴症灸很好。

第三百一十九条。

原文：【少阴病】，身体痛，手足痛，骨节痛，脉沉者，【附子汤】主之。

“身体痛，骨节痛，脉浮紧”标准的麻黄汤症。手足痛，脉沉者，病在里，寒湿在里面。如故寒在表的时候，单是一个寒，是麻黄汤。寒湿在里造成身体痛，骨节痛的时候，肌肉痛，这个时候用附子汤。

附子汤方

附子二枚，炮，破八片。茯苓三两。人参二两。白术四两。芍药三两。

右五味，以水八升，煮取三升，去渣，温服一升，日三服。

附子二枚，就是六钱，重用附子。茯苓三钱。人参二钱。白术四钱。芍药三钱。

白术比茯苓多一点点。这里如果把人参，换成生姜就是真武汤。真武汤是下焦有寒水，头会昏眩，头重脚轻，真武是一个神，专门管世界上的水。真武汤用茯苓用的比较多，白术用的比较少，因为它要把水排掉。这个附子汤不是，附子汤是要去寒去湿，所以它要靠大剂的炮附子下去，白术去湿，茯苓加一点不要加太多，让它慢慢出来，同时人参怕津液伤到，少阴症只可以利尿，不可以发表，也不可以攻下，里面是寒湿的。芍药温补。

当血有问题的时候芍药，气有问题的时候人参。附子能够同时管心脏管肾脏。白术茯苓把中间的湿去掉，病是由太阴进到少阴的，所以进来后脾和肺是两虚，人参来补肺，白芍来补脾。张仲景最多到这个阶段，不会开滋阴的药开很多。开

很多，病人虚的话，病人不但不会接受，反而是负担，所以药简力专。他这五味药把心肾脾肺统统解决掉了。

这里身体会痛是虚痛，里面寒湿很盛的时候造成的痛，所以用附子汤。附子汤附子用三钱，就没有用了，这里身体痛脉沉，最主要是寒症，去寒的药加的不够，没有办法化掉。

第三百二十条。

原文：【少阴病】，下利便脓血者，【桃花汤】主之。

脓血是跟大便混在一起的。现在西医讲的大肠癌，大肠炎。

【桃花汤】煮起来是红色的，所以叫桃花汤。

一般少阴症下痢不止，就危险，就死掉了。

桃花汤方

赤石脂一斤，一半全用，一半筛末。干姜一两。粳米一升。

右三味，以水半升，煮米令熟，去渣，温服七合，纳赤石脂末，方寸匕，日三服，若愈，余勿服。

比如说赤石脂用五钱，两钱半煮，两钱半打碎生用。主力是赤石脂，干姜在旁边温中，加一点点粳米，能够增润肠的津液。粳米是甜米，谷的气能够停里面。

7——4

粳米不能太多，一个汤匙就够了。这个药是涩剂，会让食物停在里面排不出去。桃花汤跟大黄附子细辛汤刚好是反的，大黄附子细辛汤是希望排出去，所以用大黄。这里要用涩剂，这个下痢可能一天二三十次。

第三百二十一条。

原文：【少阴病】，二三日至四五日，腹痛，小便不利，下利不止，便脓血者，【桃花汤】主之。

下痢不止的时候，水都排掉了，当然小便都没有了。一定会有腹痛。

第三百二十二条。

原文：【少阴病】，下利便脓血者，可【刺】。

如果刺的话，关元、天枢、中极可以针灸看看。

第三百二十三条。

原文：【少阴病】，吐剧。手足厥冷，烦躁欲死者，【吴茱萸汤】主之。

经方里，生姜也可以止呕，半夏也可以止呕，干姜也可以止呕，吴茱萸也可以止呕。吴茱萸是用在阴症的时候。手脚是胃气的强弱，吐的厉害的时候，手足冰冷，用吴茱萸来治。

吴茱萸汤有：吴茱萸一升洗。人参三两。生姜六两切。大枣十二枚劈。人参

吐很严重，胃津液伤到了。生姜能够把胃里面的水散掉，吴茱萸能够止呕，止恶心。人参生姜红枣是滋阴的药，吴茱萸是主力治疗恶心呕吐的药。

在阴症的时候，出现恶心会使用吴茱萸，如果是阳症，胃里面停水很多，恶心会用到生半夏。或者干姜也可以止呕，温中。生半夏能够去胃周围的水，都可以止恶心。

第三百二十四条。

原文：【少阴病】，下利，咽痛，心烦者，【猪肤汤】主之。

少阴病就是寒湿挡在心肾中间，让心和肾没有办法相交，心的火往上走造成咽痛，肾的寒水往下走，造成下痢。

猪肤汤方

猪肤一斤

右一味，以水一斗，煮取五升，去渣，加白蜜一升，白粉五合，熬香，和令相得，温分六服。

猪皮会煮出胶质出来。加白蜜，白粉，白粉就是米粉。

用这种方法把失去的津液补回去。这里下痢不是便脓血。猪皮煮过不加任何东西还是白色的，色白入肺，肺里津液不够了，热往上跑才会造成咽痛。他用这种方式把津液补回去。张仲景认为这种食补没有关系，如果用补药用太多，补能恋邪，当有病邪在身上的时候，如果吃到补药，就像打狗又给它骨头吃，它不会走。所以不用补药，用食物的方式把津液补回去。

少阴症，心脏肾脏有问题的时候，我就让他们煮米粉汤吃，很多米粉汤都有放猪皮在里面。

猪皮汤是补阴的，因为下痢很重，去滋阴的药。

我们有两种，一种下痢是水。一种是血，脓血出来，大肠炎的时候不要用猪肤汤，用桃花汤。

第三百二十五条。

原文：【少阴病】，二三日咽痛者，可与【甘草汤】；不差者，与【桔梗汤】。

这个比较轻的，喉痛。甘草汤就是单味的甘草去煮，如果吃了甘草汤没有好，甘草是滋润的，因为他上面的津液不够了，再开桔梗汤。

甘草汤方

甘草二两

右一味，以水三升，煮取一升半，去渣，温服七合，日一服。如果单味药，开一两二两没有关系，甘草二，桔梗一。

【桔梗汤】就是甘草加桔梗的复方，叫桔梗汤。

桔梗是去痰湿。金匱里讲到一篇会用到桔梗，那是口吐白沫，咳出来或吐出

来是白白泡沫，会用到桔梗。桔梗出来，是白色泡沫的痰，没有什么颜色。

### 第三百二十六条。

原文：「少阴病」，咽中伤，生疮，不能语言，声不出者，「苦酒汤」主之。

苦酒就是醋。平时可以一瓶醋，放点生半夏在里面，冷藏。平常泡在那边，泡时用醋，张仲景那个朝代都没有白醋，都是米醋。泡了很久了，放在那边。病人来了，半夏苦酒汤，不能吃东西，声音没了。拿一个鸡蛋，蛋黄不要了，用汤匙捞大概两颗生半夏，生半夏已经泡开了，跟蛋壳里的蛋清，里面还有一点醋和在一起，和一和，用酒精灯或者蜡烛、打火机在蛋壳下面烧一下，很快，看到起一两个泡泡，马上熄火，大概只能一分熟，拿给病人，喝下去。

最重什么都吞不下去了，还有巴豆贝母，弄成牙膏黏黏的，用管子吸起来，喷到喉咙里面去。一喷进去打个洞出来，所以不能乱喷，喷到舌头上，舌头打个洞，巴豆腐蚀性很强，所以要对的很准。不小心吸进去很痛，像烧的一样，喝杯冷水吐掉就好了，巴豆碰到冷水，当场毒就解掉了。就好像吃硫磺怕中毒，中毒的话全身麻，不能动，吃鸭肉汤当场就解掉了。当医生要能收能放。没办法就喷，打个洞下去，比半夏苦酒汤强十几倍，非常迅速。

半夏苦酒汤不要泡白醋泡黑醋力量比较强。

### 苦酒汤方

半夏洗破，如枣核，大十四枚。鸡子十枚，去黄，内上苦酒，着鸡子壳中。

右二味，纳半夏，着苦酒中，以鸡子破，置刀环中，安火上，令三沸，去滓，少少含咽之，不差，更作三剂。

### 第三百二十七条。

原文：「少阴病」，咽中痛，「半夏散」及「汤」主之。

### 半夏散及汤方

半夏洗。桂枝去皮。甘草炙。以上各等分。

以上三味，各别捣筛已，合治之，白饮和服七寸匕，日三服，若不能散服者，以水一升，煎七沸，内散两方寸匕，更煎三沸，下火令小冷，少少咽之。

这里炙半夏没有用，要用生半夏。生半夏，本身甘草可以解半夏的毒，生姜也可以解半夏的毒。加上桂枝，很凶的。用散比较好。如果不能散服用汤剂给他吃。这个是专门去喉咙痛。我讲的喉咙痛不是扁桃腺发炎，那是小题大做。你巴豆贝母是小题大做，巴豆贝母是到后来喉癌，才会用到的，这个喉咙生疮化脓的时候，整个喉咙发炎了，非常痛，可以用半夏散。

大部分吞不下东西的时候，我都用半夏苦酒汤，一般来说喉咙痛化脓发炎，还能吞东西我用半夏散。

这个下去喉咙发炎就去掉。生半夏去水，水是生万物的，喉咙老发炎生疮，喉咙里面有水在那边，病毒环境很好，生半夏下去，水没了。炙半夏没效，一定要用生半夏。

第三百二十八条。

原文：「少阴病」，下利，「白通汤」主之。

当我们去治利的时候，如果是脓血桃花汤。这个下痢不止是里面寒掉了，里面寒湿很盛。

白通汤方

葱白四茎。干姜一两。附子一枚，生用，去皮破八片。

右三味，以水三升，煮取一升，去滓，分温再服。

附子用的时候要用棉布包起来。附子一枚，大的差不多五钱，少的三钱也有。干姜一钱。葱白四茎，放在一起。三碗水煮成一碗。去下痢。

葱白，上下通利的时候用葱白，这里没有用炙甘草，炙甘草对下利没有什么帮助。这里会利，是因为寒湿，附子能够通神经，血脉，干姜能够温中去寒。寒利不止白通汤。热力不止桃花汤。

第三百二十九条。

原文：「少阴病」，下利，脉微者，与「白通汤」。利不止，厥逆无脉，干呕烦者，「白通加猪胆汁汤」主之。服汤，脉暴出者死，微续者生。

脉微细都是少阴症，吃了白通汤，下痢还是没有停，这时候，手脚冰冷，更严重了，白通加猪胆汁汤。吃了这个汤，脉突然崩出来，代表阳绝了，都没救了，微微，慢慢回来的都会好。

白通加猪胆汁汤方

葱白四茎。干姜一两。附子一枚，生用，去皮破八片。人尿五合。猪胆汁一合。

右三味，以水三升，煮取一升，去滓，纳胆汁、人尿，和令相得，分温再服，若无胆亦可用。

煮的方法，前三味药，葱白、干姜一、附子。猪胆汁和人尿不煮的。六碗煮两碗，加入人尿小酒杯五杯，猪胆汁一碗。

人尿又叫回龙汤。唐容川讲每天早上起来喝一杯回龙汤。比如山东人吃水饺，再喝水饺汤，原汤化原食。这是物的性。比如，吃鱼鱼骨头卡住了，过去的中医就把同一只鱼的骨头，用火烧焦黑，打碎变成灰，当药粉水冲下去，一阳一阴，一结合骨头就会掉下去，化掉。人尿小便排出来的，要喝自己的尿，原汤化原食。猪胆汁内服帮助消化，因为胆没有功能了，暂时取代人的胆。人尿过去用童子尿，我的老师，他的腰闪到，自己没有把法扎针，他找童子，弄一泡尿回来，喝下去大概二十分钟，他感觉腰的活力很强，腰的命门的地方一直在动，痛开始慢慢舒缓下来，热力慢慢扩散开来，就好了。他说童子尿很强，进到命门的地方，童子是纯阳的。

7——5

他有恢复命门火的功能，因为回龙汤。原汤化原食，人尿简单说就是帮助消

化。猪胆汁也是帮助消化。

张仲景在研究这个白通汤的时候，看这个症状，一般少阴病下痢，脉微者，病人有少阴病下痢，脉微者，脉症相合。中医看病最怕脉症不和，明明人很虚，摸到脉很大，这都是危险。或者人很壮，摸到脉很小，这都是脉症不和。脉症不和都是危险的症状。

俗话，男怕脚肿，女怕头肿。当发现男是脚肿，女是头肿，是逆症危险的时候，知道他是危险的时候，病人没感觉，你摸他脉很小，很危险。

这里脉症是相合的，白通汤就可以了。

“利不止，厥逆无脉，干呕烦者，”里面里阳没有了，阴很盛，就会干呕，烦躁，手脚逆。这个时候，因为里面的阳没有了，阳是动能，消化能力没有了，所以会白通汤加上人尿，猪胆汁。要一搏，到这个阶段无所谓了。如果吃下去，脉暴出者死，暴出就是身体不接受，如果是微续的，慢慢回来，表示身体在继续接受药。所以如果遇到危症的时候，脉是慢慢回来的，都是很好的现象，可以一搏。

张仲景说找不到胆汁，人尿就可以了。

看药典的时候，人尿童子尿专门治跌打损伤。腰痛，强烈的腰痛。

第三百三十条。

原文：「少阴病」二三日不已，至四五日，腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利者，此为有水气，其人或咳，或小便利，或下利，或呕者，「真武汤」主之。

“「少阴病」二三日不已，至四五日，”就是病慢慢深入下去了。伤寒论只要出现“或”，就是有时候有这个症状，有时候没有这个症状。

真武汤和附子汤很接近。把附子汤里面的人参拿掉，换成生姜就是真武汤。真武汤是里寒用的，小便不利，关节四肢沉重使用的。

“腹痛”经方在腹痛的时候，当然真武汤有白芍，主要还有炮附子在里面，痛是寒，里面有淤血。但是如果只开活血化瘀的药，没有开去寒的药，这个痛不会去，所以一定要去寒。腹痛的时候，不单单是白芍，炮附子下去，所以有芍药甘草附子汤。热药是去寒用的。

这个汤就是里面水气很盛，自己已经在排了，会自己下利。水气停在里面，小便不利，小便小不出来，自下利，从大便排出来。沉重疼痛，里面是寒湿很盛。

真武汤症，里面水不排掉，一动的时候，头会很昏。真武汤症里面寒湿的时候，水盛的时候会头重脚轻的感觉。常常要晕倒的感觉。

真武汤方

茯苓三两。芍药三两。生姜三两。白朮二两。附子一枚炮。

右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服七合，日三服。

真武汤的时候，茯苓比白朮多，最主要是把水利出来，去湿的药开的比较少，

利湿的药开的比较多一点。芍药可以去腹痛，炮附子可以去里寒，同时也可以去腹痛。八升就当成八碗，煮成三碗，把渣丢掉，一天三次。

### 真武汤方加减法

若咳者，加五味子半升，细辛、干姜各一两。若小便利者，去茯苓。若下利者，去芍药，加干姜二两。若呕者，去附子，加生姜，足前成半斤。

如果有咳嗽加五味子，一般来说五味子用两钱或者三钱都可以。五味子治咳非常好，但是五味子治咳，是里面有水气的时候，引起的咳。干姜能够温中，因为里面有水，干姜是胃，细辛是下焦，肚子。所以麻黄附子细辛汤，下焦的寒湿靠细辛来升提阳气。如果小便很利，我们知道茯苓是利尿，把茯苓拿掉。如果拉肚子很严重，把芍药去掉。芍药活血化瘀的动能有，又有滋阴的功能，下痢很严重的，可以把芍药拿掉，加干姜下去，干姜能温中。若呕者去附子加生姜，恶心出来的时候，用生姜，因为这个是代表胃里面有水，干姜已经有了，还要用生姜，干姜是温中，但是干姜不能去胃里面的停水，还有恶心的时候我们要用生姜。前面已经有生姜了，再加重，跟前面合起来有半斤，大概四五片生姜，也可以多一点。

### 第三百三十一条。

原文：「少阴病」，下利清谷，里寒外热，手足厥逆，脉微欲绝，身反不恶寒，其人面色赤，或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止，脉不出者，「通脉四逆汤」主之。

少阴会有问题，是因为太阴有问题，太阴的寒湿，没好，越来越盛，影响到少阴。

中焦都是寒湿，下痢清谷，代表里面很冷很寒，东西不消化。这种状况下，里面是寒外面是热。常人里面应该是热的，外面是冷的，所以你摸到皮肤上是冷的，病人身体上是热的。

人正中心的地方是心脏搏动，跟小肠中间有个大动脉，正常的心脏搏动到小肠去。里寒外热，下痢清谷，代表里面寒湿太盛。手脚厥逆，手脚的温度是根据肠胃的温度来的，脾主四肢，所以手脚冷。一般的手脚冷，不见得到手肘，如果手冷到手肘，脚冷到膝盖的时候，就叫做厥逆。四逆汤就是冷到手肘膝盖了，如果手脚冷就是手脚冷，他不会讲四逆。

“脉微欲绝”里面寒湿很盛。“或腹痛，或干呕，或咽痛，或利止，脉不出者，「通脉四逆汤」主之。”为什么会有利止的现象，因为里面寒湿到了一个阶段以后，寒越来越盛的时候，里面阳已经快绝了，阳要绝，往外走的时候，脸上会看到赤色，这个赤色不应该出现的时间出现，比如说，我们出现的冬天，冬天应该颜色暗一点，但是他看到脸色红的，就是里阳往外走。所以红润的颜色应该是在夏天的时候，春夏的时候，而且红色是均匀的。像他这种面色赤是两颧的地方，这种都是不对，里寒很盛。

通脉四逆汤跟四逆汤有点差异。通脉四逆汤，

通脉四逆汤方



甘草二两炙。附子大者一枚，生用，去皮，破八片。干姜三两。

右三味，以水三升，煮取一升二合，取滓，分温再服，其脉即渐出者愈。非若暴出者之自无而忽有，既有而仍无，如灯火之回焰也。面赤色者，加葱九茎。腹中痛者，去葱，加芍药二两。呕者，加生姜二两。若咽痛者，去芍药，加桔梗一两。利止，脉不出者，去桔梗，加人参二两。

如果把干姜减一般，就是一般的四逆汤。重用干姜的时候，就代表要胃中，里面太冷了。

心脏搏动移热到小肠，就是经过这个大动脉到小肠里面，当里面寒掉了，中焦冷掉，中焦开始寒的时候，有一种病就是动脉血管剥离，就是心和小肠中间的动脉破裂。这个可以预测的。像没事在那边下痢，里寒外热的时候，为什么会破裂，寒很盛的时候会爆裂掉。有两种\*\*，一种是里面堵塞掉了，一种是血管破裂掉了，如果是淤血跑回心脏堵塞掉了，也是寒。你的末梢如果太冷的时候，血会结块。所以用炮附子下去，很热就化掉了。所以当病人四逆，手脚冰冷的，下痢不止，我们知道里寒很盛，看到他里寒的时候就赶快治，不治好动脉血管会剥离。

“其脉即渐出者愈”因为寒是渐渐化掉的。

“面赤色者，加葱九茎。”葱白能够通表里。色白入肺，辛辣也是入肺。为什么不用蒜，蒜色白入肺，但是葱像个管子一样，同时像毛孔。

“腹中痛者，去葱，加芍药二两”肚子痛会用芍药，它已经有生附子在里面了。

“呕者，加生姜二两。”生姜和干姜同用。两个功能不一样。

“若咽痛者，去芍药，加桔梗一两。”桔梗是治疗喉痛的很好的方子，但是桔梗最主要是化痰。

“利止，脉不出者，去桔梗，加人参二两。”就是告诉你，他是虚症，桔梗治痰，但是桔梗不补虚。脉不出就是气脉还没有回来。利停止了，代表病人回来了，但是很虚，才会加人参。

第三百三十二条。

原文：「少阴病」，四逆，其人或咳，或悸，或小便不利，或腹中痛，或泄利下重者，「四逆散」主之。

四逆散方

甘草炙。枳实破，水渍，炙干。柴胡。芍药。

右四味，各十分，捣筛，白饮合服方寸匕，日三服。咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利。悸者，加桂枝五分。小便不利者，加茯苓五分。腹中痛者，加附子一枚，炮令拆。泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，去滓，以散三方寸匕纳汤方，煮取一升半，分温再服。

柴胡疏肝，枳实能够扩张管道，比如胆的管子太窄了，或者是大肠的管子太小了，燥矢在里面了，心脏血管太小了也可以用枳实，胸满的时候，张仲景都在用枳实。芍药腹中痛。这个痛怎么跑到少阴来，心脏外面心包，心包有一条脉络

到胆囊上面，心脏在搏动，心包跟着心脏的速度来，所以胆汁出来的速度跟心脏搏动的速度相通。当中焦寒湿很盛，会影响到胆囊，寒湿很盛，身体不消化，寒湿在外面，里面太干了，会造成这种结果。

四逆散在治胆结石，胆发炎非常好用。胆结石胆堵到，痛的要死，肚子痛，手脚是冷的，所以处方去湿去热，没有什么去寒的药，增润一些津液在里面。

四逆散治疗最多的就是胆结石，除了可以加滑石，还可以加五倍子，海金沙。五倍子是虫的壳，刚好结在树枝分叉的地方。海金沙结在树叶跟树枝分叉的地方，褐色咖啡色，就像胆的位置，所以会用海金沙。一般原因是胃寒引起的，四逆症，里面寒湿，胆汁会越来越浓。还有一种原因是地域。

“咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利。”这个方子为什么跑到这里来，有点疑问。中间可能少掉东西。平常张仲景的方子是几两，这里几分不太合理。咳嗽加五味子干姜是很合理的。干姜温中，咳嗽是五味子。

“悸者，加桂枝五分。”心下悸是桂枝，脐下悸是茯苓甘草汤。

“小便不利者，加茯苓五分。”茯苓本来就是利尿的。

“腹中痛者，加附子一枚，炮令拆。”为什么不用白芍，炮附子热把寒去掉。

“泄利下重者，先以水五升，煮薤白三升，去滓，以散三方寸匕纳汤方，煮取一升半，分温再服。”薤白在胸牌篇会介绍到，薤白就是大蒜味，入肺。下痢很重的是时候，因为里面是热，才会用到柴胡，枳实。用薤白能宣肺，肺跟大肠是表里，因为他不是寒利，所以用薤白，一宣肺，汗一出来，利就止掉了。

第三百三十三条。

原文：「少阴病」，下利六七日，小便不利，咳而呕，渴，心烦不得眠者，「猪苓汤」主之。

照理“下利六七日”应该脱水了，造成小便不利。

「猪苓汤」本来是去水热，有水积在里面，有热，热就是发炎。里面小便石头堵到了。照理说下痢以后病人应该是津液不够了，应该补津液。

“渴”有热才会渴，寒症没有渴。

“心烦不得眠者”肾结石堵到了，当然烦躁了，身体里面不舒服有痛。这种都是猪苓汤。是水热并结。照理说热不会累积东西，寒才会累积，热是东西堵到了。

7——6

大家只要知道猪苓汤的功能，一般是石头沙堵到，真正很大的石头堵到的时候，猪苓汤还不够力。金匱还有方子。

第三百三十四条。

原文：「少阴病」，得之二三日，口燥咽干者，急下之，宜「大承气汤」。

“口燥咽干者”照理少阴病不会有口燥咽干，这还是大承气汤症。如果有阴

证的时候，看到阳明证，这种都是很好，就是病回头。阴症不要看到阴，看到阳症代表好。

### 第三百三十五条。

原文：「少阴病」，自利清水，色纯青，心下必痛，口干燥者，急下之，宜「大承气汤」。

有一种燥矢宿便，是大便很大堵到，旁边一点点小缝隙，一般大便通不过去，只有水能通过去，拉出来的是水。病人说下痢，一天二三十次都是水排出来，你要小心，一种真的是寒利，一种根本是承气汤症。你压他肚子，一压很痛，拒按，小便是深黄色，这个时候，病人的下痢是因为便秘。病人气色光鲜，舌头很黄，还在下痢，应该是便秘。真实少阴症的时候，大黄附子细辛汤，病人很安静，阳症的时候病人很闹。

### 第三百三十六条。

原文：「少阴病」，六七日腹胀不大便者，急下之，宜「大承气汤」。

如果是少阴病，六七天不大便了，肚子很胀，一看他是大承气汤症，就用大承气汤攻，只要有症在就可以使用他。

如果少阴症，他是腹胀，他并没有感觉到大便很难过，小便是淡白的，这个就不是大承气汤。是大黄附子细辛汤症。

### 第三百三十七条。

原文：「少阴病」，脉沉者，急温之，宜「四逆汤」。

少阴病本来就该脉沉，是里面寒湿，这时候急温他，这时候四逆汤。四逆汤和通脉四逆汤就是干姜的剂量不一样而已。

所以在预防心脏周围动脉血管剥离的时候，病人一出现少阴症马上下手，温中，干姜下去就可以预防破裂。

### 第三百三十八条。

原文：「少阴病」，饮食入口则吐，心中温温，欲吐复不能吐，始得之，手足寒，脉弦迟者，此胸中饮实，不可下也，当吐之；若膈上有寒、干呕者，不可吐也，急温之，宜「四逆汤」。

“心中温温”就是胃。

“手足寒”跟四逆不一样。

“脉弦迟者，此胸中饮实，不可下也，当吐之”这个看着像少阴症，实际上他是吃东西梗到了。胸中有饮实，要吐它。吃东西梗到食道里面，要吐它。

“若膈上有寒、干呕者，不可吐也，急温之，宜「四逆汤」。”这个是让你去分辨有寒湿，或者是里面有东西堵到。

这个很好分辨，看那个人的气色，急的像猪肝脸色一样，就是梗到了。病人很虚弱，脸色苍白，一副阴寒的样子，干呕，恶心打嗝，都是寒症。临床上一看

就知道，不会弄错的。

### 第三百三十九条。

原文：「少阴病」，下利，脉微濡，呕而汗出，必数更衣，反少者，当温其上，灸之。

「少阴病」，下利，因为肾主二便，下痢里面寒湿，自己在排。一般来说少阴症只要不断的下痢，恶心汗出，代表阳一直在虚，在流失津液的时候，应该常常在跑厕所。这个人反而没有。少阴症如果在恶化的时候，应该是越来越严重，“反少者，”他下痢自己停掉，可以灸他，这个不是很严重。灸就可以了，可以灸神阙关元就可以了。

### 辨厥阴病脉证并治法

厥阴产生的原因，太阴没好，影响到少阴，少阴再没好，阴寒会进入厥阴，进到肝脏里面去。厥阴是肝跟心包。肝合胆，胆就靠心包来推动它，才能排胆汁。

到了人体最后一个防线的时候，里面有元阳在里面，所以从太阴到少阴看到的都是阴症，等到厥阴的时候，就寒热并见。寒多热少就完蛋了，热多寒少就有救。

### 第三百四十条。

原文：「厥阴」之为病，消渴，气上撞心，心中疼热，饥而不欲食，食则吐蚘，下之，利不止。

所谓厥，阴的尽头。正常人，太极可以看到，阴和阳是循环的，常人阴和阳是相辅相成，到肝里面去了以后，因为肝里面有阳，所以它能够回头，不断的循环走。如果到肝里面不回头了，一直呆在里面就完蛋了。所以阴阳要不断的循环。

厥代表阴的尽头，阴的尽头就是阳之初了，应该要有阳气的，这是正常。不能阴到了尽头累积，越累积越多，结果变成实证了，阴实阳虚掉了。阳没了就出事情了。

“「厥阴」之为病，消渴”口渴，喝水不能止渴。

“饥而不欲食”肚子饿又不想吃东西，他有饿，代表说他有热，但是又有寒在里面。寒热并结在这个地方。

“心中疼热”胃中疼，胸腔食道里面很辣。

“气上撞心”厥阴的时候，寒湿很盛，已经顶到肝去了，寒湿入到肝里面去的时候，肝就慢慢肿大了。肿大之后，中膈已经分隔开了。上和下分隔开来，因为中焦寒湿很盛。呼吸的气应该往下走，下不去，中间都是寒湿，整个中焦堵满了，所以会上撞心，呼不下去。

如果不去治他，第一个现象，吃东西会有吐蚘。虫会吐出来。如果攻他，攻下的药大部分都是寒凉的药。而他并不是真正有燥矢在里面，他是有寒湿在里面。你一攻下，寒药再配上里面的寒湿，造成病人下痢不止。

他这个腹胀并不是真正有大便在里面。胃里面很寒的时候，会吐虫出来。为

什么会有蛭虫，就是因为有寒湿。中焦很寒，影响到胃里面去了，胃里面也很寒湿，胃的消化就不好了，同样吃生菜，胃不好的吃到虫卵就会长虫出来。因为寒湿，温度下降，胃没有办法消化，虫就在里面生了。吃又吃不下去，胃停在那边。

“饥而不欲食” 饿想吃东西，虫也想吃东西，吃不下去，人体自然的一种反应。所以如果病人说肚子很饿，又不想吃东西，就是虫了。

还有一种辩证上可以看到，怎么知道他有虫？一个百虫窝，有压痛点。第二个唇内牙龈的地方，有很多白点，成串的白点。还有眼睛眼白有蓝点或黑点。这就百分之七十五有虫了，还有肛门痒，晚上睡觉的时候肛门很痒，肛门痒可能是虫，有时候是痔疮。有时候大便会排出虫。

如果病人渴不欲饮，就是里面有淤血。饥而不欲食，肚子有虫。小朋友肚子有虫，肚子会比较大。

第三百四十一条。

原文：「厥阴」中风，脉微浮，为欲愈；不浮，为未愈也。

厥阴症出现的时候，如果看到病人有中风，就是太阳中风，不是半边瘫痪的中风，看到有太阳病的症状，就知道这个病会好。

反过来，如果这个病人是厥阴症，如果治疗脉微浮起来了，病人快治疗正常了。

第三百四十二条。

原文：「厥阴病」，欲解时，从丑至卯上。

第三百四十三条。

原文：「厥阴病」，渴欲饮水者，少少与之，愈。

如果病人在厥阴，比如肝病，心脏病，胰脏癌。你帮他治疗了，病人说口渴想喝水，病人要痊愈了。丑时醒来会肚子饿。胃气恢复了。

第三百四十四条。

原文：诸四逆厥者，不可下之，虚家亦然。

四逆证手脚冰冷的时候，大原则就是绝对不要去攻下。这个攻下是攻大便，不是攻小便。“虚家” 人体里虚的时候，比如病人刚刚手术恢复，一攻下里面会虚掉，最好是调理身体让他自己去排大便。

所以为什么说当归有时候很好用。当归补血，当归有仁，仁剂有油脂在里面，他能通利大便。

治肝癌病人的时候，只要半夜醒来肚子很饿，就是好转。

第三百四十五条。

原文：「伤寒」，先厥，后发热而利者，必自止，见厥复利。

如果表症伤寒的时候是冷的，照理说是恶寒，不会发热，应该是麻黄汤症，

全身是恶寒，体痛，脉是浮紧的，甚而会有高热的。

“「伤寒」，先厥”刚开始是冰冷的，看起来像恶寒，“后发热而利者”突然出现了发热而利。这就是厥阴症，寒热并结了。如果是发热而利了，利会自己停下来。“见厥复利”冷回来的时候，又会下痢。

所以厥阴证出现的时候，冷的时候会下痢，身体很热的时候病就停掉了。这是寒热并见的一种现象。

### 第三百四十六条。

原文：「伤寒」，始发热六日，厥反九日而利；凡厥利者，当不能食，今反能食者，恐为「除中」。食以「素饼」，微发热者，知胃气尚在，必愈；恐暴热来出而复去也。后三日脉之，其热续在者，期之旦日夜半愈。所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，为厥相应，故期至旦日夜半愈。又三日脉之，而脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。

有一种状况叫回光返照，这个回光返照维持三天时间。本来病人很严重，突然肚子饿了，开始吃东西了。如果“除中”就是回光返照。也可能是正常回来了，恢复了。怎么知道？问他“除中”之前。如果，寒热阴阳的区分。正常太极阴等于阳。阴很盛，阴大于阳的状态之下，你问他之前的冷热感觉怎么样。病人说先热六天，后冷九天，冷九天阴比较盛，“始发热六日，厥反九日而利；凡厥利者，当不能食，”如果热六天，冷九天，照理说阴很盛，很危险了，会下痢，大小便失禁，阴越来越盛，阳会脱掉。当不能食，他突然可以吃东西了，这是“除中”，回光返照。

如果“食以「素饼」”饼就是谷类的东西，以前汉朝的时候叫汤病，面条就是饼。“微发热者，知胃气尚在，必愈”我们最希望就是微发热，一点点热慢慢回来最好，人体是渐进的。就好像太极图，阴和阳是慢慢改变的，胃气还在。最怕突然暴热回来，热了三天，又走掉，走掉就完蛋了。如果说他吃东西以后，“后三日脉之”，这个脉不见得是你摸他的脉，你再去看看他，“其热续在者”有热的脉，病人告诉你身体很热，“后三日脉之，其热续在者，期之旦日夜半愈。”为什么？因为这个三天的热和前面六天的热加起来是九天，刚好九天热九天冷，阴阳是平衡的状态，所以说半夜会好。“所以然者，本发热六日，厥反九日，复发热三日，并前六日，亦为九日，”“为厥相应”阴和阳是相应的。“故期至旦日夜半愈”所以这个人半夜胃气会回来，肚子饿，开始吃东西。

### 8——1

所以说，本来发热六天，冷九天，是阴盛阳退，病情在进，结果复发热三日，并前六日，加起来是九日，阴阳循环，相等，“故期至旦日夜半愈”应该要半夜胃气会恢复。“又三日脉之，”再等三天，看他怎么样，如果“脉数，其热不罢者，此为热气有余，必发痈脓也。”应该里面会化脓痒。

如果正好九天热九日冷，病人是恢复的。如果超过九天，热气有余，里面会化脓。

一个是不及，一个是太过，一个是正好。我们要求的是正好。九是一个阳数。

如果病人前面六天是热的，后面九天是冷的，胃气开始恢复了，三天以后脉

就没有了，热脉就没有了，就是除中。如果热脉还继续在那边，病人就不会除中。

### 第三百四十七条。

原文：「伤寒」：脉迟，六七日，而反与「黄芩汤」彻其热。脉迟为寒，今与「黄芩汤」，复除其热，腹中应冷，当不能食，今反能食，此为「除中」，必死。

伤寒，脉浮数的时候，是表症，会发表。病人现在是恶寒，很冷，脉是迟的，里寒，药开错了，开了寒凉的药，「黄芩汤」是寒凉的药，寒上加寒，再把里面的药去掉，这个时候肚子里面应该是冷的，应该是不能食，因为他里面本来是冷的，又开寒凉的药，“今反能食，此为「除中」，必死”这就是回光返照。他能吃东西，完全没有热的脉，脉是迟的，完全没有热的症状，这是回光返照。

### 第三百四十八、第三百四十九条。

原文：「伤寒」：先厥后发热，下利必自止。而反汗出，咽中痛者，其喉为痹，发热，无汗，利必不自止。若不止，便脓血。便脓血，其喉不痹。

“先厥后发热，下利必自止。”先冷后发热。本来厥阴就是寒症，里寒，突然发热了，代表阳回头了，下痢会自己好。

这是讲，肝脏上面是肺，下面是大肠，肝脏是木，肺是金，大肠也是金。金刚好把木夹在中间。所谓金克木，木反侮金，两个平衡的话很好，不会有病。什么叫平衡，当肺吸气的时候，横膈膜会下降，下降横膈膜压迫到肝脏，肝脏会把血吐出来，肝藏血，不会自己阳跑出来，所以当吸气的时候，按照黄帝内经，天阳入肺，空气里面阳气很多，进来的时候，肺一膨胀，横膈膜下降，把肝一挤，肝里面的血从血管进入大肠，大肠周围很多血管，得到肝脏的血以后，大肠就开始蠕动了，把大便往前推。

肺上面紧接到就是喉咙，如果里面寒湿很盛，厥阴证就是寒，中焦肝脏都是寒的，热一发起来会往上冲到喉咙，这个热本来应该储存在身体里面的，可是寒湿很盛的时候，往上走跑到喉咙去了，热本来要进来，没有办法进入肝，一个往上走，一个往下走。热如果往下走，从肝脏走到大肠里面去了，这个热就是痺，最后一道系统，病毒都属于这种热，下去到大肠里面，排出来都是脓血。

肝脏里面有生阳，阴极生阳。生阳是元气，很好。还有一种热是病毒的热，所以他不是往上走，就是往下走。所以肝病的时候，我们看到病人会吐血，有的时候热往下走，大便就会带脓血出来。有脓血的话，喉咙就不会痺痛，吐血这种现象。

我们要保持每天都有正常的大便，然后要多运动。运动的话肺活量就会增加。抽烟影响到肺，就会克木，影响到肝脏。喉咙跟大肠相通的。

### 第三百五十条。

原文：「伤寒」，一二日，至四五日，前厥者，必发热；前热后厥者，必厥深热亦深，厥微者热亦微。厥应下之，而反发汗者，必口伤烂赤。

伤寒一二日，至四五日，就是病在进了。病情如果到厥阴症的时候，有发热

的现象都是好现象，若发热后又冷了，这就是热深厥亦深。当热到极限的时候，会看到寒症。所以中医比较难分辨的时候，有的时候热是假的热，里面是寒的。

如果是很高热，很壮热的时候，里面很冷，外面会看到很热，热深厥亦深。如果热很微弱寒也会很微弱。

当看到病人寒热交接的时候，如果发汗，这个不能发汗，发汗必须要有伤寒表症，或者太阳中风表症，才会去发汗，这个不应该发汗，你以为是热症伤寒，你给他麻黄汤，口伤烂赤，因为他这个不是在表，而是在厥阴，阴的尽头。所以千万不要发汗。我们在厥阴篇的治症里面，讲究的不是发汗，也不是攻下大便，而是利尿。小便出黄就开始退。有必要，大便堵到的时候，会加上轻微的剂量在里面，让大便自己顺出来，不要用大黄去攻它。

这个条辨是说，看起来好像是伤寒是热要发汗，实际上他是厥阴症。厥阴证忌发汗。一发汗，本来里面阴寒很盛了，再发汗会造成病毒往外跑，会造成口伤烂赤。

第三百五十一条。

原文：「伤寒病」，厥五日，热亦五日，设六日当复厥，不厥者自愈。厥终不过五日，以热五日，故知自愈。

伤寒病，冷五天，热五天，第六天如果再回去冷，病还是在进行中间。如果第六天开始热起来，不再冷了，病就会自己会恢复了。五天都是纯阳，九天就不好，五天没有过一候，不是危险的症状。如果是持续的冷下去，或持续的热下去，超过九天才是不好。五天都是没有什么问题的。

第三百五十二条。

原文：凡厥者，阴阳气不相顺接，便为厥。厥者，手足逆冷是也。

厥者，手足逆冷。就是手指头到手肘关机，脚趾头到膝盖关节。厥症就是阴阳气不相接。肺是阴，大肠是阳。肺往下走，血往下来，大肠就顺时针往下走。大肠在行走的时候，小肠是火在下面烧，大肠水气化到肺里面，到肺里面又开始下雨下来，到肾脏去，一直在循环的。如果肝有问题的时候，中间横隔，比如脾脏胰脏有问题的时候，梗在中间，水道不通，水不断的气化，结果到横隔就梗到，肚子越来越大，上面很干，水上不来。喝水下去没有办法去产生水，在里面梗到，他又渴，喝不下去，中间梗到，水在下面不断累积起来，腹水是这样来的。

第三百五十三、第三百五十四条。

原文：「伤寒」，脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁，无暂安时者，此为藏厥。非若蚘厥也。蚘厥者，其人常自吐蚘。今病者静，而复时烦，此为蚘厥。蚘上入膈，故烦。须臾复止，得食而呕又烦者，蚘闻食臭出，其人当吐蚘也，蚘厥者，「乌梅丸」主之，又主久利。

这个是寒热并结，专门治疗有寒有热时候的一个处方。

伤寒脉微而厥，如果真正的是太阳伤寒，应该是脉浮而紧。“「伤寒」，脉微而厥，至七八日，肤冷，其人躁，无暂安时者，此为藏厥。”脏里面阴寒很盛的时候，病人会烦躁，阳会往外走，脉很小，这个是持续的，一直烦躁，藏结很危



险，阴寒很盛，脏里面的阳往外走，所以病人不断的烦躁。阴阳在分隔的状态之下，这是藏结。藏结病人一定烦躁。

乌梅丸除了去虫以外还有久利。

虫在肚子里生起来。会有虫一定是肠胃寒湿，才会长虫。所以虫的体温跟胃的体温相等，它才可以活在里面，胃比较冷。病人安安静静，有虫在里面没有动。当想吃东西的时候，虫也抢着吃，虫就往上膈走，虫往上膈的时候，会觉得很烦。“须臾复止，”因为饥不欲食，没有东西吃，虫又回去。吃东西硬吃下去，得食则呕，又烦，虫一直往上逆。「乌梅丸」主之，又主久利。

每逢考试必下痢，乌梅丸症。舌头黄湿，乌梅丸有寒有湿在里面。有时候心包经有湿热，痰梗在这边，胃是冷的，肠胃是冷的，心包是热的，这个就是乌梅丸，这个就是久利。心包是相火。相火就是欲望。考试到了，心包有积痰，很紧张，肠胃是冷的，下痢。看到病人紧张下痢，舌苔是黄的，舌为心表，其实肚子里是寒的，久利一般是寒利。最常见的就是病人一考试就下痢，乌梅丸就完了。

乌梅丸还有一个是去虫，虫的性，虫一遇到酸不动了。辣一吃到虫就服从了。虫一吃到苦就逃走了。乌梅丸就把中药最苦的，醉辣的，最酸的，刚放在一起。把乌梅找出来，乌梅还不够酸，泡醋里面泡一个晚上。怎么确定虫吃到乌梅，人吃到饭。

乌梅丸方

乌梅三百个。细辛六两。干姜十两。黄连一斤。当归四两。附子六两炮。蜀椒四两炒去汗。桂枝六两。人参六两。黄柏六两。

右十味，异捣筛，合治之。以苦酒渍乌梅一宿，去核，蒸之，五升米下，饭熟，捣成泥，合药令相得，内臼中，与蜜，杵貳千下，丸如梧桐子大。先食饮，服十丸，日三服，稍加至二十丸，禁生冷、滑物、臭食等。

这十味药，分开捣筛。苦酒就是黑醋。

“五升米下”一点的米，用米为了吸引虫来吃。

“先食饮”就是饭前吃。它闻到是蜂蜜，咬下去，又酸又苦又辣，这个时候你吃饭下去，结果你吃到饭，虫吃到乌梅。

乌梅三百颗用肉，没有用壳的。

有虫的人，消化系统不好，血会比较亏一点，肚子很大，饥又不吃东西，面黄肌瘦。这个时候张仲景才用到一点当归。所以张仲景非必要不用当归。不是当归不好，如果很健康可以吃当归，生病的时候不要吃。当归补血。人参补气，肠胃的津液。

第三百五十五条。

原文：「伤寒」，热少，厥微，指头寒，默默不欲食，烦躁，数日小便利色白者，此热除也；欲得食，其病为愈；若厥多而呕，胸胁烦满者，其后必便血。

“「伤寒」，热少，厥微，”热不多冷也不多。

“若厥多而呕，胸胁烦满者，其后必便血。”如果冷多。病情在转变的时候，越来越冷，东西吃不下去了，吃东西就呕出来，胸胁烦满呕吐，一定会便脓血。因为热不能下的时候，里面很盛的时候，会造成大便带很多血。

厥阴证一定有寒热交接，当寒很盛的时候，热一定要找地方宣泄，一个是排脓血，不是往上胸胁烦满，就是后面大便带血。因为里寒很盛，热没办法呆在里面往外走。

所以治疗厥阴证，比如肝病的时候，很注意他的大便。

第三百五十六条。

原文：病者手足厥冷，言我不「结胸」，小腹满，按之痛者，此冷结在膀胱「关元」也。

病人手脚冷，没有结胸。少腹比较胀满，按他痛，里面寒水在里面。这个时候可以灸。

（三五七条至三五九条漏讲，在 8—3 集补讲）

第三百五十七条。

原文：「伤寒」发热四日，厥反三日，复热四日，厥少热多，其病当愈。四日至七日，热不除者，其后必便脓血。

冷比较少，热比较多。从这个条辨可以看到用热药治病是对的，到厥阴症，是病最深的时候，如果冷的时间比热多，这个病人是死，热比冷的时间多是生。

第三百五十八条。

原文：「伤寒」厥四日，热反三日，复厥五日。其病为进；寒多热少，阳气退，故为进也。

热多于寒是比较好。寒热同等是最好。如果是热三天，寒七天，处方下去，寒七天热七天，处方不要改，一直吃，吃到晚上肚子饿了。

好了以后，病人元气恢复了以后，可能癌细胞还在，但是他是无害的，不要去动他。

第三百五十九条。

原文：「伤寒」六七日，脉微，手足厥冷，烦燥，灸「厥阴」，厥不还者，死。

里面阴寒很盛，阳要厥的时候，就会出现这种现象。

灸厥阴的时候，期门章门穴，五脏的会穴都可以。

第三百六十条。

原文：「伤寒」发热，下利，厥逆，躁不得卧者，死。

病人有寒有发热，如果脉是浮的，大便没有下痢，照伤寒表症。

这里是里寒越来越盛，阳会出来，阳出来，病人燥没有办法躺下去，所以肝癌后期病人是坐在那里死的。最多一个礼拜。

在治疗这种末期的癌症，千万不要攻下。里面很冷的时候，燥，这是阴阳相隔了。所以不攻下，但是攻小便。然后想办法把阴阳相隔让他搭配在一起。让他阳回头。

如果看到病人坐到那边不能躺下去，然后又下痢，完了。如果他肚子胀的很大，手脚是冰冷的，但是没有下痢，你利他小便，小便一排出来，胃口一恢复，他就有机会。

第三百六十一条。

原文：「伤寒」，发热，下利至甚，厥不止者，死。

手脚越来越冷，腹水的病人腿肿的又大，摸上去像寒冰。寒气一直往身上走，这个都是死症。

第三百六十二条。

原文：「伤寒」，六七日下利，又发热，其人汗出不止者，死，有阴无阳故也。

阳要离开身体的时候，突然发热，汗出。比如病人肺癌胰脏癌，他身体很虚了，他开什么药下去，他流汗统统流掉。代表里面像冰山一样，药只到外面汗流不止者，阳已经绝掉了，药食不能受下去，这是有阴无阳的原因。

阳主要是能吸收，阴绝对不能结实。如果阴一旦结实就完蛋了。

8——2

一旦结实的时候，我们用的药物进不去的时候，病人就危险了。所以我们会去找很热的药，希望把这个冰山融化掉。

到厥阴篇的时候，只要有热的存在，病人都有机会。除非你用了热药下去，比如这个人汗出不止，又发热，你知道里面是冷的，因为他不断的下痢，吃什么拉什么东西。肚子一直排水在虚脱的状态之下。你用很大剂的药下去，他身体又不受。吐掉或者下痢，没有改变，而且，你吃的药越多，流的汗越多，代表他已经不接受了，没有办法。

第三百六十三条。

原文：「伤寒」，五六日，不结胸，腹濡，脉虚，复厥者，下可下，此为亡血，下之死。

“腹濡”肚子软绵绵的。

“亡血”病人有贫血，或者失血很多。肚子是软的，脉是虚的，手脚是冰冷的。这种状态之下，不可以攻下，一攻下他血会丧失的更多。失血的病人，不要攻下，看脸色就知道，脸色苍白，嘴唇是白的，已经失血，绝对不要攻下。血的来源就来自食物，已经贫血了，他肚子里面还有一点食物在支撑他，结果你把他攻掉了。

第三百六十四条。

原文：发热而厥，七日，下利者，为难治。

病人全身发热，但是手脚是冰冷的。下痢代表阴很盛，阳不能固住它。流汗不止，阳绝。人不动，不会流汗是阳在固表。小便失禁，大便失禁都是危险的症状，都是阳脱的现象。

这里是真寒假热的一种现象。

第三百六十五条。

原文：伤寒，脉促，手足厥逆者，可灸之。

脉促就是脉跳跳停一下。手脚冰冷胃气不够了。灸灸肠胃的穴道都可以灸。也就是即使厥阴证，但是没有下痢恶心，只有手脚冰冷，都可以灸。

第三百六十六条。

原文：「伤寒」脉滑而厥者，里有热也，「白虎汤」主之。

伤寒，滑脉速度非常流畅，我们知道里面是热。外面看起来是冷的，里面是热的。这是真热假寒，寒到极限的时候，里面是热的。热到极限的时候，寒在骨髓。里有热的时候，用白虎汤。

一般白虎汤出现的时候，舌头都是干裂的，摸他的脉比较大。他说怕冷，你摸他手很热。小便都是比较黄。百分之一，他里面是冷的，外面是热的，结果处方，也可以用白虎，叫阴极会生阳。寒极会生热。热到极限的时候也会生寒。要突破中医这个观念。当看到里面有寒，你不断用四逆汤下去还冷，生硫磺下去还冷，白虎汤让他更冷，一剂下去热就回来。

第三百六十七条。

原文：手足厥寒，脉细欲绝者，「当归四逆汤」主之。

摸到脉微细，冬天会生冻疮。「当归四逆汤」专门治疗冻疮。糖尿病的病人到后来要截肢，也是当归四逆汤症。只要是截肢要用到当归四逆汤。这是专门在手脚冰冷的时候使用。

当归四逆汤方

当归三两。桂枝三两。芍药三两。细辛三两。大枣二十五个。甘草二两炙。通草二两。

右七味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

通草就是木通。

当归四逆汤手脚逆冷的时候，病人血不够，所以加当归。生姜拿掉，生姜除了去胃里面的停水以外，胃里面如果没有水，没有恶心，他生姜不用有他不用的道理。里面有炙甘草跟红枣，他不会担心肠胃的津液不够。他不用生姜，因为生姜只是散胃里面的寒水，没有力量发散到全身四肢末梢上去。炙甘草能强心脏，红枣主津液。细辛能生下焦阳。通草能通肠子里面一点点宿便。当归四逆汤吃起来，大便会多一两次，因为里面有通草。如果已经有下痢，通草拿掉。有便秘，通草多加一点，当归多加一点。当归除了补血以外，最主要还有仁剂在里面。细辛生下焦的阳，里面有寒，像冰块一样，细辛下去把水化掉。设计这个处方没有

生姜，他并没有恶心呕吐的现象。经方药简力专。

病人如果有四逆证，手脚是冰冷的，同时又化脓，病人有恶心呕吐，要把生姜吴茱萸加上去。

临床当归四逆汤，就是血虚，寒冷，造成手脚冻疮，还有女人白带很多。临床上当归四逆汤对胃也很好，慢性胃病也很好，如果慢性胃病，又会恶心呕吐的时候，就是当归四逆加吴茱萸生姜汤。

病人疝气也可以用，因为细辛可以化他的里寒，疝气肠子下坠，一般喜欢用升麻，升麻能够升提阳气。

第三百六十七条。

原文：若其人内有久寒者，宜「当归四逆加吴茱萸生姜汤」主之。

临床看肝病的人恶心呕吐，用吴茱萸止呕，吴茱萸能够入肝。临床遇到胃下垂，一剂就去掉了。

病人常常胃里面很寒，不能吃凉的，一吃凉的恶心不消化，不是吐就是下痢。手脚都是冰冷的，手脚的温度就代表胃气的温度。

正常人手掌是热的，手背是凉的。头是凉的，手掌是热的。胃气会往上升。手脚是平衡的，胃气没有发汗，身体里面很热的话，热就会找地方发散，会发头上，头上是热的。摸到头是热的，手是冷的身体也是有问题。

当归四逆加吴茱萸生姜汤方

当归三两。桂枝三两。芍药三两。细辛三两。通草二两。甘草二两炙。大枣二十五枚。吴茱萸二升。生姜半斤。

右九味，以水六升。清酒六升，和煮取五升，去滓，分温五服。

第三百六十八条。

原文：大汗出，热不去，四肢痛而拘急，又下利，厥逆而恶寒者，「四逆汤」主之。

“大汗出，热不去，”如果没有其他症状，标准的白虎汤症状。

“四肢痛而拘急，”抽筋。又下利，外面很热，里面又下痢。这是里面真正是寒的。所以他的热往外走，看起来外面是大汗，还是很热。有两种，一种是身体的阳，一种是病的热，不一样。看起来都是热，阳往外走就是这样子，病往外走就是这样，看起来很像，造成手脚冰冷，病人下痢。又流汗又下痢，病人阳一直在往外走，津液一直在伤。四逆汤下去把里阳壮回来。为什么会叫四逆，最主要是手脚是冷的，这个冷从手指头到手肘。光是手冷脚冷不需要四逆。

第三百七十条。

原文：病人手足厥冷，脉乍紧者，邪结在胸中，心下满而烦，饥不能食者，病在胸中，当须吐之，宜用「瓜蒂散」。

“脉乍紧者，邪结在胸中，”脉有时候紧，有时候不紧，邪在胸中，梗在这

边，东西吃不下，病人告诉你胸腔很痛，东西吞不下去。这个时候要看他是不是东西梗到了，气色很好，声音很大，一定东西梗到了。只要确定有东西梗到，用吐的方式。用瓜蒂散。想其他办法让他吐也可以。

### 第三百七十条。

原文：「伤寒」，厥而心下悸者，宜先治水，当服「茯苓甘草汤」，却治其厥，不尔，水渍入胃，必作利也。

伤寒，手脚冰冷，里面是寒，体寒，心下悸，宜先治水。如果说病人有心下悸，同时有厥阴有寒，你先治心下悸，再去治其他的。心下悸应该是桂枝甘草汤。肚脐下动悸才是茯苓甘草，这个条辨弄错了。

如果说没有把这个水排掉，却治寒厥，造成这个水跑到胃里面去，先要把水排掉，再治他的厥逆。先把他动悸的现象排掉，因为动悸并不是在胃里面，而是在周围。如果用四逆汤治冷，恶寒，厥逆，手脚冰冷，四逆汤干姜是温中的，只到胃的里面去，胃的外面上方没有办法到。

### 第三百七十二条。

原文：「伤寒」六七日，大下后，寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，咽喉不利，唾脓血，泄利不止者，为难治，「麻黄升麻汤」主之。

照理太阳伤寒表症，大下，结胸。现在不是，“寸脉沉而迟，手足厥逆，下部脉不至，”尺脉摸不到。

从少阴症以后，就出来很多咽喉的问题，阴证常常看到咽喉的问题。单纯看到咽喉化脓生疮，可以用半夏桂枝甘草类似这种。

肝病的人会吐血出来，胃癌的病人也会吐血。如果胃里寒了，吐血出来，病人最好治是吐血。如果说病人，不吐血，反而是不好治，即使看到是胃癌，里面辩证很多，不见得是同样的处方。

「麻黄升麻汤」是针对肝病吐血，是寒热并用的一个方剂。有经方家怀疑这个条辨不该放到这，前后有点不连贯。

### 麻黄升麻汤方

麻黄二两半去节。升麻一两一分。当归一两一分。知母、黄芩、葳蕤各十八铢。石膏碎绵裹。白朮、干姜、芍药、桂枝、茯苓、甘草炙、天门冬去心各六铢。

右十四味，以水一斗，先煮麻黄一二沸，去上沫，纳诸药，煮取三升，去滓，分温三服，相去如炊三斗米顷，令尽汗出愈。

升麻常常使用在脱肛，疝气，肠子下坠，中气不足往下陷，常用升麻升提他的阳气。

葳蕤又叫玉竹。这个四专门治疗咽喉不利、发炎。“知母、黄芩、葳蕤各十八铢”一般是三钱。

白朮茯苓能够去湿，小便排出来。干姜能够去寒。

临床上，肝病吐血可以用。这个方子，玉竹有止血功能，当归有补血功能。

胃出血不是这样用。胃癌有黄土汤，如果是吐血就用黄土汤。

第三百七十三条。

原文：「伤寒」四五日，腹中痛，若转气下趋少腹者，此欲自利也。

寒湿肚子会痛。如果没有把去寒去湿的药加里面，就会到少腹，就要开始下痢了。

第三百七十四条。

原文：「伤寒」，本自寒下，医复吐、下之，寒格，更逆吐、下，若食入口即吐者，「干姜黄连黄芩人参汤」主之。

治疗胰脏癌最重要的处方是这个。胰脏癌很多人的症状，吐下，东西吃下去就开始吐，中膈很痛，这个处方主力处方。还有一种情形，临床上，胰脏癌很多人是吃了吐，寒格中间，吃东西一下吐出来，这个就是「干姜黄连黄芩人参汤」。

干姜黄连黄芩人参汤方

干姜、黄连、黄芩、人参各三两。

右四味，以水六升，煮取二升，去滓，分温再服。

干姜是热药，黄芩黄连是寒凉的药，中间补个人参，就四味药在里面。干姜温中，黄芩黄连去热，人参因为他吐下，肠胃津液伤到。

8——3

人参去补虚，简简单单的四味药，以这四味药为主力。这是一个。

还有一个处方是旋覆花代赭石汤，这个处方来加减，加干姜吴茱萸各三钱，如果病人恶心、呕吐、胃酸很盛就可以用。这个处方病人吃到，这两个处方会有个共同的现象，原来中膈的地方非常的痛，东西已经吃不下去了，没有吐酸的时候，就是吃入即吐，干姜黄连黄芩人参汤。旋覆花代赭石汤，这个会吃下去，但是会呕酸，是这个旋覆花代赭石，加干姜吴茱萸各三钱。病人一个礼拜后会大下，代赭石会降逆，大下，下去以后就是黑的大便，下完以后，整个痛就去掉，胃口就恢复了。干姜黄连黄芩人参汤也是一样的现象。这是胰脏癌的时候。

还有一种情形，被诊断是胰脏癌，一般西医诊断出是胰脏癌都是末期了。还有人还在往来寒热，恶心，小柴胡汤症，你开小柴胡汤。按照症来开最好。

在治癌症的时候，不见的癌细胞完全去掉，但是药吃到一个阶段，这个癌不影响你，跟你共存就好了。

「干姜黄连黄芩人参汤」这个药速度很快，当有寒格的时候，所有的癌症都是寒。寒格在中间，胃的中间实际上就是胰脏。

干姜、黄连、黄芩、人参各三两。不要真的三两，三钱就好了。六碗水煮两碗。早晚各一碗。病人有点怕风吹，桂枝汤加里面，有点项强葛根汤。没有恶寒，就是项强，脖子硬，脸部有点中风，桂枝汤加葛根。基础方不动，可以加一些上去。皮肤很痒，麻黄连翘赤小豆汤。

寒格在胃，如果看到不是胰脏癌，同样的症状，结果病人一吃下去就吐，东西吃不下去，又吐又下，寒格在中间，喝热水比较暖和一点，喝冷水不行，都是寒格。都可以使用「干姜黄连黄芩人参汤」这个处方。不用管他里面的症是什么东西。当把病人救回来的时候，可能病还在那边。可能好很多，但是还有一点，不要去挖他。

第三百七十五条。

原文：下利，有微热而渴，脉弱者，令自愈。

厥阴篇都在讲下痢，所以霍乱疟疾都是属于下痢。下痢不能止痢病人也会死的。

厥阴，肝脏上面是肺，下面是大肠，当有问题的时候，热要出来的时候，一定会走到大肠里面，开始下痢。如果下痢有微热而渴，代表津液要回来，胃气在那边。这个病人自己会痊愈的。

第三百七十六条。

原文：下利，脉缓，有微热，汗出，令自愈；设复紧，为未解。

本来自己会痊愈，因为有微热。热回来，胃口也开了，能喝点水。结果摸他的脉，还有点紧，代表还没有完全排掉，还有寒在里面。

像这种不要去治他，让他多吃点稀饭，慢慢会恢复。

常跟病家说，平常吃七分饱，病态的时候吃五分饱，吃太饱对身体不好。如果常常保持这样，胃会一直蠕动，胃气会一直在。只要胃气长存，手脚温热，这种都是长寿。

第三百七十七条。

原文：下利，手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者，死。

这个微喘是阳要厥，阴寒太盛了，这种都是死症。死症脸都变成青黄、暗黄。皮肤都没有反光了。

第三百七十八条。

原文：「少阴」负「趺阳」者，为顺也。

「趺阳」脉是胃脉，脚的地方。「少阴」脉是肾脉，在太溪的地方。

冲阳脉比较大，少阴脉比较小，是正常。太阴本来是阴，在里面，冲阳脉胃气比较大，在外面。

第三百七十九条。

原文：下利，寸脉反浮数，尺中自濇者，必清脓血。

阳脉寸脉，正常人应该比较小，尺脉比较大。阴阳是平衡的。

如果阳一直往上浮，跑到胸阳上来，寸是指胸部的地方，上焦。下面的阳就不够，阳不够的时候，大便的血排出来。



有的时候大便排血出来，不单是肝病或者大肠炎，有的时候是消化的食物，成为血了，结果阳不够排出来，大便会看到脓血。

病人精子带血，行房不痛，寒。行房痛，可能有性病。精的前身是血，血的前身是食物。下焦比较寒的时候，男人的精宫是在小肠跟膀胱之间，女人子宫在小肠膀胱之间，小肠的热把精宫的血变成白的，如果小肠温度下降，血没有办法完全化成精，精和血一起出来，但是他的精就是血，所以他不痛，是寒。阳虚热不够的时候，会出现这种现象。

第三百八十条。

原文：下利清谷，不可攻表；汗出，必胀满。

有里寒症的时候，不可攻表。如果攻表，汗出，里寒更盛，造成胀满。

胀满寒湿很盛，没有便秘，都是气，用厚朴生姜半夏人参甘草汤，但是这个里面是寒湿了，被误下，本来下痢清谷，里面是寒湿的，用厚朴生姜半夏人参甘草汤，如果加炮附子、白术、茯苓把小便利掉，寒湿去掉就很对症。

第三百八十一条。

原文：下利，脉沉弦者，下重也；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热，不死。

“脉沉弦”病在里，里面有寒。

霍乱、伤寒，我讲这个伤寒不是太阳伤寒，而是那个病疟疾，下痢上吐下泻。

“脉微弱数者”就是胃气还在，这个都不会有问题的。

下痢代表里虚，怕他脱阳，津液不足，脱水的时候，如果脉比较洪大的，脉症不和的，都不是很好。如果发热的时候，手脚温热，病人感觉自己也热起来，代表胃气回来，这种都不会有事。

第三百八十二条。

原文：下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，病人微厥。所以然者，其面「戴阳」，下虚故也。

“脉沉而迟”沉是里，迟是寒，里寒。“其人面少赤”脸是红的。脉小细，里面是寒的，脸是红的，代表阳气被里寒逼出来。

这个脸上是红色叫「戴阳」，里面下焦太虚了。

“下利清谷”是很常见的症状。最常用的是干姜附子汤。一剂就好了。如果里虚的很盛，用生附子也没关系。

第三百八十三条。

原文：下利，脉数而渴者，令自愈。设不差，必清脓血，以有热故也。

“脉数而渴”代表里面有热，照理热症的话，让他自己好。如果没有好的话，这个热会从大便排出来。这里讲的下痢都是在厥阴症，寒热都会有。简单讲手脚都是冰冷的，他现在有热症。

第三百八十四条。

原文：下利后，脉绝，手足厥冷，晬时脉还，手足温者生，脉不还者死。

“脉绝”脉没有了。“晬时”差不多一天。“手足温”代表胃气回来。

病人冷，虚脱下去了，脉很少，看他会不会活回来，手足温，胃气慢慢回来，不会死。一天之后回不来，就会很危险。

第三百八十五条。

原文：伤寒，下利日十余行，脉反实者，死。

如果下痢，脉是很细微的，如果下痢很严重，脉摸起来是很洪大的，阳要绝了，脉症不合。如果是承气汤症，便秘，摸到脉很实，这是脉症合，承气汤下去就好了。如果下痢，怎么会有那么实的脉，这是阳要走表，阴阳分隔的一种现象。

第三百八十六条。

原文：下利清谷，里寒外热，汗出而厥者，「通脉四逆汤」主之。

“通脉”就是表里能够通。里外不通的时候要靠他来通。寒利严重的时候，用通脉四逆汤。

第三百八十七条。

原文：热利下重者，「白头翁汤」治之。

伤寒论有好几个地方出现热利，第一个葛芩连汤的时候有热利，但是葛芩连汤一定是有表症。第二个热利黄芩汤，黄芩汤的热利一定有肚痛。第三个黄连汤热利，黄连汤是寒热并结的，有寒有热的。这个白头翁汤也是纯热利，大便拉出来十几次，肛门很痛，里急后重。

白头翁汤方

白头翁二两。黄连、黄柏、秦皮各三两。

右四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈，更服一升。

秦皮是很好的止痢的药，能够润肠。黄连胃里面。黄柏是肠子里面。黄芩比较走上焦。

病人下痢，两三天热利，很臭。但是有一天大便和血混在一起。有的时候又没有。这个时候用桃花汤跟白头翁汤复方。

如果遇到疟疾，有的下痢清谷，用通脉四逆汤，或者是干姜附子汤。有时候热利怎么办，白头翁汤。疟疾霍乱都会有这种情形。

第三百八十八条。

原文：下利，腹胀满，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表，温里宜「四逆汤」，攻表宜「桂枝汤」。

这是原则。当有表和里，先温其里，再攻其表。如果看到病人是桂枝汤症，又有里寒的时候，先用四逆汤，再去攻表，不要发过来做。因为里寒很盛，你去

攻表的时候，寒湿会带动，会阳绝。里面寒湿的时候，阳在外面，你再攻表的时候，阳会绝，会让阳发散的太厉害。

攻表的时候宜桂枝汤。如果病人有四逆汤症，里面很冷，用麻黄汤很可怕的，麻黄汤发阳的力量很强，他本来阳不够了，里面是寒湿了，再去发阳。

你如果是用桂枝汤，即使你没有先温里，你攻表也不会有事的。桂枝汤比较温。

第三百八十九条。

原文：下利，欲饮水者，以有热故也，「白头翁汤」主之。

白头翁汤有热利，想喝水，喝冷水，有热的关系。记得，只要病人想喝水都没有问题。下痢欲饮水，代表肠胃功能很好。

第三百九十条。

原文：下利，谵语者，有燥矢也，宜「大承气汤」。

大便干在里面造成的下痢，还是大承气汤。

第三百九十一条。

原文：下利后，更烦，按之心下濡者，为虚烦也，宜「栀子豉汤」。

什么叫虚？病人如果是便秘，汗不出，小便不出，大便不出，都是实。当下痢流汗不止，小便很多，都是属于虚。

想他下痢后更烦，按之心下软软的，他不是便秘阴气的下痢，肚子里面没有东西。这是虚烦，「栀子豉汤」，虚热的时候用。

刚恢复痊愈的病人，失眠的都可以用栀子豉汤。

第三百九十二条。

原文：呕家，有痈脓者，不可治呕，脓尽自愈。

如果病人呕吐，有化脓的吐出来。甚至于胃癌，吐出来是血的时候，不要去治他呕，不要管他的恶心，不要加什么吴茱萸之类，去止他的呕，不需要。有时候会吐脓，吐脓出来，有时候肺里面化脓的时候，跟肠胃里面化脓不太一样，所以有时候看到是血，有时候看到是白痰。

但是呕家人，如果有脓吐出来的现象，千万不要去止呕，这是原则。因为他肠胃里面功能正在恢复，脓你把他止呕的话，脓排不出来了，脓尽他自然而然会好。

第三百九十三条。

原文：呕而脉弱，小便复利，身有微热，见厥者，难治，「四逆汤」主之。

当身体里面是寒冷的时候，中焦是寒的，比如肝肿大，顶到胃，把胃缩小了，呕。

“小便复利，身有微热，见厥者”小便是肺的津液，下来到肾脏里面，然后

在膀胱气化出来。如果身有胃热，四肢冷的，为什么难治？这个小便复利是他没办法控制的流出来。

四逆汤：生附子、干姜、炙甘草。它把小肠的温度壮回来的时候，我最常用生附子的原因，第一个是小肠太冷了。而生附子强心脏的阳，生附子下去心脏搏动的很快，生附子又很热，中焦的寒湿会打开来，心脏的热会进入小肠。

这个小便复利，就是小便非常的频数，不断重复的去小便，是说他控制的很好，这个代表里面有寒。寒的话，外面有点微热，代表阳要绝了，里面阴寒很盛，“小便复利”一直跑厕所，恶心东西吃不下，脉又很小，这就是里阴寒很盛，要用四逆汤，生附子、干姜、炙甘草。

第三百九十四条。

原文：干呕，吐涎沫，头痛者，「吴茱萸汤」主之。

在肝病的时候，胃下垂的时候，都会有恶心干呕。干呕并不是说吃坏肚子吐出来，而是胃里面恶心，吃不下东西。代表胃没有问题，是别的东西影响到胃。

为什么会头痛？吴茱萸汤是很热的药。可能肝肿起来顶到胃，顶到胃，胃的容积变小了，蠕动也变缓了，胃家变寒症，胃本来没有寒，因为肝脏问题造成的。胃气往上升的时候，头痛。

吴茱萸的头痛出现，一定在印堂痛。

第三百九十五条。

原文：呕而发热者，「小柴胡汤」主之。

只要恶心而发热，在厥阴篇的时候，大部分是恶寒，手脚冰冷。呕而发热，代笔它又回到阳了，小柴胡汤主之。

如果治肝硬化肝癌的病人，他原来身体是冷的，你帮他治治，恶心有，但是身体是热的，不感觉冷了，水也退掉了，代表进入少阳了。

从少阳进入太阴再进入少阴，进入厥阴。治厥阴的时候，回到少阴，回到太阴，再回到少阳，代表病在退。这是很好的现象。

第三百九十六条。

原文：「伤寒」，大吐大下之，极虚，以其人外气怫郁，发其汗，复极汗出者，复与之水，因得「哕」；所以然者，胃中寒冷故也。

病人伤寒，太阳表症。大吐大下，照理说应该汗解。大吐大下之后，肠胃津液伤到了，极虚。他表还在，没有去掉，如果这个时候再发他的汗。意思是说，大吐大下之后，肠胃津液伤到了，已经寒掉了，寒掉你再去发他的汗，一发汗肠胃津液更少了。再发他的汗，造成肠胃冷掉了。所以胃寒有可能是这种情形产生的胃寒。胃里面是寒的，一喝水下去就打嗝。

造成胃冷的原因很多，比如长期的喝咖啡可乐。

第三百九十七条。

原文：「伤寒」，「哕」而腹满，视其前后，知何部不利，利之即愈。

分消汤可以用在脾脏实症，肚子腹水的时候，比如脾脏肿大。肝癌肿的时候，补气建中汤。

有一个处方，补中治湿汤。就是前面的补气建中汤，把泽泻拿掉，换当归，木通，升麻。

人参、白术各四钱，苍术茯苓陈皮麦冬当归木通各三钱。黄芩厚朴各二。升麻一，这个升麻可加可不加，如果病人嫌药苦，可以去之。

补中治湿汤是病人肝病到末期，没有把法了，给他一剂。

“腹满，视其前后，知何部不利”肝癌后期的时候，大小便都没有了，最重要的是小便。

肝肿大，肚子肿的很大，知道他是寒湿，去强脾。甘味的药，像陈皮，茯苓苍术，白术，这种都是甘淡利湿，能够行湿，排湿的药。麦门冬润肺。

制定一个处方出来，不能说只针对一个脏，一定要兼顾其他的东西。气虚掉了，加人参。把肺强起来，麦门冬。因为他的津液统统停在中间，这个时候肺上面没有津液了，小肠的津液不断的上来，中间的肝堵到了，所以停水在这个地方，因为肝横逆在中间。会用当归代表血虚了，内脏有病的时候，不管是脾脏、肝脏、心脏都会有血虚的现象，久病也有虚，所以加当归。木通就是大便不通，大便不通的时候，又不能用大便去攻，厥阴症的时候不能攻下，里寒盛的时候，一攻下死掉了。病人有虚热，肠子气往上逆，加黄芩厚朴，宽肠，让肠气往下走，同时黄芩里面有宿食的话，它能够解毒。这个处方下去，小便出来就有救。那要增强它，怎么增强，就要靠热药。

整个厥阴篇讲，热多比较好，寒多不好。所以补中治湿汤，加生附子五钱。生硫磺可以用到七钱。附子生硫磺用棉布包起来。当行气利湿的时候，水已经很盛了，整个三焦都堵到了，很重，里寒很盛。我们希望热药能够进入身体的中心去，把寒湿化掉，光是行湿，可能外面湿排掉，里面寒湿可能还是有，所以会使用到生附子。生附子能够强心，心脏和小肠这一段靠生附子去强他，生硫磺从命门到三焦，生硫磺平时治疗水肿，硫磺放一点下去，全身冒汗，水肿就推掉了，能够点命门火的药，最后的就是生硫磺，生硫磺下去以后，命门火会起来，阳气会起来，阳气在走的时候，再配合行气治湿的药的时候，能够一搏。他便秘，绝对不能用大黄芒硝，用就死，所以用木通。临床上木通，心脏热要移热到小肠，木通很好用，当归四逆汤也有木通。小肠很冷的时候，小肠的蠕动靠木通，木通除了通小便，还能通大便，对大便也很好。

原方补中治湿汤，加生附子、生硫磺下去，药性就大增。做最后一搏。病人恶心，呕吐，吃不下去，吴茱萸，生姜来不及了用干姜，吴茱萸可以用四钱五钱，干姜三钱。千万不放甘草。排腹水的时候，甘草，大黄，芒硝都不用，因为厥阴篇忌下，绝对不能攻下的。

分消汤，脾脏肿大，腹水很快。肝脏就很难。

在治癌症的时候，第一要求，不要病人做任何的检查的动作，不要做切片栓塞，什么都不要做。第二个要求就是，不要回去做体检了。中医得标准是，里面

可能还有其他的变症在里面，可是这个人能吃能喝能拉能睡，即使肝癌的肿瘤还在，可能十年才长指甲那么大一个，你就不要小题大做了。

以上讲的是厥阴证。

这里开八本书：

《伤寒论辑义》大新书局，作者：丹波元简

《证因方论》清朝汪汝麟。

《世补斋医书全集》五洲出版，陆久之、傅青主、戴天章。

《徐灵胎医书全集》五洲出版。

《伤寒杂病论》士林出版，作者东汉张仲景。

《石室秘录》作者：陈士铎

《黄帝外经》

《伤寒论解说》作者日本大塚敬节

金匱还没有开始讲，先看伤寒，把伤寒看熟，先不要看金匱，金匱我来帮你启蒙，打根基，等我讲完金匱，你再去看，不然现在看会误解。

这些书买到，先看伤寒的部分，这都是历代的经方家，都非常的优秀。